



Kaasrahanud
Euroopa Liit



Eesti
tuleviku heaks

Uuring täisealiste puudega inimeste puude tuvastamise, toetuste ja hüvede võimalikust kaasajastamisest

Uuringu aruanne

2026

PRAXIS | MÕTTEKODA

Mõttekoda Praxis on avalikes huvides tegutsev sõltumatu mõttekoda, kelle eesmärk on Eesti ühiskonnale olulistes küsimustes luua uusi teadmisi, leida mõjusaid lahendusi ja rikastada avalikku arutelu.

Autorid: Isabel Jezierska, Merilen Laurimäe, Miriam Lehari, Katre Pall, Markus Nopason, Hede Sinisaar.

Õigusliku analüüsi tegi Merle Malvet. Töö valmimisse on andnud olulise panuse: Kristi Rekand, Kristi Kähär, Tauno Asuja, Ann Gertrud Norberg, Eveliis Padar, Veronika Kaska ja Daniel Kotsjuba.

Väljaande autoriõigus kuulub mõttekojale Praxis. Väljaandes sisalduva teabe kasutamisel palume viidata allikale.

Viitamine: Jezierska, I. M., Laurimäe, M., Lehari, M., Pall, K., Nopason, M. ja Sinisaar, H. (2026). Uuring täisealiste puude raskusastme tuvastamise lõpetamisest ja puudega seotud toetuste ning hüvede ümber korraldamisest. Uuringu aruanne. Tallinn: Mõttekoda Praxis.

Uuringu tellija Sotsiaalministeerium. Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi 2021–2027 perioodi toetuse andmise tingimuste "Pikaajalise hoolduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine" vahenditest (SFOS 2021–2027.4.09.23-0002).

Sisukord

Mõisted ja lühendid	5
1. Metoodika ja rollijaotus	6
1.1. Eksperdiintervjuud	6
1.2. Individuaalintervjuud	6
1.3. Töötoad	7
1.4. Andmeanalüüs	8
2. Sissejuhatus ja uuringu eesmärk	12
3. Puude mõiste	14
3.1. Puude mõiste filosoofilises kirjanduses	14
3.2. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon	15
3.3. Puude mõiste Eesti seadusandluses	16
3.4. Puuetega inimeste ja esindusorganisatsioonide vaade	19
4. Eesti praegune süsteem	21
5. Puude, töövõime ulatuse ja abivajaduse tuvastamise metoodikad	23
5.1. Töövõime hindamine ja puude raskusastme tuvastamine tööelistel inimestel	23
5.2. Puude raskusastme tuvastamine vanaduspensioniealisel inimesel	27
5.3. Abivajaduse hindamine	28
5.4. Hindamiste andmete kasutamine muudes teenustes	30
6. Kitsaskohad praeguses süsteemis ja ootused süsteemile ekspertide hinnangul	31
6.1 Kitsaskohad süsteemi/ametnike vaates	32
7. Puuetega inimeste toimetulek, vaesus ja teenuste vajadus	35
8. Puuetega inimeste kogemused ja ootused süsteemile	40
8.1. Ootused ja hinnangud süsteemile ja ühendamisele	40
8.2. Kitsaskohad taotleja vaates	43
Kitsaskohad metoodikas ja aluspõhimõtetes	43
Kitsaskohad kliendikogemuses	47
9. Välisriikide praktikad	53

9.1. Soome	53
9.2. Rootsi	56
9.3. Holland	58
9.4. Lähiriikide reformid	60
10.Sihtrühmade ülevaade	63
10.1.Puudega ja vähenenud töövõimega tööelised inimesed	63
10.2. Puudega vanaduspensioniealised inimesed	93
11.Lahendused	105
11.1. Väärtused, millest hindamine peaks lähtuma	105
11.2.Eeldused, mida süsteemi muutmine peaks täitma	106
11.3.Teekond 1 – üks hindamine töötukassas, riik ei tuvasta puude raskusastet	109
11.3.1. Tööelised inimesed	109
11.3.1. Vanaduspensioniealised inimesed	123
11.4.Teekond 2 – Tervishoiukeskne	129
11.5.Teekond 3 – puude tuvastamine asendatakse abi- ja toetusvajaduse hindamisega KOV-is	133
11.6.Kokkuvõtte lahendusettepanekutest	139
12.Persoonad	141
13.Terviklahendused	149
13.1.Lahendus A – puuetega inimeste toetamise süsteemi lihtsustamine	149
Lahenduse A mõjud	151
13.2. Lahendus B – süsteemi lihtsustamine ja puuetega inimeste majandusliku toimetuleku parandamine	158
Lahenduse B mõjud	158
13.3. Lahendus C - teenuste kättesaadavuse tagamine	161
Lahenduse C mõjud	161
13.4. Võimalikud riskid ja nende maandamismeetmed	165
13.5. Kooskõla võetud rahvusvaheliste kohustustega	166
Kokkuvõtte ja soovitused	169
Lisad	173

Lisa 1 – Lühikokkuvõtted	173
Lisa 2 – Puude mõiste ja puude tuvastamisega seotud rahvusvahelised kohustused	173
Lisa 3 – Toetused, teenused ja muud soodustused	177
Lisa 4 – Kulumudel	181
Lisa 5 – Täiendavad statistilised andmed ja selgitused	182
Lisa 6 – Hüvede ümberkorraldamine ja nendega seotud kulude muutus	184
Kasutatud kirjandus ja õigusaktid	187

Mõisted ja lühendid

EL – Euroopa Liit

EPIK – Eesti Puuetega Inimeste Koda (ka *EPIKoda*)

EUROMOD – Eesti rahvastikupõhine maksude ja toetuste mikrosimulatsiooni mudel

Eurostat – Euroopa Statistikaamet

IT – Infotehnoloogia

KELA – Soome sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Institution of Finland)

KOV – kohalik omavalitsus

PISTS – puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus

PIK – puudega isiku kaart

RFK – rahvusvaheline funktsioonipiirangute klassifikaator

RHK – rahvusvaheline haiguste klassifikaator

SHS – sotsiaalhoolekandeseadus

SKA – Sotsiaalkindlustusamet

SRT – sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

STAR – sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregister

STS – stsenaarium

TIS – terviseinfosüsteem

TRT – täieliku või raske piiranguga inimese toetus

TVTS – töövõimetoetuse seadus

Töötukassa (TK) – Eesti Töötukassa

VõrdKS – võrdse kohtlemise seadus

WHO – Maailma Terviseorganisatsioon (World Health Organization)

ÜRO – Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (United Nations)

1. Metoodika ja rollijaotus

Mõttekoda Praxis vastutas analüüsi metoodika ja läbiviimise eest, viis läbi dokumendianalüüsi, eksperdiintervjuud, intervjuud puuetega inimestega, andmeanalüüsi, EUROMOD-i simulatsioonid ning mõjude hindamise. Praxis vastutas ka raporti kirjutamise ning kommunikatsiooni eest tellijaga.

EPIK värbas töötubades osalejad ja korraldas ruumid, toitlustuse jms töötubade läbiviimiseks. EPIK osales süsteemi praeguste kitsaskohtade kirjeldamisel, lähiriikide reformide kirjeldamisel, viis läbi intervjuud lähiriikide ekspertidega ning konsulteeris analüüsi ja lahenduste pakkumist.

Analüüsi kaasasime teenusedisaineri, kes aitas töötubade ettevalmistuse ja kommunikatsiooniga. Õigusekspert koostas ülevaate rahvusvahelistest õigusaktidest ning kohustustest, millega Eesti on seotud puuetega inimestele abi ja toetuse pakkumisel, ja analüüsis lahenduste õiguslikke mõjusid.

1.1. Eksperdiintervjuud

Uuringus tehti 3 eksperdiintervjuud Sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja Eesti Töötukassa (töötukassa) ekspertidega, sh kahe ekspertarstiga. Intervjuud viidi läbi veebis Teamsi kaudu, salvestised transkribeeriti.

EPIK viis läbi kaks intervjuud Läti ja Leedu ekspertidega nende riikide hiljutiste reformide ja nende mõjude teemal.

1.2. Individaalintervjuud

Uuringus tehti 11¹ individaalintervjuud tööealiste inimestega, kellel on tuvastatud puude raskusaste, aga ei ole tuvastatud töövõime vähenemist. Need on inimesed, kes võivad reformiga sattuda halvemasse olukorda. Intervjuudesse ei hõlmatud inimesi, kellele on määratud püsiv töövõimetus² vanaduspensioni eani, kuna koos töövõimetuspensioniga töövõimetoetust ei maksta. Intervjueeritavate värbamiseks kasutati SKA registriandmeid.

¹ Uuringu pakkumuses lubati teha 10 intervjuud. Intervjuude peamiseks eesmärgiks oli mõista, mis puude raskusastmega inimestel ei ole tuvastatud vähenenud töövõimet. Esialgu hinnati sihtgruppi kuuluvate inimeste arvuks ligikaudu 900 inimest. Analüüsis selgus, et neist umbes 700 inimest on püsiva töövõime kaotusega töövõimetuspensioni saajad ning seetõttu ei saa nad töövõimetoetust. Seega jäi sihtgrupi suuruseks 218 inimest, kellest omakorda 168 on Euromodi andmetel muu pensioni saajad, kellel samuti puudub õigus töövõimetoetusele. Seega sihtgrupp, kellele oleks õigus saada lisaks puudega inimese toetusele ka töövõimetoetust, kahanes 50 inimeseni.

² Kuni 1. juulini 2016 hindas Sotsiaalkindlustusamet püsivat töövõimetoetust ja maksis töövõimetuspensioni kui töövõimetus kaotuse korral vahemikus 40–100%.

Valimisse kaasati eri puudeliikide (liikumis-, kuulmis-, nägemis- ja kõnepuue) ja puude erineva raskusastmega inimesed. Kaasati nii eesti- kui ka venekeelseid intervjuueeritavaid.

Intervjuueeritavatega võeti esmalt ühendust e-postiga ning intervjuud tehti viidi läbi telefonitsi või veebis teel. Intervjuu salvestiste põhjal tehti RAP-lehed, mille alusel koostati analüüs. Kaks inimest (kuulmis- ja kõnepuudega) vastasid küsimustele kirjalikult.

Kokku intervjuueriti kaht kuulmis-, kaht nägemis-, üht kõne- ning kuut liikumispuudega inimest. Kaks intervjuud olid venekeelsed ning kaks intervjuueeritavat olid mehed.

1.3. Töötoad

Uuringu läbiviimisel lähtusime põhimõttest, et puuetega inimesed on oma kogemuse eksperdid ning neid puudutavaid probleeme tuleb sõnastada ühes nendega. Puuetega inimeste sisuliseks ja tähenduslikuks kaasamiseks on oluline, et sisendit kogutakse nii probleemi mõistmisel, ettepanekute kogumisel kui ka võimalike lahenduste analüüsimisel.

Töötubades kaardistasime tänase töövõime ja puude tuvastamise praeguse süsteemi kitsaskohad ja töötasime da välja lahendused õiglasemaks, selgemaks ja inimesele sõbralikumaks süsteemiks. Samuti analüüsisime süsteemi erinevate muudatuste mõjusid sihtrühma vaatest.

Viisime läbi üheksa töötuba puude- või haigusspetsiifiliste organisatsioonide ja erinevate puuetega inimeste esindajatega. Kolm töötuba toimus tööealiste inimeste esindajate ja kolm vanaduspensioniealiste esindajatega. Lisaks toimus kaks töötuba vaegkuuljate ja kurtidega, kus olid esindatud nii vanaduspension- kui ka tööealsed. Töötoas osalejad olid EPIKu võrgustikust, neile lisandus kolm organisatsiooni väljaspoolt. Kokku osales töötubades 47 inimest³, enamik neist tööealsed. Esindatud olid erinevad Eesti piirkonnad, maa- ja linnaelanikud, naised ja mehed. Osalesid kõikide puudeliikide esindajad (intellekti- ja psüühikahäire, liikumis-, nägemis-, kuulmis- ja kõnepuue).

Üks töötuba viidi läbi poliitikakujundajate ja ametnikega. Töötuppa olid kaasatud Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiits- ja Digiministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Siseministeeriumi, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi, Õiguskantsleri kantselei, töötukassa ja SKA esindajad. Lisaks osalesid töötoas EPIKoja ja tema liikmesorganisatsioonide esindajad.

Töötoad olid üles ehitatud järjestikuste sammudena. Esimeses keskendusime probleemide kaardistamisele ja puude tuvastamise mõtestamisele, teises töötasime välja võimalikke lahendusi ja teekondi, tuginedes nii kogemusele kui ka teiste riikide headele näidetele. Kolmandas töötoas arutasime võimalikke alternatiive praegusele süsteemile. Teekonnad

³ Oli inimesi, kes ei osalenud kõigis kolmes töötoas, mõned osalesid ühes või kahes.

koostati teiste analüüsitud riikide näidete, töötubadest tulnud ideede ja ekspertintervjuude sisendi põhjal, lisaks konsulteeriti teekondade koostamisel uuringu tellijaga.

Poliitikakujundajate ja ekspertide töötoas arutati praeguse süsteemi alternatiivide ja nende rakenduslikkuse üle.

Osalejad värbas Eesti Puuetega Inimeste Koda oma võrgustiku kaudu, välja arvatud poliitikakujundajate ja ametnike töötoas, kus osalejate valimi koostamisel osales ka uuringu tellija. Töötoad toimusid oktoobris ja novembris 2025.

Töötoad kestsid 3–5 tundi ja olid üles ehitatud struktureeritud arutelude vormis. Töötubade ettevalmistuses osalesid EPIKoja eksperdid, mõttekoja Praxis analüütikud ja sotsiaalse disaini ekspert Daniel Kotsjuba.

1.4. Andmeanalüüs

Registriandmete analüüs on vajalik, et saada vähenenud töövõime ja/või puudega tööealiste ja vanaduspensioniealiste inimeste ülevaade, anda alus kulumudelile ning hinnata inimeste väljumist või liikumist süsteemis, töövõime hindamise skeemi uute lahenduste korral. Kvantitatiivse analüüsi peatüki üks ülesannetest oli ka analüüsida alarühmade kattuvust ja suuruset. Selleks loodi neli alarühma, kes võiksid oletuslikult uute lahenduste puhul olla enim mõjutatud:

1. Üksnes vähenenud töövõime, puuet ega püsivat töövõimetust ei ole;
2. Üksnes puue, töövõime vähenemist ega püsivat töövõimetust ei ole;
3. 2024. aasta jooksul vähemalt ühel päeval puue ja töövõime vähenemine, püsivat töövõimetust ei ole;
4. 2024. aasta jooksul puue ja püsiv töövõimetust.

Kuna samaaegselt puue ja töövõime vähenemine defineeriti vähemalt ühepäealise kattuvusega, osutus vajalikuks ka viies alarühm, inimesed, kellel oli 2024. aasta jooksul eri aegadel puue ja töövõime vähenemine. Ühendada nad ühegi teise sihtrühmaga oli põhjendamatu, sest nende taustatunnuste profiil erines teistest rühmadest (vt lisaks 8.1 peatüki eri aegadel puue ja vähenenud töövõime osa). Alarühmad on määratletud vastastikku välistavatena, st iga inimene kuulub analüüsis ainult ühte alarühma.

Sihtrühmade kirjeldavas statistikas on kasutatud 2024. aasta töötukassa ja SKA registriandmeid. Töötukassa andmetest on kasutusel taustatunnused (sugu, sünni- ja surmaaasta, maakond), töövõime ulatus, diagnoos, töötuskindlustushüvitise, töötutoetuse ja töövõimetoetuse maksed, teenuste kasutamine ja maksumus. SKA andmetest on kasutusel sugu, sünni- ja surmaaasta, maakond, puude raskusaste, puude liik, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse (SRT) saamine ja maksumus, puhkusetasu hüvitis ning abivahenditoetuse hooldajatoetuse ja toimetulekutoetuse maksed. Samuti olid ka andmed

töövõimereformieelse püsiva töövõimetuse ja töövõime kao kohta, aga ainult inimestele, kellel oli ka puue. Andmestike kokku viimisel kasutati mõlemale andmestikule ühiste tunnuste puhul selle andmestiku andmeid, mis olid detailsemad. Näiteks töötukassa andmetes olid sünnid esitatud päeva täpsusega, aga SKA andmetes kuu täpsusega. Registriandmetele lisaks on kasutatud ka Statistikaameti rahvaarvu ja rahvastiku koosseisu avaandmeid, et võrrelda uuritavaid alarühmasid ülejäänud rahvastikuga.

Lisaks kasutati sihtrühmade kirjelduses ning nende probleemide ja vajaduste analüüsimiseks erinevate uuringute andmeid. Eelkõige kasutati Eesti Sotsiaaluuringu 2016–2024 andmeid, kuid ka Turu-uuringute AS-i läbi viidud elanikkonna tegevuspiirangute uuringu 2020 ja 2025 andmeid. Lisaks kasutati ka Statistikaameti tööturu rakenduse ja Eurostati avaliku andmebaasi andmeid.

Registriandmete analüüs ja statistika oli aluseks ka **kulumudeli** loomisel. Võttes aluseks puuetega inimeste sotsiaaltoetuse ja töövõimetoetuse saajate arvud 2024. aastal ja toetuste suurused 2025. aastal, leiti kuluhinnangud muutunud oludes eri teekondade ja stsenaariumite korral. Toetuste puhul oli eeldatud, et kõik toetustele kvalifitseeruvad inimesed ka taotleavad neid (ka uusi või integreeritud toetuseid). Kulumudel on Exceli põhine lihtsustatud mudel, kus on iga stsenaariumi korral leitud uus toetuse saajate arv toetuse astmete lõikes (nt madalam toetus, kõrgem toetus) ning see korrutatud vastava uue toetuse kuumääraga ja seejärel 12-ga (aastane toetuse summa). Seejärel võrreldakse stsenaariumi aastaseid kogukululusid baasstsenaariumiga ehk 2025. aasta eeldatavate kuludega praeguste toetuste tingimuste juures. Kuna osade stsenaariumite korral integreeritakse puuetega inimeste sotsiaaltoetus töövõimetoetusega, siis kulude võrdlemisel analüüsitakse nii töövõimetoetuse kululusid kui ka puuetega inimeste sotsiaaltoetuse kululusid. Kulumudelis on esitatud ka arvutused, kuidas töövõimetoetuse päevamäär mõjutab aprilli alguses toimuv indekseerimine (pensioniindeksi prognoosi aluseks on rahandusministeeriumi pikaajaline prognoos). Samuti on kulumudelis esitatud arvestus, kuidas täisealiste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste (PISTS) kulu n-ö vabaneb arvestades puude raskusastme kehtivuse otsuseid. Osade stsenaariumite korral makstakse uut toetust tegevuspiirangu alusel. Kuna päritud registriandmetes ja ka EUROMOD-is puudub informatsioon tegevuspiirangute kohta, siis on sellisel juhul võetud aluseks varasemad uuringud tegevuspiirangute ja puude raskusastme kombinatsioonide kohta ning selle põhjal tehtud eeldused, milline puude raskusaste (keskmine, raske, sügav) võiks vastata millisele tegevuspiirangu astmele (mõõdukas, raske, täielik piirang). Täpsemad stsenaariumid on esitatud mõjude analüüsi osas ning seosed piirangu ja puude raskusastme ning töövõime ulatuse vahel on toodud välja Lisas 4.

Poliitikamuudatused toovad kaasa muutused **tööjõukuludes** – kui puude tuvastamine kaob või integreeritakse töövõime hindamisega, siis puudega seotud hindamiste ja taotluste menetlemise kululusid ei ole. Tööjõukulude kokkuhoiu või muutusega seotud analüüsil on tuginetud SKA 2024. aasta tegelikele tööjõukulude statistikale ning uuringus „Andmepõhise

personaliseerituse potentsiaali ja mõjude hindamine sotsiaal- ja haridusvaldkonna avalikes teenustes ja toetustes (Arrak *et al.*, 2024)“ analüüsitud töötukassa toetuste menetlemise tegelike kuludega. Detailsem analüüs sõltub teekonnast ning on kirjeldatud iga teekonna mõjude analüüsi osas.

Analüüsi käigus välja pakutud poliitikamuudatused toovad kaasa ka täiendavad **arenduskulud** IT tegevustele. Täpseid arenduskulusid ei ole selle uuringu raames võimalik arvutada, kuid välja on toodud hinnangulised kuluvahemikud. Kuluvahemike leidmisel tugineti uuringus „Andmepõhise personaliseerituse potentsiaali ja mõjude hindamine sotsiaal- ja haridusvaldkonna avalikes teenustes ja toetustes (Arrak *et al.*, 2024)“ hinnatud arendustööde kuludele, sama uuringu jaoks töötukassalt päritud sisendile seoses töötukassa toetuste ja teenuste arendustega ning viidud need tänasesse väärtusesse, võttes arvesse palgakasvu. Siiski tuleb arvestada, et tegemist on hinnanguliste väärtustega ning sõltuvalt lahendusest, tööde teostajast ja muudest aspektidest võivad kulud olla erinevad (vt eelduseid ja piiranguid ka Arrak *et al.*, 2024). Arrak *et al.* (2024) uuringus välja toodud arenduskulud on kategoriseeritud järgnevalt:

- väike kulu: arendusele kuluv aeg on u 1–3 nädalat, maksumus u 3000–12 000 eurot (nt töötuskindlustushüvitise maksimaalse määra langetamine);
- keskmine kulu: arendusele kuluv aeg on u 1–3 kuud, maksumus u 12 000–36 000 eurot (nt üksikvanema lapse toetusele ülempiiri kehtestamine);
- suur kulu: arendusele kuluv aeg u 4–12 kuud, maksumus u 36 000–150 000 eurot (nt peretoetuste viimine ühe toetuse alla, töötutoetuse automaatne maksmine);
- väga suur kulu: arendusele kuluv aeg 1+ aastat, maksumus u 150 000 – 1 mln või rohkem eurot (nt koolikohtade sobitusmehhanismi loomine).

Siinses uuringus võeti aluseks Arrak *et al.* (2024) kategooriad, kuid teisalt kombineeriti neid ka töötukassa varasemate arenduste tegelike kuludega (pigem suur kulu või väga suur kulu kategooriates) ja palgakasvuga.

Täiendavalt kasutati sihtrühmade kirjeldamiseks ja teekondade mõjude hindamiseks **EUROMOD maksude- ja toetuste mikrosimulatsioonimudelit** ja selle registripõhiseid kogu elanikkonda hõlmavaid 2024. aasta sisendandmeid (vaatluste arv kokku 1,37 miljonit). Sihtrühmade kirjeldamisel tugineti EUROMOD andmestikule nende taustatunnuste osas, mida päritud registriandmetes ei olnud või oleksid nõudnud täiendavate registrite kaasamist (sh haridustase, elukoha piirkond (linn/maa), ka hoolekandeaustuses elamine kodakondsus, sotsiaalmajanduslik seisund (töötamine, pensioni saamine, peretoetuste saamine), töötamise korral inimese tegevusvaldkond, ametiala). Lisaks annab EUROMOD täiendavat informatsiooni inimese leibkonnaliikmete olemasolu ja nende sissetulekute ning kokkuvõttes leibkonna vaesusriski kohta. EUROMOD-i kasutati teekondade ja nende eri stsenaariumite (nt eri toetuse suurused) mõju hindamiseks puude raskusastmega ja

vähenenud töövõimega leibkondade vaesusele. Lisaks hinnati EUROMOD-iga stsenaariumite mõju riigi kuludele võrdlusena kulumudeli põhjal leitud summadega, et neid valideerida. Analüüsis kasutati kõige uuemaid EUROMOD aastaseid registriandmeid (2024), mis on hinnakasvu ja muid muudatusi (nt puuetega inimeste sotsiaaltoetuse tõus 2025. aastal, töövõimetoetuse indekseerimine) arvesse võttes viidud 2025. a väärtustesse. Muudatuste mõjude hindamisel vaesusele on eeldatud, et muudatused toimuksid koheselt 2025. aastal ja muud praegu kehtivad poliitikareeglid jääksid muutumatuks. Mõju vaesusele ei saa EUROMOD-is hinnata järk-järguliselt (üleminekuperiood), sest EUROMOD-is puudub informatsioon toetuste lõppemiste (kehtivuste) kohta ning on teada üksnes aasta jooksul saadud toetuse summa. Samuti muutuks hinnang pikas perioodis ebatäpseks, sest vaesuse näitajat mõjutavad ka paljud muud tegurid (sh nt alampalga muutus). Toetuste puhul on eeldatud, et kõik toetustele kvalifitseeruvad inimesed taotleavad neid. Suhtelise vaesuse määr on leitud eraldi nii tööealiste stsenaariumite kui ka vanaduspensioniealiste stsenaariumite korral, aga ka terviklahendusest lähtuvalt. Vaesuse määra arvutamisel tuleb siiski pidada meeles, et tegemist on leibkonna sissetulekut arvestava näitajaga. Seega kui ühes leibkonnas on eri sihtrühmast või vanuserühmast (tööealine ja vanaduspensioniealine) või eri puude raskusastmega inimesi, siis on mõju vaesuse näitajale selles leibkonnas kombineeritud (nt ühel leibkonnaliikmel sissetulek kasvab, teisel väheneb, siis kokkuvõttes mõju puudub).

Persoonade näol on tegemist üldistustega, mis aitavad kirjeldada vähenenud töövõimega ja puuetega inimeste sihtrühmi ja mustreid. Registriandmete ja intervjuude analüüsi põhjal loodi kokku **kaheksa persoonat**, mis kirjeldavad peamisi sihtrühma esindajaid tööealiste vähenenud töövõimega ja puuetega inimeste seas (neli sihtrühma, igaühe kohta kaks persoonat). Persoonade loomisel kombineeriti erinevaid meetodeid, sh klasteranalüüs, statistilised jaotused ja sagedustabelid erinevaid sihtrühmi iseloomustavate taustatunnuste osas, kuid võeti arvesse ka erinevusi sihtrühmade vahel, et vastavaid gruppe ja nendevahelisi erinevusi paremini kirjeldada. Klasteranalüüs viidi läbi tervele tööealiste valimile Goweri kaugusel põhineva k-medoidide meetodiga (PAM), kasutades sisendtunnustena sugu, vanuserühma, puude raskusastet ja töövõime ulatust. Intervjuude ja töötubade tulemused aitasid samuti neid mustreid ja rühmi elulisemate näidetega täiustada.

2. Sissejuhatus ja uuringu eesmärk

Pikaajalise tervisekahjustusega inimestele pakub Eesti sotsiaalkindlustussüsteem kaitset nii sellest tuleneva sissetuleku puudumise või vähenemise eest kui ka puudest või piirangutest tulenevate lisakulude katmiseks. Töövõimetoetus tagab asendussissetuleku vähenenud töövõimega inimestele. Inimestele, kellel on tuvastatud puude raskusaste, makstakse lisakulude osaliseks kompenseerimiseks puuetega inimeste toetusi. Kui mitmetes riikides on puue (*disability*) võrdsustatud vähenenud töövõimega, siis Eestis ei käsitleta puuet vähenenud töövõimena, vaid oluliselt kitsamalt. Paljud hüved ja soodustused on mõeldud inimestele, kellel on tuvastatud puue, kusjuures mõned soodustused on seotud konkreetse puudeliigi (eelkõige liikumispuue, nägemispuue) ja raskusastmega, mistõttu on selles uuringus mõnevõrra suurem fookus nendel. Töövõimetoetust maksab Eesti Töötukassa (TK või töötukassa) osalise või puuduva töövõime tuvastamise otsuse alusel, puuetega inimeste sotsiaaltoetusi maksab Sotsiaalkindlustusamet (SKA) tuvastatud puude raskusastme alusel. Mõlemad süsteemid hindavad inimese funktsioonipiiranguid ja vajadusi, kasutades sarnaseid terviseandmeid ning SKA toetub oma otsustes töötukassa antud hinnangutele.

Süsteem, kus pikaajalise tervisekahjustusega tööealistele inimestele määratakse ja makstakse toetusi kahe asutuse poolt, on dubleeriv nii inimestele kui riigiasutustele. Tööealistel inimestel võib olla keeruline orienteeruda kahes süsteemis ning TK ja SKA teevad dubleerivaid tegevusi, millega kaasnevad personalikulu, majanduskulu, IT süsteemide arendus- ja halduskulud. IT süsteemide arendusi tuleb teha korraga kahes asutuses, mida on keeruline ühildada. Kokkuvõttes on see riigi vaates ebaefektiivne.

Vanaduspensioniealistel inimestel tuvastatakse üksnes puude raskusaste. Puude tuvastamise taotlemine võib muuhulgas olla ajendatud puudega kaasnevatest õigustest ja soodustustest.

Riigikontroll on erivajadusega inimeste toetamist käsitlevas auditis (Riigikontroll, 2024) välja toonud, et sotsiaalhoolekandelse abi saamise süsteem ei moodusta loogilist tervikut, abi saamine on inimese jaoks keeruline ja ebaefektiivne ning toetuste ja teenuste saamiseks peab inimene laskma hinnata oma olukorda korduvalt. Lahendusena dubleerivatele hindamistele pakub audit välja kahe sarnase ja paralleelse süsteemi ehk töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise liitmise ühtseks tegutsemisvõime hindamiseks. Riiklike süsteemide koondamist on soovitatud ka töövõime toetamise süsteemi mõju hindamise uuringus (Kallaste *et al.*, 2022).

Uuringu eesmärk on hinnata ja pakkuda välja lahendusi täisealiste inimeste puude raskusastme korralduse muutmiseks, analüüsida võimalusi ühtse süsteemi loomiseks ning ühe hindamise sisseviimiseks tööealistele inimestele. Lahendused ei saa halvendada puuetega inimeste olukorda, arvestades, et puuetega inimeste suhtelise vaesuse määr Eestis

on märkimisväärselt kõrgem elanikkonna vaesuse määra. Lisaks vaesusriskile takistavad puuetega inimestel teistega võrdväärset ühiskonnaelus osalemist teenuste kättesaamatus, vähene ligipääsetavus jm ebasoodsad tegurid.

Samuti on vaja arvestada rahvusvahelisi kohustusi, mille keskmes on puuetega inimeste õigused, heaolu ja teenuste kättesaadavus. Uuringu lahendusettepanekute väljatöötamise eesmärgiks on vähendada süsteemide killustatust, muuta toetuse saamine arusaadavamaks ning tagada asjakohasem tugi nii tööeliste kui vanaduspensionistidele inimestele. Lahendused hõlmavad hindamist, toetuste maksmist ning puuetega inimestele antavaid soodustusi ja hüvesid, tagades, et puuetega inimeste õigused, toetused ja hüved oleksid ka uues süsteemis tagatud. Uuringuga tuvastatakse sihtgrupi ootused ja tänased katmata vajadused.

3. Puude mõiste

Puue on mitmekülgne mõiste, mille tähendus ja kasutus sõltuvad kontekstist: õigusest, poliitikast, kultuurist, teadusest ja inimeste igapäevasest kogemusest. Puue ei ole ainult juriidiline termin, vaid ka viis kirjeldada inimese suhet ümbritseva keskkonna ja ühiskonnaga. Puude käsitus mõjutab otseselt nii poliitikavalikuid kui ka puuetega inimeste õiguste tegelikku kaitset.

Puude mõistega on seotud ka rahvusvahelised raamistikud, millest tulenevad Eestile õiguslikud kohustused. Riigid mõistavad, määratlevad ja mõõdavad puuet erinevalt ning need erinevused kujundavad ühiskonna arengut ja sotsiaalkaitstesüsteeme. Seetõttu on puude riikliku tuvastamise lõpetamine oluline süsteemimuutus.

Peatükk tugineb teaduskirjandusele, uuringu raames toimunud töötubadele, ekspertintervjuudele ja juriidilisele analüüsile.

3.1. Puude mõiste filosoofilises kirjanduses

Puuet puudutavas filosoofiliste arutelude keskmes on kolm põhiküsimust (Wasserman & Aas, 2023):

- **Ontoloogiline:** Kas puue on indiviidi omadus (meditsiiniline mudel) või sotsiaalne suhe (sotsiaalne mudel)?
- **Epistemoloogiline:** Kelle teadmine puudest on autoriteetne – kas meditsiinieksperptide "objektiivne" vaade või puuetega inimeste endi "subjektiivne" elukogemus?
- **Poliitiline:** Kuidas tagada õiglus – kas ressursside ümberjaotamise või erinevuse tunnustamise kaudu?

Meditsiiniline vaade käsitleb puuet indiviidi bioloogilise või psühholoogilise defektina ning suunab tähelepanu indiviidi korrigeerimisele, depolitiseerides seeläbi puude kui sotsiaalse nähtuse. Sotsiaalne mudel nihutab fookuse indiviidilt ühiskonnale, mõtestades puuet sotsiaalse suhte ja struktuurse tõrjumise tulemusena ning rõhutades materiaalsete ja institutsionaalsete barjääride rolli. Feministlikud lähenemised täiendavad sotsiaalset mudelit, tuues esile vastastikuse sõltuvuse, hoolesuhete ja haavatavuse kui inimkogemuse keskse mõõtme. Kriitiline teooria vaidlustab omakorda nii meditsiinilise kui ka sotsiaalse mudeli eeldusi, käsitledes puuet diskursiivse ja institutsionaalse võimukorralduse tulemina ning seades kahtluse alla selge piiri bioloogilise ja sotsiaalse vahel. Viimaks seob inimõiguste perspektiiv puude sotsiaalse mõtestamise universaalsete õiguste raamistikuga, käsitledes puuet mitte kõrvalekalde, vaid identiteedina, mis toimib õiguste kandjana. Siiski on oluline märkida, et ükski neist teoreetilistest vaadetest ei ole saavutanud universaalset heakskiitu, vaid need on jätkuva kriitilise arutelu keskmes.

Siiski lähtuvad kaasaegsed puude käsitleused (Wasserman & Aas, 2023) puude määratlustest, mis võtavad arvesse nii selle meditsiinilist kui ka sotsiaalset mõõdet, ning rõhutavad, et puude mõistmiseks on olulised nii meditsiinieksperptide nn objektiivne vaade kui ka puuetega inimeste endi elukogemusel põhinev vaade. Sellest lähtuvalt seotakse puue õigluse küsimusega, tuues esile, et puuetega inimesed kogevad samaaegselt nii majanduslikku ebavõrdsust kui ka sotsiaalset tõrjumist ning et õiglane ühiskond peab tagama neile nii majandusliku toimetuleku kui ka sotsiaalselt võrdsed õigused teiste ühiskonnaliikmetega. Selline kahemõõtmelise õigluse kontseptsioon toob endaga kaasa avalikus elus dilemma puuetega inimesele. Toetuste saamiseks peab inimene sageli tõestama oma meditsiinilist "puudujääki", mis on aga stigmatiseeriv. Selleks, et inimest tunnustataks teistega võrdse kodanikuna, peab inimene rõhutama oma võimed ja panustamist ühiskonda, näitamine võib teiselt poolt ohtu seada tema toetuste saamise võimalused.

3.2. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon

[Puuetega inimeste õiguste konventsiooni](#) eesmärk on kaitsta ja edendada puuetega inimeste inimõigusi ning tagada nende täielik ja võrdne osalemine ühiskonnas. Konventsioon kohustab riike astuma vajalikke samme puuetega inimeste õiguste edendamiseks ja toimetuleku parandamiseks, teadlikkuse suurendamiseks, toetuste, teenuste ja muu abi kättesaadavuse tagamiseks. Seega on konventsioonist tulenevate õiguste ring lai ning puudutab kõiki puudest tulenevaid olukordi nagu näiteks võrdsus ja mittediskrimineerimine, inimväärikus, õigus ise teha oma valikuid, olla kaasatud, sõnavabadus, juurdepääsetavus, õigus haridusele, tervishoiule, tööle jne.

Konventsioon ei sätesta, kuidas peaks riigid puuet defineerima või määrama. Konventsioon lähtub arusaamast⁴, et puue on „arenev kontseptsioon, mis tuleneb puuetega inimeste vahelisest suhtlusest ning hoiakulistest ja keskkonnaalastest barjääridest, mis takistavad nende inimeste täielikku ja tõhusat osalemist ühiskonnas teistega võrdsetel alustel” (ÜRO, 2006).

Konventsioon hõlmab inimesi, kellel on pikaajaline füüsiline, vaimne, intellektuaalne või meeleline kahjustus, mis võib koostoimel erinevate takistustega tõkestada nende täielikku ja tõhusat osalemist ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel (konventsiooni artikkel 1).

Riigi õigusaktide alusel on puude tuvastamisel praktiline tähendus, kuid see ei piira konventsiooniga kaitstud inimeste ringi. Konventsioon on inimõiguste instrument, mis keskendub osaluspiirangutele, ühiskondlikele takistustele ja tugivajadustele laiemalt,

⁴ Puuetega inimeste kontseptsiooni erinevate käsitluste kohta vt nt Statistikaameti 2014. aasta väljaanne „[Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine](#)“, lk 6–9.

sealhulgas hoiakutele, teenuste korraldusele ja õiguslikele piirangutele (vt Waddington & Priestley, 2021).

Lisaks puuetega inimeste õiguste konventsioonile on Eesti võtnud kohustused, mis tulenevad [parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta](#) ning [Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksist](#). Sotsiaalharta näeb ette, et riigid peavad astuma samme, et tagada puuetega inimestele õigus elada iseseisvalt, sotsiaalselt integreeruda ja võtta osa ühiskonna elust. Selleks peavad nad rakendama meetmeid puuetega inimeste hariduslike õiguste ja tööalaste õiguste edendamiseks ning ka laiemalt puuetega inimeste sotsiaalseks integreerumiseks ning osavõtuks ühiskondlikust elust. Riik peab võtma meetmeid puuetega inimeste suhtlemis- ja liikumistakistuste ületamiseks ning transpordi, eluaseme ja kultuuritegevuse ning vaba aja veetmise võimaluste kättesaadavuse tagamiseks. Kui puuetega inimesed elavad vaesuses, siis piirab see nende võimalusi elada iseseisvalt, sotsiaalselt integreeruda ja võtta osa ühiskonna elust piiratud. (sotsiaalharta artiklid 15 ja E).

Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks kehtestab sellega ühinenud riikidele miinimumstandardid üheksas sotsiaalkindlustuse valdkonnas, neist üks (IX osa) käsitleb invaliidsushüvitise seonduvat. Invaliidsushüvitise eesmärk on tagada vähenenud töövõimega inimesele elatusvahendid ehk sissetulek (koodeksi artikkel 55). Eesti mõistes vastab invaliidsushüvitisele töövõimetoetus.

Puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamisel on soovitatud puude tuvastamisel kasutada Maailma Terviseorganisatsiooni poolt vastu võetud rahvusvahelise funktsioneerimisvõime klassifikatsiooni (RFK) (vt WHO, 2001; ÜRO, 2022, lk 15). Puuetega inimeste õiguste konventsioon, sotsiaalharta ega sotsiaalkindlustuskoodeks ei nõua aga seda, et kõik riigid peavad puude tuvastama ainult ühel kindlal viisil. Sellegipoolest ei ole konventsiooniga kooskõlas ainult või eelkõige meditsiinilistel näidustustel põhinev puude tuvastamine (vt Lisa 2).

Täpsem ülevaade rahvusvahelistest kohustustest ning nende täitmisest on toodud aruande Lisas 2.

3.3. Puude mõiste Eesti seadusandluses

Eestis on puude mõiste määratletud eeskätt kahes seaduses: võrdse kohtlemise seaduses ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses.

[Võrdse kohtlemise seaduse](#) (VõrdKS) tähenduses on puue inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millel on oluline ja pikaajaline ebasoodus mõju igapäevatoimingute sooritamisele (VõrdKS § 5).

[Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses](#) (PISTS) on kehtestatud puude õiguslik termin. Erinevalt õiguslikust kontseptsioonist, mis on laiem õigusnormide teoreetiline raamistik, on

õigusterminil kitsas, täpselt määratletud tähendus, mille eesmärk on vältida mitmeti mõistmist või ebamäärasust. Õiguslik termin võib olla erinev filosoofilisest mõistest või inimeste igapäevasest keelekasutusest.

Õigusliku termini kasutamine tuleneb sellest, et PISTS alusel makstakse puuetega inimestele sotsiaaltoetusi. Neid toetusi ei maksta kaalutlusõiguse alusel, vaid kõigile, kellel on tuvastatud keskmine, raske või sügav puue (PISTS § 2 lõiked 1¹; 2¹; §-d 6-12).

Arvestades, et puuetega inimeste sotsiaaltoetusi makstakse riigieelarvelistest vahenditest sõltuvalt riigi majanduslikest võimalustest, peab toetuste saajate ring olema seaduses konkreetselt määratletud.

PISTS kohaselt on puue inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel (PISTS § 2 lõige 1).

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmise üks eesmärk on puuetega inimeste iseseisva toimetuleku, sotsiaalse integratsiooni ja võrdsete võimaluste toetamine (PISTS § 1 lõige 2). Puuetega inimeste sotsiaaltoetusi makstakse, kui laps või vanaduspensioniealine inimene vajab seaduses ettenähtud ulatuses kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet (PISTS § 2 lõige 1¹). Samuti makstakse neid toetusi siis, kui tööealise inimese igapäevane tegutsemis- ja ühiskonnaelus osalemine on seadusega ettenähtud ulatuses puudest tingitult piiratud (PISTS § 2 lõige 2¹).

Puuetega inimeste sotsiaaltoetusi makstakse puudest tingitud abstraktsete lisakulude (st inimene ei pea oma kulutusi dokumentidega tõendama) osaliseks hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tegevusteks, kui neid kulutusi ei finantseerita ravikindlustuse ja riigieelarve muudest vahenditest (PISTS § 6 lõige 1; § 7 lõige 1; § 7¹ lõige 1).

Sotsiaalministeeriumi puude määratlemise ja tuvastamise metoodika töörühm (Sotsiaalministeerium, 2019, viidatud EPIKoda 2024 kaudu) jõudis 2019. aastal järeldusele, et seaduses sätestatud puude mõiste on puuetega inimeste õiguste konventsiooniga kehtestatust kitsam.

Konventsioon hõlmab inimesi, kellel on pikaajaline füüsiline, vaimne, intellektuaalne või meeleline kahjustus, mis võib koostoimel erinevate takistustega tõkestada nende täielikku ja tõhusat osalemist ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel (konventsiooni artikkel 1).

Töörühm leidis, et konventsiooni artiklis 1 kasutatud sõnad „võib tõkestada” viitavad sellele, et puude tuvastamiseks piisab, kui on olemas võimalus, et mitmesugused takistused võivad tõkestada puudega inimesel täielikku ja tõhusat osalemist ühiskonnas. PISTS-i sõnastus viitab aga sellele, et takistus peab juba olema ilmnenu või on kindlaks tehtud, et see ilmneb.

Õiguseksperdi hinnangul põhineb PISTS-is sätestatud puude mõiste kriitika teksti lihtsal grammatilisel tõlgendamisel ega vii õige järelduseni. Kasutada tuleb teleoloogilist

tõlgendamist, mis lähtub konventsiooni ja PISTS-i eesmärkidest (Kakoullis & Ikehara, 2018, lk 36; PISTS § 1 lõige 2). Kui eesmärgiks on universaalse rahalise toetuse maksmine, nii nagu see PISTS'is on, peab sihtrühm olema piiritletud. Sellise rahalise toetuse maksmisel ei saa olla sihtrühmaks inimesed, kellel pole pikaajalise tervisekahjustuse tõttu takistusi ühiskonnaelus osalemisel. Seetõttu ei saa PISTS-is lähtuda konventsiooni artiklis 1 kasutatud puuetega inimeste mõistest, mis on PISTS-is kasutatud mõistest laiem ja hõlmab ka inimesi, kellel mingis (tuvastamata olukorras) võivad sellised takistused esineda.

Puude õiguslikust terminist tuleb eristada puude mõiste sisustamist, sest puude õigusliku termini asemel võib Eestis vastuolu konventsiooniga peituda pigem puude raskusastme tuvastamise alustes: selles, milliseid funktsioneerimisvõimeid ja taustategureid hinnatakse; kui palju võetakse arvesse inimese enda hinnangut oma olukorrale; kuidas saadakse hindamistulemused; missugust abi inimesele hindamise järgselt pakutakse. Oluline on ka hindamise alusel tehtud haldusotsuste selgus, sest see mõjutab hindamistulemuste usaldatavust ning vaiete ja kaebuste hulka. Konventsiooniga suurema kooskõla saavutamiseks saab täiendada puude tuvastamise metoodikat, võttes näiteks tööeliste inimeste puhul arvesse ka neid takistusi, mis ei ole otseselt inimese töövõimega seotud. Puuetega inimesed ise on rõhutanud andmekvaliteedi küsimust. Konventsiooniga suurema kooskõla saavutamiseks tuleks astuda samme ka selle probleemi lahendamiseks. Nende eesmärkide saavutamiseks ei ole ilmtingimata vaja PISTS-is olevat puude mõistet muuta.

Järeldusele, et õigusliku termini asemel seisneb probleem pigem puude raskusastme tuvastamises, viitavad nii ÜRO puuetega inimeste komitee poolt Eestile antud tagasiside kui ka käesoleva uuringu tegemisel ekspertidelt ja puuetega inimestelt endilt saadud teave (vt Puuetega inimeste õiguste komitee, 2021; uuringu raames läbiviidud töötubade tulemused).

ÜRO puuetega inimeste komitee leidis, et Eestis ei ole puuetega seotud õigusakte ja poliitikat veel täielikult konventsiooniga kooskõlla viidud, toonitades eriti puuetega inimeste hindamise süsteemide negatiivset mõju, mis takistab puuetega laste ühiskonda kaasamist ning nende juurdepääsu asjakohastele teenustele ja vajalikule toele (Puuetega inimeste õiguste komitee, 2021, punkt 7 a). Samuti leidis komitee, et puuduseks on see, et puuetega inimesi käsitletakse peamiselt sotsiaalteenuste saajatena kõigis eluvaldkondades (Puuetega inimeste õiguste komitee, 2021, punkt 7 c). Seetõttu soovitas komitee Eestil muu hulgas puude hindamise süsteemid läbi vaadata ja viia need kooskõlla **puuetega inimeste õiguste mudeliga** (Puuetega inimeste õiguste komitee, 2021, punkt 8 a). Lisaks leidis komitee, et Eesti õigusaktides kasutatakse halvustavaid termineid ja mõisteid, mis on puuetega inimeste õiguste mudeliga vastuolus (Puuetega inimeste õiguste komitee, 2021, punkt 8 b).

Puude mõistega seonduvat arutelu käsitleb ka Riigikohtu 2022. aasta kohtupraktika analüüs, milles leetakse, et puude mõistes tuleb igal juhul hinnata nii inimese tervises seisundit kui ka tema hakkamasaamist keskkonnas. Puude mõistest tuleneb haldusorganite kohustus hinnata, kas inimesel on võimalik tõhusalt osaleda ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel. Analüüsi kohaselt on kohtupraktikas kinnitust leidnud, et puude tuvastamise otsus ei saa olla diagnoosipõhine, vaid eeldab tervises seisundi igakordset hindamist ning abivahendite kasutamise ja ravi järgimisega arvestamist. (Reisberg, 2022)

3.4. Puuetega inimeste ja esindusorganisatsioonide vaade

Töötubades ilmnas, et puue kui mõiste on olemuslikult **vaidlustatav ja kontekstis muutuv** – erinevates olukordades ning erinevate inimeste kogemustes omandab see sõna erineva sisu. See ühtib eelnevalt tutvustatud puude filosoofias peetud aruteludega. Mõne osaleja jaoks ei ole puue üheselt piiritletav kategooria, vaid pigem **mitmetähenduslik mõiste**, mille tähendus kujuneb sõltuvalt sellest, kas vaatenurk on institutsionaalne, kogemuslik, meditsiiniline või õiguspõhine. Samas oli osalejaid, kes seostasid puuet peamiselt meditsiinilise diagnoosi või stigmatiseeriva sildiga.

Puuet mõtestati eelkõige kui inimese ja keskkonna vahelist suhet – kogemust, mis mõjutab igapäevast elu ning kujuneb kokkupuutest nii ruumilise kui sotsiaalse keskkonnaga. Näiteks toodi välja, et:

- puue võib olla takistus nii inimesele endale kui tema lähedastele, kes peavad sellega arvestama;
- töö saamisel sõltuvad piirangud sageli mitte ainult inimese võimetest, vaid ka ühiskondlikest hoiakutest;
- puue ei tohiks takistada osalemist meeldivates tegevustes ning takistus tekib sageli keskkonnast, mitte inimesest;
- puue tähendab vajadust pidevalt ette planeerida, sest baaseeldused (nagu ligipääs hoonesse või tualetti) ei pruugi olla tagatud;
- puue on üks viis rääkida ligipääsetavusest ja huvikaitsest, andes hääle inimestele, kes on ajalooliselt olnud nähtamatud.

Samas on oluline, et puue ei määra inimest tervikuna – puudega inimesed on töötajad, ettevõtjad, lapsevanemad ja kogukonnaliikmed. Vestlustes rõhutati ka meditsiinilist vaatenurka. Valdavalt nõustuti, et puue on individuaalne ning **pikaajaline ja püsiv tervisepiirang** ja et puue on individuaalne.

Erinev arusaam puude mõistest tekitab segadust ka praeguses puude tuvastamise süsteemis. PISTS kohaselt kirjeldab „puue” inimese elundkonna, sh psüühika kõrvalekallet või puudulikkust. „Puude raskusaste” tähistab aga seda, kuidas puue mõjutab inimese hakkamasaamist. Igapäevakeeles aga on „puue” levinud termin, mida kasutatakse laiemalt ja vabamalt. Seega pole puude tuvastamise protsessis kasutatavad terminid alati intuiitiivselt mõistetavad ega loogilised.

Oluliseks peeti mõistete ühtset ja selget kasutust nii Eesti asutuste vahel kui ka rahvusvahelisel tasandil (sh vastavust ingliskeelsele *disability* -mõistele). See ei välista mõiste paindlikku sisustamist sõltuvalt kontekstist, küll aga eeldab läbipaistvust selles, millist definitsiooni konkreetsel juhul aluseks võetakse.

4. Eesti praegune süsteem

Tööealisel pikaajalise tervisekahjustusega inimestel hindab töötukassa töövõime ulatust järgmiselt: töövõime ei ole vähenenud, osaline töövõime, või puuduv töövõime. Osalise ja puuduva töövõimega inimestele makstakse töövõimetoetust. Töövõimetoetust vähendatakse, kui osalise või puuduva töövõimega inimese tööine sissetulek ületab teatud summa (2025 osalise töövõime korral 1956,60 eurot, puuduva töövõime korral 2700 eurot).⁵

Puude raskusastme tuvastab SKA funktsioonide ehk puude liikide kaupa järgmiselt: keskmine puue, raske puue või sügav puue. Puudega täisealistele inimestele makstakse PISTS alusel järgmisi toetusi (tabel 1) :

- Puudega tööealise inimese toetus
- Puudega vanaduspensioniealise inimese toetus
- Puudega vanema toetus
- Õppetoetus
- Täienduskoolitustoetus

Tabel 1. Pikaajalise tervisekahjustusega inimestele makstavad igakuised toetused eurodes, 2025. aasta juulist

Toetuse suurus 2025. a juulist (€)	Osaline töövõime*	Puuduv töövõime*	Keskmine puue	Raske puue	Sügav puue
Tööealine isik	371,75	652,20	29–42	50	100
Vanaduspensioniealine isik	–	–	13	27	41

*30 päeva eest.

Töövõimetoetust indekseeritakse iga-aastaselt pensioniindeksiga. Puudega inimese toetusi ei indekseerita, nende tõstmiseks on vaja Riigikogu otsust.

Administreerimise ja taotlemise lihtsustamiseks on **tööealistele inimestele** välja töötatud ühine taotlus töövõime hindamiseks ja puude raskusastme tuvastamiseks. Ühise taotlemisega hoitakse kokku eksperthinnangu andmise ressursse, kuna piirangute olemasolu ja raskusastet hindab enamjaolt üksnes töötukassa töövõime hindamise ekspertarst⁶. Seda hinnangut kasutavad mõlemad asutused vastavalt töövõime ulatuse ja puude raskusastme tuvastamisel. Samuti on ühine taotlus vähem koormav taotlejale. SKA ekspertarst teeb puude raskusastme tuvastamise ekspertiisi vaid juhtudel, kui töövõime hindamise andmed ei ole puude raskusastme tuvastamiseks piisavad.

⁵ Vt <https://www.tootukassa.ee/et/tervisepiiranguga-inimesele/toovoime-hindamine>

⁶ Töövõime hindamise ekspertarst on töötukassa poolt kaastatud tervishoiuteenuse osutaja.

Vanaduspensioniealistel inimestel tuvastatakse üksnes puude raskusaste ja puudeliik, mille alusel makstakse igakuist puudega vanaduspensioniealise inimese toetust.

Puudega isiku kaart

Õigustatuse tõendamiseks puudega kaasnevatele soodustustele antakse puude raskusastmega inimesele puudega isiku kaart. Kaardi väljastab SKA. Vanaduspensioniealistele antakse puudega isiku kaart koos pensionikaardiga. Vähenenud töövõimega inimestele väljastab töötukassa lisaks ka töövõimekaardi.

Alates 2028. aastast hakkab kõikides EL liikmesriikides kehtima Euroopa puudega inimeste kaart. See kaart tagab puuetega inimestele soodustused üleeuroopaliselt. Sellisteks soodustusteks võivad olla tasuta või soodsamad sissepääsud kultuuri- või spordiüritustele, soodustused transpordis, eelisjärjekorrad jms. Kaart ei anna õigust saada sotsiaaltoetusi, sotsiaalabi või puudespetsiifilisi- ja rehabilitatsiooniteenuseid. Kaardi välimus ja elemendid on sarnased kõikides EL riikides, kuid kaardi väljaandmise tingimused on iga riigi otsustada.

Samast aastast hakkab kehtima ka Euroopa puudega inimeste parkimiskaart, mis annab õiguse parkida spetsiaalset puudega inimestele mõeldud parkimiskohtadel jm puuetega inimestele mõeldud parkimisega seotud soodustusi. Kaartide väljastamise aluseks on EP ja Nõukogu direktiiv (EL) 2024/2841.

5. Puude, töövõime ulatuse ja abivajaduse tuvastamise meetodikad

Puuetega inimeste õiguste konventsiooni juhendmaterjalides on soovitatud puude hindamisel kasutada Maailma Terviseorganisatsiooni rahvusvahelist funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsiooni (RFK) (WHO, 2001; ÜRO, 2022).

RFK on universaalne raamistik, mis käsitleb inimese funktsioneerimist tervikuna. See ei jaota inimesi eraldi puuderühmadesse, vaid kirjeldab puuet kui järjepidevust. Fookus on küsimusel, mil määral on inimese tegevus ja osalus piiratud („rohkem“ või „vähem“), mitte sellel, kas inimesel on puue või mitte („jah“ või „ei“) (WHO, 2001).

RFK põhineb tänapäevasel arusaamal puudest ning on välja töötatud pikaajalise rahvusvahelise koostöö tulemusena, kaasates nii tervise- ja sotsiaalteadlasi kui ka puudega inimesi (WHO, 2001). RFK-d kasutatakse laialdaselt teenuste kavandamisel, poliitikakujunduses, uuringutes, majandusanalüüsides ja keskkonnategurite hindamisel (vt RFK selgitusi Tervise Arengu Instituudi [veebilehelt](#) ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse [veebilehelt](#)).

RFK ja puuetega inimeste õiguste konventsioon täidavad siiski erinevaid eesmärke. RFK on tehniline klassifitseerimisvahend, mis aitab kirjeldada inimese tegevuspiiranguid.

Nii puude raskusastme tuvastamise kui töövõime hindamise meetodika põhinevad RFK-l, mille alusel saab dokumenteerida inimese funktsioneerimisega ehk igapäevase toimetulekuga seotud infot, kasutades kirjeldava hinnangu asemel koode (Hanga, 2020). Sama meetodikat kasutatakse mõningal määral ka KOV abivajaduse hindamisel.

5.1. Töövõime hindamine ja puude raskusastme tuvastamine tööelistel inimestel

Tööelistel inimestel tuvastatakse nii töövõime ulatus kui ka puude raskusaste. Samas võib inimene taotleda kas ainult töövõime hindamist või ainult puude raskusastme tuvastamist. Eraldi grupi moodustavad inimesed, kellel on enne 2016. aasta reformi tuvastatud tähtajatult püsiva töövõime kaotuse protsent ning kes ei ole taotlenud töövõime hindamist (tabel 4).

Tööelisele inimesele on puude raskusastme ja töövõime ulatuse tuvastamiseks ühine taotlus. Taotlemise eelduseks on tingimus käia hindamisele eelneva kuue kuu jooksul perearsti või peamiselt raviva arsti vastuvõtul. Kahtluse korral tuleb puude raskusastme ja puude tuvastamisel võtta arvesse ka varasemaid terviseandmeid (Riigikohtu halduskolleegiumi 20. juuni 2022. a otsus [nr 3-20-2474](#), punktid 25 ja 26). Nii puue kui vähenenud töövõime tuvastatakse kestusega 6 kuud kuni 5 aastat. Töövõimet välistavate

seisundite korral võib puuduva töövõime tuvastada kuni vanaduspensionieani ([tervise- ja tööministri määrus nr 39](#)). Sel juhul võib tuvastada ka puude raskusaste kuni vanaduspensionieani. Ühistootlus esitatakse töötukassasse, hindamine algab töötukassast ning seejärel tuvastab töötukassa hindamise andmete alusel puude raskusastme SKA. Inimene saab kaks hindamisotsust ning kaks toetuse otsust.

Töövõime hindamise metoodika

Töövõime hindamist reguleerivad [töövõimetoetuse seadus](#) ning [tervise- ja tööministri määrus nr 39](#) „Töövõime hindamise taotlusele kantavate andmete loetelu, töövõime hindamise tingimused ja töövõimet välistavate seisundite loetelu“. Lisaks on Sotsiaalministeerium koostanud juhendi „[Töövõime hindamise metoodika](#)“. Töövõime hindamisel hinnatakse RFK metoodikaga inimese tegutsemis- ja osalemisspiiranguid. Tegutsemispiirang tuleneb funktsioonihäirest, mille aluseks on omakorda diagnoos rahvusvahelise haiguste klassifikaatori RHK alusel. RHK kasutamine diagnoosimisel meditsiinis on kohustuslik, kuid tegutsemispiiranguid raviarstid ei kirjelda. Töötukassa eksperdi sõnul tegutsemispiirangut ei tuvastata, kui inimese kaebused ei ole kinnitatud diagnoosiga. Hindamist läbi viiv ekspertarst määratleb tegutsemispiirangu (nt liikumisspiirang), põhjendab seda funktsioonihäirega (nt liikumisfunktsiooni häire), mille põhjuseks on haigus või struktuurimuutus kehas (diagnoos). Eksperti hinnangul võib sama koodiga diagnoos põhjustada piiranguid erinevas ulatuses. Töövõimet ei hinnata ametikoha või töökoha põhiselt, vaid tegutsemispiiranguid hinnatakse üldiselt ning nende alusel antakse soovitusi töötingimuste kohta.

„Kui sul on mäluga probleeme või sul on näiteks emotsioonide kontrollimisega probleeme, siis see võib ühteviisi olla problemaatiline nii töökohal kui ka kodus. Aga fookus on töövõimel kui sellisel.“ TK ekspert

Tegutsemispiiranguid hinnatakse 7 valdkonnas, milleks on: a) liikumine, b) käeline tegevus, c) teabe edasiandmine ja vastuvõtmine (nägemine, kuulmine ja kõne), d) teadvusel püsimine ja enesehooldus, e) õppimine ja tegevuste sooritamine, f) muutustega kohanemine ning ohu tajumine ning g) suhtlemine. Igas valdkonnas on omakorda 2–3 võtmetegevust, mille osas tegutsemispiiranguid hinnatakse.

Ekspertiisiarst hindab tegutsemispiiranguid valdkondades, milles inimene on oma taotluses märkinud piirangu olemasolu. Iga võtmetegevuse puhul hinnatakse tegutsemispiirangut punktiväärtustega 0–4. Punktiväärtuste aluseks on RFK määratlus tegutsemispiirangu raskusastmele:

0 – probleemi ei ole 0–4%;

1 – kerge probleem 5–24%;

2 – mõõdukas probleem 25–49%;

3 – raske probleem 50–95%;

4 – täielik probleem 96–100%.

Seega 0 tähendab, et piirangut ei ole, ning 4 tähendab täielikku piirangut tegevuse sooritamisel ehk olukorda, kus inimene ei saa ka abivahendi või abistaja abil tegutseda.

Töövõime hindamise ekspertiisis fikseeritakse kõikide valdkondade tegutsemispiirangud. Valdkonna raskusaste määratakse selle valdkonna kõrgeima skooriga võtmetegevuse järgi. Võtmetegevuste punkte ei liideta ning arvesse läheb neist suurim.

Töövõime ulatuse määramisel liidetakse kõikide võtmetegevuste punktiväärtused, v.a punktid 0 ja 1. Täielik funktsioonipiirang valdkonnas annab puuduva töövõime. Osalise töövõime korral (võtmetegevuste punktiväärtuste summa on 4 või suurem) on mõned tegevused teostatavad, mõned mitte. Kerged piirangud jäävad liitmisest välja ning mitmete kergete piirangute puhul osalist töövõimet ei tuvastata. Samuti ei anna vähenenud töövõimet ühe valdkonna mõõdukas piirang ning kerged piirangud teistes valdkondades.

Töövõime hindamist viib läbi TK-ga lepingu sõlminud tervishoiuteenuse osutaja. Töövõime hindamisel on võimalik kasutada muude spetsialistide, nt sotsiaaltöötaja, teenuseosutaja, füsioterapeudi jm hinnanguid, mille inimene saab ise taotlusele lisada. TK eksperdi sõnul sotsiaaltöötajatega infovahetust praktiliselt ei ole, kuid hindamisel kasutatakse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse (SRT) ja tööalase rehabilitatsiooniteenuste tegevuskavade infot piirangute kohta. Tugispetsialisti antav info kirjeldab sageli inimese piiranguid täpsemalt kui võimaldab ainult diagnoosi teadmine. Samas kasutavad tööelised inimesed rehabilitatsiooniteenust vähe.

„See tugispetsialist, kes oskab täpsemalt kirjutada, nii et nad [ekspertarstid] tegelikult arvestavad seda küll, sest sealt on päris palju infot saada, aga lihtsalt häda on selles, et neid rehabilitatsiooniteenusel käivaid inimesi, näiteks töötavaid inimesi, on tegelikult väga vähe.“ TK ekspert

TK esindaja sõnul annavad ekspertarstid ka soovitusi piirangute tasandamiseks vajalike teenuste kohta, kuid tema hinnangul ei ole ekspertiisiarst siiski piisavalt pädev selliste hinnangute andmiseks. Tööalaste teenuste vajadust saavad paremini hinnata TK juhtumikorraldajad ning sotsiaalteenuste vajadust sotsiaaltöötajad. Sotsiaalteenuste ja igapäevaelu toetamise vajaduse hindamiseks puudub taotlusel ka vastav informatsioon. Hindamise kitsaskohti sihtgrupi vaatest käsitletakse peatükis 8.2.

Puude raskusastme tuvastamise metoodika

Puude raskusastme tuvastamist reguleerivad [PISTS](#) ja selle määrused ning juhendid⁷. Puude raskusastme tuvastamise aluseks on samuti terviseandmetel põhinevad tegutsemispiirangud, mida hindab RFK metoodika alusel ekspertarst. SKA eksperdi sõnul algab puude tuvastamine diagnoosist. Järgmise sammuna tuvastatakse, millised funktsioonipiirangud diagnoosist tulenevad ning millised on tegutsemispiirangud. Tegutsemispiirangu alusel tuvastab SKA puude raskusastme.

“Mida meie eksperdid teevad, nad tõlgivad meditsiinisüsteemi andmeid sotsiaalsüsteemi jaoks. Noh, meil on teatud mõttes tõlkebüroo.” SKA ekspert

Tööealistel inimestel hinnatakse tegutsemispiiranguid sarnaselt töövõime hindamisega – piiranguid hinnatakse samades valdkondades ja samade võtmetegevuste kaupa (vt [sotsiaalkaitseministri määrus nr 18](#)). Puude raskusastme tuvastamiseks hindab TK ekspertarst eraldi nägemise-, kuulmise ning kõne ja keele funktsioone. Puude raskusastme tuvastamiseks arvutatakse võtmetegevuste punktiväärtuste alusel valdkonna **aritmeetiline keskmine**. Puuet ei tuvastata, kui aritmeetilise keskmine on väiksem kui 2. Kui valdkonna punktiväärtuste aritmeetiline keskmine on 2–2,75, tuvastatakse keskmine puue; keskmise punktiväärtusega 2,76–3,49 raske puue; ning keskmise punktiväärtusega üle 3,5 sügav puue. Teadvusel püsimise ja enesehoolduse valdkonnas tuvastatakse üksnes keskmine ja raske puue, vastavalt aritmeetiliste keskmistega 2,76–3,49 ja 3,5–4. Kui piirangud esinevad mitmes valdkonnas, võetakse puude raskusastme tuvastamisel aluseks suurima piiranguga valdkond. Erijuhtumina saab tuvastada keskmise puude arvestades kergemate piirangute koosmõju. ([sotsiaalkaitseministri määruse nr 18 lisa 2](#))

SKA eksperdi sõnul võib võtmetegevuste aritmeetilise keskmise kasutamine puude tuvastamisel tekitada probleeme. Näiteks kui inimesel on ühes valdkonnas kahes võtmetegevuses mõõdukas piirang (punktiväärtus 2) ning ühes võtmetegevuses piirang puudub, siis puuet ei tuvastata.

Puude raskusastme tuvastamisel tööelisel inimesel tugineb SKA enamasti töötukassa ekspertiisiarsti hinnangule tegutsemispiirangute kohta. Ühistaotluse puhul, või juhul kui töövõime hindamisest on möödas vähem kui 6 kuud, kasutatakse puude raskusastme tuvastamiseks töötukassa töövõime hindamise punktiväärtuseid. TK poolt hinnatud tegutsemispiirangute väärtused kantakse TK infosüsteemist automaatselt SKA süsteemi. Ligikaudu 90% juhtudest **tuvastatakse puude raskusaste automaatselt töövõime hindamise andmete alusel** ilma SKA ekspertarsti kaasamata.

Teatud juhtudel, sh töövõimet välistava seisundi korral, kaasab SKA puude tuvastamiseks ekspertarsti, kes saab teatud ulatuses muuta piirangu punktiväärtust. Näiteks kui inimese

⁷ Vt <https://sotsiaalkindlustusamet.ee/puue-ja-hoolekanne/puude-tuvastamine>

taotluses (vt [sotsiaalkaitseministri määrus nr 30](#)) toodud hinnangud oma piirangutele erinevad suurel määral arsti tuvastatud tegutsemispiirangutest, võib peaspetsialist kaasata hinnangu andmiseks SKA ekspertiisiarsti. SKA ekspertiisiarst kaasatakse ka piirangute puhul, mis mõjutavad töötamist ja igapäevaelu erinevalt. Nendeks võivad olla vaimse valdkonna tegutsemispiirangud, mis häirivad töötamist, aga kodustes tingimuses saab inimene hakkama.

„Inimene ei saagi (tööl) rasketes vaimselt situatsioonis hakkama, aga igapäevaelus tal raskusi ei teki – saab käia poes ja suhelda teiste inimestega.”
SKA ekspert

SKA eksperdi sõnul püütakse viia SKA tehtavad hindamised miinimumini. Kui inimene taotleb ainult puude raskusastme tuvastamist või on töötukassas tuvastatud töövõimet välistav seisund, hindab tegutsemispiiranguid SKA ekspertiisiarst.

Puude raskusastme tuvastamise kitsaskohad puuetega inimeste vaates on käsitletud alapeatükis 8.2.

Puudeliigi tuvastamine

Puudeliigi tuvastamine on eeskätt vajalik teatud soodustuste saamiseks. Näiteks annab nägemispuue soodustusi ühistranspordis, liikumispuue annab õiguse puudega isiku parkimiskaardile ning muid õigusi (vt täpsemalt Lisa 3). Puudeliigi mõiste ei ole õigusaktides defineeritud, selle asemel eristatakse funktsiooni kõrvalekaldeid. Puudeliigi tuvastab SKA, võttes aluseks, millistes valdkondades piirangud esinevad. Täpse puudeliigi tuvastamiseks eristatakse teabe edasiandmise ja vastuvõtmise valdkonnas kõne, kuulmise ja nägemise piirangud. Liikumispuue tuvastatakse liikumisfunktsiooni piirangu alusel. Puudeliigid tuvastatakse nii tööelistel kui ka vanaduspensioniealistel inimestel.

5.2. Puude raskusastme tuvastamine vanaduspensioniealisel inimesel

Vanaduspensioniealisel inimesel tuvastatakse puue samuti RFK alusel. Puude raskusastme tuvastamise metoodika toetub suures osas töövõime hindamise metoodikale, võttes arvesse samad valdkonnad kui tööeliste inimeste puhul. Puude raskusaste tuvastatakse valdkonna järgi, milles esinevad suurimad piirangud. Erisusena ei määrata piiranguid võtmetegevustes, vaid valdkonda vaadatakse SKA eksperdi sõnul tervikuna. (Sotsiaalkindlustusamet, 2025a)

Puude raskusaste tuvastatakse valdkonnas esinevate piirangute alusel järgmiselt: keskmine puue, kui valdkonnas on piirangu raskusastme arvvärtus 2; raske puue kui valdkonnas on piirangu raskusastme arvvärtus 3; ning sügav puue kui valdkonnas on piirangu

raskusastme arvvärtus 4 ([sotsiaalkaitseministri määruse nr 18 lisa 1](#)). Kui terviseandmetel ei tuvastata üheski valdkonnas keskmist puuet, kuid esinevad kergemad piirangud eri valdkondades, saab uue võimalusena tuvastada muu funktsiooni keskmise puude raskusastme, sarnaselt tööelisele inimesele.

Vanaduspensioniealistel inimestel võib puude raskusastme tuvastada tähtajaliselt või eluajaks. Eksperdi vaates on puude tuvastamine ressursimahukas, makstav toetus aga väike. Seega kulub ressurss pigem hindamisele kui inimeste toetamisele. Eksperdi hinnangul on keeruline eristada puuet vanusega kaasnevatest funktsiooni muutustest või pikaajalise hoolduse vajadusest.

5.3. Abivajaduse hindamine

Lisaks töövõime hindamisele ja puude raskusastme tuvastamisele saab piiranguid kogev inimene pöörduda abivajaduse hindamiseks kohaliku omavalitsuse poole ([Sotsiaalhoolekandeseadus](#) (SHS) § 15). Hindamise tulemusel selgub pikaajalise hoolduse, iseseisvust võimaldavate teenuste või muu abi vajadus. Proaktiivselt peab KOV võtma ühendust sügava puudega inimesega, et pakkuda abivajaduse hindamist. Omavalitsus võib omal algatusel võtta ühendust ka keskmise või raske puudega isikuga (SHS § 15²). Seega hinnatakse puudega inimesi kahel kuni kolmel korral – töövõime hindamiseks, puude raskusastme tuvastamiseks ning abivajaduse hindamiseks igapäevaelus.

KOV-del ei ole kohustust kasutada kindlat hindamisvahendit. SKA on välja töötanud „[Täisealise inimese abi- ja toetusvajaduse hindamise juhendi](#)“, mis põhineb RFK-l (Sotsiaalkindlustusamet, 2025b). Selle metoodikaga määratakse tegutsemispiirangud, mida hinnatakse skaalal 0–4. Piiranguid ei põhjendata diagnoosi olemasoluga. Puude raskusastme tuvastamisel ei ole KOV-de hindamise andmed kättesaadavad.

Abivajadust hinnatakse seitsmes valdkonnas: suhtlemine, vaimne tervis, füüsiline tervis, elukeskkond, hõivatus, vaba aeg ja huvitegevus ning igapäevaelu toimingud. Lisaks kaardistatakse mitteformaalse abi saamine pereliikmetelt ja tuttavatelt, formaalse abi saamine sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnast, abivahendite kasutamine ja kohandused. Hinnatakse inimese enda rahalist võimekust igapäevase toimetuleku tagamisel. Pole teada, kui palju KOV-e seda metoodikat abivajaduse hindamisel kasutavad.

Nii töötubadest kui ka eksperdiintervjuust selgus, et inimesel on abivajaduse hindamisel lihtsam pöörduda anonüümsemana tajutava SKA kui KOV-i poole. SKA maksab toetusi universaalselt, sõltumata inimese või tema leibkonna sissetulekust, samal ajal võib KOV-i pakutav abi sõltuda inimese või tema pere majanduslikust toimetulekust. Näiteks ei maksa KOV toetusi inimestele, kelle sissetulek ületab nende sätestatud piiri. Puuetega inimeste kogemusel tõlgendavad KOV-id samas olukorras olevate inimeste abi saamist ja teenuste vajadusi erinevalt. Sageli on abi saamise eelduseks ka puude raskusaste.

Nelja hindamise võrdlus on toodud Tabelis 2.

Tabel 2. Töövõime hindamise, puude raskusastme tuvastamise ja abivajaduse hindamise võrdlus

Aspekt	Töövõime hindamine	Puude raskusaste tööealistel	Puude raskusaste vanaduspensioniealistel	Abivajaduse hindamine
Hindamise alus	RFK, diagnoos, enesehinnang	RFK, diagnoos, enesehinnang	RFK, diagnoos, enesehinnang	RFK, enesehinnang
Hinnatavad valdkonnad	7 valdkonda: liikumine, käeline tegevus, teabe vastuvõtt ja edastamine, teadvusel püsimine ja enesehooldus, õppimine/tegevus ete elluviimine, kohanemine ja ohu tajumine, suhtlemine. Iga valdkonna all on 2–3 võtmetegevust	Samad valdkonnad, samad võtmetegevused, mis töövõime hindamisel. Puude raskusastme tuvastamiseks hinnatakse töövõime hindamise käigus eristavalt nägemise-, kuulmise ja keele-kõne funktsioone.	Samad valdkonnad, võtmetegevusi ei hinnata	7 valdkonda: suhtlemine, vaimne tervis, füüsiline tervis, elukeskkond, hõivat us, vaba aeg ja huvitegevus ning igapäevaelu toimingud
Skaalad	0–4	0–4	0–4, ekspertiisiarst otsustab kliinilise pildi ja kõrvalabi vajaduse alusel	0–4
Arvutamine	Suurim võtmetegevuse piirang ja valdkondade raskusastmed	Aritmeetiline keskmine võtmetegevuste piirangute raskusastmest	Ekspert arvestab piirangute ulatust, eksperdiarvamus põhineb kaalutlusel	
Kestus	6 kuud – 5 a või vanaduspensionieani	Sama mis töövõime hindamisel	2 – 5 a või eluaegne	
Protsess	Taotlus TK-le, arsti külastus 6 kuu jooksul enne taotluse esitamist, andmed Tervise Infosüsteemist	Sama mis töövõime hindamisel, ühistootlus TK-le või SKA-le	Taotlus SKA-le, andmed Tervise Infosüsteemist	Taotlus KOV-le

Raskusastme te klassid	Osaline või puuduv töövõime	Keskmine, raske või sügav puue	Keskmine, raske või sügav puue	
------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Kokkuvõttes rakendatakse täisealiste inimeste piirangute tuvastamiseks kolme erinevat hindamismetoodikat sõltuvalt hindamise eesmärgist ning inimese vanusest. Neljas metoodika on abivajaduse hindamiseks.

Tööealiste inimeste puhul on töövõime ja puude hindamise alusandmed ja hinnatavad valdkonnad sarnased, hindamismetoodika on sarnane teatud osas (võtmetegevuste punktiväärtused), kuid töövõime ulatuse hindamisel ja puude raskusastme tuvastamisel kasutatakse erinevat arvutuskäiku. Töövõime hindamise käigus hinnatud tegutsemispiirangud sobivad puude raskusastme ja puudeliigi tuvastamiseks tänase metoodikaga.

5.4. Hindamiste andmete kasutamine muudes teenustes

Puude raskusastme hindamise andmed on kasutuses erihoolekande teenuse ja rehabilitatsiooniteenuse vajaduse hindamisel. Samuti kasutatakse puude hindamise andmeid abivahendite erandi menetluse korral. Erandi menetlust rakendatakse abivahendite puhul, mis ei ole soodustuste nimekirjas, omaosaluse vähendamiseks jm juhtudel, mil on vaja teha erietsus.

KOV saab teavituse inimestest, kellele on määratud sügav puue, KOV-i soovil ka raske ja keskmise puudega inimestest. Selle info põhjal võib omavalitsus pakkuda inimesele abivajaduse hindamist. KOV abivajaduse hindamisel korral edastatakse 2025. aasta lõpust töövõime või puude raskusastme hindamisel hinnatud RFK koodide andmed sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistri (STAR) kaudu KOV-i. Omavalitsused näevad tegutsemispiirangute väärtuseid võtmetegevuste kaupa koos tekstilise väljendusega. Andmete edastamine puudutab nii tööealisi kui ka vanaduspensioniealisi puudega inimesi. Kui töövõime on hinnatud töötukassas, siis jõuab KOV-i töövõime hindamise andmed.

Kohalikud omavalitsused on mõnikord sotsiaalteenuste saamise eelduseks seadnud puude raskusastme olemasolu. SKA eksperdi sõnul lihtsustab see omavalitsuse tööd, kes ei pea sel juhul ise hindama inimese õigust teenusele. See praktika ei ole õiguspärane ning survestab inimesi taotlema puude raskusastme tuvastamist. Inimene, kellel puuet siiski ei tuvastata, võib jääda vajaliku teenuseta.

Haridussüsteemi puude andmeid SKA poolt ei edastata.

Nii töövõime hindamise kui ka puude raskusastme tuvastamise andmed on nähtavad tervise infosüsteemis.

6. Kitsaskohad praeguses süsteemis ja ootused süsteemile ekspertide hinnangul

Puude raskusastme tuvastamise lõpetamine ja ühe hindamise sisse viimine on märkimisväärne muudatus, millel on süsteemi vaatest erinevad mõjud ja lahendamist vajavad kohad. Selles peatükis on kirjeldatud töövõime ja puude raskusastme tuvastamise süsteemi kitsaskohad ja ootused süsteemi lihtsustamisele. Peatükk põhineb töötukassa ja SKA esindajate intervjuudel.

Tänases süsteemis rakendatakse täisealiste inimeste piirangute tuvastamiseks kolme erinevat hindamismetoodikat sõltuvalt hindamise eesmärgist ning inimese vanusest. Neljas metoodika on abivajaduse hindamine, mis toimub KOVi sotsiaalhoolekandeosakonnas.

Üheks probleemiks on ekspertide hinnangul hindamiste dubleerimine ning sellest tulenev vajadus teha infosüsteemi arendusi paralleelselt. Ekspertide hinnangul on tänases süsteemis suur halduskoormus, mis ei ole proportsioonis inimestele makstavate toetuste suurusega. Samuti on probleemiks, et inimese jaoks pole arusaadav, kuidas ühes süsteemis hinnatud skooride alusel tekib arvutuse käigus puude raskusastme hinnang. Peamiseks ootuseks on süsteemi lihtsustamine ja halduskoormuse vähendamine.

Ühise hindamise rakendamist töövõime, puude ja abivajaduse jaoks ei pidanud eksperdid rakendatavaks. Töötukassa esindaja hinnangul ei saa meditsiinivaldkonna hindajad teha teenuste vajaduste hindamist, vaid saavad anda infot, milline piirang vajab adresseerimist. Meditsiinitöötajal ei ole ülevaadet inimese keskkonnast, tugivõrgustikust jm igapäevaeluga seonduvast.

Arstlik ekspertiis ei anna piisavalt sisendit igapäevaelu toetavate teenuste vajaduse kohta, mistõttu ei ole arstliku ekspertiisi ja teenusevajaduse hindamise ühildamine otstarbekas.

Ühe puude raskusastme tuvastamise lõpetamisega seotud lahendust vajav asjaolu on, et kui lõpetatakse puude raskusastme tuvastamine, katkeb KOV-idele proaktiivne andmete edastamine puuetega inimeste kohta ning vanaduspensioniealiste inimeste tegutsemispiirangute andmete edastamine abivajaduse hindamiseks.

Ühe lahendusena nägid eksperdid, et RFK alusel hinnatud piirangute andmed edastatakse tulevikus meditsiinisüsteemist teistele osapooltele, kes inimesele abi korraldavad. Meditsiinisüsteem piirangu ulatust ja tegutsemispiirangut hetkel ei hinda. Töötukassa eksperdi arvates ei ole tervishoiusüsteem piirangute kirjeldamist omaks võtnud ning arstidel ei ole sobivaid tööriistu. Praegu on kasutusel rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon RHK-10 ja RFK. Alustatud on RHK-11 ülevõtmist, mis integreerib diagnoosid ja piirangud. SKA ekspert tõi välja, et masinloetavad piirangute koodid võivad olla abiks ka meditsiinisüsteemis ning vähendavad tekstilist osa epikriisis. Kui RFK koodid antakse meditsiinisüsteemis, kaob

ära vajadus piirangute raskusastme hindamiseks sotsiaalsüsteemi poolt. Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel on loodud tööühm, mis töötab välja tsentraalset lahendust, et Tervise Infosüsteemi tekiks inimese funktsioneerimisvõime profiil ning oleks tagatud erinevate osapoolte andmevahetus (Viidalepp, 2023; Aavik-Märtmaa, 2020).

SKA eksperdi hinnangul on vaja süsteemi muutmise korral kaasata ka puude raskusastme hindamine lastele. Vanusega seotud metoodika muutus ei ole inimese vaates loogiline.

6.1 Kitsaskohad süsteemi/ametnike vaates

Puude ja puude raskusastme mõisted

PISTS-s kasutatakse nii mõisted „puue“ kui „tuvastatud puude raskusaste“ ning tööelistel ja vanaduspensioniealistel inimestel on erinev puude raskusastme tuvastamise definitsioon. Tööelistel inimestel tuvastatakse puude raskusaste lähtuvalt igapäevastest tegutsemis- ja ühiskonnaelus osalemise piirangutest, vanaduspensioniealistel inimestel kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajaduse alusel (PISTS § 2 lõiked 1¹; 2¹). Viimast hinnatakse igapäevaelu põhitegevustega hakkamasaamise kaudu. Kõrvalabi või juhendamine on abi osutamine inimesele, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, ravitoimingute, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega. Erinevad definitsioonid võivad tekitada tõlgendamisel segadust.

Lisakulude mõiste

PISTS ei täpsusta, millised on puudest tulenevad lisakulud. Seadusest tulenevalt on laste ja vanaduspensioniealiste inimeste puhul tegemist abstraktsete (mitte tegelike) kuludega kõrvalabile, juhendamisele, järelevalvele. Tööeliste inimeste puhul on tegemist abstraktsete puudest tingitud piirangute ületamiseks tehtavate kuludega (PISTS § 2 lõiked 1¹-2¹). Varasema halduspraktika järgi oli puude raskusastme tuvastamisel üheks kaalutluseks lisakulude olemasolu, mida puue inimesele põhjustas. Kuna puudega tööelise inimese toetuse suurused on diferentseeritud, siis eeldatakse, et erinevate puude raskusastmete või liikide korral erinevad ka lisakulud. Siiski on ebaselge, milles lisakulud seisnevad ning lisakulude loetelu on määratlemata. Näiteks on SKA erinevates vaidemenetlustes selgitanud, et kulud ravimitele ei ole lisakulu ning ravimite omaosalus on kõikide inimeste kanda.

Eakohase abivajaduse arvestamine

Vanaduspensioniealistel inimestel võetakse puude raskusastme tuvastamisel arvesse **eakohasest** abivajadusest suurem kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajadus. Eakohasust käsitleb teatud määral SKA ekspertiisiarstide juhend, kuid seda ennekõike laste kontekstis. On ebaselge, kuidas ja millise metoodika alusel toimub eakohasest suurema abivajaduse

hindamine vanaduspensioniealistel inimestel. Lapsega seonduvas kohtuasjas (Tallinna halduskohus, 2020) on kohus leidnud, et järeldamiseks lapsele osutatava kõrvalabi vastavust lapse arengule, tuleks kõrvutada lapse eale vastava kõrvalabi olemust sellega, millist kõrvalabi osutatakse lapsele konkreetsel ajahetkel. Vanaduspensioniealiste inimeste puhul on selline lähenemine keerukas. SKA eksperdi sõnul ei ole vananemine standardiseeritud, see protsess on väga erinev ning ealiste muutuste ja puude eristamine ei ole selged.

Tööealiste inimeste puude tuvastamise taotlusel ei küsita elukeskkonnaga seonduvat teavet, vanaduspensioniealistel on teatav viide elukeskkonnale olemas.

Kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve on puude tuvastamise praktikas keerukas tuvastada

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses on tööealistel ja vanaduspensioniealistel erinev puude raskusastme tuvastamise alus ja meetod. Tööealiste puhul tuleb puude tuvastamise aluseks võtta igapäevaelu takistused, vanaduspensioniealistel aga kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajadus. Eksperdi hinnangul ei ole kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajadus paraku mõõdetavad ega kajastu terviseandmetes.

„Tegelikkuses hinnatakse sooritus- ja tegutsemispiiranguid, millest võivad tuleneda kõrvalabi-, juhendamise- ja järelevalvevajadus.“ SKA ekspert

Kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve mõiste sisustamine on kohtupraktikates võtmetähtsusega, samas on õiguseksperptide hinnangul need mõisted erakordselt avatud ning raskesti mõõdetavad. Kohtupraktika analüüsist nähtub, et on keeruline hinnata, kui palju juhendamist või järelevalvet konkreetne isik võrreldes teiste isikutega või võrreldes „normaalse toimetulekuga“ vajab. (Reisberg, 2022)

Terviseandmete kvaliteet

Üheks intervjuueeritud eksperdi väljatoodud probleemiks on terviseandmete kvaliteet ja selle piirkondlik varieeruvus. Ka Riigikontroll toob auditis „Terviseandmete õigsuse, täpsuse ja ajakohasuse tagamine“ (2025) välja, et patsientide terviseinfo Eestis on ebaühtlane ja sageli puudulik, teave on ebatäpne ning dokumente esitatakse hiline misega või jäetakse need esitamata. Riigikontroll järeldab, et terviseandmete puudulik kvaliteet piirab inimeste võimalusi saada sotsiaaltoetusi ja -teenuseid. Terviseandmete kvaliteeti peavad suureks probleemiks ka toetuste taotlejad (vt nt [Welfare Experiences](#)). Taotlejate hinnangul on probleemideks nii andmete puudumine terviseinfost, püsivate seisundite andmete arvestamata jätmine, kui terviseandmete koosseisu ebapiisavus. Need viivad püsivate seisundite korral erinevate hindamistulemusteni. Samad probleemid toodi välja ka käesoleva uuringu raames läbiviidud töötubades.

Ekspertarsti kaalutlus

Töötukassa eksperdi sõnul on töövõime hindamisel probleemiks hindava arsti kaalutusõigus ning sellest tulenev subjektiivsus. Kuigi ekspertarstid kasutavad ühtseid juhendeid, mille on välja töötanud vastavad erialaarstid, võib hindamise otsus sõltuda hindava arsti erialast ning erialalistest teadmistest ja kogemustest. See võimalik subjektiivsus kandub edasi ka puude raskusastme tuvastamisse. Ekspert tõi välja, et osaline töövõime on lai kategooria, mis võib ühelt poolt olla lähedal täielikule töövõimele e kergele piirangule ning teiselt poolt puuduvale töövõimele e täielikule piirangule. Seetõttu on suur osa otsuseid kaalutusotsused. Vaideid esitatakse mõnele protsendile otsustest ja 70% neist on töövõimeliste otsuste kohta. Vaiete rahuldamise protsent on eksperdi sõnul madal.

Metoodikate erinevused

Töövõime ja puude hindamiste metoodikate erinevused viivad ekspertide sõnul olukordadeni, kus puuduv töövõime ei tähenda alati sügavat puuet. Inimese jaoks ei pruugi metoodika erisuse põhjendus olla piisav või asjakohane. Samuti eeldavad inimesed tööealise grupist vanaduspensioniealiste gruppi üle minnes, et nende puude raskusaste ei muutu. Praktikas võib puude raskusaste muutuda, kuna süsteem ei eelda vanaduspensioniealiselt inimeselt enam sarnast aktiivsust ja hakkamasaamist kui tööealiselt inimeselt.

Eksperti sõnul puudutavad vaided sageli olukordi, kus tervisekahjustus on kompenseeritud abivahendite või ravimitega, mis leevendavad tegutsemispiirangud. Eksperti hinnangul inimesed ei jaga seda käsitlust ning peavad primaarseks funktsioonipiirangut, mis ajas ei muutu. Seda probleemi toodi tugevalt esile töötubades.

Andmebaasi ja infosüsteemi seotus

Ühistaotlus tähendab ka seda, et TK ja SKA infosüsteemid on omavahel sõltuvuses. Kui üks organisatsioon teeb andmebaasis või infosüsteemis muudatusi, peab arendused tegema ka teine organisatsioon, ehk see toob kaasa sunnitud kulud. SKA eksperdi sõnul toob küsimustiku ülesehituse muudatus kaasa infosüsteemi arendusvajaduse u 1000 arendustunni mahus.

7. Puuetega inimeste toimetulek, vaesus ja teenuste vajadus

PISTS eesmärk on toetada puuetega inimeste iseseisevat toimetulekut, sotsiaalset integratsiooni ja võrdseid võimalusi ning soodustada nii õppimist kui töötamist (PISTS § 1, lõige 2). PISTS alusel makstavate puuetega inimeste sotsiaaltoetuste saajate arv on aastate võrdluses oluliselt vähenenud. Kui 2015. aasta lõpus sai puuetega inimeste sotsiaaltoetust veidi enam kui 133 tuhat 16-aastast ja vanemat puudega inimest⁸, siis 2023. aasta lõpus oli saajate arv veidi vähem kui 107,5 tuhat. Vähenenud on nii keskmise, raske kui ka sügava puudega inimeste arv. Samas on jagunemine puude raskusastme järgi jäänud sarnaseks: kui 2015. aastal moodustasid toetuse saajatest 37% keskmise puudega, 52% raske puudega ning 10% sügava puudega inimesed, siis 2023. aasta lõpus vastavalt 38%, 52% ja 11%.

Eesti sotsiaalkaitse kogukuludest⁹ moodustasid Euroopa Statistikaameti (Eurostat)¹⁰ andmetel 2023. aastal¹¹ ligi 10% puude funktsiooniga seotud kulud, Euroopa Liidu riikide keskmine oli samal ajal 7,1%. Puudega seotud sotsiaalhüvitistest suurema osa ehk 67,6% moodustasid töövõimetoetuse kulud ja 9,1% PISTS alusel makstavad puuetega inimeste sotsiaaltoetused¹². Teenuste kulud moodustasid puude funktsiooni alla kuuluvatest sotsiaalhüvitistest kokku 21,3% (EL-27 keskmine oli 27%).

⁸ Statistikaamet. Tabel SK18: PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALTOETUSED. <https://andmed.stat.ee/et/stat>

⁹ EL-s kasutatakse sotsiaalse kaitse kulude hindamisel kokkulepitud metoodikat (ESSPROS), mille järgi sotsiaalse kaitse kogukulutused moodustuvad sotsiaalhüvitistest ja toetuste jagamise süsteemi ülalpidamise halduskuludest. Sotsiaalhüvitised omakorda jagunevad rahalisteks hüvitisteks (hüvitiste ja toetustena makstud summad) ja mitterahalisteks hüvitisteks (sotsiaalteenuste osutamiseks kulunud raha). Haldus- ja kapitalikulud loetakse sotsiaalse kaitse kulutusteks juhul, kui need on otseselt seotud toetuste maksmise või teenuste osutamisega. Isiku omaosalust teenuste eest tasumisel ei loeta sotsiaalse kaitse kulutusteks. Sotsiaalhüvitised jagunevad omakorda veel ka funktsiooni järgi – millise eesmärgiga hüvitisi kasutatakse ehk millise riski või vajaduse leevendamiseks need on mõeldud. Sellisteks funktsioonideks on haigus/tervishoid; puue; vanadus; toitjakaotus; pere ja lapsed; töötus; eluase; mujal käsitlemata sotsiaalne tõrjutus. Vt ka Statistikaamet, Sotsiaalkaitse kogukulutuste (ESSPROS) käsiraamat: <https://stat.ee/sites/default/files/2020-12/Sotsiaalkaitse%20kogukulutuste%20%28ESSPROS%29%20k%C3%A4siraamat.pdf>

¹⁰ Eurostat. Tabelid: Expenditure on social benefits by function [spr_exp_func]; Expenditure on disability function by type of benefit and means-testing [spr_exp_fdi]; Expenditure on disability function by type of benefit and means-testing [spr_exp_fdi]. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database>

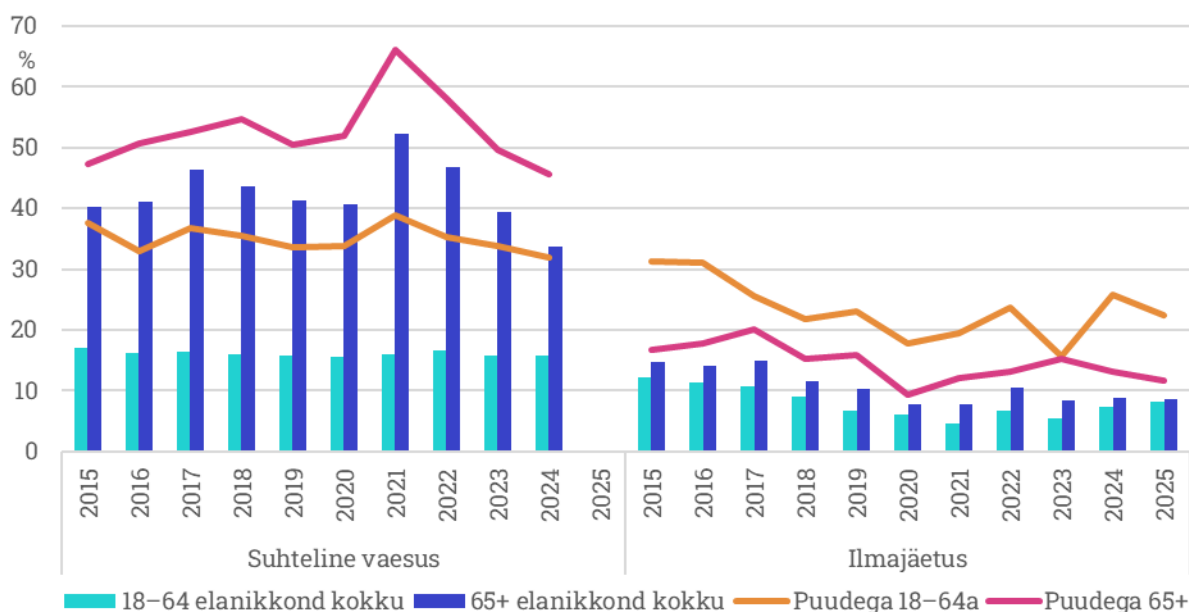
¹¹ 2024. aasta detailsemaid jaotusi ei ole avaldatud. 2024. aastal moodustasid sotsiaalkaitse kogukuludest Eestis 10,7% puude funktsiooniga seotud kulud, Euroopa Liidu riikide keskmine 7%.

¹² ESSPROS metoodikas kajastatakse neid kulutusi kui „Periodic cash benefits – care allowance“, sest selle alla mõeldakse hüvitisi, makstakse puudega inimestele, kes vajavad sagedast või pidevat abi hoolduse (v.a tervishoiuteenused) lisakulude katteks. Töövõimetoetus ja töövõimetuspension kui „Periodic cash benefits – disability pension“. Nendele lisaks eristatakse veel erinevaid hüvitiste ja toetuste liike, mistõttu riikide võrdluses saab võrrelda hüvitiste kulu kokku, kuid mitte hüvitiste alajaotusi.

Kui puude funktsiooniga seotud sotsiaalkaitse kulude osas oleme EL-27 keskmisega võrreldes mõnevõrra paremad, siis seda ei saa öelda puuetega inimeste vaesuse näitajate võrdluses. Eurostati¹³ andmete järgi oli 2023. aastal¹⁴ (uuringuaasta 2024) suhteline vaesus puudega 16–64-aastaste seas 26,1% ning puudega 65-aastaste ja vanemate elanike seas 45,8% (EL-27 keskmine oli vastavalt 21,8% ja 19,4%). Eestist kõrgem näitaja oli 16–64-aastaste võrdluses viiel riigil ning 65-aastaste ja vanemate elanike näitaja võrdluses vaid Lätil.

Aastate jooksul on nii 18–64-aastaste kui 65-aastaste ja vanemate puudega inimeste suhteline vaesus ja ilmajätetus olnud suurem kui kõikide samas vanuses elanike seas. Statistikaameti värskematel¹⁵ ehk 2024. aasta andmetel oli puudega 18–64-aastaste suhteline vaesus kaks korda kõrgem kui kõikide samas vanuses elanike seas, ning 65-aastaste ja vanemate puudega inimestel 1,4 korda suurem kui kõikidel vähemalt 65-aastastel. Ka ilmajätuse määr on puudega täisealiste seas suurem kui samas vanuses elanikkonna seas kokku: 2025. aastal oli ilmajätuse määr 18–64-aastaste seas kokku 8,3%, kuid puudega samas vanuses elanike seas 22,4%. Ka vanemaealiste seas on puudega inimeste hinnang oma materiaalsele ilmajätusele oluliselt kõrgem (11,7%) kui kõikide samas vanuses inimeste seas (8,7%).

Joonis 1. Suhtelise vaesuse ja ilmajätuse määr 18–64-aastaste ning 65-aastaste ja vanemate seas, 2015–2025



Allikas: Statistikaamet, Eesti Sotsiaaluuring 2016–2025 (sissetulekuaastad 2015–2024)

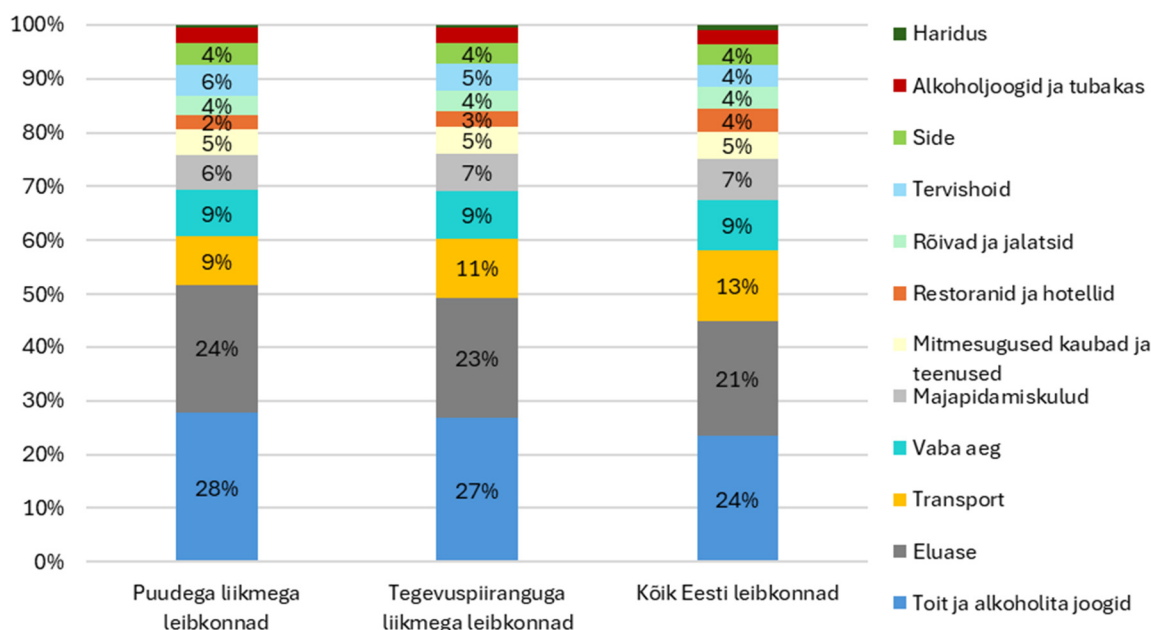
¹³ Eurostati andmebaas. Tabel: Persons at risk of poverty by level of disability (activity limitation), sex and age [hlth_dpe020]. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database>

¹⁴ Eurostati andmebaasis on avaldatud kui 2024. aasta näitajana: Eurostat avaldab uuringuaasta järgi, Eesti Statistikaamet sissetulekuaasta järgi. Uuringut viiakse läbi tagasiulatuvalt ehk 2024. aastal läbi viidud uuringus hinnati 2023. aasta vaesust. Puuetega inimestena käsitletakse Eurostati avaldatud näitajas igapäevategevustes oluliselt piiratud või piiratud, kuid mitte oluliselt elanikke.

Statistikaamet. Tabel THV41: VAESUSE JA ILMAJÄETUSE MÄÄR. <https://andmed.stat.ee/et/stat>

Vaesuse ja sissetulekute ebavõrdsus näitab, et puuetega inimeste ja nende leibkondade majanduslikud võimalused on väiksemad ning see peegeldub ka nende tarbimiskuludes. Nimelt on tarbimiskulude struktuuri järgi puudega või tegevuspiiranguga (enesehinnanguline) liikmega leibkondades toidukulude osakaal 27–28%, mis on suurem kui Eestis keskmiselt (Laurimäe, Sinisaar ja Jezierska, 2025). Puudega leibkonnaliikmega leibkondade tarbimiskulude jaotus on samas sarnane I ja II tulukvintiili kuuluvate leibkondade tarbimiskulude jaotusele ehk kõige madalama sissetulekuga inimestele.

Joonis 2. Tarbimiskulude jaotus kõikides Eesti leibkondades keskmiselt ning leibkondades, kus vähemalt ühel liikmel on puue või tegevuspiirang



Allikad: Statistikaameti 2020. a leibkonna eelarve uuringu andmete ja tarbijahindade alusel korrigeeritud tarbimiskulud 2024. aastaks, autorite arvutused. Laurimäe, M., Sinisaar, H., Jezierska, I. M. (2025). Analüüs riiklike maksutõusude ja eelarvekärbete mõjust haavatavas olukorras sihtrühmadele. Tallinn: Mõttekoda Praxis.

Võrreldes aga kõikide leibkondadega on puudega leibkonnaliikmega leibkondades tervishoiule tehtavate tarbimiskulude osakaal kahe protsendipunkti võrra suurem (Laurimäe, Sinisaar ja Jezierska, 2025). Tervishoiule tehtavad kulud võivad sisaldada nii ravimite kui erinevate teenuste, sh omaosaluse kulu.

Sotsiaalministeeriumi tellitud ja Turu-uuringute AS läbi viidud „Elanikkonna tegevuspiirangute ja hooldusvajaduse uuring 2025“¹⁶ näitab, et ravimite tarvitamine on puuetega inimeste seas oluliselt suurem kui puudeta inimeste seas. Uuringu järgi on viimase 30 päeva jooksul võtnud ravimeid suurem osa keskmise, raske kui sügava puudega inimestest (vastavalt 91%, 92%, 96% vastava puude raskusastmega vastajatest). Seevastu ilma puudeta

¹⁶ Vainu, V. (2025). Elanikkonna tegevuspiirangute ja hooldusvajaduse uuringu lõppraport. Andmetabelid (avaldamata materjal). Sotsiaalministeerium/Turu-uuringute AS/ Euroopa Sotsiaalfond.

inimestest võttis ravimeid vaid 56%. Vähenenud töövõime või püsiva töövõimetusega vastajatest kasutas ravimeid 88%. Puuetega inimestest 60%-l jäid ravimitele tehtud kulutused ühes kuus keskmiselt vahemikku 26 eurost kuni 100 euronini ning umbes kümnendikul koguni üle 100 euro. Neile lisanduvad abivahendite ja hooldusvahendite kulud (veerandil jäid need vahemikku 26 eurot kuni 100 eurot), transpordikulud (veidi vähem kui kolmandikul olid need vahemikus 26–100 eurot). (Vainu, 2025)

Nii vaesust kui ka ilmajäetust mõjutab inimese ja tema leibkonna saadav sissetulek, eelkõige töötasu. Statistikaameti andmetel¹⁷ on alates 2020. aastast vähenenud puuetega inimeste tööhõive määr ning seda nii keskmise kui raske puudega inimeste seas (sügava puudega inimeste tööhõive määr ei ole võimalik vaatluste arvu vähesuse tõttu avaldada). Kui 2019. aastal oli puudega 18–64-aastaste tööhõive määr 40,9%, siis 2024. aastal oli see 33,2% (puudeta 18–64-aastaste tööhõive määr oli vastavalt 82,6% ja 82,3%). Sellele sarnaselt vähenes keskmise puudega 18–64-aastaste tööhõive määr 54%-lt 2019. aastal, 41,9%-le 2024. aastal. Keskmise puudega võrreldes on raske puudega inimeste tööhõive oluliselt madalam ning ka see on aastate võrdluses vähenenud: kui 2019. aastal oli see 25,1%, siis 2024. aastal 20,8%. Võrdluseks: 18–64-aastaste vähenenud töövõimega inimeste tööhõive määr oli 2024. aastal 52,7% (2019. aastal 52,5%). Osalise töövõimega inimeste tööhõive määr ulatus 70,7%-ni (71,2% 2019. aastal) ja puuduva töövõimega inimestel 22,4%-ni (22,1% 2019. aastal). Kui inimesel on üheaegselt nii vähenenud töövõime kui ka puue, on tööhõive määr märksa madalam – 33,9% (2024. a). Üksnes vähenenud töövõime korral oli tööhõive määr 66,2% ning ilma vähenenud töövõime ja puudeta inimestel 83,5% (2024. a).

Samas ei tööta puudega inimesed täisajaga¹⁸: põhitöö osaajaga töötavate hõivatute osatähtsus oli 41,7% puudega 18–64-aastaste seas, samas kui puudeta 18–64-aastaste seas oli 12,7%. Osaajaga töötamine tähendab eeldatavalt ka väiksemat töist sissetulekut ja see avaldub ka puuetega inimeste sissetuleku suuruses ja hiljem nende vanaduspensioni suuruses.

Puuetega inimeste töötamist ning nende majanduslikku toimetulekut mõjutab lisaks nende enda tervises seisundile ja muudele teguritele ka see, kas puudega inimene ise peab hooldama mõnda pereliiget – 2024. aastal oli täisealist pereliiget hooldavate inimeste määr puudega 18–64-aastaste seas 6,7% (vähemalt pooltel juhtudel on hooldajaks keskmise puudega 18–64-aastane) ning puudeta 18–64-aastaste seas 3,7%.

2025. aasta elanikkonna tegevuspiirangute ja hooldusvajaduse uuringu järgi kasutavad enam kui pooled 18-aastastest ja vanematest puudega¹⁹ inimestest terviseprobleemi või

¹⁷ Statistikaamet. Tööturu rakendus. <https://tooturg.stat.ee/>

¹⁸ Statistikaamet. Tööturu rakendus.

¹⁹ Uuringus küsiti vastajalt, kas tal on tuvastatud puude raskusaste ning seetõttu on tegemist enesehinnanguga, mitte registriandmetel põhineva teabega.

tegevuspiirangu²⁰ tõttu kõrvalabi. Ametlikke teenuseid sai aga oluliselt vähem – vaid 14% ütles, et saab mõnda teenust (peamiselt koduteenust, sotsiaaltransporditeenust) riigilt, KOV-ilt või mõnelt muult asutuselt. Enamjaolt leiti, et saadud teenused aitasid piisavalt, kuid siiski oli neid, kes leidsid, et teenus ei vastanud vajadustele. Peamise murekohana toodi välja, et teenuse maht oli liiga väike, kuid nimetati ka teisi probleeme (sh teenuse liiga kõrget maksumust või omaosaluse määra). Seejuures on abi või teenuse saamiseks pöördutud valdavalt perearsti ja rehabilitatsiooniteenuse osutaja poole ning oluliselt vähem SKA ja KOV-i poole. (Vainu, 2025)

Puuetega inimestest 36% leidis, et nad vajavad toimetulekuks täiendavaid teenuseid (sh need, kes said mõnda teenust). Eelkõige vajatakse transporditeenuseid ning teenuseid igapäevaste toimingute tegemiseks oma eluruumides, kuid ka ravimite, toidu ja muude vajalike kaupade koju toomiseks või keerulisemate ülesannetega toimetulekuks. Peamiseks põhjuseks, miks neid täiendavaid teenuseid pole saadud, on teenuse maksumus või omaosaluse suurus, kuid ka teadmatus, kuhu ja kelle poole pöörduda, või millist teenust või abivahendit on võimalik saada. (Vainu, 2025)

Seega on puuetega inimeste probleemid ja sellest tulenevad vajadused seotud nii majandusliku toimetuleku kui ka teenuste kättesaadavusega. Ühelt poolt on puuetega inimestel teiste elanikega võrreldes suurem suhteline vaesus ja madalam sissetulek, kuid teisalt vajadus täiendavate teenuste järele. Seejuures on vajadus saada ka juba saadavaid teenuseid senisest suuremas mahus. Ka on teenuste maksumus või omaosalus sissetulekute taset arvestades oluliseks probleemiks.

²⁰ „Tegevuspiirang – inimese enesehinnanguline piirang igapäevategevustes, mis tuleneb tema tervises seisundist, mitte rahalistest, kultuurilistest vms tervisega mitte seotud põhjustest. Tegevuspiirang ei kattu ametlikult määratava puude ega töövõime kategooriatega: tegevuspiirangu esinemine võib olla laiem, kuna inimese hinnang enda igapäevategevuste piiratusle kehtib ka siis, kui tal vähenenud töövõimet või puuet ametlikult tuvastatud ei ole.“
Allikas: Vainu, V. (2025). Elanikkonna tegevuspiirangute ja hooldusvajaduse uuringu lõppraport. Andmetabelid (avaldamata materjal). Sotsiaalministeerium/Turu-uuringute AS/ Euroopa Sotsiaalfond.

8. Puuetega inimeste kogemused ja ootused süsteemile

Et pakkuda lahendusi õiglasemaks ja lihtsamaks puude tuvastamise süsteemiks, on oluline mõista praeguseid kitsaskohti puuetega inimeste jaoks ning vajadusi. Selleks viisime läbi töötoad puuetega inimeste esindusorganisatsioonidega (vt täpsemat metoodikakirjeldust alaptk 1.3). Järgnevas tekstis oleme rohelisel taustal toonud töötubades osalejate pakutud ettepanekud süsteemi parendamiseks.

8.1. Ootused ja hinnangud süsteemile ja ühendamisele

Puuetega inimeste jaoks pole puude ja töövõime tuvastamine pelgalt tehniline menetlus. See on teekond, mis võetakse ette eesmärgiga saada abi tervisest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Inimese jaoks ei alga see protsess taotluse täitmisest ega lõppe otsuse teavitusega. Taotlusele eelnevad ettevalmistused, näiteks arsti juures käimine ja vajadusel taotluse täitmise jaoks abi otsimine. Taotlusele järgneb otsus, millel võivad olla olulised tagajärjed. Puude ja töövõime tuvastamise otsus mõjutab majanduslikku toimetulekut, töötamist, ühiskonnaelus osalemist ja elukvaliteeti. Samuti mõjutab see kuuluvus- ja kindlustunnet. Seetõttu on tegemist inimese jaoks kaaluka teekonnaga.

Töövõime ja puude tuvastamist taotlevad inimesed tavaliselt olukorras, kus nad on oma tervise tõttu haavatavad. Süsteemilt oodatakse mitte ainult otsust, vaid ka abi: rahalist toetust, teenuseid, abivahendeid ja õigusi, ehk laiemalt öeldes tasandusi, mis aitaks ühiskonnas osaleda võrdselt ilma puudeta inimestega. Seega riivavad õiglustunnet olukorrad, kus riigi hinnang ei ühti abivajaja enda kogemusega. Sellisel juhul võib inimesele tunduda, et tema raskusi ei tunnista ning abivajadust ei arvestata.

Kuna otsustel on inimese elule suur mõju, oodatakse hindamise protsessilt süsteemsust, inimlikku suhtumist ja sotsiaalset õiglust. Töövõime hindamise ja puude tuvastamise süsteem või selle alternatiiv peaks täitma eesmärgi saada põhjalik ülevaade inimese tegelikust abivajadusest. Äärmiselt oluline on, et sellele järgneks tugi – rahaline toetus, puuetega inimese kaardi ja teenuste pakkumine. Kuna paljud tervisepiirangud on eluaegsed, oleks inimeste jaoks loogiline, et puude hindamise ja teenuste saamise teekond oleks ühtlane kogu elukaare lõikes.

Töötubade arutelud näitasid, et taotleja jaoks ei ole süsteemi sisese halduse lihtsustamise küsimused – näiteks asutuste-vahelise vastutuse jaotus ja koostöö korraldus – esmatähtsad. Oluline on, et puude ja töövõime tuvastamise protsess või selle alternatiiv tulevikus tagaks rahalise toe, hüved ja suunaks inimesed vajalike teenusteni.

Töötubades ilmnas, et kahe dubleeriva süsteemi olemasolu ei ole taotleja kliendikogemuse vaatest suur probleem. Tööealised inimesed esitavad enamasti töövõime ja puude

tuvastamise taotluse koos. Kahe eraldi süsteemi probleem ilmneb siis, kui töövõime otsus ja puude otsus pole inimese hinnangul loogilises seoses. Sellistel juhtudel kritiseeriti puude tuvastamise metoodikat. Lisaks juhiti töötubades tähelepanu, et töövõime ja puude hindamisega kaasnevad erinevad soodustused, kuigi rahvusvahelises käsitluses peetakse neid mõisteid sisuliselt samaväärseks (nt ÜRO puuetega inimeste konventsiooni raamistikus).

Inimeste jaoks ei ole puude tuvastamise metoodika loogiline ega läbipaistev. Esindusorganisatsioonide hinnangul on Eestis märkimisväärne hulk puudega inimesi, kellel tänases süsteemis puuet ei tuvastata ning kes ei saa toetusi ega muid hüvesid ehk vajalikku tuge. Samas jagati korduvalt, kuidas põhjendused taotluse mitterahuldamiseks ja puude raskusastme otsuseks ei ole ammendavad ega arusaadavad.

Töövõime tuvastamise metoodika osas oldi töötubade aruteludes mõnevõrra positiivsemad. Tunnustati RFK-l põhinevat käsitlust. Positiivsena toodi välja avatud küsimused ja tekstiväljad taotluses. Puude ja töövõime mõiste seose aruteludes kõlas erinevaid seisukohti. Mõne jaoks on oluline hoida need mõisted eraldi, teised aga näevad osalist või puuduvat töövõimet sisuliselt samaväärsena ÜRO konventsioonis kasutatava puude mõistega.

Puude tuvastamise ja selle lõpetamise tähendus

Puude tuvastamise lõpetamise kaalumisel tuleb mõista, mida inimeste jaoks puude tuvastamine tähendab. Töötubades osalejad nõustusid, et toetuste, teenuste ja hüvedeni jõudmine on täna inimese jaoks koormav ning pole selge, kust abi saada. Siiski suhtuti puude tuvastamise lõpetamise ja puudetoe toetuste ümberjagamise ettepanekusse ettevaatlikult ning skepsisega. Kuna „puue“ on inimese jaoks laiem mõiste, siis võib selle tuvastamisel olla ka sotsiaalse identiteedi kohalt oluline tähendus. Puude tuvastamist nähakse kui riigipoolset kontrolli inimese enda hinnangule, näiteks nähti, et puude tuvastamise protsessis selgub „kas ma olen puudega või mitte“ (töötubades laialt kasutatud fraas). Riikliku puude tuvastamise lõpetamises tajuti riski, et puudega inimesed muutuvad haavatava grupina nähtamatuks (näiteks räägiti puude ja puuetega inimeste „kaotamisest“).

Selle kohta, kas riik peaks kinnitama inimese subjektiivset kogemust puude olemasolu osas, olid töötubades osalejatel erinevad hoiakud. Mitmed toetasid konventsiooni lähenemist, kus puue on subjektiivne elukogemus ja riigipoolne hinnang selle olemasolule pole vajalik ega kohane. Samas oli neid, kelle jaoks on riiklik puude tuvastamine oluline, sest see annab ühtselt mõistetava termini või "sildi" avalikeks aruteludeks ja tavadeks.

Üheks skepsise põhjuseks on puuetega inimeste toetuste roll inimeste heaolus. Osalejate hinnangul on toetused toimetulekuks vajalikud. Eriti rõhutasid vanaduspensioniealiste töötoas osalejad, et puudega vanaduspensioniealise inimese toetus on oluline riigipoolne meede. Toetusi peeti vajalikuks ka õigluse ja võrdsuse põhimõttest lähtudes, sest puudest

tulenevad kulud töötamiseks, ühiskonnaelus osalemiseks ja täisväärtusliku elu elamiseks, mida puudeta inimestel ei ole.

Töötubades osalejate hinnangul kasutatakse puudetoetusi peamiselt igapäevaste kulude katmiseks nagu toit, eluase ja sideteenused. Leibkondades, kus elab puudega inimene, on sundkulutuste ehk toidu- (28%) ja eluasemekulude osakaal (27%) suurem kui Eestis keskmiselt (vastavalt 24% ja 21%) (Laurimäe, Sinisaar, Jezierska, 2025). Ka on tervisega seotud kulutuste osakaal puuetega inimeste leibkondades mõnevõrra suurem kui Eestis keskmiselt (6% vs 4%) (*ibid.*). Samuti kasutatakse toetusi abivahendite ja ravimite soetamiseks, osaliselt teenuste eest tasumiseks ning muude puudega seotud kulude katmiseks.

Rahalist toetust, ka väikese summana, peeti oluliseks ka seetõttu, et see annab inimesele võimaluse ise otsustada oma väljaminekute üle. See tagab väärikuse, et inimesel on õigus paindlikult valida, millist teenust, abivahendit vms ta vajab. Seda peeti vajalikuks, kuna puuded ja diagnoosid ning nendest tulenevad vajadused on erinevad ning teenuste ja ravimite vajadus individuaalne.

Puuetega inimeste toetusi, puudega kaasnevaid soodustusi ja puudega inimese kaarti nähakse kui viimast tugivõrku, mis tagavad minimaalse abi. Täna kahe süsteemi liitmiseks nii, et puuetega inimeste õigused säiliks ja süsteem oleks inimesekeskne, peaks minimaalselt tänaste toetuste määr säilima.

Puudega inimeste toetuste vahendite ümber suunamine teenustesse

Töötubadest ei joonistunud välja korduvaid kogemusi ega ühist arusaama, mille alusel järeldada, millistesse teenustesse tuleks praegu puudetoetusteks minevad vahendid suunata, sest teenuste vajadus erineb puute lõikes.

Näiteks on liikumispuudega inimeste jaoks äärmiselt olulised rehabilitatsiooniteenused. Kurtide inimeste jaoks jällegi ei pruugi see nii olla – kui puuduvad muud piirangud, vajatakse üksnes viipekeele tõlketeenust.

Aruteludest ilmnes, et ka sama diagnoosi või puudega inimesed võivad vajada erinevaid teenuseid. Töötoas osalejad pidasid oluliseks, et teenuste valikul arvestataks inimese individuaalsust ja igapäevaelu konteksti. Samuti rõhutati teenuste kohta käiva info kättesaadavust ja teenuste taskukohasust. Osalejad tõid näiteid, kus teenused on kohaliku omavalitsuse tasandil seotud leibkonna sissetulekuga.

Indiviidi vaatest ei ole puuetega inimeste toetuste maksmise lõpetamine ja vahendite suunamine teenustesse loogiline lahendus süsteemi lihtsustamiseks. Praegused toetused üldjuhul ei kata vajalike teenuste kulu.

Lisaks väljendati ootust, et toetused, teenused ja hüved võiksid olla laiemad ja paindlikumad. Näiteks parkimiskaarti võivad vajada ka need, kellel pole ametlikult tuvastatud liikumispuue, kõnepuude korral oleks vaja kättesaadavaid logopeedi ja tugiisiku teenuseid jpm.

EPIKoda on avalikus kommunikatsioonis (vt EPIKoda, 2025) pikaajaseks rõhutanud vajadust säästa inimesi ülemäärasest hindamise koormusest, kuid ei toeta lahendusi, mis vähendavad tänaste toetusesaajate õigusi.

8.2. Kitsaskohad taotleja vaates

Töövõime hindamise ja puude tuvastamise praegune süsteem hindab taotleja enesehinnangu ja diagnoosi alusel funktsiooni- ja tegutsemispiiranguid. Sellest ei selgu, mis abi inimene täisväärtusliku elu elamiseks igapäevaselt vajab ega jõua temani piisavalt meetmeid, sekkumisi ja teenuseid. Pärast puude raskusastme tuvastamist vastutab inimene ise teenuste otsimise ja leidmise eest, mida pakutakse eri tasanditel (riik, KOV) ja erinevate asutuste poolt (Tervisekassa, SKA, TK, erasektor). Seega jääb inimese vaates abi saamiseks ette võetud teekond justkui pooleli.

Süsteemi vaatest aga polegi puude tuvastamine mõeldud üldiseks abivajaduse ja teenuste vajaduse hindamiseks, vaid toetuse määramiseks. Seega on süsteem disainitud eeskätt ressursside jaotamiseks, mitte inimese toetamiseks. Töötubades tunnetati samuti, et töövõime ja puude tuvastamise eesmärk on tervisepiirangute tõestamine ja toetuse kriteeriumitele vastamise hindamine. See on osalejate hinnangul alandav ja frustreriv (näiteks oli levinud hoiak „miks peab pöördumatut seisundit ikka ja jälle tõestama?“). Selleks, et süsteem inimest toetaks ja ta saaks vajaliku abi, nähakse asjakohasena abivajaduse terviklikumat kirjeldamist.

Kitsaskohad metoodikas ja aluspõhimõtetes

Töötubades tuli esile inimeste ootus, et töövõime ja puude hindamisel selguksid piirangud ja abivajadus. Praegune töövõime hindamise ja puude tuvastamise süsteem ei peegelda inimese tegelikke vajadusi sedavõrd piisavalt, et tulemuseks oleks teadmine, millist abi, teenuseid ja kohandusi ta igapäevaelus vajab, et toime tulla ja ühiskonnas osaleda.

Esiteks, töövõime ja puude raskusastme tuvastamisel arvestatakse abivahendite ja kodu kohandamise kompenseerivat mõju. See võib viia olukorrani, kus inimene saab puudetoetuse abil soetada vajalikud abivahendid või muud tasandused, kuid järgmisel hindamisel hinnatakse tema puude raskusaste kergemaks. Selle tulemusena võib puudetoetus väheneda või selle maksmine lõppeda, kuigi just toetus aitas inimesel piirangutega toime tulla. Piirangutega kohanemiseks ja iseseisvaks toimetulekus on vaja jätkusuutlikku tuge. Mainiti, et abivahendite arvestamine puude raskusastme hindamisel ei pruugi olla igas olukorras põhjendatud. Paljusid abivahendeid ei ole meditsiinilistel põhjustel võimalik kasutada ööpäevaringselt.

Samuti toodi välja, et eeldus, et ravimid kompenseerivad piirangud ei pruugi alati paika pidada. Ravimitel võivad olla kõrvaltoimed, mis takistavad tegutsemist. Kroonilise valu puhul võivad valuvaigistid küll sümptomeid leevendada, kuid ei vähenda pidevat väsimust, mis mõjutab töötamist ja osalemist ühiskonnaelus.

Töötubade aruteludes oli läbivaks mõtteks, et taotluse küsimustik ei võimalda piisavalt täpselt kirjeldada inimese igapäevaelus esinevaid tervisest tulenevaid piiranguid. Üheks põhjuseks on, et mõned küsimused peegeldavad sooritust hüpoteetilistes, mitte päriselulistes olukordades. Näiteks on küsimus, kus hinnatakse inimese võimekust liigutada tühja pappkasti. Kui sellest küsimusest võib järeldada, et inimene on võimeline seda tegema, siis reaalses elus oleneb suutlikkus keskkonnast (libe põrand või ebatasane maapind vms).

Samuti ei ole töötoas osalejate hinnangul piisavalt võimalusi selgitada asjaolusid, mis tingivad abivajaduse: kui kaua aega igapäevane tegevus võtab või kui kaua on pärast tegevust vaja taastuda. Näiteks võib inimene saada iseseisvalt hakkama hammaste pesemisega, kuid see võtab rohkem aega, kui inimesel, kellel pole puuet (hambapasta tuubi avamine või pigistamine võib nõuda keerukamaid ja aeglasemaid võtteid). Samuti võib olla, et abivahend lihtsustab tegevust, kuid ei kompenseeri piirangut täielikult, st tegevus võib siiski võtta rohkem aega kui ilma puudeta inimesel.

Selleks, et paremini mõista abivajadust, on oluline arvestada inimese elu konteksti. Inimese igapäevaelu ja vajaduste kirjeldamisel on oluline ka tema enda hinnang. Töötubades väljendati korduvalt tunnet, et taotleja enda hinnangut oma toimetulekule ei arvestata piisavalt. See kannustab tunnet, et taotlejat ei usaldata, teda kontrollitakse või kahtlustatakse, mis suurendab haavatavas olukorras abivajaja häbi ja pinget. Teisalt nõustuti, et piirangute hindamiseks on olulised ka objektiivsed andmed ja meditsiinispetsialisti hinnang.

Töötubades tunnustati positiivselt avatud küsimusi ja võimalust taotluses enda kogemusi kirjeldada. Siiski peavad tänases süsteemis terviseandmed piiranguid ka kinnitama, mistõttu sõltub otsus suurel määral terviseandmete kvaliteedist. Töötubades ilmnes, et levinud on praktika, kus selleks, et piirangud oleksid terviseandmetes piisavalt täpselt kajastatud, peab inimene paluma arstil oma olukorda kirjeldada ja arsti motiveerima. Nii võib hindamise otsus hakata sõltuma inimese ja arsti suhtest, arsti ajast, oskustest ja motivatsioonist inimese olukorda võimalikult täpselt kirjeldada.

Lisaks mainiti, et tänases süsteemis ei arvestata, et ka muutlike krooniliste haigustega võib olla vaja toetust ja puudega inimese kaardiga kaasnevaid õigusi. Praeguse loogika järgi ei kvalifitseeru ravile alluvad diagnoosid töövõime vähenemiseks ega puudeks. Töötubades peeti seda ebatäpseks, sest ka ravile alluvate haiguste puhul on inimestel sageli vaja kohandusi, tasandusi ja toetust haigusega kaasnevate lisakulude katmiseks.

Vaimse tervisega seotud seisundite puhul ei ole sageli bioloogilisi indikaatoreid, mida hindamissüsteem arvesse võtaks, mistõttu ei saa taotluse tulemusel head ülevaadet, kuigi

need mõjutavad inimese tegelikku abivajadust väga oluliselt. Samuti mainiti, et taotluses ei ole head võimalust kirjeldada tervises seisundi ja abivajaduse muutlikkust. Näiteks psüühikahäirete puhul võib olla toimetulemise ja abivajaduse rütm 9 kuud keskmine, 3 kuud kõrgem abi- ja toetusvajadus.

Töötubades pakuti, et abivajaduse paremaks kaardistamiseks võiks tulevikus:

- ✓ **Inimese enesehinnangut rohkem kasutada.** Inimesel peaks olema võimalus oma olukorda sisukamalt kirjeldada (nt rohkem tähemärke, selgemad ja elulised küsimused). Inimese kogemus on kõige täpsem infoallikas ning seda tuleks usaldada. Kui inimese enesehinnangut ei arvestata, siis peab otsuses olema selgitatud, miks.
- ✓ **Hinnata suutlikkust reaalses elus toimuvate tegevuste alusel.** Sihipärasemaks hindamiseks võiks kasutada konkreetseid näiteid – kui kaua võtab aega riietumine, söögivalmistamine või muud igapäevased toimingud.
- ✓ **Arvestada mitmete erinevate spetsialistide hinnanguid.** Füsioterapeutide, tegevusterapeutide ja psühholoogide hinnangud annavad täpsema pildi tegevusvõimest. Ekspertiisiarstil võiks olla automaatselt ligipääs juba kogutud andmetele, nagu rehabilitatsioonimeeskonna kokkuvõtted, kohaliku omavalitsuse abivajaduse hindamised või kodukohanduse kaardistused.
- ✓ **Ekspertiisiarstil võiks olla võimalus konsulteerida eri spetsialistidega.** Süsteem peaks võimaldama vajadusel arutada juhtumit eriarsti, teiste arstide, inimese enda või puuetega inimeste esindusorganisatsioonidega.

Töövõime ja puude korduv tuvastamine ei täida eesmärki

Kuna hindamise tulemusel ei selgu muutus abivajaduses ega pakuta inimesele teenuseid, siis ei näinud töötubades osalejad praegusel korduval hindamisel eesmärki. Nõustuti, et abivajadus ja keskkond võivad muutuda ning et seda on vaja teatud aja järel uuesti hinnata. Samuti nõustuti, et abivahendite ja teenuste vajadus võib sõltuda elukorralduslikest tingimustest, mis võivad tingida korduva hindamise vajalikkuse. Näiteks olukorras, kus inimese peamine hooldaja teda enam ei hoolda ning on vaja teenuseid, mis neid tegevusi asendaksid. Samuti võib tervises seisund sõltuda muutlikest teguritest, nagu soov ravimeid võtta ja tugivõrgustiku olemasolu. Selles osas, mis tingimustel ja kui tihti võiks hindamised korduda, oli erinevaid arvamusi, mis on toodud allpool rohelisel taustal tekstis.

Korduvalt rõhutati, et on seisundeid, mille osas saab eeldada, et see ei muutu ning seega ei muutu ka puudetoetuse ja puudega inimese kaardi vajadus. Näiteks inimesed, kes on pimedad, kurdid või seljaajukahjustuse tagajärjel liikumispirangutega. Nagu eelnevalt kirjeldatud, kogetakse töövõime ja puude tuvastamist sageli kui vajadust riigile tõestada oma tervises seisundit ja muresid, sest otsusele ei järgne suunamine ja abistamine teenuste osas. Seega on korduvad hindamised inimeste jaoks praegusel kujul frustratsioon.

Aruteludes toodi esile ka kitsaskohti, mis puudutavad tööaliste hindamismetoodikalt vanaduspensioniealiste metoodikale liikumises. Ühes näites ei tuvastatud eluaegse funktsioonipiiranguga inimesel vanaduspensionieas puuet, vaid seda tõlgendati eakohase kõrvalabi vajadusena. Teises näites jäi inimesel tööeas vanaduspensioniiikka jõudes taotluste menetlemise tõttu teenustesse nädalane lünk.

Lahendusettepanekud korduvhindamiste koormuse vähendamiseks:

- ✓ **Püsivate seisundite loetelu ajakohastamine.** Ekspertiisiarstide konsiilium võiks täiendada ja korrastada püsivate seisundite nimekirja, et see hõlmaks üheselt ka kurte, pimedaid, püsiva liikumisvõimetusega inimesi ja teisi selgelt eluaegseid seisundeid. Tähtajatu puude määramise alused võiks olla selgelt määratletud ja kommunikeeritud.
- ✓ **Süsteemi uus siseneja: jälgimisperiood.** Esmakordsel hindamisel võiks inimene läbida paar korduvhindamiste perioodi, et hinnata seisundi ja abivajaduse muutumatust. Kui muutusi ei ole, võiks ekspertkomisjon määrata seisundi püsivaks ning lõpetada edasised korduvhindamised.
- ✓ **Eeltäidetud korduvhindamise vorm.** Korduvhindamisel võiks vorm sisaldada automaatselt eelmiste hindamiste vastuseid, mida inimene saab vajadusel muuta või täiendada, et vältida info korduvat sisestamist.
- ✓ **Korduvhindamine ainult kindlates olukordades.** Korduvhindamist rakendada üksnes kokkulepitud juhtudel:
 1. kui turule tuleb uus ravim, meditsiiniline sekkumine või abivahend;
 2. progresseeruva haiguse korral;
 3. olulise keskkonnamuutuse korral (nt hooldaja surm);
 4. kui tervishoiusüsteemis ilmneb otsene korduvhindamise vajadus (nt perearsti regulaarne kontroll, perearst suunab).
- ✓ **Vanusest sõltuv hindamissagedus.** Teatud vanusest alates võiks korduvhindamise intervall olla kümme aastat.
- ✓ **Fookus abivajadusel.** Abivajadust võiks hinnata sarnaselt raviarsti lähenemisele: kui puudub konkreetne põhjus (nt protees, progresseerumine), ei ole vaja korduvalt hinnata puude raskusastet. Selle asemel tuleks regulaarselt hinnata keskkonda, teenuste vajadust ja teenuste tõhusust. Hindamine peaks arvesse võtma, et abivajaduse muutumise rütm võib olla individuaalne.

Puude ja töövõime tuvastamise läbimine ei vii teenusteni

SHS-i kohaselt peab kohalik omavalitsus hindama pöördunud isiku abivajadust (§ 15 lõige 1). Puudega inimesele peab omavalitsus tagama abi takistuste vähendamiseks või kõrvaldamiseks, sh vajaliku tugi- ja tõlketeenuste korraldamise (SHS § 15 lõige 3). Seega on praeguses õigusruumis võimalik teekond puudega inimeste teenusteni jõudmiseks järgmine: SKA tuvastab puude raskusastme, seejärel pöördub isik KOV-i, kus tehakse põhjalik abivajaduse hindamine ning pakutakse teenuseid. Sügava puude korral on proaktiivselt kontakti võtmise kohustus KOV-il. Kohustuse täitmist ei seirata. Sotsiaalministeeriumi

andmetel on 16 omavalitsust soovinud saada proaktiivselt abivajaduse hindamiseks andmeid ka keskmise ja raske puudega isikute kohta. EPIKojani on jõudnud korduvalt info, et sügava puude puhul siiski proaktiivselt abi pakkumist ei toimu. Abi saamiseks võib omavalituse poole pöörduda ka isik, kellel on kroonilisest haigusest, erivajadusest või pikaajalisest terviseprobleemist põhjustatud hooldusvajadus. Seega võivad tervisekahjustusega inimesed jõuda teenusteni ka ilma puude tuvastamiseta.

Praktikas ei ole see teekond hästi rakendunud ega vasta puuetega inimeste ootustele ja vajadustele. Töötubades osalejate kogemustest võib järeldada, et pärast puude otsuse saamist ei saa inimene piisavalt selget ja praktilist infot, kuidas oma olukorda parandada, näiteks kust saab talle vajalikke abivahendeid või teenuseid. Süsteem eeldab, et inimene ise pöördub SKA, TK nõustaja või KOV sotsiaaltöötaja poole. Töötubades osalejate kogemused viitavad, et inimesed pole sellest eeldusest kas teadlikud või ei vasta see vajadustele. Otsusega saadetakse taotlejale teabeleht infoga. Töötubades osalejate kogemused viitavad, et see ei ole inimese jaoks piisav. Levinud on olukord, kus inimesed saavad info juhuslikult tuttavate käest. Seda puudujääki illustreerib ka asjaolu, et uuringu raames tehtud töötubades oli osalejatel suur huvi vestluste käigus omavahel teenuste ja soodustuste kohta infot jagada. Kui taotlemisele ei järgne infot ja soovitusi teenustest või teistest abi saamise võimalustest, tekib inimestes pettumus ja frustratsioon.

Lisaks on teenuste kättesaadavus piirkonniti väga erinev. Töötubades osalesid inimesed nii keskustest kui väljaspool keskus erinevatest piirkondadest ning aruteludes tuli välja suured erisused pakutavate teenuste ja nende tingimuste osas. Mitmetes kohalikes omavalitsustes on teenused seotud puude raskusastmega ning samuti leibkonna sissetulekutega.

Lahendusettepanekud:

- ✓ Personaliseeritud lähenemine – koos puude otsusega antakse inimesele info tema piiranguid tasandavatest teenustest.

Kitsaskohad kliendikogemuses

Klienditeekond on pikk ja kurnav

Kuigi töövõime ja puude raskusastme hindamine on digitaliseeritud ning võimalikult bürokraatiavaba, osutavad varasemad uuringud, et protsess on pikk ja keerukas ning kogemused toetuse taotlemisest võivad olla koormavad ja emotsionaalselt kurnavad. Projekti „Welfare Experiences“ fookusgruppides toodi esile stress, ärevus ja emotsionaalne pinge, mis kaasneb töövõime vähenemise ja puude raskusastme hindamise protsessiga (Welfare Experiences). Siinse uuringu töötubades rõhutati samuti ühe keskse probleemina protsessi keerukust. Tuleb arvestada, et töövõime ja puude raskusastme tuvastamise taotluse esitajad on terviseprobleemidega inimesed, kellel võivad olla valud, krooniline väsimus, piirangud

asjaajamisel jms. Esmataotlejal on tõenäoliselt samal ajal käsil elukorralduse muutustega seotud toimetusi ja kohustusi.

Töötubades kirjeldati, et hindamisprotsess ei piirdu pelgalt küsimustiku täitmisega. Kirjeldati olukordi, kus enne korduvtaotluse esitamist broneerib inimene mitme eriarsti vastuvõtu, kuigi tema tervises seisund pole muutunud. Vastuvõtud on vajalikud üksnes selleks, et tervise infosüsteemi tekiks värskem info, mis omakorda mõjutab hindamistulemust. See koormab nii taotlejat kui ka tervishoiusüsteemi.

Inimesel puudub ligipääs puude tuvastamise otsuse hindamise alustele. Punktiskoori ja hinnangu kujunemist näeb ainult eraldi päringu esitamisel. Otsuses on viidatud seaduse sätteid, ilma et neid tsiteeritaks. See tähendab, et otsuse mõistmiseks peab inimene suutma lugeda seadust ning viidatud sätteid leidma.

Töövõime ja puude hindamise teekond inimese vaatest:

Järgnevalt on kirjeldatud näide teekonnast, mis joonistus välja töötubade osalejate kogemustest (enda, kui ka inimeste, keda nad on nõustanud).

- Taotlemisele eelneb **6 kuu jooksul arstide külastamine**, et uuendada TIS-andmeid. Püsiva seisundiga inimeste jaoks ei pruugi arsti külastamine vajalik olla, seda tehakse ainult hindamise pärast. Näiteks peab eluaegne kurt saama arstilt iga 3 aasta järel audiogrammi. Kuna puude otsus sõltub suuresti TIS andmete kvaliteedist, **peab inimene arsti juhendama**, et tervisepiiranguid kirjeldataks detailselt. Mitmete erinevate diagnoosidega inimesed teevad mitmeid eriarstivisiite.
- Paljudel inimestel **on vaja taotlemisel ligipääsetavuse tõttu abi**. Selleks pöörduetakse viipekeeletõlgi, töötukassa konsultandi, lähedaste või esindusorganisatsioonide poole. Taotluse täitmisel tuleb oma kogemus esitada ametlikus keeles ja vastata hüpoteetilistele küsimustele, mis ei peegelda inimese igapäevast tegelikkust.
- Kui hindamise tulemus ei vasta inimese tegelikele vajadustele, ei ole enamasti selge, miks otsus just selline tuli, millised andmed puudusid, mis jäi ebapiisavalt kirjeldamata või kuidas olukorda hinnati. Seetõttu ei tea inimene, mida vaide või uue taotluse esitamisel muuta.
 - Inimene peab **küsima ligipääsu puude tuvastamise alustele**. Seejärel peab ta **otsima** välja otsuses viidatud seaduse paragrahvid ning analüüsima, mis infot puudu jäi. Alles seejärel saab alustada vaide või uue taotluse esitamist.
- Ka pärast positiivset otsust **ei anta inimesele ülevaadet talle vajalikest ja teoreetiliselt kättesaadavatest teenustest**. Töövõime hindamise otsusega kaasneb fail teenuste üldise loeteluga, kuid inimene peab ise välja selgitama, mis talle sobivad ja vajalikud, kelle poole pöörduda ja millistel tingimustel teenuseid või abivahendeid saada. Praktikast tähendab see, **et infot kogutakse perearstilt, eriarstidelt, KOV sotsiaaltöötajalt, esindusorganisatsioonidelt** või tuttavatelt. See illustreerib Riigikontrolli (2024) järeldust, et abi saamiseks peab inimene tundma ning oskama orienteeruda kogu sotsiaalhoolekandesüsteemis.
 - Esindusorganisatsioonide poole pöörduvad sageli ka inimesed, kellel puuet ei ole tuvastatud, kuid kelle igapäevaelu siiski eeldaks teenuseid ja abivahendeid.

Kasutajamugavus ja ligipääsetavus

Töötubades tõid mõned osalejad esile kitsaskohti seoses töövõime ja puude tuvastamise taotlusega. Aruteludes ei käsitletud töövõime ja puude tuvastamise taotluste ligipääsetavust eraldi, sest ligipääsetavuse hindamine polnud uuringu fookuses. Taotluse täitmisele kuluv aeg ja hinnang mugavusele võib sõltuda inimese terviseprobleemidest, võimekusest ja abi kättesaadavusest. Seega ei saa all kirjeldatud kitsaskohtade osas teha üldistavaid järeldusi. Kasutajakogemusele ja ligipääsetavusele võib olla vajalik pöörata rohkem tähelepanu, kuivõrd taotlejad ja nende võimekus on väga erinev.

Mõnevõrra enam nägid taotlust keerulise ja koormavana vanemaealised osalejad. Oluline on arvestada digilõhega, mis on kõige suurem maapiirkondade vanemaealiste elanike seas (Sakkeus ja Tambaum, 2025). Terviseprobleemidega inimeste jaoks võib digilõhe olla võimendatud.

Nii tööealiste kui vanaduspensioniealiste töötubades osalejad tõid kitsaskohana korduvalt välja, et taotluse täitmisele kulub mitu tundi. Selleks võib olla erinevaid põhjuseid. Näiteks oleneb taotluse täitmise aeg sellest, kui suur osa taotlusest täita tuleb. Töötubadest ilmnes, et taotlejad alati ei adu, et ei pea vastama küsimustele tegevuste kohta, milles piiranguid ei ole, kuigi vormis on see viidatud. Töövõime taotlemise pilootuuring näitas, et taotluse täitmise aeg võib varieeruda mõnest minutist mitmete tundideni; keskmiselt kulus vormi täitmiseks 55 minutit (Kreitzberg, Kamenik & Sinisaar, 2015). Siinse uuringus töötubades osalejate hulgas oli mitmeid, kes rõhutasid, et selleks kulub mitmeid tunde.

Samuti leiti, et küsimused pole alati arusaadavad. Mitmed osalejad leidsid, et vastamiseks on vaja oma kogemust tõlgendada ja kirjeldada viisil, mis pole intuiitiivne ja loomulik. Näiteks võib olla raske mõista küsimusi, mille osas pole taotlejal otsest igapäevast kogemust. Samuti peab taotleja mõtlema ja otsustama, millises osas ja kuidas jagada infot piirangute kohta, mida pole otse küsitud.

Eeltoodu tõttu vajavad esindusorganisatsioonide esindajate sõnul paljud, eriti vanemad inimesed, taotluse täitmisel abi. Abi saadakse lähedastelt, esindusorganisatsioonidelt, tuttavatelt, samuti SKA klienditeenindusest. Tööealised saavad abi ka TK konsultandilt. Sealjuures toodi välja, et TK konsultandi vastuvõtuaeg on piiratud ja selle jooksul ei pruugi jõuda kogu taotlust täita, mistõttu tuleb käia vastuvõtul mitu korda. See teeb taotlemise inimese jaoks koormavaks.

Ligipääsetavusega seotud kitsaskohti mainisid erinevate puudeliikide esindajad. Pimedate organisatsioonide esindajad mainisid, et pimedate jaoks on mahuka taotluse täitmine koormav ja kõigil pole võimekust iseseisvalt iseteeninduskeskuses taotlust esitada. Taotluse täitmine võib oleneda kättesaadavatest vahenditest ja oskusest neid kasutada (nt ekraanilugeja). Samuti võib pimedatel olla raskusi ametiasutusse kohale minemisega (seoses tänavate, ühistranspordi ligipääsetavusega), et intervjuu vormis taotlust täita. TK pakub

võimalust tellida taotluse esitamisele viipekeele või kirjutustõlge. Samuti pakutakse tõlgi võimalust konsultandi juurde aja broneerimisel. Siiski mainisid töötubades vaegkuuljate ja kurtide esindajad, et ligipääsetav hindamine pole alati kättesaadav. Näiteks mainiti, et tõlkega kohtumised on mõnes piirkonnas saadaval vaid piiratud aegadel. Samuti on kitsaskohaks viipekeeletõlkide vähesus. See puudutab ligipääsetavust ka laiemalt kui taotluse esitamise kontekstis.

Vaiete esitamise koormus

Vaiet hindamise otsusele võib esitada vormivabalt kõikide kanalite kaudu. Nii EPIK kui ka töötubades osalejad tõid välja, et otsuste vaidlustamine on vaatamata näilisele lihtsusele inimese jaoks koormav. EPIKoja hinnangul peab arvestama sihtrühma eripära (terviseprobleemid/funktsioonipiirangud, sotsiaalse- ja majandusliku toimetuleku raskused jms), mille tõttu võimekus tegeleda vaide- ja kohtuasjadega võib olla keskmisest piiratum. Töötubades väljendati korduvalt, et vaidlustamine on koormav, seda nii vaimselt kui ka asjaajamise osas. Esiteks, vaide esitamine nõuab enda kehtestamist, tahet ja julgust oponeerida ning kahelda otsuse tegija kui autoriteedi otsustuses. Teiseks on vaide aluseks olevate dokumentide kogumiseks vaja asjaajamis- ja digivõimekust. Samuti tuleb otsuse põhjendust ja jagatud infot analüüsida – millist infot on vaja lisaks esitada, mis taotlusel jäi esitamata.

Lisaks peab inimene vaidlustama KOV otsuse, kui abi andmisest keeldutakse põhjusel, et tuvastatud ei ole teatud puude raskusastet või liiki. Kuigi ametlikult ei tohi sotsiaalteenuste osutamine olla seotud puude raskusastme olemasoluga, siis töötubades osalejate kogemused näitavad, et on endiselt KOVe, kus puude olemasolu on abi saamise eelduseks. Kohtusse pöördumine sotsiaalhoolekandelistes küsimuses on aga inimese jaoks sageli emotsionaalselt raske.

Töötubades oli mitmeid osalejaid, kellel oli vaide esitamise või kohtusse pöördumise kogemus, ja esindusorganisatsioon, kelle juurde vaide nõu saamiseks pöörduakse. Vaideprotsess on ajamahukas ja vaimselt kurnav ning sageli vajatakse selleks kõrvalist abi. Eriti haavatavas olukorras inimesed – nii töö- kui vanaduspensioniealised – jätavad sageli oma õigused kaitsmata, sest neil ei ole selleks ressursse.

- ✓ **Selgem viide, et inimene ei peaks täitma küsimustiku osi, mis tema seisundile ei kehti.** Kuigi praegu on TK ekspertide sõnul viited taotluses olemas, siis töötubadest võib järeldada, et need ei pruugi olla piisavalt selged, et taotleja seda alati mõistaks.
- ✓ **Puudespetsiifilised piirangud ja ligipääsetavus.** Taotlus peaks olema kättesaadav ja täidetav erinevate puuetega inimestele, nt pimedatele iseseisvalt täitmiseks. Portaali arendustesse võiks olla testijatena kaasatud erinevad vanuserühmad.

- ✓ **Korduvhindamise juhised.** E-kirjaga kutse võiks sisaldada juhiseid täitmiseks ning infot protsessi ja otsuse kujunemise kohta (hindamise alused, arvestatavad andmed, tähelepanekud taotlemisel).
- ✓ **Terminid lahti seletada.** Küsimustiku juures võiks veelgi enam selgitada kasutatud mõisteid.
- ✓ **Õiguslike aluste selgitus otsuses.** Otsuses viidatud õigusaktide sätted tuleks mitte ainult ära märkida, vaid ka selgitada.

Kui inimesel on mitmeid erinevaid terviseprobleeme, siis kogu protsess ja taotluse täitmine on koormav. See võib mõjutada taotluse täitmise otsust, eriti olukorras kus toetuse suurus on võrdlemisi väike, näiteks vanaduspensioniealiste hulgas.

Olemasoleva süsteemi kasutajasõbralikumaks tegemine seisneb eeskätt eeltäidetud taotluste kasutamises, otsuste kestvuse pikendamises püsivate seisundite puhul ning muude hindamiste arvesse võtmises.

9. Välisriikide praktikad

Välisriikide süsteeme kirjeldades keskendume toetustele, mida makstakse puudega inimestele ning mis ei ole sissetulekuasendajad (Eesti mõistes töövõimetoetus). Peatükis kirjeldatakse välisriikide toetussüsteeme, mis peavad katma puudespetsiifilised kulud ja toetama igapäevaelus hakkamasaamist.

Euroopa Sotsiaalpoliitika Analüüsi Võrgustik (ESPN) soovitas 2022. aastal, et puudest tulenevad lisakulud ei tohi jääda üksnes puudega inimese ja tema perekonna kanda. Kooskõlas puuetega inimeste õiguste konventsiooni juhistega peaksid sotsiaalkaitse süsteemid katma puudest tulenevaid lisakulusid kõikidele vanusegruppidele, sh mitte sissetulekupõhiselt, vältimaks horisontaalset ebavõrdsust (Baptista, Marlier, 2022).

Puude tuvastamisega on sageli seotud erinevad hüved, sh puudega isiku parkimiskaart, soodustused ühistranspordis, teenused, kodu kohandamine ja puude alusel makstavad toetused (*Ibid*). Mitmetes riikides, nt Saksamaal, Prantsusmaal ja Itaalias, jätkub puude tuvastamine vanaduspensionieas. Hindamise fookus võib sealjuures olla pikaajalise hoolduse vajadusel. Järgnevalt kirjeldame selliste riikide tugisüsteeme, kus vanaduspensionieas puuet ei tuvastata, kuid pikaajalise tervisekahjustusega inimestele on kättesaadavad toetused, teenused ja abi. Sellisteks riikideks on muuhulgas Soome, Rootsi ja Holland.

9.1. Soome

Abi ja toetus puuetega inimestele on Soomes heal tasemel ning puuetega inimeste vaesuse määr EL keskmisest tunduvalt madalam (Kalliomaa-Puha & Kangas, 2022). Soome Sotsiaal- ja Tervishoiuinstituudi THL (Tervej den ja hj vinvoinnin laitos) hinnangul on ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimine 2016. aastal ja sellest tulenevad meetmed oluliselt mõjutanud puuetega inimeste olukorda (THL).

Puude definitsioon

Puudega inimene on isik, kellel on puude või haiguse tõttu pikaajaline takistus tavapäraste elutegevuste sooritamisel (Disability : IN, Finland).

Hindamine

Toetuste taotlemisel täidab perearst või raviarst vormi (*B-lausunto*), milles kirjeldatakse põhjalikult tervises seisundit, funktsionaalseid võimeid, võimet töötada, prognoosi ja ravi. Sotsiaalkindlustusamet KELA määrab ekspertarsti kaasates terviseandmete alusel hüvitise või toetuse, kuid ei tuvasta puude olemasolu. Toetusele õigustatuseks hindab ekspertarst funktsionaalseid võimeid, kasutades RFK metoodikat, mis arvestavad füüsilisi, vaimseid, motoorseid ja intellektuaalseid takistusi ning piiranguid igapäevategevustes ja töös. Lõpliku otsuse toetuse määramisel teeb KELA ametnik.

Hüvitised ja toetused

Pikaajalise tervisekahjustusega tööelisel inimestel on võimalik saada tähtajatut **töövõimetuspensioni** või ajutiselt makstavat **rehabilitatsioonihüvitist**, mis on inimestele, kelle seisund eeldatavalt paraneb. Noortele vanuses 16–19 pakutakse tööalast rehabilitatsiooni ja rehabilitatsioonitoetust või haigushüvitist. Need on sissemaksetel põhinevad kindlustushüvitised.

Lisaks maksab KELA puuetega inimestele toetusi igapäevaelu kulude ja hooldusvajaduse katmiseks – need on elamispõhised toetused, mis ei sõltu inimese sissetuleku suurusest ning mille saamiseks ei maksta sotsiaalkindlustusmaksid. Toetuste taotlemiseks esitatakse taotlus koos raviarsti poolt täidetud terviseseisundi vormiga KELA-le.

Tööelisele inimesele vanuses 16–64, kes ei saa töövõimetuspensioni, makstakse puudega inimese toetust (*disability allowance for adults, vammaistuki*). Toetuse määramisel keskendutakse igapäevaelu abivajadusele. Toetuste saamiseks peab olema täidetud kolm tingimust – arsti poolt diagnoositud pikaajaline puue või haigus, sellest põhjustatud funktsioonihäire kestusega vähemalt 12 kuud ja vajadus abi järele.

Toetust makstakse kolmes määras (2025. aasta määrad):

- **Baasmääras (109,97 €) inimesele, kellel on haiguse tõttu raske kontsentreeruda, kes vajab diabeediravi ja kellel on komplikatsioonid või kel on raskusi keerulisemate ülesannete täideviimisega.**
- **Keskmisses määras (256,52 €) kui inimene vajab regulaarset abi igal nädalal riietumisel, pesemisel, sotsiaalsel suhtlusel või kellel on lisakulud teenustele.**
- **Kõrges määras (497,60 €) makstakse inimesele, kes vajab igapäevaselt abi tegevustes, kes on pime, liikumisvõimetu või täiskurt. (KELA)**

Üle 16aastastele inimestele, kes ei tööta ja saavad **töövõimetuspensioni, rehabilitatsioonitoetust või vanaduspensioni**, makstakse lisaks pensionisaaja hooldustoetust (*care allowance for pensioners²¹*). Toetuse saamiseks peab inimene vastama kolmele tingimusele: tal on puue või diagnoositud krooniline haigus; sellest põhjustatud funktsioonihäire kestusega vähemalt 12 kuud ning vajadus igapäevaelus abi, hoolduse või järelevalve järgi oma seisundi tõttu.

- **Baasmääras saavad toetust (84,17 €) inimesed, kes vajavad nädalas abi liikumisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, söömisel või ravimite võtmisel.**
- **Keskmisses määras saavad toetust (183,36 €) inimesed, kelle vajadused kattuvad baasmäära vajadustega, kuid kellel on puudest tingitud lisakulud või kes vajavad eelnimetatud tegevustega abi igapäevaselt. Samuti saavad keskmisses määras toetust**

²¹ Care allowance for pensioners. <https://www.kela.fi/care-allowance-for-pensioners>

mälu- või tasakaaluhäiretega inimesed. Lisakulud on toetatud elamise kulud, koduteenuste kulud, transpordi- ja majapidamistöõde kulud, ravimikulud, rehabilitatsiooniga seotud kulud.

■ **Kõrges määras (387,73 €) saavad toetust ööpäevaringset abi vajavad inimesed. (KELA)**

Puudega inimese hooldajale (omastehooldajale) määrab ja maksab toetust heaalupiirkond (varasemalt kohalik omavalitsus).

Teenused

Sotsiaalteenuste osutamist Soomes reguleerib sotsiaalhoolekande seadus ([Sosiaalihuoltolaki](#)). Puuetega inimestele pakutavaid teenuseid reguleerib puuetega inimeste teenuste seadus ([Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista](#)). Puuetega inimestele pakutavatele teenustele on inimestel **subjektiivne õigus**, st teenuste pakkumine ei sõltu olemasolevatest ressurssidest, vaid inimesel on õigus teenusele, kui ta vastab nende saamise tingimustele. Puudega inimesele osutatavate teenuste hulka kuuluvad isiklik abistaja, transporditeenus, eluasemeteenus, kodu kohandamine ja tehnilised abivahendid, päevased tegevused ning töötamise teenus (THL). Teenuseid osutab heaalupiirkond.

Heaalupiirkondades on puuetega inimeste nõukogud – koostööfoorumid puuetega inimeste ühenduste ja ametivõimude vahel. Nõukogu rolliks on mõjutada planeerimist, otsuste tegemist ja järelevalvet kõigis kohaliku omavalitsuse valdkondades. Puuetega inimesed ja nende perekonnad peavad olema nõukogudes piisavalt esindatud (THL).

Puudega inimese kaart ja parkimiskaart

Puudega inimese kaardi (EL puudega inimese kaart) väljastab KELA puudega inimese toetuse saajale ning hooldustoetuse saajale, lisaks kuulmispuudega või nägemispuudega või kõnepuudega isiku teenuste saajale. (KELA)²²

Puudega inimeste parkimiskaart antakse välja puudest või haigusest tuleneva liikumispiiranguga inimestele. Parkimiskaarti saab taotleda Transpordi- ja Kommunikatsiooniametist. Kaart väljastatakse meditsiinitõendi alusel, millest nähtub liikumispiirang ja selle raskusaste. Parkimiskaart antakse välja kuni kümneks aastaks, teoreetiliselt ka tähtajatult. Taotlust saab esitada meili teel või ameti iseteeninduses. (Traficom)

Hinnangud

Positiivsena on välja toodud, et toetuste taotlemine ei ole puuetega inimestele stigmatiseeriv. ESPAN võrgustiku ekspertide hinnangul on puuetega inimeste toetuste süsteem Soomes keeruline, see võib olla raskesti mõistetav ning seetõttu võivad inimesed jätta

²² EU Disability Card. <https://www.kela.fi/disability-card>

toetused taotlemata. Samuti on üleval küsimus tavapärasest vananemisest ja puudest, nt tavapärane vananemine ei anna õigust saada isikliku abistaja teenust, ehkki eakas inimene võib seda vajada (Kallioma-Puha & Kangas, 2022).

9.2. Rootsi

Põhiline puuetega inimeste hoolekannet reguleeriv seadus on *Act Concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments* (*Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade*, LSS). Eesmärgiks on pakkuda puuetega inimestele iseseisvat elu, võrdseid tingimusi ja kaasatust ühiskonnaellu. Puudepoliitika koordineerimise eest vastutab Tervishoiu- ja Sotsiaalministeerium.

Rootsi panustab pikaajalisse hooldusesse umbes 3,3% SKP-st. Rootsi sotsiaalne mudel põhineb suures osas kohalikel omavalitsustel, kes vastutavad sotsiaalhoolekande, ligipääsetavuse ja kohalikus kogukonnas osalemise eest.

Puude definitsioon

Puude definitsioon põhineb ÜRO puuetega inimeste konventsioonil. Puudega inimeseks loetakse neid inimesi, kellel on pikaajaline füüsiline, vaimne, intellektuaalne või sensoorne piirang, mis koostoimes erinevate takistustega võib takistada nende täielikku osalemist ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel (Disability :IN, Sweden).

Hindamine

Toetuste taotlemisel täidab raviarst põhjaliku tervisetõendi, milles kajastub tervises seisund ja funktsioonipiirangud. Rahaliste toetuste puhul hindab Rootsi sotsiaalkindlustusamet Försäkringskassan õigustatust taotluse ja arsti koostatud tervisetõendi alusel. Töövõimet hinnatakse ameti või töökoha kontekstis. Kui perearsti poolt edastatud dokumendist ei piisa, võib Försäkringskassan ise läbi viia eksperthindamise. Õigust toetusele hinnatakse „DFA-ahela“ abil ning seda kasutatakse iga taotluse hindamiseks. DFA-ahel koosneb kolmest osast: (1) diagnoos – haigust või puuet põhjustava seisundi diagnoos(id), (2) funktsioonihäire – millised funktsioonid on haiguse või puude tõttu häiritud, (3) tegevuspiirangud – diagnoosi ja/või funktsioonihäire tagajärjed. Hindamisel pannakse rõhku inimese enesemääratlusele ning võimele tööturul ja/või üldiselt elus aktiivne olla.

Toetused ja teenused

Töövõimetuspension koosneb Rootsis kahest hüvitisest: aktiivsushüvitisest (19–30-aastastele isikutele) ja haigushüvitisest (19–64-aastastele isikutele). Töövõime vähenemist hinnatakse kas 25%, 50%, 75% või 100% ulatuses, olenevalt juhtumist. Otsus tuleb langetada kuni nelja kuu jooksul pärast taotluse esitamist. (Försäkringskassan).

Lisaks maksab Försakringskassan puuetega inimestele erinevaid toetusi. Inimene esitab toetuse avalduse koos vastava arstliku tõendiga.

2021. aastast asendati puudega inimese toetus **lisakulude toetusega**. Reformiga sooviti selgemaid reegleid ning toetuse paremat sihitamist, makstes toetust üksnes tegelike lisakulude eest (Heap & Schön, 2022). Täisealised inimesed, kellel on puudest tulenevad lisakulud, saavad Försakringskassanilt taotleda toetust nende hüvitamiseks.

Lisakulud on kulud, mida ei ole samas vanuses ilma puudeta inimestel ning mida ei korvata muudest allikatest, sh KOV poolt. Samuti ei kompenseerita kulusid teenuste eest, mida saab pakkuda omavalitsus (nt ei kompenseerita abivahendi kulusid, kui omavalitsusest saab laenutada tasuta abivahendi). Lisakulud võivad esineda seitsmes kategoorias, milleks on: ravimid ja toit, ringiliikumine, abivahendid, teenused, eluase, riided, ja muud kulud.

Kulude kalkulatsiooni teeb taotleja, kasutada saab Rootsi Tarbijaameti andmeid tavapärase, s.o ilma puudeta inimeste kulude kohta. Lisakulud arvutatakse aasta kohta, kuid toetust makstakse igakuiselt. Kulu peab olema mõistlik ja põhjendatud. Toetust makstakse, kui aastased kulud ületavad 1300 eurot, sellest summast väiksemate kulude puhul toetust ei maksta. Toetuse suurus on 133–311 € kuus sõltuvalt aastastest kuludest.

Lisaks maksab sotsiaalkindlustusasutus toetust inimestele, kes on nooremad kui 66-aastased ning vajavad isiklikku abistajat ja abi rohkem kui 20 tundi nädalas. Inimesed, kelle abivajadus on väiksem, saavad isikliku abistaja teenust omavalitsuselt. Toetuse saamiseks on vaja arstitõendit, millest nähtub puue. Toetuse määramiseks kohtutakse inimesega tema kodus, telefoni teel või asutuses. Otsuse tegemiseks on asutusel aega 4 kuud.

Liikumispiiranguga inimesed, kes ei saa piirangu tõttu kasutada ühistransporti, saavad taotleda toetust kohandatud auto jaoks.

Tööealised inimesed, kes haiguse või puude tõttu on sageli või pikaajaliselt haiguslehel, saavad taotleda kõrge riski kaitset. Sellega kompenseeritakse tööandjale tema poolt makstud haigushüvitise kulud. Lisaks on puuetega inimestele eraldi toetus tööalaste abivahendite soetamiseks, eluasemetoetus ja hambaravitoetus. (Försakringskassan)

Teenuseid puuetega inimestele pakuvad kohalikud omavalitsused. Abivajadust hindab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja näost-näku kohtumisel.

Puudega inimese kaart ja parkimiskaart

Parkimiskaardi vajadust hindab ning neid väljastab kohalik omavalitsus. Üleriigilist puudega inimese kaarti Rootsis praegu ei ole.

Hinnangud

ESPN ekspertide hinnangul pakub Rootsi puuetega inimestele palju programme, mis aitavad neil iseseisvalt elada ning ühiskonnaelus osaleda. Samuti on perekonnad vabastatud

hoolduskohustustest, nt isikliku abistaja teenusega. Probleemina on esile toodud seniste poliitikameetmete jätkusuutlikkuse puudumist ja praeguse heaolumudeli säilitamise kulud (Heap ja Schön, 2022).

9.3. Holland

Peamisena sissetuleku kaotust kompenseeriv töövõimetuse süsteem pakub hüvitisi osalise (35-80%) ning täieliku töövõimetuse korral (80–100%). Osalise töövõimetuse puhul eeldatakse, et tervisesesund võib muutuda ning inimene võib jätkata töötamist või tööle naasta. Hüvitise suurus põhineb teoreetilisel töötasul, mida inimene on võimeline teenima. Kui töövõime kaotus on täielik, ei tehta reeglina korduvhindamisi (MISSOC).

Hoolduse või abivajaduse korral saavad inimesed lisaks pöörduda tervishoiusüsteemi või kohaliku omavalitsuse poole, mis pakuvad pikaajalise hoolduse teenuseid või toetusi.

Puude definitsioon

Puude (*disability*) mõiste Hollandis on töökeskne – puudega on inimene, kes on võimeline töötama, kuid mitte ilma riigipoolse abita (*Disability: In, The Netherlands*). Puue defineeritakse RFK metoodika alusel, see on krooniline või pikaajaline tervisesesundist tulenev tegevuspiirang. Puue ei ole seotud diagnoosi olemasoluga või toetuste maksmisega.

Hindamine

Töövõimetuse, mida loetaksegi puudeks (*disability*), tuvastamisel hinnatakse funktsionaalset võimekust terviseandmete alusel.

Abivajadust hindab kohalik omavalitsus, pöörates tähelepanu sellele, mida inimene saab jätkuvalt teha ise, ning mida pereliikmete või teiste inimeste abiga. KOV pakub abi tegevustes, millega inimene ise või lähedaste abil hakkama ei saa. KOV teenused on kas personaliseeritud või standardsed. Personaliseeritud on nt seltsi pakkumine, kodu kohandused, transport, päevane tegevuskava, toetus mitteformaalsetele hooldajatele, koduteenused (koristamine). Standardsed teenused hõlmavad toidu toomist, poes käimist, abi kogukonnakeskustes.

Inimesed, kes vajavad pikaajalist hooldust kogu elu, pidevat järelevalvet või ööpäevaringset hooldust, pöörduvad hooldusvajaduse hindamiskeskuse Care Needs Assessment Centre (CIZ) poole, mis on tervishoiusüsteemi osa ning rahastatud kindlustusmaksetest. Keskus hindab, mitu tundi ja millist hooldust vajatakse (CIZ). Inimesed, kelle hooldusvajadus on väiksem ning kes ei kvalifitseeru CIZ teenustele, pöörduvad hindamiseks kohaliku omavalitsuse poole.

Toetused ja teenused

Hollandis on kompleksne ja keeruline toetuste ja teenuste süsteem, teenuseid pakutakse mitmete seaduste alusel nii tervishoiusüsteemi kui ka omavalitsuste poolt. Sealhulgas on

erisused töötajatele ja ettevõtjatele, näiteks ei ole füüsilisest isikust ettevõtjatel töötajatega samu hüvesid.

CIZ teenuseid pakutakse kas kodus või hoolekandetasutuses. Pikaajalise hoolduse teenuseid saavad nii puudega kui ka puudeta isikud. Tervishoiusüsteemi kaudu kaetakse samuti abivahendite kulud, aga ka viipekeele tõlgi kulud.

Kohalikud omavalitsused (neid on üle 400) peavad pakkuma puuetega inimestele abi ja toetusi WMO (Social Support Act) alusel. Abi vajav inimene saab toetuse ise teenuste ostmiseks või pakub teenust omavalitsus (Ministry of Health, Welfare and Sports). Teenused hõlmavad hooldust, abi ja abivahendeid, kodu kohandamist, tehnoloogilisi abivahendeid. Teenuste pakkumisel võetakse arvesse inimese sissetulek ning omavalitsusel on kaalutusõigus, milliseid teenuseid pakkuda. Kohaliku omavalitsuse ja CIZ poolt samaaegselt teenuseid ei osutata.

Puudega inimese parkimiskaart

Puudega inimese parkimiskaardi saab isik, kelle liikumiskiirang ei võimalda kõndida 100 meetrit. Parkimiskaardi taotlemine käib kohalikust omavalitsusest, selle eelduseks on arstlik hinnang, mille korraldab omavalitsus. Kui omavalitsus on tuvastanud pikaajalise hoolduse vajaduse, siis arsti eksperthinnangut ei nõuta. Kaart määratakse reeglina viieks aastaks.

Hinnangud

Kohalikel omavalitsustel on suur kaalutusõigus puuetega inimeste toetamisel, mis võib osutada nii tugevuseks kui nõrkuseks. Näiteks on omavalitsustes mitmeid häid praktikaid puuetega inimeste tööle aitamisel, abivahendite tagamisel või rahaliste toetuste pakkumisel (Van Dijk, 2022). Samas erineb omavalitsuste pakutav suurel määral.

Võrdlus Eestiga

Peamine sissetulekukaitse tööealistele inimestele tagatakse vaadeldud riikides sarnaselt Eestile püsiva töövõimetuse hüvitisega (haigushüvitis, rehabilitatsioonihüvitis, töövõimetuspension vms). Neid hüvitisi vanaduspensionieas ei maksta.

Puudest tulenevad lisakulud ja hooldusvajadus tuvastatakse eraldi hindamisega. Hindamise eelduseks on pikaajaline tervisekahjustus või funktsioonipiirang, mida käsitletakse puudena. Inimene, kellel on pikaajaline tervisekahjustus või krooniline haigus, taotleb hindamist toetuste ja teenuste õigustatusele, kuid mitte puude tuvastamist.

Soomes, Rootsis ja Hollandis ei ole puuetega inimeste iseseisva elu toetamise toetused ja teenused vanusegrupiti diferentseeritud. Soomes eristatakse toetused sõltuvalt sellest, kas inimene suudab osaliselt töötada või on täielikult pensionil (sh tööealine isik). Sarnaselt Eestile kaetakse Soomes puudest tulenevad lisakulud kehtsandi poolt. Kuigi puude

raskusastet ei määrata, tuvastatakse toetuse maksmiseks funktsioonihäire ja abivajaduse ulatus.

Rootsis ei tuvastata puuet, kuid lisakulude toetusega kompenseeritakse tegelikud kulud, mis tulenevad inimese puudest ning mida ilma puudeta inimestel ei esine. Selleks hinnatakse inimese funktsioonipiiranguid ning kulusid, mida inimene ise raporteerib. Toetust määrab ja maksab kesktasand, see on igakuine ning toetuse suurus sõltub aastasest kulust.

Hollandis pakutakse teenuseid ja toetusi hooldus- või abivajadusega inimestele sõltuvalt hooldusvajaduse intensiivsusest kas tervishoiusüsteemi või kohaliku omavalitsuse poolt. Pikaajalise hoolduse vajaduse hindamisega tuvastatakse tervishoiusüsteemi poolt pakutavate teenuste vajadus või sotsiaalsüsteemi (KOV-id) poolt pakutavate teenuste vajadus.

Üheski vaadeldud riigis ei maksta puudest tulenevaid toetusi **ilma eraldiseisva hindamiseta**, üksnes töövõime(tu)se hindamise alusel.

Puudega inimese parkimiskardi saamine toimub arstitõendi alusel või hindab õigustatust terviseandmete alusel KOV.

Tabel 3. Puudega inimese parkimiskaart

	Soome	Rootsi	Holland
Kaardi väljastamise alus	Arsti väljastatud terviseandmete vorm	Omavalitsuse läbi viidud hindamine	Omavalitsuse läbi viidud arstlik ekspertiis
Väljastav organisatsioon	Transpordi-ja Kommunikatsiooniamet	Kohalik omavalitsus	Kohalik omavalitsus
Kehtivusaeg	Kuni 10 aastat	Enamasti 5 aastat	Enamasti 5 aastat

9.4. Lähiriikide reformid

Eesti lähiriigid Läti ja Leedu on hiljuti läbi viinud või alustanud puuetega inimeste toetamise süsteemide reformimisega. Järgnevalt anname ülevaate nende riikide reformidest või reformikavadest. Leedu ülevaate koostamisel konsulteeriti Leedu Puuetega Inimeste Foorumi presidendiga.

Leedu

Leedus jõustus 2024. aastast puude tuvastamise reform, millega muudeti puuetega inimeste õiguste kaitse seadust ja selle aluseid. Reformiga liiguti traditsiooniliselt meditsiinilistele kriteeriumidele keskendunud süsteemilt RFK põhisele funktsioonidest lähtuval süsteemile. Terminoloogias asendati varem stigmatiseerivad väljendid mõistetega nagu „osalemise tase”

ja „individuaalne abivajadus”, lisaks pandi rõhku ligipääsetavatele suhtlusvahenditele ja selges keeles teabele.

Reform hõlmas **institutsionaalset muudatust**: varasemad struktuurid ühendati ning Sotsiaalministeeriumi haldusalasse loodi Puuetega Inimeste Õiguste Kaitse Amet (ANTAA). Ameti ülesannete hulka kuulub õiguste kaitse koordineerimine, poliitika ja programmide rakendamine ning individuaalse toe plaanide koostamine. Amet tuvastab puude raskusastme lastel, osaluse taseme tööelistel ja eakatel, otsustab teenuste kulude hüvitamise ning annab puuetega inimestele infot nende õiguste kohta. Osaluse tasemega on seotud puudega inimese kaardi saamine (Agency for the Protection of the Rights of Persons with Disability). Hüvitised – töövõimetuspensioni ja lisakulude toetuse – maksab välja Sotsiaalkindlustusamet.

Reform tõi kaasa ka süsteemi muudatused ja **“ühe ukse” poliitika**. Enne 2024. aastat hinnati tööelistel inimestel töövõime kaotuse protsenti ja puude raskusastet, vanaduspensioniealistel ainult puude raskusastet. Hindamine põhines valdavalt meditsiinilisel diagnoosil. Alates 2024. aastast viiakse läbi RFK-põhine ühishindamine, mis hõlmab osalemise taseme määramist (varasem töövõimetus), puude raskusastme tuvastamist ja KOV teenuste vajaduse tuvastamist. Hindamine põhineb terviseandmetel ja individuaalse küsimustiku täitmisel, mille tulemus seotakse koordinaatsiooniplaani kaudu omavalitsuse poolt pakutava toega. Osalemise taseme protsent määratakse 6–24 kuuks või tähtajatult; puude staatuse saavad isikud, kelle tulemus on 0–55%. Raske ja sügava vaimse alaarengu diagnoosiga täisealiste puhul võrdsustatakse osalemise tase nulliga. Hindamist tehakse vajadusel inimese kodus või hooldusasutuses (Made in Vilnius, 2023).

Vanaduspensioniiikka jõudnud inimestel hinnatakse osalemise taset. Kui see on kuni 30%, saab inimene vanaduspensioni puudega inimesele, mis võib olla kõrgem tavalisest vanaduspensionist. Üleminekul uuele süsteemile uut hindamist ei tehta; eelnev puude raskusaste muudetakse vastavaks osalemise tasemeks. Suurema pensioni maksmine on võimalik üksnes kõrge erivajaduse taseme puhul. Eraldi puudega inimese toetust vanaduspensioniealistele ei maksta².

Kuna muudatused on kehtinud lühikest aega, siis on reformi tulemused ebaselged, puuetega inimeste poolt on välja toodud järgnevat³:

- **Pimedate esindajad on öelnud, et nende vaates on RFK põhine hindamissüsteem õiglasem. N.ö nähtamatute puuete korral on küsimusi ja kitsaskohti rohkem olnud. Keerulisemate erivajaduste puhul on hindamisel väga palju spetsiifikat, mida on raske arvesse võtta.**
- **Hindamise ja toe integreerimine on olnud samm õiges suunas, aga kriteeriumid abile peavad olema õiglased ja läbipaistvad. Näiteks isikliku abistaja teenust said omavalitsuses paljud vanaduspensioniealistel, aga tööelised jäid ilma.**
- **Halduskoormus inimese jaoks kasvas, kuna tuleb täita rohkem dokumente.**

- **Positiivne muudatus oli, et varem vähenes tööle minnes töövõimetuspensioni suurus. Uue süsteemiga kaotust ei ole.**
- **Rakendunud ei ole koordineeritud abi pärast puude raskusastme hindamist.**

Läti

Puude määrab Riiklik Meditsiiniline Komisjon (VDEĀVK/SMC) meditsiinilise mudeli alusel. Täiskasvanud jagatakse kolme gruppi: töövõime kaotus 80–100 %; töövõime kaotus 60–79 %; ning töövõime kaotus 25–59 %. Hindamine on dokumendipõhine ning enesehindamise vorme kasutatakse harva. Kuigi alates 2015. aastast mindi üle RFK põhisele lähenemisele⁴, siis praktiliselt muudatusi toimunud ei ole. Kriteeriumidesse kaasatud funktsioneerimise valdkonnad moodustavad väikese osa RFK laiemast loetelust ning pole selge, mille alusel need valiti.

Maailmapanga 2020. aasta hinnangus (Posarac, Celmina, & Bickenbach, 2020) leiti, et kuigi haldusprotsess on lihtne, nõrgestab seda arendamata infosüsteem ja standardiseeritud funktsiooni hindamise puudumine. Hindamine on endiselt meditsiiniline ja enesehindamise andmeid ei kasutata.

Lätis alustatakse puude tuvastamise reformiga lastest – hinnatakse funktsioneerimist (World Health Organization Disability Assessment Schedule ehk WHODAS küsimustik²³) koos intervjuuga. Katseprojekt käivitus septembris 2025.

2024. aastal ilmus raport²⁴ avatud aruteludeks täiskasvanute hindamissüsteemi muutmiseks. Eesmärk on liikuda meditsiinilisest, diagnoosipõhisest lähenemiselt RFK-põhisele lähenemisele, tagada läbipaistvad ja järjepidevad otsused ning standardiseeritud hindamisvahendid (sh erinevate seisunditele – nägemine, kuulmine, liikumine, vaimne tervis, kroonilised haigused) ja selgeid hindamislävendid ning võtta paremini arvesse vaimse tervise seisundid, mis meditsiinilistes mudelites jäävad sageli alahinnatuks. Läti plaanib täisealiste uue puude hindamise ellu viia 2029. aastal.

²³ Vt <https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health/who-disability-assessment-schedule>

²⁴ Invaliditātes novērtēšanas sistēmas pilnveide pilngadīgām personām. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/11a1b331-ea83-4e98-be6f-efccd6309ab6#

10. Sihtrühmade ülevaade

Selles osas kirjeldatakse eraldi tööealiste ja vanaduspensioniealiste sihtrühmi nii nende suuruse, profiili kui ka taustatunnuste järgi. Kirjelduses kasutatakse nii registriandmete analüüsi, EUROMODi ja Statistikaameti Eesti Sotsiaaluuringu 2016–2024 analüüsi tulemusi. Samuti esitatakse üksnes puudega tööealiste sihtrühma kvalitatiivuuringu tulemused.

10.1. Puudega ja vähenenud töövõimega tööelised inimesed

Et tööelistel on võimalik taotleda nii puude raskusastme kui ka töövõime ulatuse tuvastamist, siis analüüsitakse esmalt, kui paljudel on tuvastatud mõlemad ning kui paljudel on vaid üks neist.

Sihtrühma suurus ning puude ja töövõime tuvastamise vaheline seotus

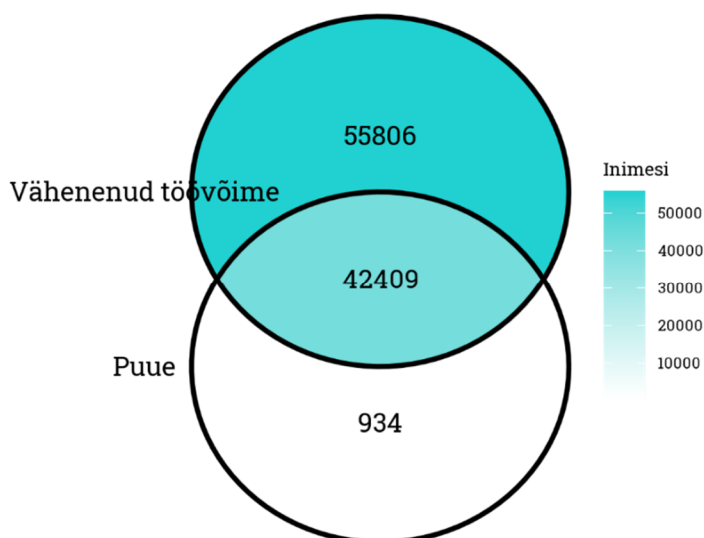
Registriandmete analüüsis kuuluvad tööealiste (18–64)²⁵ valimisse inimesed, kellel oli 2024. aastal vähemalt ühel päeval kehtinud puude raskusastme või vähenenud töövõime otsus. Kokku on selliseid inimesi 99 149. Püsiva töövõimetusega inimesed kaasati valimisse ainult juhul, kui neil on puue. Seetõttu jäid registriandmetest välja need, kellel puude raskusastet ei olnud tuvastatud, kuid oli hinnatud püsiva töövõime kaotuse ulatus²⁶. EUROMOD-i andmete järgi oli üksnes püsiva töövõimetusega 739 inimest.

Enamik tööelistest puudega inimestest oli 2024. aastal ka vähenenud töövõimega. Vähemalt ühel päeval oli 2024. aastal puue 43 343 tööelisel, kellest ligi 98%-l kehtis aasta jooksul vähemalt ühel päeval ka vähenenud töövõime hindamise otsus. Nii vähenenud töövõime kui ka puue esinesid samaaegselt vähemalt ühel päeval kokku 40 266 tööelisel inimesel. Tööeliseid inimesi, kellel oli puue, kuid ei olnud vähenenud töövõimet, oli 2024. aasta jooksul 934 (sh need, kellel oli puue ja püsiv töövõimetus).

²⁵ Nii tööealiste kui vanaduspensioniealiste sihtrühma vanus on seisuga 31.12.2024.

²⁶ Töötukassa hindab töövõimet ja maksab töövõimetoetust alates 1. juulist 2016. Enne seda hindas Sotsiaalkindlustusamet püsivat töövõimetust ja maksis töövõimetuspensioni kui töövõimetuse kaotus oli vahemikus 40–100%.

Joonis 3. Tööealised (18–64-aastased), kellel oli 2024. aasta jooksul vähenenud töövõime, puue või mõlemad



Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registriandmete põhjal, Venni diagramm.

Märkus: Puude kategooriasse kuuluvad ka püsiva töövõimetusega inimesed, kuid seda Venni diagrammil ei eristata. Valimi suurus: 99 149 inimest

Analüüs keskendub tööealiste (18–64) seas neljale sihtrühmale (tabel 4). Esimese, kõige suurema rühma moodustavad inimesed, kellel on tuvastatud²⁷ vähenenud töövõime, kuid mitte puude raskusastet ehk puuet (edaspidi „üksnes vähenenud töövõimega“). Teise rühma moodustavad inimesed, kellel on tuvastatud puue, kuid mitte vähenenud töövõimet või püsivat töövõimetust (edaspidi „üksnes puudega“). Kolmanda rühma moodustavad inimesed, kellel on tuvastatud nii vähenenud töövõime kui ka puude raskusaste. See rühm jaguneb omakorda kaheks: esiteks need, kellel kehtis nii vähenenud töövõime kui ka puude raskusastme otsus üheaegselt vähemalt ühe päeva (edaspidi „samaaegselt puue ja vähenenud töövõime“) ning teiseks need, kellel oli 2024. aasta jooksul nii vähenenud töövõime kui ka puude raskusastme kehtiv otsus, kuid seda erinevatel aegadel. Analüüsi neljanda rühma moodustavad inimesed, kellel on hinnatud püsiv töövõimetust. Selles rühmas eristub kaks alarühma olenevalt sellest, kas puue on tuvastatud või mitte.

²⁷ Analüüsi valimi aluseks on otsuste kehtivusaeg ning kui otsus kehtis 2024. a vähemalt ühe päeva, siis hõlmati inimene valimisse. Seega tähendab „tuvastatud“ seda, et puude, vähenenud töövõime või püsiva töövõimetuse otsus kehtis vähemalt ühe päeva 2024. aastal.

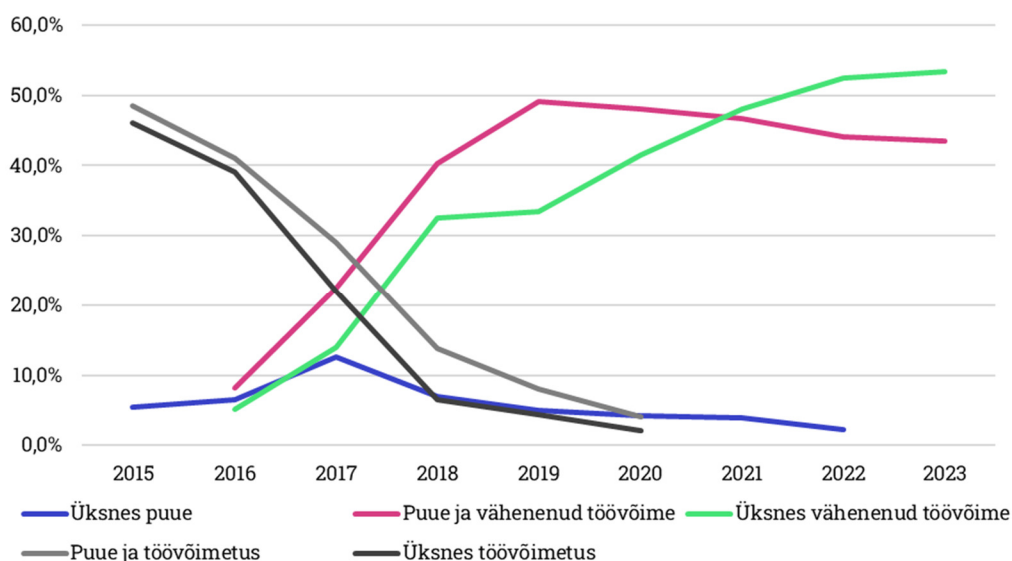
Tabel 2. Tööealised puude, vähenenud töövõime ja püsiva töövõimetuse järgi, 2024

Rühm	Inimesi kokku
Vähenenud töövõime, puuet ei ole (üksnes vähenenud töövõime)	55 806
Puue, töövõime vähenemist ei ole (üksnes puue)	218
Samaaegselt puue ja vähenenud töövõime vähemalt ühel päeval	40 266
Puue ja töövõime eri aegadel (aasta jooksul)	2 143
Püsiv töövõimetusetas ja puue	716
Püsiv töövõimetusetas, puuet ei ole (EUROMOD)	739

Allikad: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete ja EUROMODi maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli 2024. aasta registripõhised sisendandmete põhjal. Valimi suurus: 99 888 inimest

Tööealiste jaotust puude, vähenenud töövõime ja püsiva töövõimetuse järgi perioodil 2015–2023 analüüsisime Statistikaameti Eesti Sotsiaaluuringu andmetel. Analüüsi järgi oli ka enne töövõimereformi üksnes puudega tööealiste osakaal madal (5% 2015 aastal), samas 49%-l oli nii puue kui ka püsiv töövõimetusetas ja 46%-l üksnes püsiv töövõimetusetas. Alates 2019. aastast on üksnes puudega tööealiste osatähtsus veelgi vähenenud, jõudes 2022. aastal 2,2%-ni. Üksnes vähenenud töövõimega (osaline või puuduv töövõime) tööealiste osatähtsus tõusis töövõimereformi rakendumise järel juba 2018. aastal ligi 33%-ni ning 2023. aastal oli see 53%. Nii puue kui ka vähenenud töövõime otsusega tööealiste osatähtsus oli vaadeldud perioodil suurim 2019. aastal (49%), kuid on seejärel vähenenud, ulatudes 2023. aastal 43%-ni.

Joonis 4. Tööealiste jaotus puude, vähenenud töövõime ja püsiva töövõimetuse järgi, 2015–2023



Allikas: autorite arvutused Statistikaameti Eesti Sotsiaaluuring 2016–2024 alusel.

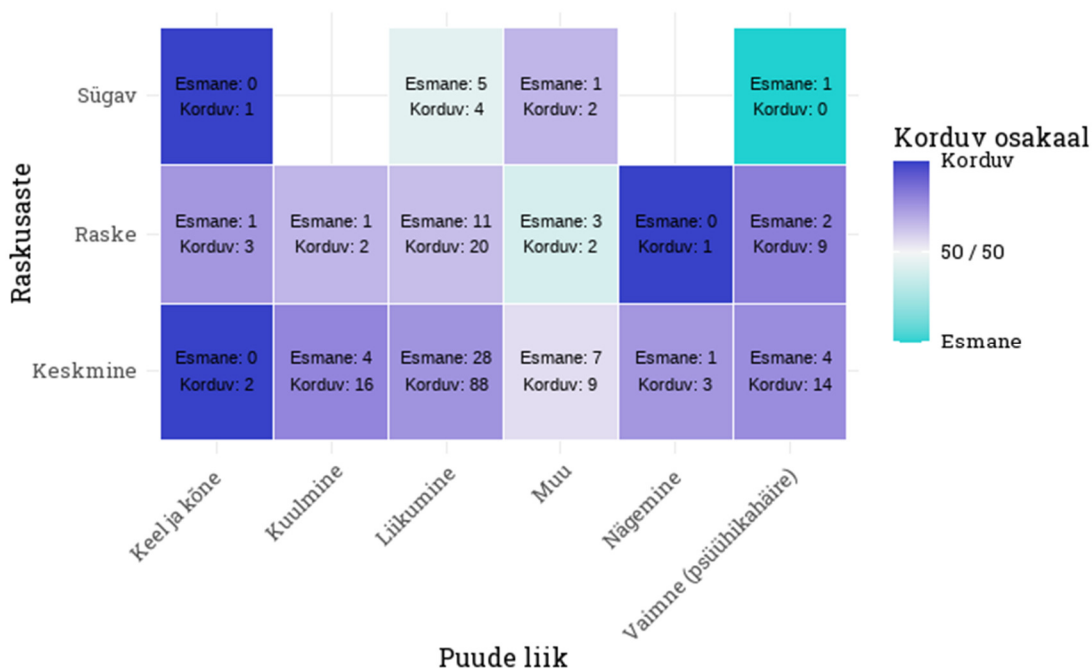
Märkus: Joonisel 4 esitatud osatähtsus näitab, kui suure osa vastav sihtrühm moodustas kogurühmast. Kogurühmaks on kõik tööelised, kellel oli puue, vähenenud töövõime või püsiv töövõimetus. Joonisel ei ole esitatud andmeid, mille vaatluste arv Eesti Sotsiaaluuringu valimis ei olnud avaldamiseks piisav – nimelt üksnes püsiva töövõimetusiga tööeliste ning samaaegselt nii puude kui püsiva töövõimetusiga tööeliste osatähtsust aastatel 2021–2023 ning ka üksnes puudega tööeliste osatähtsust 2023. aastal ei ole võimalik avaldada.

Puude raskusastme hindamise korduvtaotlemine ja töövõime hindamise otsuste kestus

Korduvaid puude raskusastme otsuseid oli igas rühmas rohkem kui esmaseid. Erinevus oli kõige väiksem rühmas, kus vähenenud töövõime ja puue esinesid eri aegadel. Selles rühmas oli 873 esmakordset määramist ning 1270 korduvat (1,45 korduvat iga esmase taotluse kohta). Üksnes puudega sihtrühmas oli 64 inimesel esmakordsel määratud puue ning 154 korduv (esmaste ja korduvate suhe 2,4). Samaaegselt vähenenud töövõime ja puudega inimeste seas oli esmaseid määramisi 5 885 ning korduvaid 34 381 (suhtarv 5,8). Kõige enam oli korduva puude raskusastme otsuseid püsiva töövõimetus ja puudega inimeste seas – ühe esmase puude otsuse kohta 43,75 korduva puude raskusastme hindamise otsust (16 esmakordset ning 700 korduvat).

Korduvaid puude raskusastme tuvastamise otsuseid oli reeglina rohkem kui esmaseid ka puude raskusastmete ja puudeliikide võrdluses. Joonistel 5 ja 6 on esitatud üksnes puudega ning samaaegselt puude ja vähenenud töövõimega inimeste jaotus esmaste ja korduvate otsuste alusel nii puudeliigi kui raskusastmete lõikes – tumedamad väljad viitavad suuremale korduvate otsuste arvule ning heledamad väljad esmastele otsustele.

Joonis 5. Üksnes puudega tööeliste puude raskusastme otsused puudeliigi, raskusastme järgi, 2024

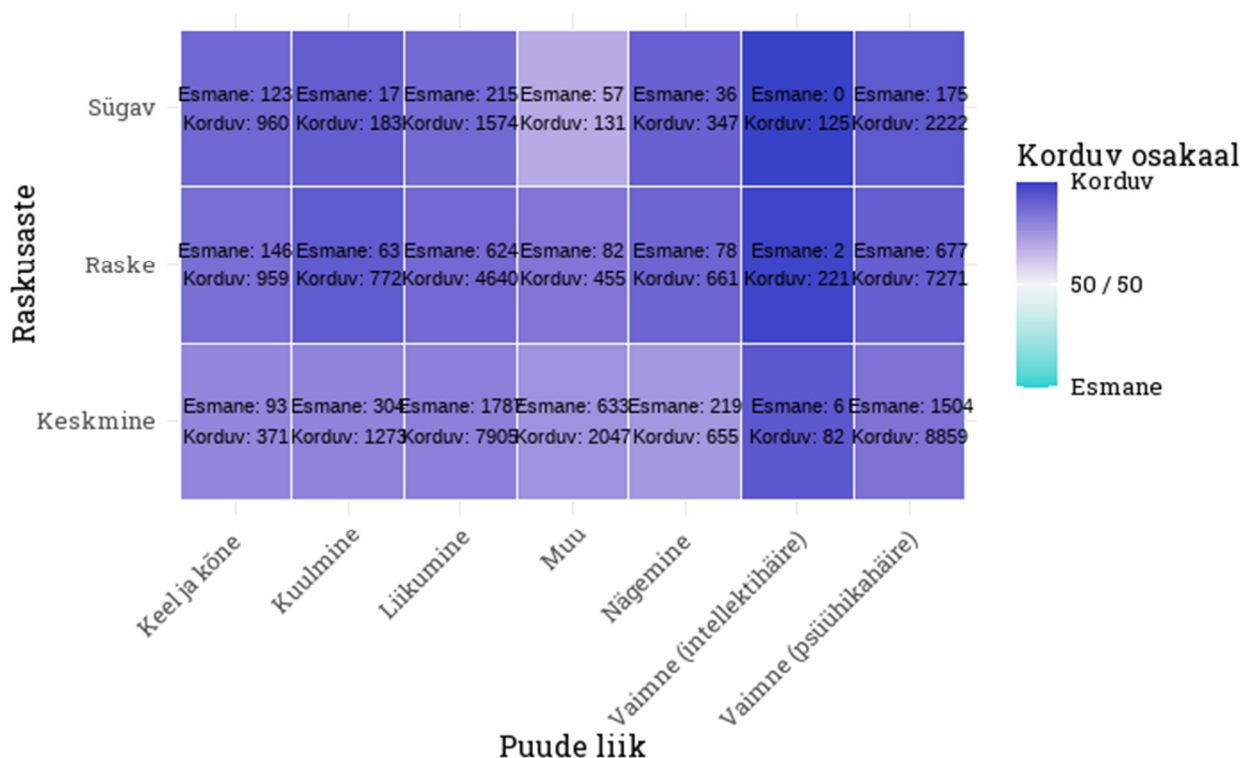


Allikad: autorite arvutused Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal. Valimi suurus: 218 inimest.

Märkus: Kui inimesel oli aasta jooksul mitu puudeliiki või raskusastet, siis ta esineb tabelis mitu korda. Joonisel on esitatud esmaste ja korduvate otsuste arv vastavas rühmas – esmased otsused on tähisega „1” ja korduvad „2+”, nt sügava liikumispuudega otsuste seas oli viiel juhul tegemist esmase ja neljal juhul korduva otsusega. Maatriksjoonisel on viitavad tumedamad väljad suuremale korduvate otsuste arvule ning heledamad väljad esmastele otsustele.

Korduvaid puude raskusastme tuvastamise otsuseid oli samaaegselt vähenenud töövõime ja puude raskusastme otsusega inimeste seas enam intellektipuude korral (olenemata puude raskusastmest). Puudeliikide võrdluses oli kõige vähem korduvate puude raskusastme otsuste osakaal muu puude korral.

Joonis 6. Samaaegselt vähenenud töövõime ja puudega tööelised puude tuvastamise otsuste korduvuse ja puudeliigi ja raskusastme järgi, 2024



Allikad: autorite arvutused Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal. Valimi suurus: 40 266 inimest

Märkus: Kui inimesel oli aasta jooksul mitu puudeliiki või raskusastet, siis ta esineb tabelis mitu korda. Joonisel on esitatud esmaste ja korduvate otsuste arv vastavas rühmas – esmased otsused on tähisega „1” ja korduvad „2+”. Maatriksjoonisel on viitavad tumedamad väljad suuremale korduvate otsuste arvule ning heledamad väljad esmastele otsustele.

Tabelis 5 on tööeliste puude otsuste kestused 2024. aastal. Kõige sagedamini oli puue määratud vanaduspensionini nende tööeliste seas, kellel oli nii püsiv töövõimetus kui ka puue (36,2%). Selles rühmas oli otsuse keskmine kestus 5 aastat. Kõige harvem oli puue määratud vanaduspensionieani rühmas, kus puue ja vähenenud töövõime esinesid eri aegadel. Keskmine otsuse kestus oli kõige lühem – 3 aastat ja 2 kuud – nii üksnes puudega kui eri aegadel puude ja vähenenud töövõime otsusega inimeste seas.

Tabel 5. Tööealised puude otsuse kestuse järgi, 2024

Rühm	Vanaduspensionieani	Otsuse keskmine kestus aastates
Üksnes vähenenud töövõime (n= 55 806)	N/A	N/A
Üksnes puue (n= 218)	67 (30%)	3 aastat 2 kuud
Samaaegselt puue ja vähenenud töövõime vähemalt ühel päeval (n= 40 266)	6 557 (16,3%)	4 aastat 4 kuud
Puue ja töövõime eri aegadel (aasta jooksul) (n= 2 143)	311 (14,5%)	3 aastat 2 kuud
Püsiv töövõimetus ja puue (n=716)	259 (36,2%)	5 aastat

Allikad: autorite arvutused Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal.

Märkus: Kui puue kestis vanaduspensionieani, ei ole nad arvestatud keskmise kestuse arvutamisel. Vanaduspensionieani määratud otsuste osakaal on esitatud tabelis.

Tabelis 6 on tööealiste vähenenud töövõime otsuste kestused 2024. aastal. Eri aegadel puude ja vähenenud töövõime otsusega inimestest 30%-l oli töövõime vähenemine määratud vanaduspensionini. Kõige vähem oli vähenenud töövõime otsuseid kuni vanaduspensionieani määratud üksnes vähenenud töövõimega inimestel. Samas keskmine töövõime otsuse kestus oli nii üksnes vähenenud töövõimega inimeste kui ka eri aegadel vähenenud töövõime ja puude otsust omanud inimeste seas samasugune. Mõnevõrra oli otsuste keskmine kehtivusaeg pikem juhtudel, kui samaaegselt esines nii puue kui vähenenud töövõime. Sihtrühmad, kus keskmine vanus on suurem, oli rohkem otsuseid vanaduspensionieani. Eri aegadel puude ja töövõime vähenemine grupis on suurim osakaal vanaduspensionieani otsuseid, sest ~34% sihtrühmast on 60–64 vanuserühmas.

Tabel 6. Tööealised vähenenud töövõime otsuse kestuse järgi, 2024

Rühm	Vanaduspensionieani	Keskmiselt mitu aastat
Üksnes vähenenud töövõime (n= 55 806)	8 795 (15,8%)	3 aastat 3 kuud
Üksnes puue (n= 218)	N/A	N/A
Samaaegselt puue ja vähenenud töövõime vähemalt ühel päeval (n= 40 266)	9 185 (23%)	4 aastat 5 kuud
Puue ja töövõime eri aegadel (aasta jooksul) (n= 2 143)	648 (30%)	3 aastat 3 kuud
Püsiv töövõimetus ja puue (n=716)	N/A	N/A

Allikad: autorite arvutused Sotsiaalkindlustusameti ja töötukassa registrite andmete põhjal.

Märkus: Andmestik ei sisalda töövõime hindamise otsuste korduvuste infot. Vanaduspensionieani määratud otsuste osakaal on esitatud tabelis.

Sihtrühm: üksnes vähenenud töövõime või puue

Üksnes vähenenud töövõimega inimeste seas oli enamikul (86,3%) osaline töövõime, samas kui puuduv töövõime esines vaid 13,7%-l. Üksnes puudega inimeste seas oli kõige sagedasem

keskmise puue (76,1% ehk 166 inimest) ning raske puue oli 19,2%-l (42 inimest) ja sügav puue 4,6%-l ehk kümnel inimesel.

Tabel 7. Üksnes puudega või vähenenud töövõimega inimeste jaotus puude raskusastme ja töövõime ulatuse järgi, 2024

Rühm	Osaline töövõime	Puuduv töövõime	Keskmine puue	Raske puue	Sügav puue
Üksnes vähenenud töövõime (n= 55 806)	48 143 (86,3%)	7 663 (13,7%)	N/A	N/A	N/A
Üksnes puue (n= 218)	N/A	N/A	166 (76,1%)	42 (19,2%)	10 (4,6%)

Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal.

Üksnes puudega inimeste hulgas oli kõige sagedasem liikumispuue, mis oli 156 inimesel, kellest 74% on keskmise puudega. 194 inimesel oli üks puudeliik, 21 inimesel kaks puudeliiki ning kolmel inimesel oli kolm või enam puudeliiki (tabel 8).

Tabel 8. Üksnes puudega inimeste jaotus puude raskusastme ja töövõime ulatuse järgi, 2024

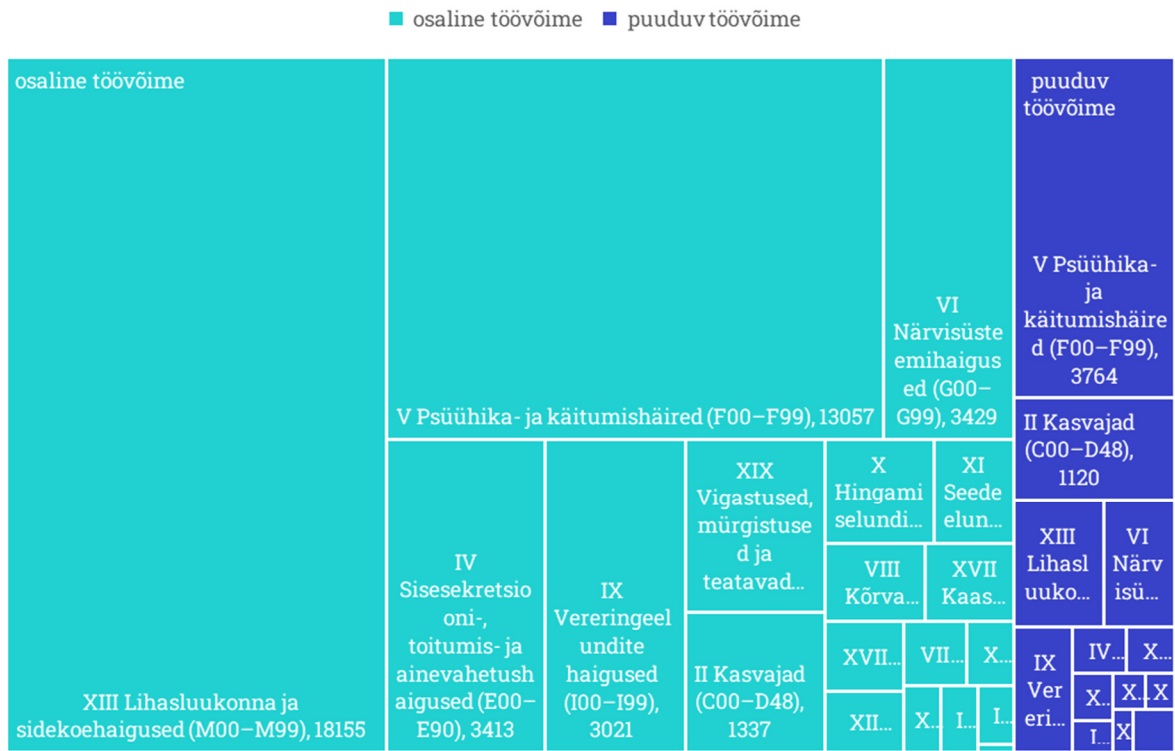
Puudeliik	Keskmine	Raske	Sügav	Inimesi kokku
Keel ja kõne	2	4	1	7
Kuulmine	20	3		23
Liikumine	116	31	9	156
Nägemine	4	1		5
Psüühikahäire				0
Intellektihäire	18	11	1	30
Muu	16	5	3	24

Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal. Valimi suurus: 218 inimest.

Märkus: Kui inimesel on mitu puudeliiki, siis ta esineb tabelis mitu korda.

Üksnes vähenenud töövõimega inimeste seas oli peamine töövõime vähenemise põhjus osalise töövõimega inimestel lihasluukonna ja sidekoehaigused (18 155 inimesel), samas kui puuduva töövõimega inimestel olid sagedasemad psüühika- ja käitumishäired (3 764 inimesel). Puuduva töövõime otsuste aluseks olnud diagnoosides esinesid sagedamini ka kasvajad (1120 inimesel) ning lihasluukonna ja sidekoe haigused (785 inimesel). Psüühika- ja käitumishäired olid väga levinud ka osalise töövõimega inimeste seas (13 057 inimesel). Töövõime vähenemise otsuses märgitud diagnooside jaotus on toodud joonisel 7.

Joonis 7. Üksnes vähenenud töövõimega inimeste jaotus töövõime ulatuse ja põhidiagnoosi järgi, 2024



Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal. Valimi suurus: 55 806.

Märkus: kõigi diagnooside jaotus on esitatud tabelina Lisa 5 tabel 46.

Sihtrühm: samaaegselt puue ja vähenenud töövõime või püsiv töövõimetus

Kui samaaegselt (vähemalt ühel päeval) esines nii puue kui ka töövõime vähenemine, siis enamasti on tegemist puuduva töövõimega inimestega (75% ehk 30 093 inimest 40 266-st). Viimaste seas on kõige enam inimesi, kellel kehtis puuduva töövõimega samaaegselt ka keskmise puude raskusastme otsus (14 110 inimest). Mõnevõrra vähem on neid, kellel on puuduva töövõimega samal ajal raske puue (12 393 inimest).

Samaaegselt nii puude raskusastme kui vähenenud töövõime otsust omanud inimeste seas on osalise töövõimega inimesi 10 173 ehk 25%. Seejuures on nende seas kõige enam neid, kellel on keskmine puue ja osaline töövõime (9 330 inimest). Raske või sügava puudega, kuid samal osalise töövõime otsusega oli kokku 843.

Kokkuvõttes on samaaegselt nii puude kui vähenenud töövõime otsust omanud inimeste seas enam puuduva töövõime ja keskmise puudega (35%), puuduva töövõime ja raske puudega (31%) inimesi, kuid ka osalise töövõime ja keskmise puudega inimesi (23,2%).

Tabel 9. Samaaegselt puude ja vähenenud töövõimega inimeste jaotus puude raskusastme ja töövõime ulatuse järgi ning püsiva töövõimetuse ja puudega inimeste jaotus puude raskusastme järgi, 2024

Rühm	Keskmine puue	Raske puue	Sügav puue	KOKKU
Osaline töövõime	9 330 (23,2%)	803 (2%)	40 (0,1%)	10 173
Puuduv töövõime	14 110 (35%)	12 393 (31%)	3 590 (9%)	30 093
Vähenenud töövõime ja puue KOKKU	23 440	13 196	3 630	40 266 (100%)
Püsiv töövõimetus	127 (17,7%)	321 (45%)	268 (37%)	716 (100%)

Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal.

Märkus: Tabelis esitatud %-jaotus näitab osatähtsust kõigist inimestest, kellel oli samaaegselt puue ja vähenenud töövõime. Eraldi real on püsiva töövõimetusega inimeste jaotus puude raskusastme järgi.

Püsiva töövõimetuse ja puudega inimeste seas on aga enam raske ja sügava puudega inimesi – 45%-l oli raske puue, 37%-l sügav puue ning vaid 17,7%-l oli keskmine puue (vt tabel 9).

Samaaegselt puude ja vähenenud töövõimega inimeste hulgas oli kõige sagedasemad puudeliikideks psüühikahäired (20 708 inimesel) ja liikumispuue (16 745 inimesel) (tabel 10). Psüühikahäirega inimestest 50% ning liikumispuudega inimestest 57% on keskmise puudega. Enamikul samaaegselt puude ja vähenenud töövõimega inimestest (33 600) esines üks puudeliik. Kahe puudeliigiga oli 5 282 inimest ning kolme või enama puudeliigiga oli 1384.

Tabel 10. Samaaegselt puude ja vähenenud töövõimega inimeste jaotus puudeliigi ja raskusastme järgi, 2024

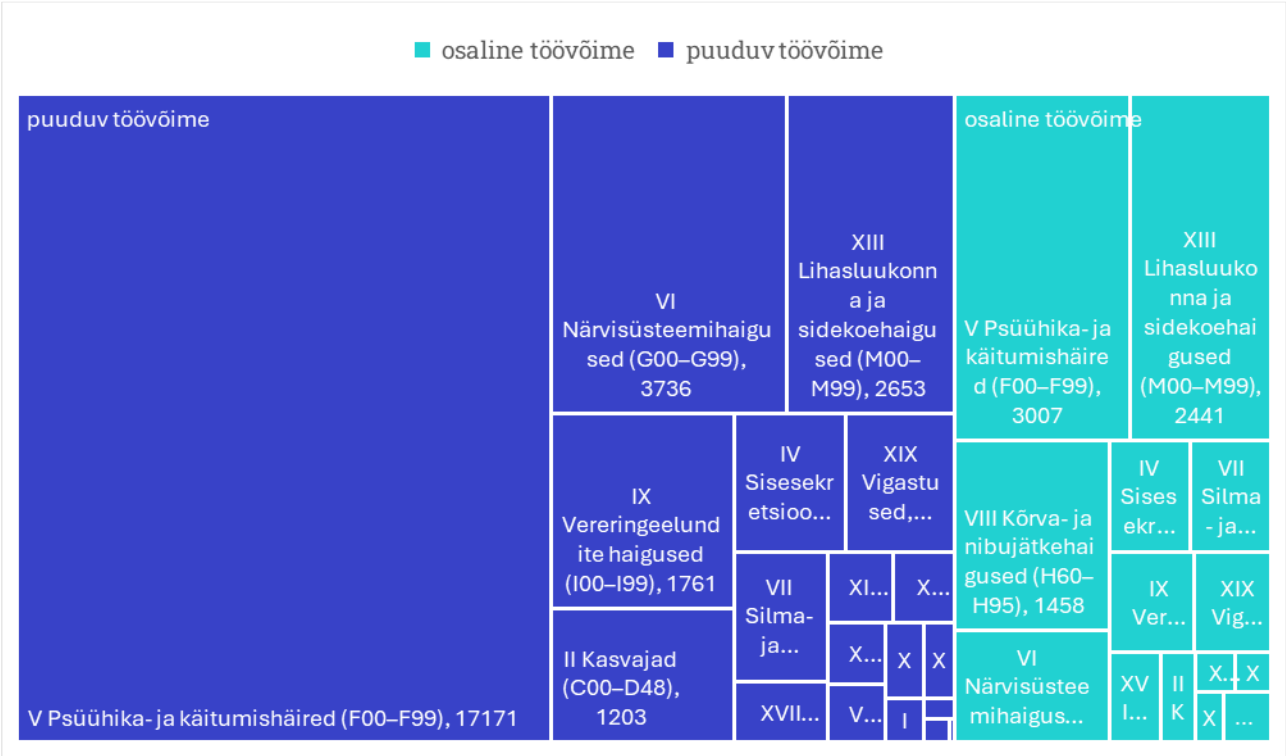
Puude liik	Keskmine	Raske	Sügav	Inimesi kokku
Keel ja kõne	464	1 105	1 083	2 652
Kuulmine	1 577	835	200	2 612
Liikumine	9 692	5 264	1 789	16 745
Nägemine	874	739	383	1 996
Psüühikahäire	10 363	7 948	2 397	20 708
Intellektihäire	88	223	125	436
Muu	2 680	537	188	3 405

Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal. Valimi suurus: 40 266.

Märkus: inimesed, kellel on mitu puuet korraga on tabelis mitu korda loetud.

Kõige sagedasemaks diagnoosiks nii osalise kui ka puuduva töövõimega inimeste seas olid psüühika- ja käitumishäired (vastavalt 3 007 ja 17 171 inimest). Nendest 7 208-l inimesel oli kerge, mõõdukas, raske või sügav vaimne alaareng (F70–F73). Võrreldes üksnes vähenenud töövõimega sihtrühmaga on samaaegselt puude ja vähenenud töövõimega inimeste seas F70–F73 diagnoosiga inimesi ligi 10 korda rohkem.

Joonis 8. Samaaegselt puude ja vähenenud töövõimega inimeste jaotus töövõime ulatuse ja põhidiagnoosi järgi, 2024



Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal. Valimi suurus: 40 266.

Märkus: kõigi diagnooside jaotus on esitatud tabelina Lisa 5 tabel 46.

Sihtrühm: eri aegadel puue ja vähenenud töövõime

Lisaks eristusid andmetes need töörealised inimesed, kellel oli 2024. aastal nii puue kui ka vähenenud töövõime, kuid seda erinevatel ajahetkedel. Puude raskusastme ja töövõime ulatuse kombinatsioone arvestades on selles sihtrühmas kõige enam neid, kellel on osaline töövõime ja keskmine puue (56,3% 2143-st). Veidi enam kui veerandi (26,5%) sellest sihtrühmast moodustavad inimesed, kellel on aasta jooksul eri aegadel olnud puuduv töövõime ja keskmine puue. Kõige vähem on selles sihtrühmas sügava puudega inimesi.

Kui vaadata, millises süsteemis need inimesed 2024. aasta seisuga viimasena olid, selgub, et kui neil oli viimati vähenenud töövõime, sarnanevad nad neile, kel oli vähenenud töövõime (puuet ei olnud). Kui aga neil oli viimati tuvastatud puude raskusaste, sarnanevad nad nendega, kel oli puue (vähenenud töövõimet ei olnud). See viitab sellele, et tegemist on tõenäoliselt nn üleminekurühmaga, kes liigub ühest hindamissüsteemist teise.

Aasta jooksul eri aegadel kehtinud puude ja töövõime vähenemise otsusega inimesi ei käsitleta edasises analüüsis eraldi sihtrühmana. Nende taustatunnused erinevad oluliselt teistest rühmadest nii puude raskusastme, töövõime ulatuse kui ka soolise jaotuse poolest. Nende liitmine kattuvuse (samaaegselt puue ja vähenenud töövõime) rühma võib viia ekslike

järeldusteni. Samuti ei ole nende arvamine üksnes puude või üksnes vähenenud töövõime rühmadesse metoodiliselt põhjendatud, kuna nad on sama aasta jooksul kuulunud mõlemasse süsteemi. Edasises analüüsis käsitleme selle rühma taustatunnuseid vaid kaudselt teiste sihtrühmade analüüsi kaudu. Eraldi esitame selle sihtrühma toetuste analüüsi, kuna neile makstavad toetused moodustavad arvestatava osa kogusummast.

Tabel 11. Aasta jooksul eri aegadel puude raskusastme ja vähenenud töövõime otsust omanud inimeste jaotus puude raskusastme ja töövõime ulatuse järgi, 2024

Rühm	Keskmine puue	Raske puue	Sügav puue	KOKKU
Osaline töövõime	1206 (56,3%)	96 (4,4%)	7 (0,3%)	1309
Puuduv töövõime	568 (26,5%)	241 (11,2%)	25 (1,2%)	834
KOKKU	1774	337	32	2143 (100%)

Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal.

Kokkuvõttes on ootuspärane, et kui aasta jooksul on inimesel olnud üksnes puue, siis on tegemist peamiselt keskmise puudega inimestega, ning kui on olnud üksnes vähenenud töövõime, siis on tegemist enamasti osalise töövõimega inimestega. Rühmades, kus esineb üheaegselt mitu staatust, on muster teistsugune. Püsiva töövõimetuse ja puude raskusastmega inimeste seas on sügava puudega inimeste osakaal oluliselt suurem kui üheski teises rühmas. Seevastu nende seas, kellel oli vähemalt ühel päeval nii puude raskusastme kui ka töövõime vähenemise kehtiv otsus, on osalise töövõimega inimesi märgatavalt vähem kui puuduva töövõimega inimesi.

Sihtrühmade profiil ja taustatunnused

Üksnes vähenenud töövõimega või üksnes puudega inimeste seas on naisi rohkem kui mehi. Seevastu on mehi enam nende seas, kellel on samaaegselt nii puue kui ka vähenenud töövõime, kuid ka nende seas, kellel on püsiv töövõimetus ja puue.

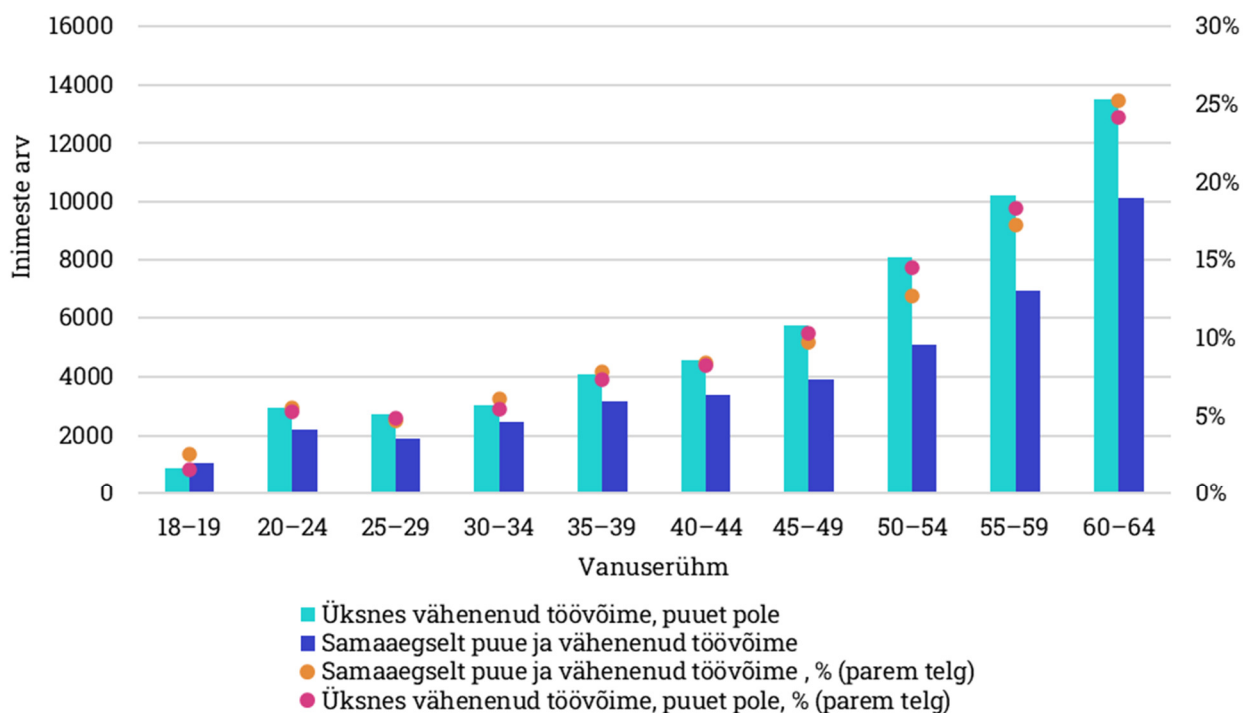
Tabel 12. Sihtrühmade sooline jaotus, 2024

Rühm	Mehed	Naised
Üksnes vähenenud töövõime (n= 55 806)	24 594 (44%)	31 212 (56%)
Üksnes puue (n= 218)	91 (41,7%)	127 (58,3%)
Samaaegselt puue ja vähenenud töövõime vähemalt ühel päeval (n= 40 266)	21 882 (54,3%)	18 384 (45,7%)
Püsiv töövõimetus ja puue (n= 716)	408 (57%)	308 (43%)

Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal.

Üksnes vähenenud töövõimega ning samaaegselt puude ja vähenenud töövõimega inimeste vanuseline jaotus on sarnane (joonis 9). Mõlema seas on enam kui pooled (vastavalt 57% ja 55%) vanuses 50–64 a.

Joonis 9. Üksnes vähenenud töövõimega ning samaaegselt puue ja vähenenud töövõimega inimesed vanuserühmade järgi, 2024



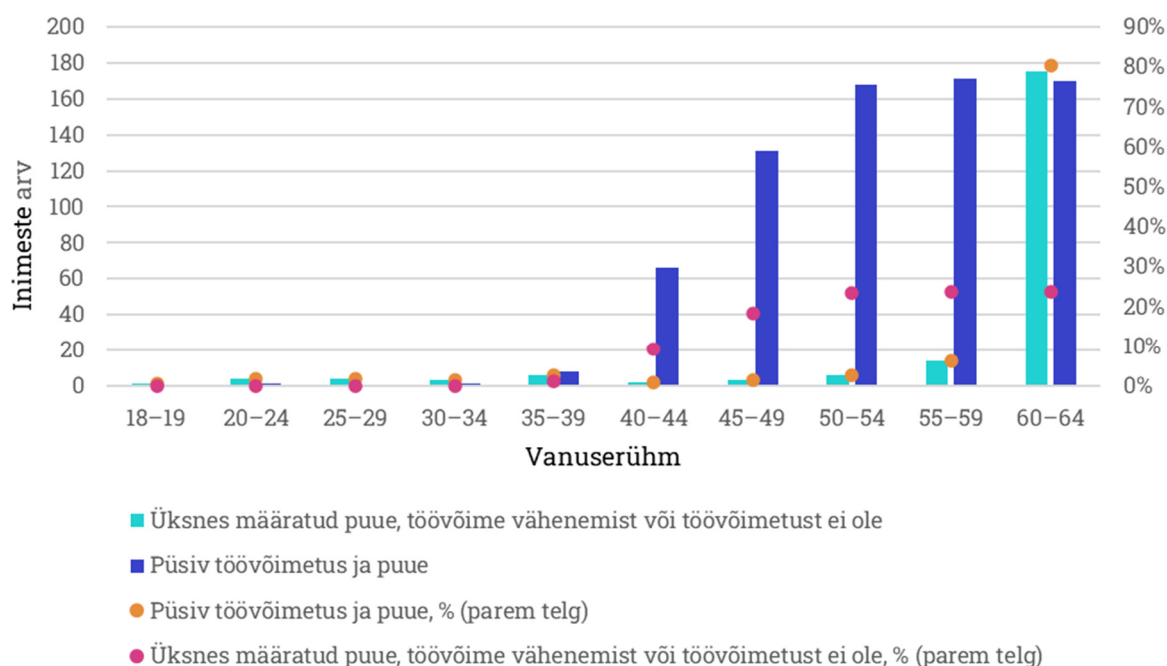
Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal.

Üksnes puuet omanud inimeste seas on kõige rohkem inimesi vanuses 60–64 (175 inimest), mis moodustab 79% kõigist, kellel oli üksnes puue. Nendest on 64-aastaseid 93, 63-aastaseid 45 ja 62-aastaseid 29. 18–59-aastaseid oli üksnes puudega inimeste seas 43 ning neist 33% oli vanuses 55–59.

Püsiva töövõimetuse ja puudega inimeste vanuselisest jaotusest (joonis 10) on näha, et alla 40-aastaseid on väga vähe (kokku 10) ning seejuures ei ole nende seas 18–19 aastaseid. Sellise vanuselise jaotuse põhjuseks, et alates 1. juulist 2016²⁸ hinnatakse töövõime ulatust ning uusi püsiva töövõimekaoga inimesi ei lisandu. Seega olid 2024. aastal 18–39-aastased 2017. aastal vanuses 11–32 ehk neil ei hinnatud töövõimetust, kuna nad ei olnud siis veel tööeas või olid vanuses, kus suurema tõenäosusega ei olnud veel tekkinud töövõime kaotust.

²⁸ Alates 1. juulist 2016 said töövõime hindamise taotlusi esitada need, kellel ei olnud kehtivat püsiva töövõimetust ning alates 1. jaanuarist 2017 hakati töövõimet hindama ka neil, kellel oli varasemalt tuvastatud püsiv töövõime kaotus.

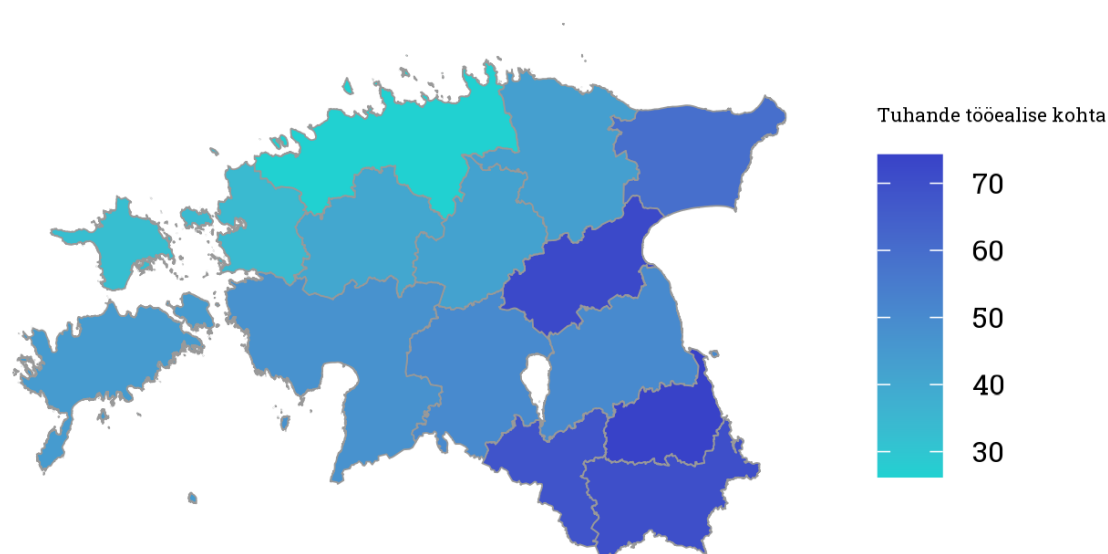
Joonis 10. Püsiva töövõimetuse ja puudega inimesed ning üksnes puudega inimesed vanuserühmade järgi, 2024



Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal.

Üksnes vähenenud töövõimega inimesi on tuhande tööealise (18–64) kohta kõige enam Põlvamaal (74,3 inimest 1000 tööealise kohta), Jõgevamaal (71,9 inimest 1000 tööealise kohta) ning Võrumaal (70 inimest 1000 tööealise kohta) (joonis 11). Kõige vähem on üksnes vähenenud töövõimega inimesi 1000 tööealise kohta Harjumaal (26,2 inimest), Hiiumaal (32,5 inimest) ja Läänemaal (34 tööealist 1000 tööealise kohta). 623 inimese elukoht ei ole teada või elavad nad väljaspool Eestit.

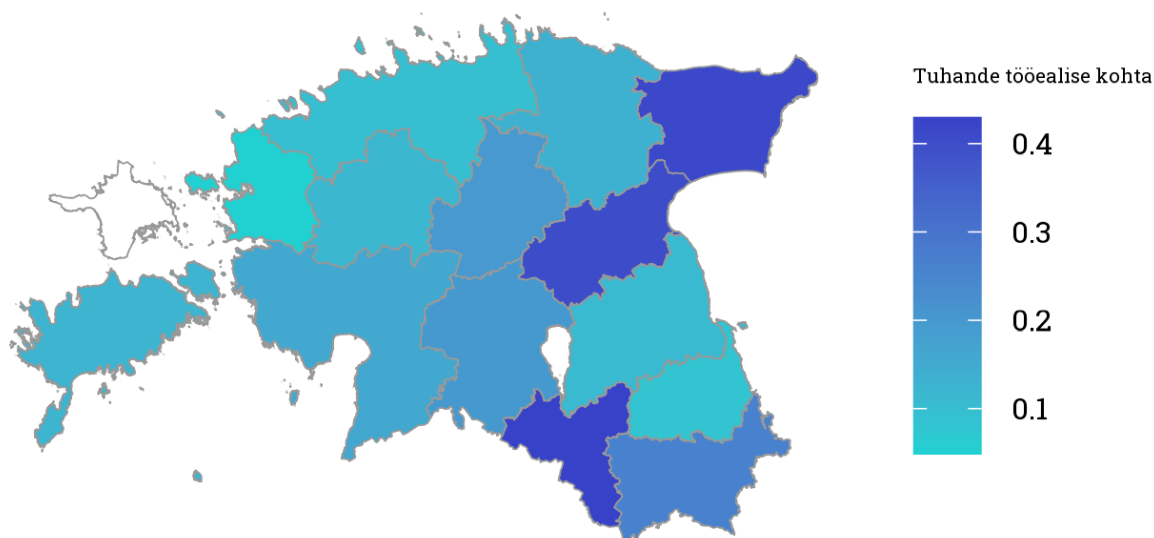
Joonis 11. Üksnes vähenenud töövõimega inimeste arv 1000 tööealise kohta maakonniti, 2024



Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete ning Statistikaameti rahvastikustatistika põhjal. Valimi suurus: 55 806.

Üksnes puude raskusastet omanud inimesi on väga vähe. Elukoha maakonna järgi on neid enam Harjumaal (62 inimest), kuid ka Ida-Virumaal (55 inimest). Tuhande tööealise (18–64) kohta on neid maakondade võrdluses aga enam Valgamaal (0,43 inimest 1000 tööealise kohta), Ida-Virumaal (0,42 inimest 1000 tööealise kohta) ja Jõgevamaal (0,4 inimest 1000 tööealise kohta). Viis inimest elab väljaspool Eestist või nende elukoht ei ole teada.

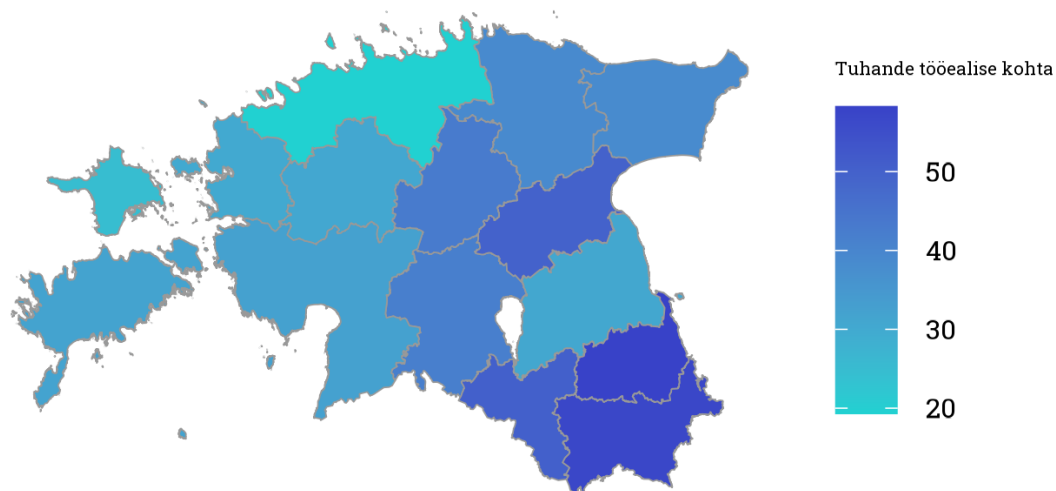
Joonis 12. Üksnes puudega inimeste arv 1000 tööealise kohta maakonniti, 2024



Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete ning Statistikaameti rahvastikustatistika põhjal. Valimi suurus: 218.

Samaaegselt nii puude kui ka vähenenud töövõime kehtiva otsusega inimesi on kõige enam Võrumaal – 57 inimest tuhande tööealise (18–64) kohta (joonis 13). Maakondade võrdluses järgneb teisena Valgamaa (50,4 inimest 1000 tööealise kohta) ning kolmandana Jõgevamaa, kus on 50 inimest 1000 tööealise kohta. Kõige vähem on samaaegselt nii puude raskusaste kui vähenenud töövõime otsusega inimesi Harjumaal (19 inimest 1000 tööealise kohta) ja Hiiumaal (24,7 inimest 1000 tööealise kohta). 284 inimese elukoht ei ole teada või elavad nad väljaspool Eestit.

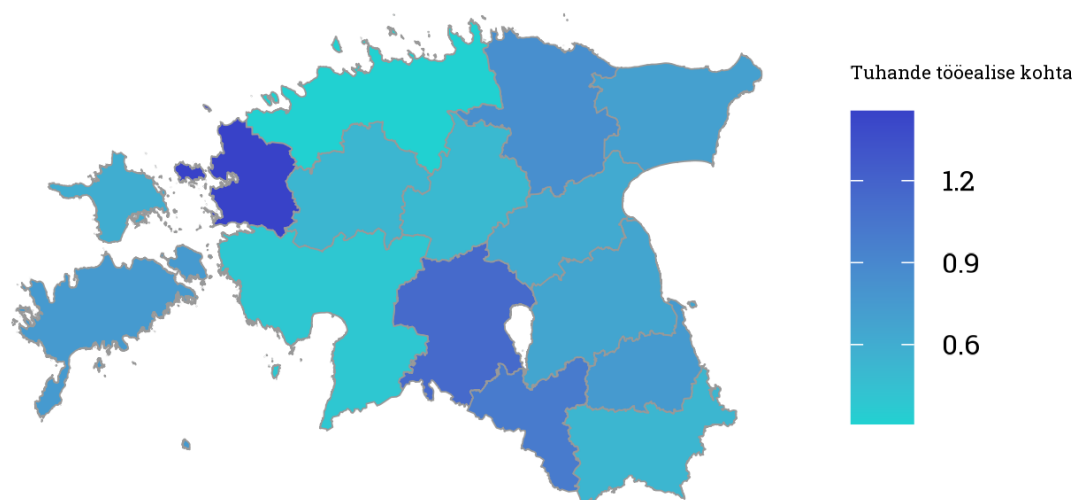
Joonis 13. Samaaegselt puude raskusastet ja vähenenud töövõimet omanud inimeste arv 1000 tööealise kohta maakonniti, 2024



Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete ning Statistikaameti rahvastikustatistika põhjal. Valimi suurus: 40 266.

Püsiva töövõimetuse ja puudega inimesi on arvuliselt kõige rohkem Harjumaal (200) ja Tartumaal (109) (joonis 14). Suhtarvuna on neid kõige rohkem aga Läänemaal (1,45 inimest 1000 tööealise ehk 18–64-aastaste kohta) ja Viljandimaal (1,14 inimest 1000 tööealise kohta). Tuhande tööealise kohta on kõige vähem püsiva töövõimetuse ja puudega inimesi Harjumaal (0,31 inimest 1000 tööealise kohta) ja Pärnumaal (0,39 inimest 1000 tööealise kohta).

Joonis 14. Püsiva töövõimetuse ja puudega inimeste arv 1000 tööealise kohta maakonniti, 2024



Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete ning Statistikaameti rahvastikustatistika põhjal. Valimi suurus: 716.

2024. aastal viibis erihoolekandeteenusel vähemalt korra kokku 5 424 inimest (tabel 13). Nendest kõige suurema osa (5 363 inimest ehk 98%) moodustasid inimesed, kellel oli samaaegselt puude raskusaste ja vähenenud töövõime. Seega kõigist neist, kellel oli samaaegselt puue ja vähenenud töövõime, viibis 2024. aastal vähemalt ühe korra erihoolekandeteenusel 13%.

Üldhooldusteenusel viibis 2024. aastal 1 030 inimest (2,5%), kellest 999-l oli samaaegselt nii puude raskusaste kui ka vähenenud töövõime. Püsiva töövõimetuse ja puudega inimestest viibis erihoolekandeteenusel 69 inimest ehk 9,6% ning üldhooldusteenusel 3,2%.

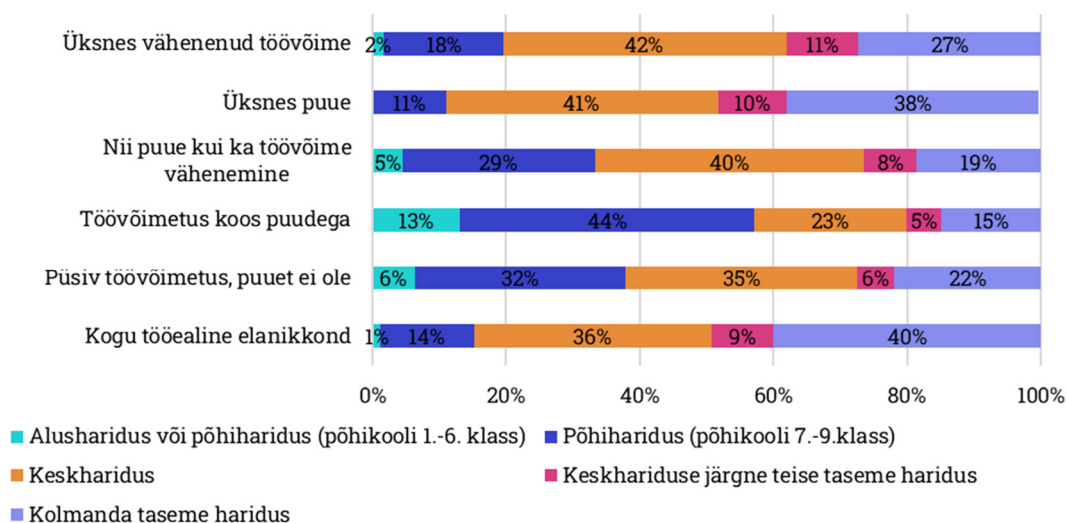
Tabel 13. Erihoolekandeteenusel ja üldhooldusteenusel viibimine 2024. aasta jooksul

	Üksnes määratud puue (n= 218)	Samaaegselt puue ja vähenenud töövõime (n= 40 266)	Püsiv töövõimetus ja puue (n= 716)	Kokku
Erihoolekandeteenusel 2024	2	5 363	69	5 424
Üldhooldusteenusel 2024	8	999	23	1 030

Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal.

Joonisel 15 on esitatud puude raskusastmega ja vähenenud töövõimega inimeste jaotus haridustasemete lõikes. Kogu sihtrühma (tööealised, kellel on vähenenud töövõime, puude raskusaste, püsiv töövõimetus) haridustase on madalam võrreldes tööealise elanikkonnaga üldiselt: nende seas on rohkem kuni põhiharidusega inimesi (26% vs 15%) ja vähem kõrgharidusega inimesi (24% vs 40%). Samas üksnes puude raskusastmega inimeste hariduslik jaotus on väga sarnane kogu tööealise elanikkonnaga – kui üksnes puude raskusastmega inimeste seas on kuni põhiharidusega inimeste osakaal 11%, siis kogu tööealisel elanikkonnal 15%. Ka kõrgharitude osakaal jääb üksnes puude raskusastmega inimeste seas vaid veidi alla kogu tööealise elanikkonna näitajast (38% vs 40%).

Joonis 15. Puude raskusastmega, vähenenud töövõimega ja püsiva töövõimetusega inimesed haridustasemetel, 2024

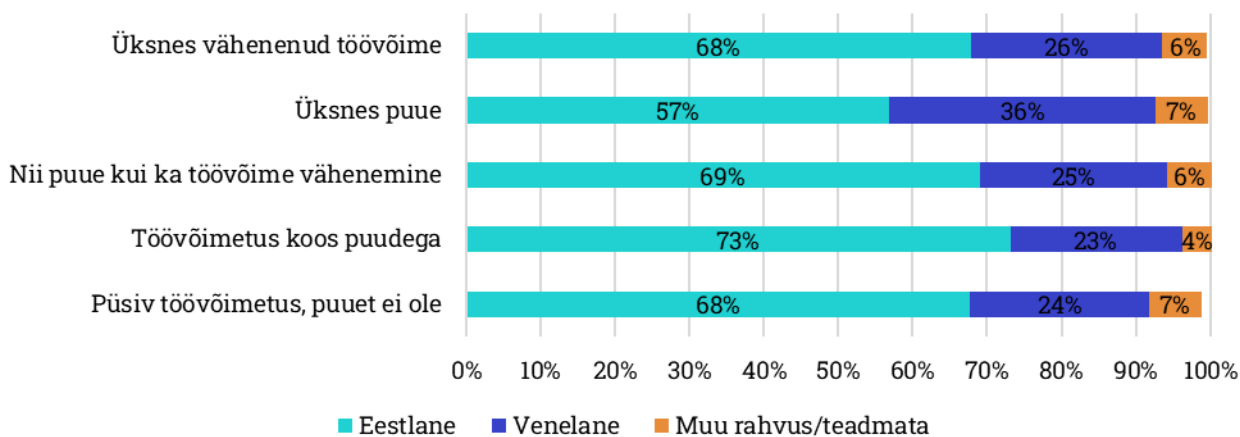


Allikas: autorite arvutused EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal, kasutades 2024. aasta registripõhiseid sisendandmeid.

Märkused: valimi suurus ainult vähenenud töövõimega inimeste puhul 54315; üksnes puude raskusastme korral 204; nii vähenenud töövõime kui ka puude raskusastme korral 41278; töövõimetuse ja puude raskusastme korral 707; püsiv töövõimetus ilma puude raskusastmeta 739.

Ligikaudu kaks kolmandikku kõigist tööealistest puude raskusastmega, vähenenud töövõimega ja püsiva töövõimetusega inimestest on eestlased (vt joonis 16). Samas eristuvad mõnevõrra need inimesed, kellel on tuvastatud üksnes puude raskusaste, kuid töövõime vähenemist või püsivat töövõimetust ei ole. Selles rühmas olevatest inimestest on 36% vene rahvusest. Teistes rühmades on vene rahvusest inimeste osakaal ligikaudu 10 protsendipunkti madalam.

Joonis 161. Puudega ja vähenenud töövõimega inimesed rahvuse lõikes, 2024

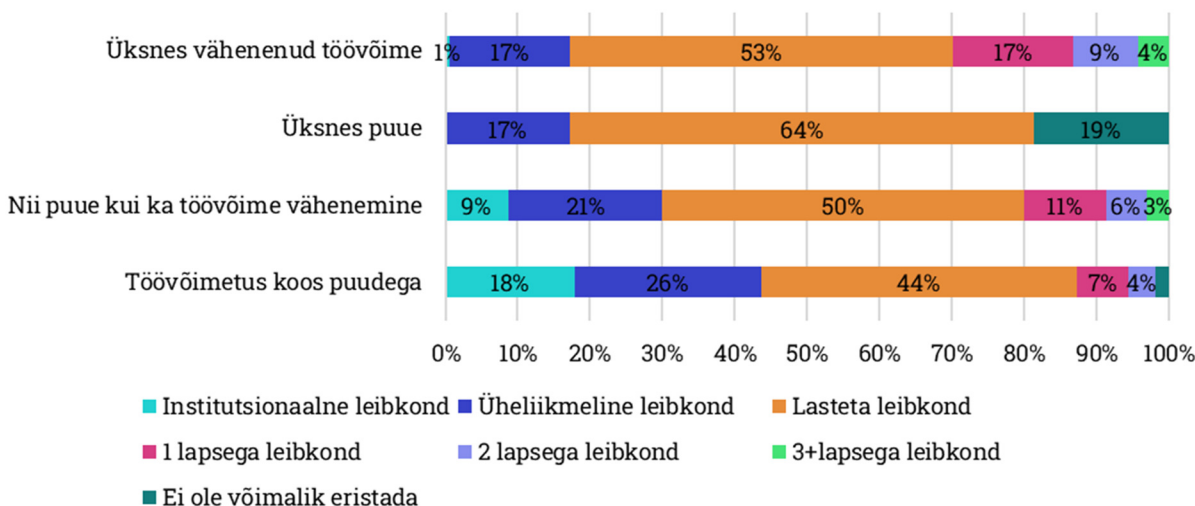


Allikas: autorite arvutused EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal, kasutades 2024. aasta registripõhiseid sisendandmeid.

Märkused: valimi suurus ainult vähenenud töövõimega inimeste puhul 54315; üksnes puude raskusastme korral 204; nii vähenenud töövõime kui ka puude raskusastme korral 41278; töövõimetuse ja puude raskusastme korral 707.

Suur osa kogu sihtrühmast (puude raskusaste, vähenenud töövõime ja püsiv töövõimetuse) elab üksi (ligikaudu 20%) või kahe või enama liikmelises leibkonnas koos teis(t)e täiskasvanu(te)ga (ligikaudu 50–60%) (vt joonis 17). Lastega leibkondade osakaal on üldiselt madalam, eriti sihtrühmas, kus inimesel on tuvastatud üksnes puude raskusaste. Kui inimesel on nii puude raskusaste kui vähenenud töövõime või püsiv töövõimetuse, siis võrreldes teiste sihtrühmadega elatakse sagedamini institutsionaalsetes leibkondades (hoolekandeesutustes).

Joonis 17. Puude raskusastmega ja vähenenud töövõimega inimesed leibkonna tüübi lõikes, 2024



Allikas: autorite arvutused EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal, kasutades 2024. aasta registripõhiseid sisendandmeid.

Märkused: valimi suurus ainult vähenenud töövõimega inimeste puhul 54315; üksnes puude raskusastme korral 204; nii vähenenud töövõime kui ka puude raskusastme korral 41278; töövõimetuse ja puude raskusastme korral 707.

Teenuste kasutamine

Üksnes puudega inimestest kasutas TK teenuseid 10 inimest (tabel 14) ja SKA sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid 5 inimest (tabel 15). SKA sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse (SRT) raames kasutati 10 erinevat teenust kokku 55 korral. Keskmiselt olid teenused 6,8 kuul. Kõige rohkem kasutati SRT raames tegevusterapeudi individuaalteenust (26 korda) ja füsioterapeut individuaalteenus (10 korda). TK teenustest kasutati kõige rohkem karjääriteenuseid (4 korda), oskuste arendamise teenuseid (3 korda, millest 1 oli tasemeõppes osalemise toetus), ning töövõime toetamine (3 korda, millest 1 oli tööalane rehabilitatsioon ning 2 tööalase abivahendi andmine). Keskmiselt saadi TK teenuseid 3,7 kuul.

2024. aastal kasutas TK teenuseid 12 909 üksnes vähenenud töövõimega inimest (kokku 24879 korral). Kõige enam kasutati karjääriteenuseid (11 299 korral), kuid ka oskuste arendamise teenuseid (5124 korral, sh 699 korral toetati tasemeõppes osalemist) ning töövõime toetamise teenuseid (3849 korral, sh tööalase rehabilitatsiooniteenust 3464 korral ja tööalase abivahendi andmist 248 korral). Keskmiselt saadi teenuseid 5 kuul. Eri aegadel puude ja vähenenud töövõime otsust omanud inimestest 352 sai TK teenuseid (696 korral) ning 89 ka sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid (1565 korral). Sarnaselt üksnes vähenenud töövõimega inimestele, oli peamiseks TK teenusteks nii karjääriteenused, oskuste arendamise teenused kui töövõime toetamise teenused. SRT teenustest kasutati enam psühholoogi individuaalteenust, sotsiaaltöötaja individuaalteenust, kuid ka kogemusnõustaja individuaalteenust. Töötukassa teenuseid saadi keskmiselt 5 kuul ning SRT teenuseid 6 kuul.

Tabel 14. Töötukassa teenuste kasutamine, 2024

Rühm	Üksnes vähenenud töövõime (n= 55 806)	Üksnes puue (n=218)	Samaaegselt puue ja vähenenud töövõime (n= 40 266)	Puue ja töövõimet us (n= 716)	Eriaegadel puue ja vähenenud töövõime (n= 2 143)	KOKKU
Saajate arv	12 909 saajat	10 saajat	4 187 saajat	42 saajat	352 saajat	17 500 saajat
Teenuse kategooria						
Ettevõtluse toetamine	51	1	17	0	0	69
Karjääriteenused	11 299	4	3 435	9	349	15 096
Muud teenused	301	0	100	0	7	408
Oskuste arendamine	5 124	3	1 523	5	112	6 767
Tasemeõppes osalemise toetus	699	1	226	0	17	943
Tööle asumise ja tööol püsimise toetamine	1 326	0	395	4	34	1 759
Töövalmiduse toetamine	2 929	1	814	1	74	3 819
Töövõime toetamine	3 849	3	1 386	41	120	5 399
Tööalane rehabilitatsioon	3 464	1	958	13	110	4 546
Tööalase abivahendi andmine	248	2	244	19	7	520
KOKKU kordade arv	24 879	12	7 670	60	696	33 317

Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal.

Samaaegselt vähenenud töövõime ja puudega inimestest kasutas TK teenuseid 4 187 inimest (tabel 14) ja SRT teenuseid 2 825 inimest (tabel 15) ning nad said neid keskmiselt 7 kuul. Kokku kasutati SRT teenuseid 2024. aasta jooksul 20 776 suunamise sees 62 518 korral ning kõige rohkem kasutati psühholoogi individuaalteenust (13 102 korda), sotsiaaltöötaja individuaalteenust (11 923 korda) ja loovterapeuti individuaalteenust (5 978 korda). TK teenuseid kasutati kokku 7 670 korral ja keskmiselt 5 kuul. Kõige rohkem kasutati

karjääriteenuseid (3 435 korda), oskuste arendamise teenuseid (1 523 korda, sellest 226 korral toetati tasemeõppes osalemist) ning töövõime toetamise teenuseid (1 386, millest 958 korral saadi tööalase rehabilitatsiooniteenust ning 244 korral oli tegemist tööalase abivahendi andmisega). Seejuures 51 inimest sai vähemalt korra aasta jooksul nii sotsiaalse rehabilitatsiooni kui ka tööalase rehabilitatsiooni teenust. Võrreldes üksnes vähenenud töövõimega inimestega kasutavad teenuseid oluliselt vähem need inimesed, kellel on samaaegselt vähenenud töövõime ja puue. Üheks võimalikuks selgituseks on, et viimaste seas on enam puuduva töövõimega inimesi, kellele ei rakendu ka aktiivsushõuded. Kõige väiksem erinevus oli tööalase abivahendi andmisel (248 vs 244). Analüüsist ei selgunud, et puude liigiti oleks teenuste kasutamises erinevusi.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamist käsitleb tabel 15.

Tabel 15. SKA sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste kasutamine, 2024

Rühm	Üksnes puue (n=218)	Samaaegselt puue ja vähenenud töövõime (n= 40 266)	Puue ja töövõimetus (n= 716)	Eriaegadel puue ja vähenenud töövõime (n= 2 143)	KOKKU
Saajate arv	5 saajat	2 825 saajat	29 saajat	89 saajat	2 948 saajat
SRT teenus					
füsioterapeudi individuaalteenus	10	4 951	52	159	5 172
tegevusterapeudi individuaalteenus	0	583	15	20	618
loovterapeudi individuaalteenus	26	5 812	79	108	6 025
füsioterapeudi grupiteenus	0	802	15	2	819
tegevusterapeudi grupiteenus	7	5 978	61	143	6 189
loovterapeudi grupiteenus	0	522	1	0	523
sotsiaaltöötaja individuaalteenus	6	11 923	80	325	12 334
sotsiaaltöötaja grupiteenus	0	1189	11	24	1 224
eripedagoogi individuaalteenus	0	4 392	75	37	4 504
eripedagoogi grupiteenus	0	594	22	0	616
psühholoogi individuaalteenus	6	13 102	94	431	13 633
psühholoogi grupiteenus	0	552	10	7	569
logopeedi individuaalteenus	0	1111	5	1	1 117
logopeedi grupiteenus	0	41	0	0	41
kogemusnõustaja individuaalteenus	0	4 565	26	196	4 787
kogemusnõustaja grupiteenus	0	681	7	24	712
õe individuaalteenus	0	2 568	7	118	2 693
õe grupiteenus	0	32	0	0	32
arsti individuaalteenus	0	1 351	5	78	1 434
Ööpäevaringne majutusteenus	0	1 677	23	61	1 761
Sõidukulude hüvitamine teenuseosutajale	0	92	2	0	94
KOKKU kordade arv	55	62 518	590	1 734	64 897

Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal.

SKA andmete alusel väljastati 2024. aastal kõige enam **puudega isiku kaarte** inimestele, kellel oli samaaegselt nii puue kui vähenenud töövõime (tabel 16). Sihtrühma suurust arvestades väljastati enam puudega isiku kaarte neile, kellel oli üksnes puue (40 inimest ehk 18% kõigist üksnes puudega tööelistest). Samuti väljastati puudega isiku kaarte 2024. aastal²⁹ enim neile, kellel oli aasta jooksul eriaegadel puue ja vähenenud töövõime (340 inimesele ehk ligi 16% vastava rühma inimestest). Kuigi puudega isiku kaarti ei pea eraldi taotlema, vaid seda saab teha koos puude raskusastme tuvastamise taotlusega, sai 2024. aasta jooksul esmakordse puude tuvastamisega tööelistest ainult 14% puudega isiku kaardi. Tööeliste hulgas oli 2024. aasta jooksul kokku 3 355 esmakordset puude hindamist, kuid puudega isiku kaardi väljastamisi oli 472.

SKA kaudu toetati **abivahendi** soetamist kõige sagedamini (5 112 inimest ehk ligi 13% vastavast rühmast) samuti nendel juhtudel, kui inimesel oli samaaegselt nii puue kui ka vähenenud töövõime – kokku oli nende abivahendite kogumaksumus ligi 5,9 miljonit eurot.

Täisealise sügava puudega isiku **hooldajal** on õigus saada kalendriaastas kuni viis tööpäeva **puhkust**, mille puhkusetasu hüvitatakse riigieelarvest. SKA andmetel hüvitati hooldajapuhkust (tabel 16) nendel juhtudel, kui hooldatavaks oli tööeline, kellel oli samaaegselt nii puue kui vähenenud töövõime (kogusummas 24 245 eurot).

Tabel 16. Puudega isiku kaardi, abivahendite hüvitamise ning hooldajapuhkuse hüvitamine, 2024

	Üksnes puue (n=218)	Samaaegselt puue ja töövõime vähenemine (n= 40 266)	Püsiv töövõimetus ja puue (n=716)	Eriaegadel puue ja vähenenud töövõime (n=2 143)
PIK kaart	40	1 310	43	340
Abivahendi hüvitise saajaid	43	5 112	177	14
Abivahendite kogumaksumus (isiku summa, SKA hüvitis)	62 486 €	5 882 241 €	102 371 €	17 825 €
Hooldajapuhkuse summa		24 245 €		

Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal.

Märkus: Täisealisel töotajal on õigus saada kalendriaastas kuni viis tööpäeva puhkust täisealise sügava puudega isiku hooldamiseks (hoolduspuhkus). Hoolduspuhkuse eest tasutakse töötasu alammäära järgi ning puhkusetasu hüvitatakse tööandja taotluse alusel.

Sissetulekud ja majanduslik toimetulek

Tabel 17 näitab toetuste maksmist sihtrühmade lõikes 2024. aastal. Kõige rohkem maksti töövõimetoetust, mida sai kokku 94 184 inimest. Kõige rohkem töövõimetoetuse saajaid oli

²⁹ Kokku oli 14 363 puude raskusastmega inimest (sh 12 630 olid vanaduspensioniealsed), kellele oli SKA andmete alusel väljastatud PIK kaart.

inimeste seas, kellel oli samaaegselt nii puue kui töövõime vähenemine (97,5% selle rühma inimestest sai töövõimetoetust). Aasta jooksul sai töövõimetoetust üksnes vähenenud töövõimega inimestest 94% ning eriaegadel puude ja töövõime vähenemise otsusega inimestest 96,7%. Töötuskindlustushüvitise saajad moodustasid üksnes vähenenud töövõimega inimestest 9,9% ning samaaegselt nii kehtivat puude raskusastme kui vähenenud töövõime otsust omanud inimestest 2,9%.

Aasta jooksul maksti täisealise puudega isiku hooldamise³⁰ eest kohalike omavalitsuste poolt hooldajatoetust kõige sagedamini siis kui hooldataval oli samaaegselt nii puue kui vähenenud töövõime (2247 inimese eest) – hooldajatoetuse määramisel ei võeta arvesse vähenenud töövõime olemasolu, vaid puude olemasolu.

Tabel 3. Toetuste ja hüvitiste saajate arv, 2024

	Üksnes vähenenud töövõime (n= 55 806)	Üksnes puue (n= 218)	Samaaegselt puue ja töövõime vähenemine (n= 40 266)	Püsiv töövõimetus ja puue (n= 716)	Eriaegadel puue ja töövõime vähenemine (n= 2 143)
Keskmise puudega tööealise toetus	N/A	160	23 379	127	1 705
Raske puudega tööealise toetus	N/A	52	13 963	322	355
Sügava puudega tööealise toetus	N/A	10	3 877	271	39
Puudega vanema toetus (üks puudega vanematest)	N/A	2	458	3	20
Puudega vanema toetus (üks last kasvatav)	N/A		125	6	2
Hooldajatoetus (hooldajale)	N/A	8	2 247	119	44
Sotsiaalmaks (hooldajatoetuse saaja)	N/A	3	423	11	8
Toimetulekutoetus	N/A	1	1 134	11	82
Töötutoetus	1 321	4	196		12
Töövõimetoetus	52 711		39 299	103	2 071
Töötuskindlustushüvitis	5 540	4	1 885	6	155

Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal.

Märkus: Aasta jooksul võib olla mitu puude raskusastme tuvastamise otsust, mistõttu võis üks ja sama inimene saada aasta jooksul erinevaid PISTS toetusi (nt aasta alguses kehtinud otsuse järgi raske puudega tööealise toetust ja aasta teises pooles uue otsuse alusel keskmise puudega tööealise toetust). Kokku maksti puudega tööealise toetusi 44 260 korral. Toimetulekutoetuse andmed on ainult puudega inimeste kohta, üksnes vähenenud töövõimega inimeste toimetulekutoetuse andmeid analüüs ei sisaldanud.

³⁰ Hooldajatoetus – oluline on arvestada, et kohaliku omavalitsuse üksus seab isiku taotluse alusel hoolduse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. KOV-id võivad seada täiendavaid tingimusi toetusi saamiseks – nt mittetöötav pereliige, ülalpidamiskohustuseta pereliige jne. Samuti võidakse hooldust mitte seada, kui tegemist on keskmise puudega inimesega.

Tabelis 18 on esitatud aasta keskmine toetuse summa 2024. aastal ja standardhälve toetuse saajate seas vastavas rühmas. Kõige suurem toetus on töövõimetoetus ning tulenevalt puuduva töövõimega inimeste suuremast osakaalust on töövõimetoetus keskmiselt suurem nende seas, kellel on samaaegselt nii puue kui ka vähenenud töövõime (aastas kokku keskmiselt 5 663€).

Tabel 4. Toetuste ja hüvitiste aastakeskmine summa ja standardhälve, 2024

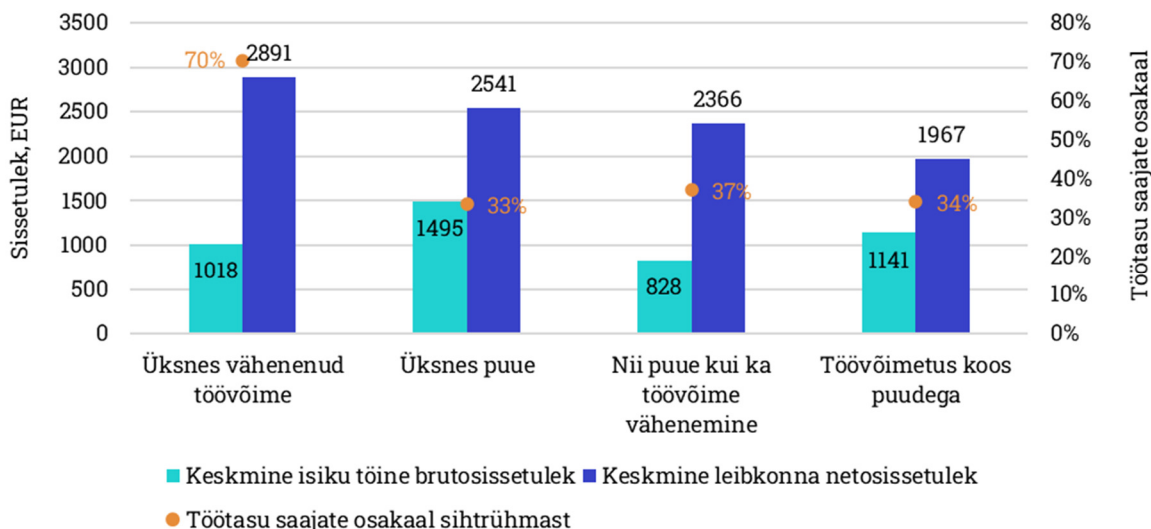
	Üksnes vähenenud töövõime (n= 55 806)	Üksnes puue (n= 218)	Samaaegselt puue ja töövõime vähenemine (n= 40 266)	Püsiv töövõimetus ja puue (n= 716)	Eriaegadel puue ja töövõime vähenemine (n= 2 143)
Keskmise puudega tööealise toetus	N/A	394 € (146 €)	404 € (111 €)	419 € (94 €)	231 € (144 €)
Raske puudega tööealise toetus	N/A	350 € (208 €)	485 € (130 €)	516 € (88 €)	342 € (209 €)
Sügava puudega tööealise toetus	N/A	386 € (237 €)	566 € (135 €)	605 € (81 €)	418 € (238 €)
Puudega vanema toetus (üks puudega vanematest)	N/A		300 € (161 €)	325 € (154 €)	296 € (142 €)
Puudega vanema toetus (üksi last kasvatav)	N/A	230 €	263 € (174 €)	153 € (66 €)	138 € (120 €)
Hooldajatoetus (hooldajale)	N/A	318 € (325 €)	645 € (370 €)	771 € (371 €)	487 € (375 €)
Sotsiaalmaks (hooldajatoetuse saaja)	N/A	1 276 € (1402 €)	2 342 € (835 €)	2 133 € (989 €)	2136 € (995 €)
Toimetulekutoetus	N/A	2 771 €	1262 € (1657 €)	689 € (927 €)	1 075 € (1 167 €)
Töötutoetus	1 164 € (839 €)	1 188 € (840 €)	1126 € (844 €)		644 € (431 €)
Töövõimetoetus	3 545 € (1 452 €)		5 663 € (1 622 €)	5307 € (1771 €)	4845 € (1548 €)
Töötuskindlustushüvitis	2 413 € (2118 €)	1 693 € (1 280 €)	2290 € (1913 €)	1710 € (1320 €)	2227 € (1866 €)

Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal.

Märkus: Toimetulekutoetuse andmed on ainult puudega inimeste kohta, üksnes vähenenud töövõimega inimeste toimetulekutoetuse andmeid analüüs ei sisaldanud. Standardhälve näitab hajuvust keskväärtuse ümber.

Puude raskusastmega inimeste seas (sh need, kellel on üksnes puue või puue koos töövõime vähenemise või püsiva töövõimetusega) on tööturuaktiivsus oluliselt madalam võrreldes nendega, kellel on üksnes töövõime vähenemine (vt joonis 18). Kui üksnes vähenenud töövõimega inimestest sai 2024. aastal töötasu 70%, siis üksnes puude raskusastmega inimestest 33%. Puudest tingitud vähenenud võimalused tööturul aktiivne olla mõjutavad ka nende leibkondade üldist toimetulekut. Leibkonna keskmine kogu netosissetulek on kõrgem seal, kus leibkonnaliikmel on üksnes töövõime vähenemine, kuid puude raskusastet ei ole. Seda seetõttu, et suur osa üksnes vähenenud töövõimega inimestest on osalise töövõimega, mitte puuduva töövõimega ning nende seas on ka töötajate osakaal suurem.

Joonis 18. Puude raskusastmega ja vähenenud töövõimega inimeste keskmine tõine sissetulek (bruto) 2024. aastal, nende leibkonna kogu keskmine netosissetulek 2025. aastal ning töötasu saajate osakaal sihtühmast

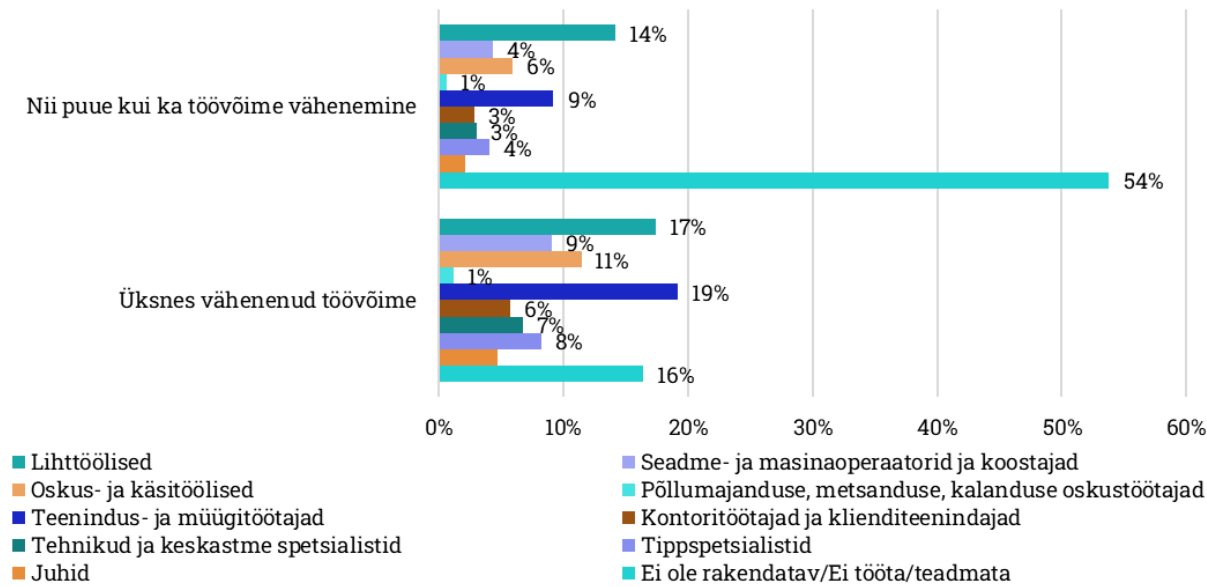


Allikas: autorite arvutused EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal, kasutades 2024. aasta registripõhiseid sisendandmeid.

Märkused: Leibkonna kogu netosissetulek on simuleeritud (sh maksuarvestus) EUROMODiga tuginedes 2024. aasta andmetele ja viidud hinnaindekseid arvesse võttes 2025. aasta väärtustesse. Brutosissetuleku andmed on registripõhised algandmed 2024. aastast; valimi suurus ainult vähenenud töövõimega inimeste puhul 54315; üksnes puude raskusastme korral 204; nii vähenenud töövõime kui ka puude raskusastme korral 41278; töövõimetus ja puude raskusastme korral 707.

Puude raskusastmega ja vähenenud töövõimega hõivatud tööelised inimesed on jaotunud erinevate ametialade vahel (joonis 19). Veidi enam on neid, kes on hõivatud lihttöölisena (14–17%) või müügi- ja teenindustöötajatena (üksnes vähenenud töövõimega inimeste seas 19%). Samas ligikaudu 10% vähenenud töövõimega ja puudega inimestest moodustavad ka tippspetsialistid või juhid (suuremas osas need, kellel on üksnes vähenenud töövõime, puude raskusastet ei ole).

Joonis 192. Puude raskusastmega ja vähenenud töövõimega inimeste hõivatus ametialade lõikes, 2024



Allikas: autorite arvutused EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal, kasutades 2024. aasta registripõhiseid sisendandmeid.

Märkused: Ülejäänud sihtrühmad olid liiga väikesed (sihtrühmad alla 800 inimese ja neist üle 60% ei tööta), et andmete konfidentsiaalsust arvestades võimaldaks sisukaid lõikeid välja võtta.

Järgnevas tabelis on esitatud erinevate sissetulekute saamine EUROMOD andmete põhjal sihtrühmade lõikes.

Tabel 19. Puudega ja vähenenud töövõimega inimeste muud sissetulekud 2024. aastal (sissetulekute saajate arv ja osakaal sihtrühmast sissetulekuliigi järgi)

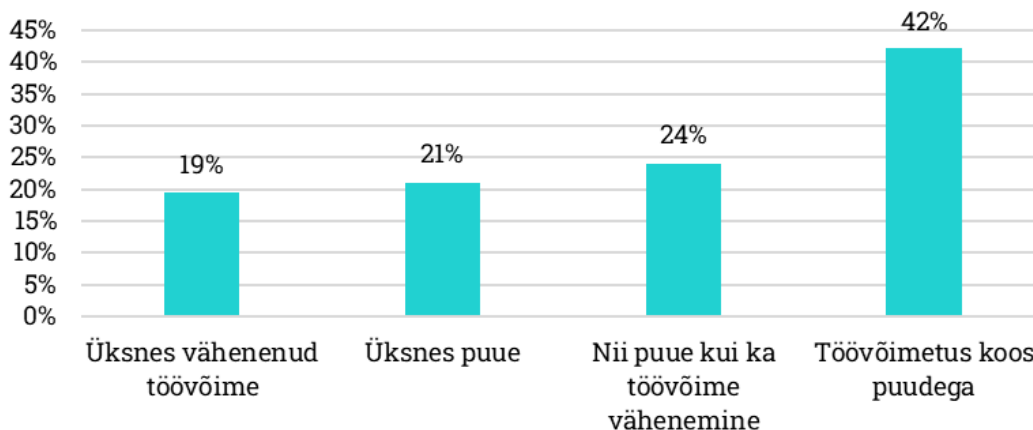
Sissetuleku liik	Üksnes vähenenud töövõime	Üksnes puue	Nii puue kui ka töövõime vähenemine	Püsiv töövõimetus ja puue
Toimetulekutoetus	1763 (3%)	Alla 20 inimese	880 (2%)	Alla 20 inimese
Peretoetus	9416 (17%)	Alla 20 inimese	3777 (9%)	51 (7%)
Iseendale tööandja tasu	2506 (5%)	Alla 20 inimese	961 (2%)	Alla 20 inimese
Pension		168 (82%)		
Kokku inimeste arv	54315	204	41278	707

Allikas: autorite arvutused EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal, kasutades 2024. aasta registripõhiseid sisendandmeid.

Leibkondade seas, kus ühel leibkonnaliikmetest on tuvastatud puude raskusaste, on suhtelise vaesuse määr mõnevõrra kõrgem võrreldes leibkondadega, kus leibkonnaliikmete seas puude raskusastet tuvastatud ei ole (vt joonis 20). Leibkondade seas, kus vähemalt ühel liikmel on üksnes vähenenud töövõime ja puude raskusastet ei ole, on suhtelise vaesuse määr 19%. Kui vähemalt ühel leibkonnaliikmel on üksnes puude raskusaste, siis on suhtelise vaesuse määr 21%. Leibkondade seas, kus vähemalt ühel liikmel on nii puude raskusaste kui ka töövõime vähenemine, on suhtelise vaesuse määr 24%. Silmapaistvalt kõrgem on suhtelise vaesuse

määr leibkondades, kus vähemalt ühel isikul on nii püsiv töövõimetus kui ka puude raskusaste (suhtelise vaesuse määr 42%).

Joonis 20. Puude raskusastmega ja vähenenud töövõimega inimeste suhtelise vaesuse määr 2025. aastal

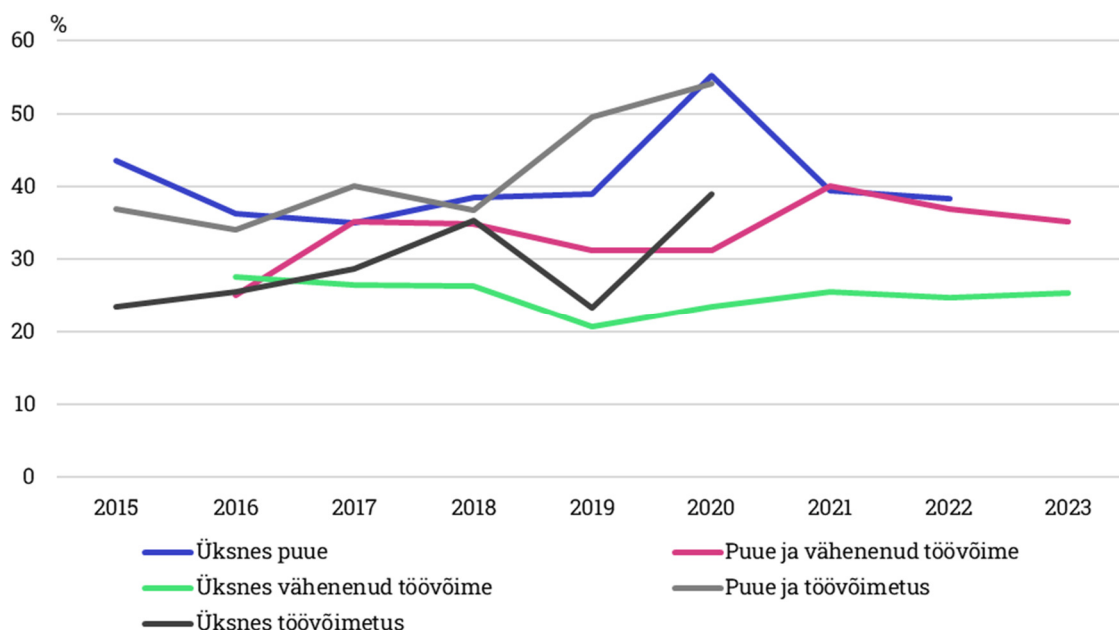


Allikas: autorite arvutused EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal, kasutades 2024. aasta registripõhiseid sisendandmeid.

Märkused: Vaesuse määra arvutamiseks on leibkonna kogu netosissetulek simuleeritud (sh maksuarvestus) EUROMODiga tuginedes 2024. aasta andmetele ja viidud hinnaindekseid arvesse võttes 2025. aasta väärtustesse.

Aastate võrdluses näitavad Eesti Sotsiaaluuringu 2016–2024 andmed, et üksnes vähenenud töövõimega tööealiste suhteline vaesus on madalam kui neil, kellel on nii puue kui vähenenud töövõime (joonis 21). Näiteks 2023. aastal oli üksnes vähenenud töövõimega tööealiste suhtelise vaesuse määr 25,2%, samas kui nii puue kui ka vähenenud töövõimega tööealistest oli suhtelises vaesuses 35,2%. Aastate lõikes on ka üksnes puudega tööealiste suhteline vaesus olnud suurem kui neil, kellel on üksnes vähenenud töövõime. Erinevalt EUROMODi kogurahvastiku andmetest näitavad uuringu andmed, et üksnes puudega tööealiste suhteline vaesus on sarnane või mõnevõrra kõrgem kui neil, kellel on nii puue kui vähenenud töövõime. Erinevust selgitavad nii andmeallikate erinevused (rahvastikupõhised andmed vs valimipõhised andmed) kui ka leibkondade struktuuri erinevus (rahvastikuregistripõhine vs tegelik leibkond).

Joonis 21. Puudega ja vähenenud töövõimega inimeste suhtelise vaesuse määr, 2015–2024



Allikas: autorite arvutused Statistikaameti Eesti Sotsiaaluuringu 2016–2024 andmetel.

Märkused: Joonisel ei ole esitatud andmeid, mille vaatluste arv Eesti Sotsiaaluuringu valimis ei olnud avaldamiseks piisav – püsiva töövõimetusega tööealiste ning samaaegselt nii puude kui püsiva töövõimetusega tööealiste suhteline vaesus aastatel 2021–2023, samuti ainult puudega tööealiste suhteline vaesus 2023. aastal.

Eesti Sotsiaaluuringu andmete järgi on samaaegselt nii puude kui vähenenud töövõimega tööealiste püsiv suhteline vaesus³¹ olnud kõikuv. Nii ulatus püsiv suhteline vaesus selles sihtrühmas 2018. aastal 31,4%ni, kuid 2019. aastal oli 22,4%. Seejärel taas suurenes 29,3%ni 2021. aastal ning vähenes taas 21,5%ni 2022. aastal (võib eeldada, et 2023. aastal vähenes see veelgi, kuid vaatluste arv ei ole avaldamiseks piisav). Üksnes vähenenud töövõimega tööealiste püsiv suhteline vaesus oli 2023. aastal 23,4% (varasemate aastate andmete avaldamiseks ei ole vaatluste arv piisav). Kuna püsivaesuse näitajad arvutatakse neljal järjestikusel aastal uuringu valimisse kuulunud leibkondade ja isikute alusel, siis on valimi suurus oluliselt väiksem kui ühe uuringu aasta valim. Vaadeldud perioodil on ka puudega inimeste üldarv vähenenud, mistõttu ei ole kokkuvõttes võimalik püsivaesuse näitajaid uuringu andmetel detailselt kirjeldada (vaatluste arv ei ole piisav).

Kulude kirjeldus

2024. aastal maksti tööealiste seas puuetega inimeste sotsiaaltoetusi kokku 19,4 miljonit eurot, sh keskmise puudega tööealise toetus moodustas sellest 51%, raske puudega tööealise toetus

³¹ Püsiva suhtelise vaesuse määr näitab nende isikute osatähtsust, kelle ekvivalentnetosissetulek (tarbimiskaaludega 1:0,5:0,3 jagatud leibkonna netosissetulek) oli suhtelise vaesuse piirist madalam vaadeldud aastal ja vähemalt kahel eelnenud kolmest aastast. Püsivaesuse näitaja aasta näitab viimast uuringuaastat.

36% ja sügava puudega tööealise toetus 12% (tabel 20). Puudega vanema toetust maksti kokku 164 tuhat eurot ja hooldamise eest makstavat toetust 1,6 miljonit eurot. Kuna tööealiste sihtrühmadest kõige suuremaks rühmaks on see, kus inimesel on tuvastatud nii puue kui ka töövõime vähenemine, siis on ka selles rühmas kulud puudetoetustele kokku kõige kõrgemad. Töötukassa makstava töövõimetoetuse väljamaksete summa 2024. aastal kokku oli 420 miljonit eurot. Sihtrühmas, kus inimestel oli tuvastatud üksnes töövõime vähenemine, oli rohkem ka neid, kes said töötutoetust või töötuskindlustushüvitist ning seega kulutused neile toetustele/hüvitistele olid suuremad.

Tabel 20. Tööealistele puudega ja vähenenud töövõimega inimestele makstud toetused toetuse liigi ja sihtrühma lõikes, 2024

Toetuse liik	Üksnes vähenenud töövõime (n= 55 806)	Üksnes puue (n= 218)	Samaaegselt puue ja töövõime vähenemine (n= 40 266)	Püsiv töövõimetus ja puue (n= 716)	Eriaegadel puue ja töövõime vähenemine (n= 2 143)
Keskmise puudega tööealise toetus	N/A	62 986 €	9 433 840 €	53 248 €	393 703 €
Raske puudega tööealise toetus	N/A	18 184 €	6 766 128 €	166 128 €	121 372 €
Sügava puudega tööealise toetus	N/A	3 863 €	2 193 147 €	163 930 €	16 312 €
Puudega vanema toetus (üks puudega vanematest)	N/A		37 468 €	1 949 €	60 €
Puudega vanema toetus (üksi last kasvatav)	N/A	460 €	120 611 €	460 €	2 760 €
Hooldajatoetus (hooldajale)	N/A	2 545 €	1 449 527 €	91 695 €	21 428 €
Sotsiaalmaks (hooldajatoetuse saaja)	N/A	3 828 €	990 547 €	23 462 €	17 088 €
Toimetulekutoetus	N/A	2 771 €	1 431 140 €	7 578 €	88 114 €
Töötutoetus	1 536 964 €	4 750 €	220 755 €		7 724 €
Töövõimetoetus	186 864 519 €		222 550 235 €	546 694 €	10 033 453 €
Töötuskindlustushüvitis	13 367 440 €	8 464 €	4 315 769 €	10 261 €	345 204 €

Allikas: autorite arvutused Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Töötukassa 2024. aasta registriandmete põhjal.

Tööealiste teenuste kasutamisega kaasnevad kulud on tabelis 21. Üksnes puude sihtrühmas oli SRT kogukulu 3339 eurot, millest 2215 eurot kulus tegevusterapeudi individuaalteenusele. Samaaegselt nii puudega kui vähenenud töövõimega inimestele osutatud SRT teenuste kulu oli 2024. aastal 5 729 489 eurot. Kõige suurema osa sellest moodustas psühholoogi individuaalteenus, mille kogumaksumus oli 1 595 864 eurot. Sellele järgnesid sotsiaaltöötaja individuaalteenus (858 873 eurot) ning tegevusterapeudi individuaalteenus (619 567 eurot) ja loovterapeudi individuaalteenus (609 758 eurot). Samaaegselt nii puudega kui ka vähenenud töövõimega inimestele osutatud TK teenuste kulu oli 2024. aastal 7 297 574 eurot, millest moodustas kõige suurema osa tööalane rehabilitatsioon kogumaksumusega 2 010 986 eurot. Suuremad kulud olid ka tasemeõppe osalemise toetamisel (1 358 834 eurot) ning palgatoetusel (1 255 818 eurot).

Tabel 21. Tööealiste teenuste kulud, 2024

Teenused	Üksnes puue (n= 218)	Samaaegselt puue ja töövõime vähenemine (n= 40 266)
SKA teenused kokku	3 339 €	5 729 489 €
TK teenused kokku	17 826 €	7 297 574 €
Toetused teenustel osalemiseks	666 €	245 501 €

Allikas: autorite arvutused Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Töötukassa 2024. aasta registriandmete põhjal.

Tööealised inimesed, kellel on tuvastatud üksnes puude raskusaste – kvalitatiivuuringu tulemused

2024 andmetel oli 218 tööealisel inimesel tuvastatud puude raskusaste, kuid ei olnud tuvastatud vähenenud töövõimet. Kolmandik neist saab töötasu (vt joonis 18). Töövõimetoetuse saamist mõjutavad mitmed seadusest tulenevad reeglid. Töövõimetoetust ei maksta koos pensioniga, ka enne vanaduspensioniga (TVTS § 12 lõige 4). On mitmeid pensioniliike, mis võimaldavad pensionile jäämist enne vanaduspensioniga. Nende hulka kuuluvad paindlik pension, ennetähtaegne vanaduspension, kutsealade ja ametikohtade sooduspensionid, väljateenitud aastate pension ning eripensionid (Sotsiaalkindlustusamet, pensioni liigid). EUROMODi andmetel on selles sihtrühmas 168 pensioni saajat. Seega on vaid 50 inimest, kellel on üksnes puue ning kes ei saa ei töövõimetoetust ega pensioni.

Töövõimetoetuse saamist ja selle suurust mõjutab ka piisavalt kõrge töötasu. Kui töövõimetoetuse saaja eelmise kalendrikuu sissetulek ületas 2025. aastal osalise töövõime korral 2700,11 eurot ja puuduva töövõime korral 3261 eurot, siis töövõimetoetust ei maksta (Töötukassa, töövõimetoetus). Selle seadusest tuleneva nõude tõttu võivad kõrget stabiilset tulu teenivad puudega inimesed loobuda töövõimetoetuse taotlemisest.

Mõistmaks, mis põhjustel on inimestel tuvastatud üksnes puude raskusaste, kuid ei ole tuvastatud vähenenud töövõimet, viisime läbi 11 poolstruktureeritud intervjuud sellesse gruppi kuuluvate inimestega. Intervjueeritavate hulka ei kuulu inimesed, kelle on puue ning püsiv töövõimetus. Intervjuudesse kaasati 2 meest ja 9 naist, 2 intervjuud olid venekeelsed. Esindatud olid liikumis-, kuulmis-, kõne- ja nägemispuudega isikud. Kuna mitme puudeliigi esindajaid on registriandmetel alla 20 isiku, ei kirjeldata käesolevas alapeatükis vastajate puudeliike, et välistada intervjueeritud inimeste tuvastatavus. Esindatud olid keskmise ja raske puudega inimesed.

Enimlevinud põhjus, miks tööealisel inimesel on tuvastatud puue, kuid ei ole vähenenud töövõimet, on pensioni saamine. Neli intervjueeritud inimest said pensioni. Varasemale pensionile mindi põhjusel, et inimene ei saanud töötamist ega töö otsimist jätkata kas terviseprobleemide või hoolduskoormuse tõttu. Üks vastaja sai pensionile minna 5 aastat enne vanaduspensioniga soodustingimusel, puudega lapse kasvatamise eest. Töövõimetoetuse õiguse lõppemine pensioni saamisel oli pensionit saavale vastajale ebaeeldiv üllatus ning seda peeti ebaõiglaseks.

„On väga ebaõiglane, et mina töövõimetoetust ei saa, kuigi töötavad inimesed seda ju saavad” – keskmise puudega inimene

Teine põhjus, miks inimesel on üksnes puude raskusaste, on olukord, kus inimene taotles nii töövõime hindamist kui puude raskusastme tuvastamist, kuid töötukassa töövõime vähenemist ei tuvastanud. Vähenenud töövõime tuvastamata jätmise põhjustena toodi välja, et piirang ei takista töötamist või on piirang kompenseeritud abivahendiga. Intervjueeritavad väljendasid töötukassa otsuse üle rahulolematust, kuna tegutsemispiirangud takistavad mitte ainult nende igapäevaelu, vaid ka töötamist.

„Nende (töötukassa) hinnangul peaksin vahetama töökohta kui mul on probleemid. Ma ei oska hinnata nende otsust. Pisut üllatunud olin küll.” – keskmise puudega inimene

Puude raskusastme taotlemise peamine motiiv oli saada abivahend soodushinnaga. Puudega tööealise inimese toetuse saamist peeti oluliseks ka abivahendi hooldamise või uuendamisega seotud kulude katteks.

„Mul on vaja toetust, sest mul on vaja protees ära vahetada, mul ei ole seda raha.” – keskmise puudega inimene

Ühel juhul tuvastati puude raskusaste pärast esmase keelduva otsuse vaidlustamist ning tuvastamisel sai määravaks lisakulu olemasolu.

Kolmandana tuli ette olukord, kus inimene taotles üksnes puude raskusastme tuvastamist. See olukord tuli esile neljas intervjuus. Ühel juhul andis sellise juhise inimese raviarst. Kuna inimene töötas, ei tekkinud tal mõtet taotleda ka töövõime hindamist.

„Oli hindamine koos puudega või ainult puue. Ma ei teadnud täpselt mis see tagajärg on. Ma arstiga konsulteerisin ja tema ütles, et tuleb valida ainult puude raskusaste. ... Ma väga ei süvenenudki.” – keskmise puudega inimene

Teisel juhul taotles inimene teadlikult ainult puude raskusastme tuvastamist, sest tema töötasu ületab piirmäära, millest alates töövõimetoetust ei maksta. Intervjueeritav oli valinud teadlikult eriala, mille puhul pikaajaline füüsiline puue töötamist ei takista. Puude raskusastme tuvastamine oli oluline abivahendi soetamiseks ning abivahendi soodustuse saamiseks. Kolmandal juhul leidis intervjueeritav, et tema funktsioonipiirang ei takista töötamist, kuid ta vajab abivahendit ning seetõttu taotles teadlikult vaid puude raskusastme tuvastamist. Samuti oli olukord, kus raske puudega inimene ei teadnud, et ta võiks taotleda töövõime hindamist töötukassast, kuigi tema piirangud takistasid töötamist olulisel määral.

Kolm vastajat said teenuseid kohalikult omavalitsuselt – sotsiaaltransporditeenust arsti vastuvõtul ja füsioteraapias käimiseks. Ülejäänud juhtudel märgiti, et puudub teadlikkus, milliseid teenuseid omavalitsused pakuvad ning millega omavalitsus aidata saab. Ühel vastajal aitas KOV vormistada valet. Kaks vastajat said füsioterapeudi vm teraapiateenuseid.

Seega võib öelda, et enamasti tuleneb olukord, kus tööelisel inimesel on tuvastatud üksnes puue, töövõimetoetuse tingimustest – enne vanaduspensioniga on inimesed valinud töövõimetoetuse asemel pensioni saamise. Kuigi pensioni saajatel on õigus töövõime hindamisele, puudus sellekohane teadlikkus ning motivatsioon, kuna töövõimetoetust pensioni saajatele ei maksta. Harvemini ei ole inimene töövõimetoetust taotlenud või ei ole vähenenud töövõimet tuvastatud. Nendel inimestel on siiski funktsioonipiirang, mis abivahendiga kompenseeritult ei pruugi takistada töötamist, kuid millega kaasnevad lisakulud, mida piiranguteta inimestel ei esine. Puudega inimese toetuse saamine oli kõikide vastajate jaoks oluline. Seda kasutati piirangute kompenseerimiseks, sh abivahendite ja ravimite ostmiseks, transportiks ja taastusraviks.

10.2. Puudega vanaduspensioniealised inimesed

Sihtrühma suurus ja puude raskusaste

Vanaduspensioniealisi ehk 31. detsembri 2024 seisuga 65-aastaseid ja vanemaid inimesi oli uuringu valimis kokku 70 387 ehk need, kellel 2024. aasta jooksul oli puue ja/või vähenenud töövõime (üksnes vähenenud töövõimega oli nende seas 1202 inimest)³².

Puude raskusastmega otsusega inimesi oli kokku 69 185. Vanaduspensioniealistel on puude raskusaste keskmiselt kõrgem kui tööelistel. Raske puudega inimesed moodustasid umbes 60% kõigist puudega vanaduspensioniealistest, samas kui samaaegselt nii puuet kui ka vähenenud töövõime otsust omanud tööeliste seas oli raske puudega inimeste osakaal ligi 33%. Mõnevõrra enam on puudega vanaduspensioniealiste seas ka sügava puudega inimesi (11%) kui samaaegselt puude ja vähenenud töövõimega tööeliste seas (9%). Seega on puudega vanaduspensioniealiste seas samaaegselt puude ja vähenenud töövõimega tööelistega võrreldes vähem keskmise puudega inimesi (28% ja 58%).

³² Märkus: Vanus on 31.12.24 seisuga ning kuivõrd pensioniga oli 2024. aastal 64 aastat ja 9 kuud, siis on aasta andmetes neid, kes olid ka vähenenud töövõimega. Andmetes ei ole neid, kellel oli 2024. aasta jooksul üksnes püsiv töövõimetus.

Tabel 22. Vanaduspensioniealised (65-aastased ja vanemad inimesed) puude, vähenenud töövõime ja püsiva töövõimetuse järgi, 2024

Rühm	Inimeste arv kokku	sh keskmine puue	sh raske puue	sh sügav puue
Üksnes vähenenud töövõime	1 202	N/A	N/A	N/A
Üksnes puue	67 305	18 627	40 975	7 703
Samaaegselt puue ja töövõime vähenemine	604	464	134	6
Püsiv töövõimetuse ja puue	620	204	374	42
Eriaegadel vähenenud töövõime ja puue	656	369	239	48
Kokku	70 387			
sh puudega	69 185	19 664 (28%)	41 722 (60%)	7 799 (11%)

Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal.

Märkus: Vanus on 31.12.24 seisuga ning kuivõrd pensioniiga oli 2024. aastal 64 aastat ja 9 kuud, siis on aasta andmetes neid, kes olid ka vähenenud töövõimega. Andmetes ei ole neid, kellel oli 2024. aasta jooksul üksnes püsiv töövõimetuse.

Kokku vanaduspensioniealiste seas oli kõige sagedasem raske liikumispuue, mis oli 35 785 inimesel ja keskmine liikumispuue, mis oli 16 438 inimesel. Võrreldes tööealistega oli vanaduspensioniealiste seas muu puudega inimesi enam. Näiteks üksnes puudega tööealiste rühmas oli muu puue kokku 24-l inimesel (11%), kuid vanaduspensioniealistel oli muu puue 14 195-l inimesel (20%).

Tabel 23. Vanaduspensioniealised (65-aastased ja vanemad inimesed) puude liigi ja raskusastme järgi, 2024

	Keskmine	Raske	Sügav	Kokku
Keel ja kõne	100	544	311	955
Kuulmine	958	1 467	202	2 627
Liikumine	16 438	35 798	5 994	58 230
Nägemine	535	2 377	1090	4 002
Intellektihäire	55	252	136	443
Psüühikahäire	860	5343	2 647	8 850
Muu	3 329	8 353	2 513	14 195

Allikas: autorite arvutused Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal. Valimi suurus: 70 387.

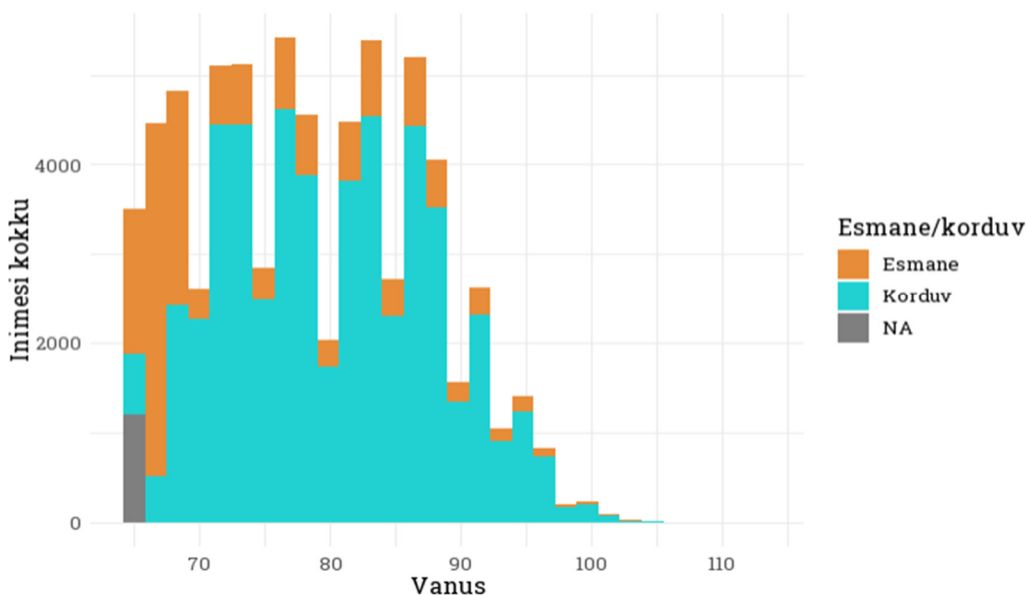
Märkus: Inimesed, kellel oli aasta jooksul mitu puuet on tabelis loetud mitu korda.

Puude raskusastme hindamise korduvtaotlemine

Vanaduspensioniealiste seas oli 53 188 korduvat puude raskusastme otsust (~77%) ning 15 997 esmast otsust (~23% kõikidest puudega vanaduspensioniealistest). Puude raskusastme ja puude liikide võrdluses ei ilmne olulisi erinevusi korduvate ja esmaste otsuste jaotuses.

Esmased puude raskusastme otsused tehakse pigem vanaduspensioniea esimestel aastatel. 49% esmastest ja ~7% korduvatest puude raskusastme hindamisotsustest on vanuses 65–69 (vt joonis 22). Eluajaks tehtud puude otsuseid oli 14 687, mis moodustas puudega vanaduspensioniealistest 21,2%.

Joonis 22. Vanaduspensioniealised puude raskusastme hindamise otsuste ja vanuse järgi, 2024

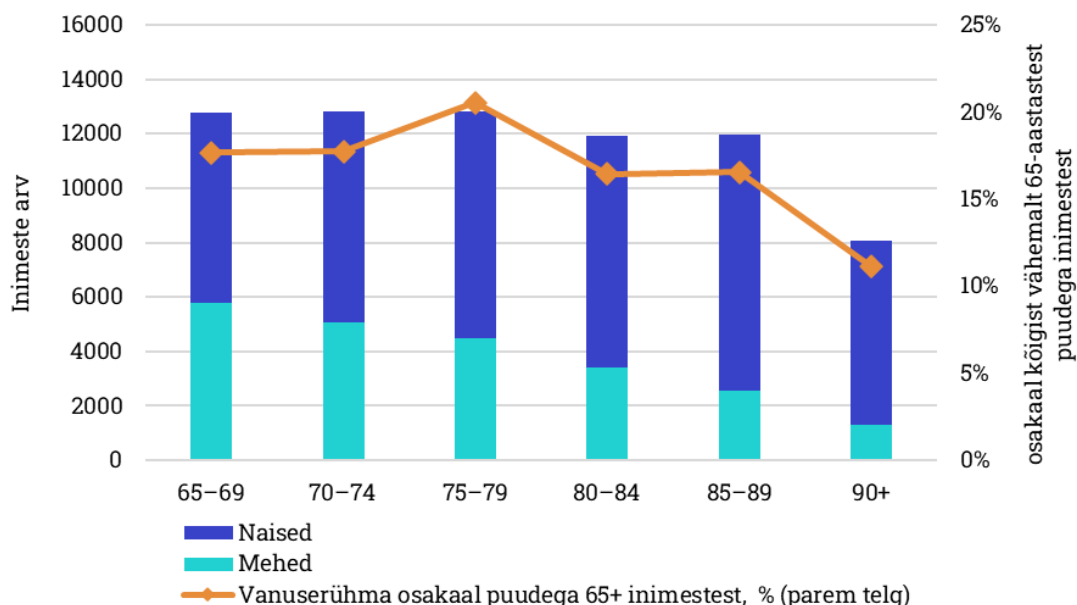


Allikas: autorite arvutused Sotsiaalkindlustusameti registre andmete põhjal. Valimi suurus: 70 387.

Sihtrühmade profiil ja taustatunnused

Võrreldes üksnes puudega tööealise sihtrühmaga, kus mehed moodustasid 42% ja naised 58%, on vanaduspensioniealiste hulgas naiste osakaal märksa suurem. Vanaduspensioniealistest puudega inimestest olid naised 68% (47 444 inimest) ja mehed 32% (22 634 inimest). Selline erinevus tuleneb sellest, et vanemaealiste seas on naisi üldiselt rohkem kui mehi. Kui 65–69-aastaste puudega inimeste seas moodustasid mehed umbes 45%, siis 75–79-aastaste seas 35% ja 90-aastaste ja vanemate puudega inimeste seas umbes 16%. Keskmise puudega vanaduspensioniealiste vanus on keskmiselt 78,5 aastat. Arvuliselt kõige suurem on 75–79 vanuserühm, mis moodustab 21% kõigist puudega vanaduspensioniealistest.

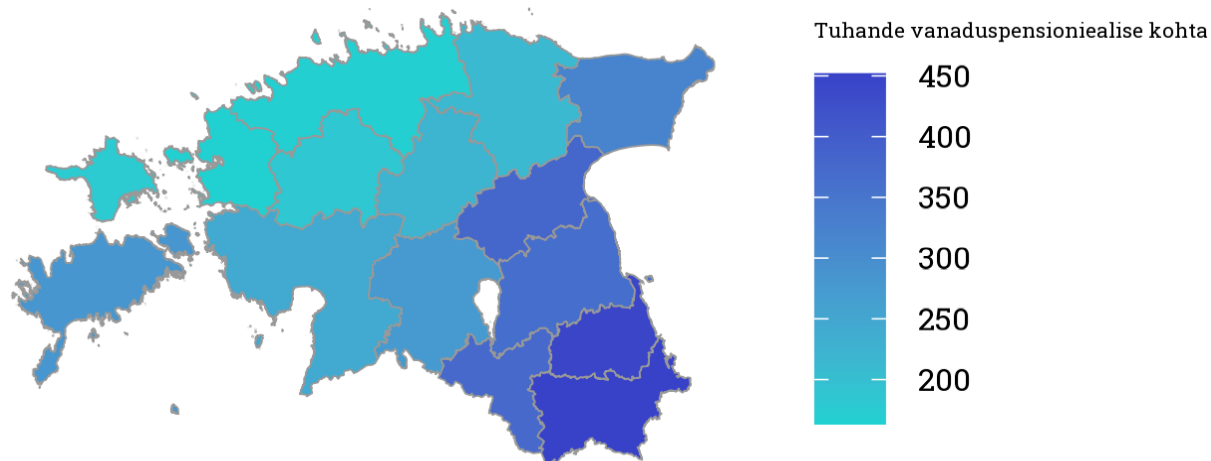
Joonis 23. Puudega vanaduspensioniealsed vanuserühmade ja soo järgi, 2024



Allikas: autorite arvutused Sotsiaalkindlustusameti registre andmete põhjal. Valimi suurus: 70 387.

Joonisel 24 on puudega vanaduspensioniealiste inimeste arv 1000 vanaduspensioniealise kohta. Puudega vanaduspensioniealisi oli kõige enam Võru maakonnas (1000 vanaduspensioniealise kohta 451) ja Põlva maakonnas (1000 vanaduspensioniealise kohta 445). Kõige vähem puudega vanaduspensioniealisi on Lääne maakonnas (1000 vanaduspensioniealise kohta 163) ning Harjumaal (1000 vanaduspensioniealise kohta 167).

Joonis 24. Vanaduspensionieas puudega inimeste arv 1000 vanaduspensioniealise kohta maakonniti, 2024

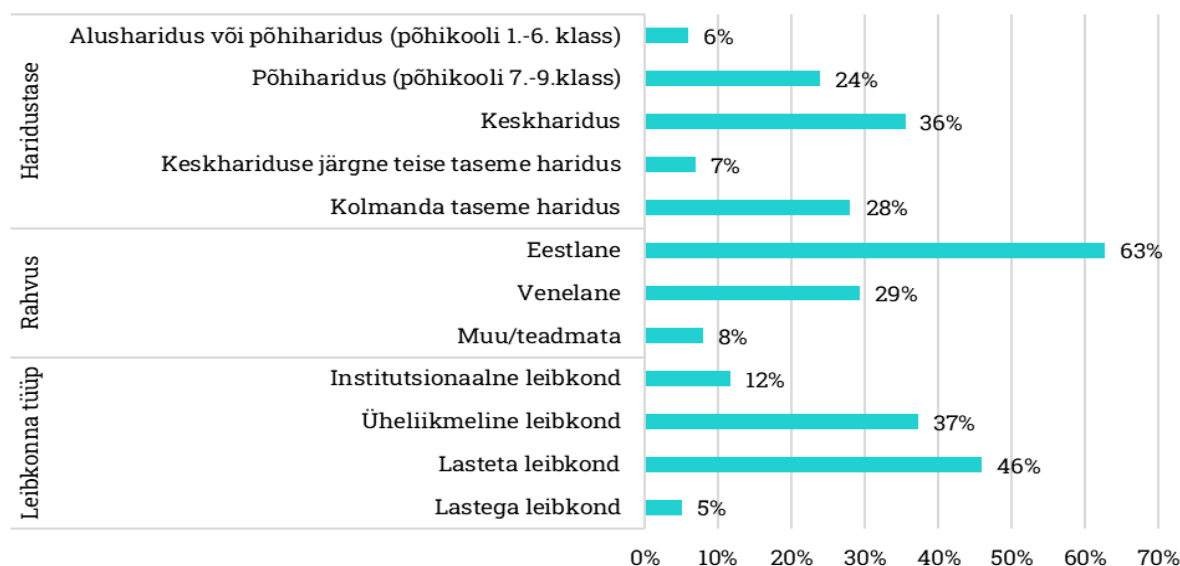


Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registre andmete ning Statistikaameti rahvastikustatistika põhjal. Valimi suurus: 70 387.

Sarnaselt tööealistega on ka vanaduspensioniealiste puuetega inimeste seas ligikaudu 30%-l vähemalt põhiharidus, alla 30% on kolmanda taseme haridusega (vt joonis 25). Õppijate arv on vanaduspensioniealiste seas väga madal (üksikud inimesed). Seega puudest tingitud

soodustused, mis rakenduvad neile, kes õpivad, ei ole vanaduspensioniealiste seas niivõrd asjakohased. Ligikaudu 2/3 vanaduspensioniealistest puudega inimeste sihtrühmast moodustavad eestlased. Leibkonnatüübi on puudega vanaduspensioniealiste seas oluliselt rohkem üksi elavaid inimesi (üheliikmeline leibkond) võrreldes tööelistega (19% vs 37%). EUROMODi andmete alusel elab institutsionaalses leibkonnas³³ (nt hoolekandeesutus) ligikaudu 12% 65+ vanuses puudega inimestest. 2024. aastal viibis erihoolekandeteenusel vähemalt korra kokku 719 inimest, mis on 1% kõigist puudega vanaduspensioniealistest. Võrreldes tööeliste puudega inimestega on vanaduspensioniealiste seas oluliselt enam neid, kes viibisid 2024. aastal vähemalt ühe päeva ööpäevaringsel üldhooldusteenusel. Kokku viibis üldhooldusteenusel 9746 inimest, mis on umbes 14% kõikidest puudega vanaduspensioniealistest.

Joonis 25. Puudega vanaduspensioniealiste inimeste haridustase, rahvus ja leibkonna tüüp 2024. aastal



Allikas: autorite arvutused EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal, kasutades 2024. aasta registripõhiseid sisendandmeid.

Teenuste kasutamine

578 vanaduspensioniealist inimest kasutas SRT teenuseid (kokku 6 872 korral). Keskmiselt saadi teenuseid 3,6 kuul. Kõige sagedamini kasutati psühholoogi ja sotsiaaltöötaja individuaalteenust (vastavalt 1 254 ja 1 043 korda).

³³ EUROMOD-is on arvestatud institutsionaalseteks leibkondadeks järgmised kategooriad: vangis, asenduskodus, hooldekodus, kloostriis, Rahvastikuregistri elukoha andmetel enam kui 18-liikmelistes leibkondades elavad inimesed, kodutud ja muu.

Tabel 24. Vanaduspensioniealised SRT teenuste kasutamise järgi, 2024

Rühm	Vanaduspensioniealised
Saajate arv	578
SRT teenus	
füsioterapeudi individuaalteenus	892
tegevusterapeudi individuaalteenus	644
loovterapeudi individuaalteenus	436
füsioterapeudi grupiteenus	253
tegevusterapeudi grupiteenus	108
loovterapeudi grupiteenus	22
sotsiaaltöötaja individuaalteenus	1 043
sotsiaaltöötaja grupiteenus	54
eripedagoogi individuaalteenus	152
eripedagoogi grupiteenus	34
psühholoogi individuaalteenus	1 254
psühholoogi grupiteenus	27
logopeedi individuaalteenus	81
logopeedi grupiteenus	4
kogemusnõustaja individuaalteenus	761
kogemusnõustaja grupiteenus	67
õe individuaalteenus	344
õe grupiteenus	5
arsti individuaalteenus	258
Ööpäevaringne majutusteenus	431
Sõidukulude hüvitamine teenuseosutajale	2
KOKKU kordade arv	6 872

Allikas: autorite arvutused Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete põhjal. Valimi suurus: 70 387.

Vanaduspensioniealiste seas oli oluliselt enam puudega isiku kaardi ning abivahendi hüvitise saajaid kui tööealiste seas. Puudega inimese kaardi (PIK) otsuseid oli 2024. aasta jooksul vanaduspensioniealiste seas 12 630 (tööealistel kokku 1 733). 2024. aastal sees esmase puude otsusega vanaduspensioniealistest 45%le väljastati PIK kaart (kokku oli 5 323 inimest, kellel oli 2024. aasta sees esmakordne puude hindamine ja neist 2 420le väljastati PIK kaart). Abivahendi hüvitise saajaid oli 28 667 ehk 40,7% (tööealiste hulgas oli saajaid kokku 5 346).

Tabel 25. Vanaduspensioniealiste puudega isiku kaardi, abivahendite hüvitamise ning hooldajapuhkuse hüvitamine, 2024

Teenus	Saajate arv/Hüvitise summa
PIK kaart	12 630
Abivahendi hüvitise saajaid	28 667
Abivahendite kogumaksumus (isiku summa, SKA hüvitis)	12 488 237€
Hooldajapuhkuse summa	19 611 €

Allikas: autorite arvutused Sotsiaalkindlustusameti registri andmete põhjal. Valimi suurus: 70 387.

Märkus: Täisealisel töötajal on õigus saada kalendriaastas kuni viis tööpäeva puhkust täisealise sügava puudega isiku hooldamiseks (hoolduspuhkus). Hoolduspuhkuse eest tasutakse töötasu alammäära järgi ning puhkusetasu hüvitatakse tööandja taotluse alusel.

Sissetulek ja majanduslik toimetulek

Tabel 26 näitab toetuste maksmist vanaduspensioniealiste sihtrühmas 2024. aastal. Puude raskusastmega inimeste suuremast osatähtsusest tulenevalt maksti vanaduspensioniealiste seas kõige rohkem raske puudega vanaduspensioniealiste toetust (42 550 inimest). Võrreldes tööelistega on puudega vanaduspensioniealiste seas enam neid, kelle eest makstakse hooldajale hooldajatoetust (7789 vanaduspensioniealise eest) ja sotsiaalmaksu mittetöötava hooldaja eest.

Tabel 26. Vanaduspensioniealised – toetuste ja hüvitiste saajate arv, 2024

Rühm	Saajate arv	Keskmine ja standardhälve
Keskmise puudega vanaduspensioniealise toetus	19 451	133,1€ (40,3€)
Raske puudega vanaduspensioniealise	42 550	288,6€ (75,7€)
Sügava puudega vanaduspensioniealise	7 941	404,5€ (145,5€)
Keskmise puudega tööelise toetus	458	109,7€ (67€)
Raske puudega tööelise toetus	756	133,8€ (83,1€)
Sügava puudega tööelise toetus	63	135,7€ (89,4€)
Puudega täisealise toetus (määratud enne 2008)	480	97,5€ (59,9€)
Puudega vanema toetus (üks puudega vanematest)	...	...
Puudega vanema toetus (üksi last kasvatav)	10	197,5€ (116,9€)
Puudega isik, täienduskoolituseks	3	283€ (14,4€)
Hooldajatoetus (hooldajale)	7 789	540,7€ (328€)
Sotsiaalmaks (hooldajatoetuse saaja)	1 115	306,3€ (828€)
Toimetulekutoetus	422	1072,3€ (1675€)
Töötutoetus		
Töövõimetoetus	15	-120,8€ (111,3€)
Töötuskindlustushüvitis	255	364,4€ (210,4€)

Allikas: autorite arvutused Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa registrite andmete põhjal. Valimi suurus: 70 387.

Märkus: Tabelis on arvestatud ka toetuste tagasimaksed (miinusmärgiga). Vanus on arvestatud 31.12.24 seisuga, mistõttu võidi aasta jooksul jõuda vanaduspensioniiikka, kuid enne seda saadi tööeliste toetusi/hüvitisi (nt töötutoetust). Standardhälve näitab hajuvust keskväärtuse suhtes.

Järgnev analüüs leibkondade sissetulekutest ja toimetulekust tugineb EUROMODi andmetele. Kuna EUROMOD andmed kogutakse aasta kaupa ja inimene võis pensionile siirduda aasta sees, siis on esmalt esitatud ka tulemused vanaduspensioniealiste kohta sarnaselt tööelistega sihtrühmade lõikes (vt tabel 27), et saada ülevaade, kui paljud vanaduspensioniealised said veel tööelistele suunatud toetuseid. Tabelist on näha, et kõige suurema rühma moodustavad siiski üksnes puudega vanaduspensioniealised (95%). Ligikaudu 4%-l on aasta jooksul olnud ka vähenenud töövõime ja 2%-l püsiv töövõimetus.

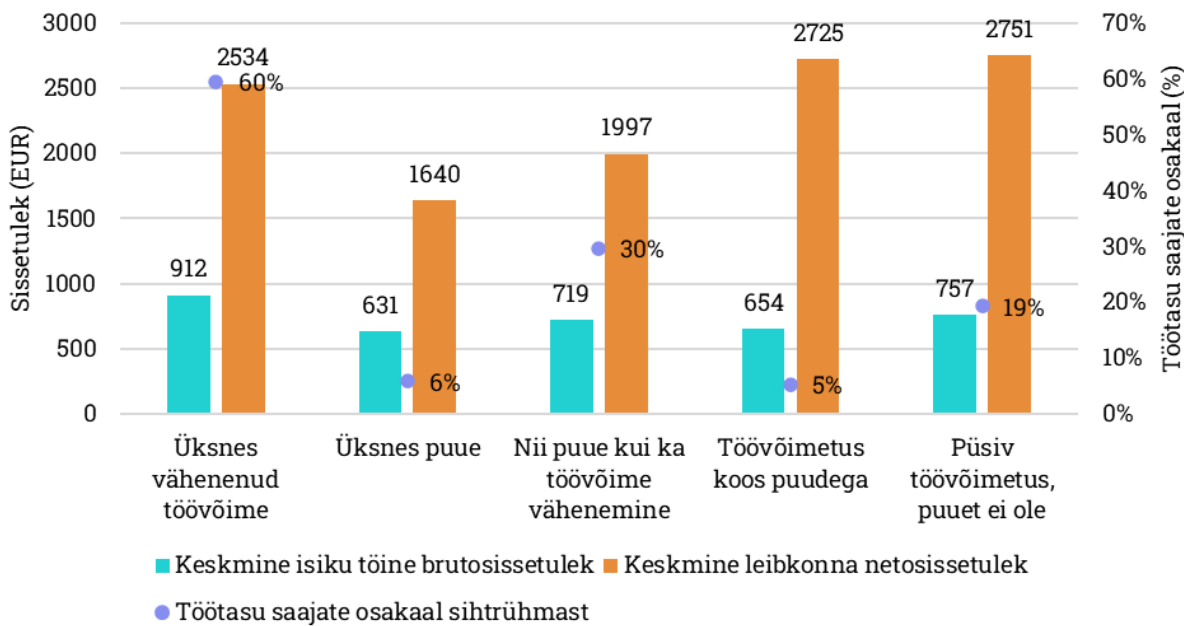
Tabel 27. Vanaduspensioniealiste jagunemine sihtrühmadesse 2024. aastal

Vanaduspensioniealised (65+)						
	Üksnes vähenenud töövõime	Üksnes puue	Nii puue kui ka töövõime vähenemine	Töövõimetus koos puudega	Püsiv töövõimetus, puuet ei ole	Kokku
Inimeste arv	1 164	61 012	1 213	587	330	64 306
Osakaal	2%	95%	2%	1%	1%	100%

Allikas: autorite arvutused EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal, kasutades 2024. aasta registripõhiseid sisendandmeid.

Üksnes puude raskusastmega vanaduspensioniealistest (kõige suurem sihtrühm) sai 2024. aastal töötasu vaid 6% (vt joonis 26). Tööealiste seas sai töötasu selles sihtrühmas ligikaudu 33%. Kuna vanaduspensioniealiste seas on enam ka neid, kes elavad üksi ja töötasu saajaid on vähe, siis on nendel ka keskmine leibkonna netosissetulek ligikaudu 1000 euro võrra madalam (1640 eurot üksnes puude raskusastmega vanaduspensioniealiste seas vs. 2541 eurot üksnes puudega tööealiste seas). Nende vanaduspensioniealiste seas, kellel oli aasta jooksul määratud veel ka töövõime vähenemine, oli töötasu saajate osakaal kõrgem (30-60%) ja sellest lähtuvalt ka sissetulek suurem, kuid need sihtrühmad ise olid väga väiksed.

Joonis 263. Puudega vanaduspensioniealiste inimeste keskmine töine sissetulek (bruto) 2024. aastal, nende leibkonna kogu keskmine netosissetulek 2025. aastal ning töötasu saajate osakaal sihtrühmast



Allikas: autorite arvutused EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal, kasutades 2024. aasta registripõhiseid sisendandmeid.

Märkused: Leibkonna kogu netosissetulek on simuleeritud (sh maksuarvestus) EUROMODiga tuginedes 2024. aasta andmetele ja viidud hinnaindekseid arvesse võttes 2025. aasta väärtustesse. Brutosissetuleku andmed on registripõhised algandmed 2024. aastast.

Kuna pikaajalise puudega inimeste töötamise võimalused üle elukaare on olnud väiksemad, siis on puudega vanaduspensioniealiste keskmine ja mediaanpension ligikaudu 50–100 eurot väiksemad Eesti keskmisest pensionist ja seetõttu on nende vaesusrisk suurem (tabel 28). Madalaim pension on sügava puudega vanaduspensioniealistel inimestel. Kuna varasemat töökogemust arvestav pensionikomponent muutub tulevikus veelgi olulisemaks, siis tõenäoliselt kasvab aastate jooksul lõhe veelgi.

Tabel 28. Pensioni saajate arv ja keskmine ning mediaanpension puudega vanaduspensioniealiste inimeste seas võrreldes nendega, kellel ei ole puuet, 2025. aasta

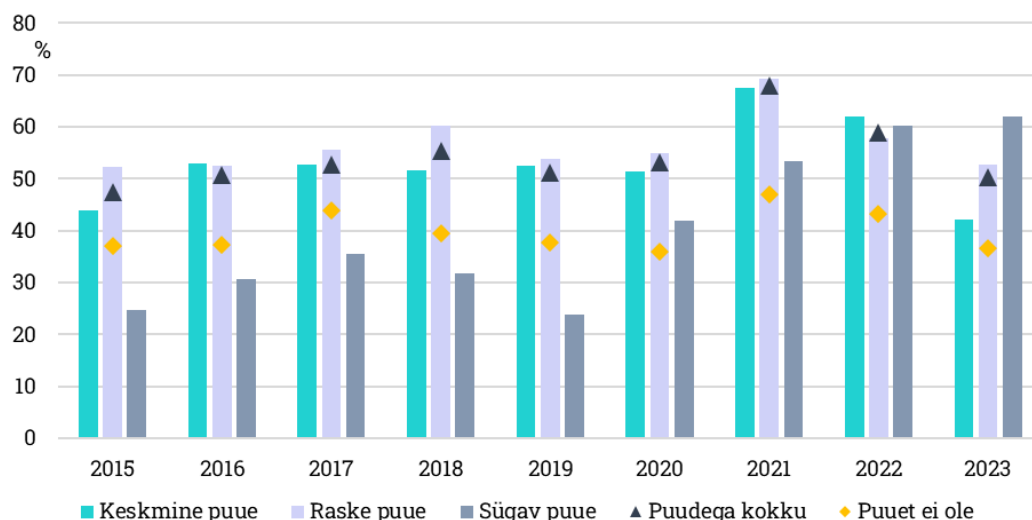
Näitaja	Vanaduspensioniealised (vanuses 65+)			
	Puuet ei ole	Keskmine puue	Raske puue	Sügav puue
Sihtgrupi suurus	223631	18908	37758	6146
Pensionisaajate arv	220684	18847	37672	6129
Keskmine pension	830,6	768,8	780,5	753,3
Mediaan pension	811,0	771,3	788,1	763,8
Puudetoetuse osakaal kogu leibkonna sissetulekus:	99% juhul ehk üle 62 tuhandel puudega inimesel moodustab puudetoetus alla 10% kogusissetulekust			

Allikas: autorite arvutused EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal, kasutades 2024. aasta registripõhiseid sisendandmeid

EUROMOD hinnangute kohaselt on puudega vanaduspensioniealiste suhtelise vaesuse määr ligikaudu 26%. See on oluliselt kõrgem tööealistega võrreldes (nt üksnes puudega tööealiste suhtelise vaesuse määr on 21%). Lisaks tuleb arvestada, et puuetega inimeste sotsiaaltoetus tõstab puudega inimeste sissetulekut ja vähendab nende suhtelist vaesust, kuid vaesusmäär ei arvesta ka võimalike täiendavate puudest tulenevate kuludega (milleks see toetus on mõeldud).

Aastate võrdluses näitavad Eesti Sotsiaaluuringu 2016–2024 andmed, et puudega vanaduspensioniealiste suhtelise vaesuse määr on läbi aastate olnud oluliselt suurem kui puudeta 65-aastastel ja vanematel inimestel (joonis 27). Kuigi viimastel aastatel on puudega vanaduspensioniealiste suhteline vaesus vähenenud, siis on see endiselt ligi 14 protsendipunkti võrra suurem kui puudeta samas vanuses inimestel. Puude raskusastme lõikes on aga viimastel aastatel suurenenud sügava puudega vähemalt 65-aastaste inimeste suhteline vaesus. Samas on ka keskmise puudega vanemaeliste suhteline vaesus oluliselt suurem kui puudeta samas vanuses elanikel. Muutused vaesuse näitajates on mõjutatud nii uuringu valimist, leibkonna koosseisust kui sellest, milline on vanaduspensioni kasv võrreldes suhtelise vaesuse piiri kasvuga.

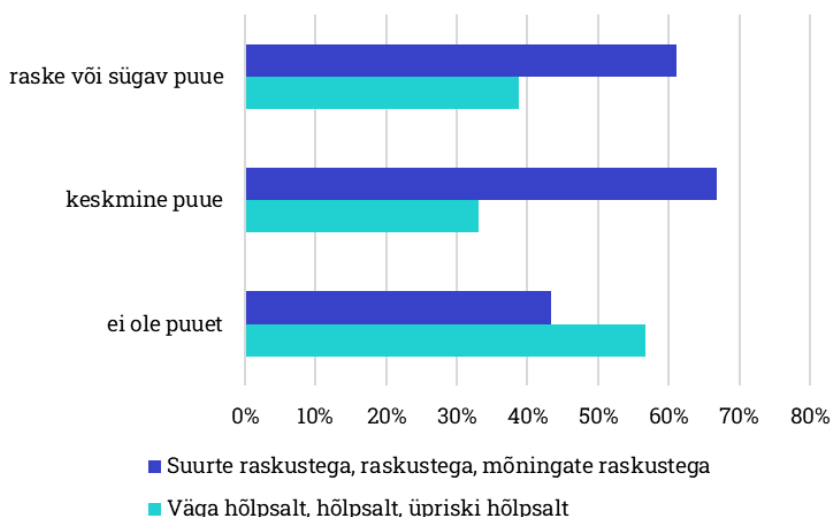
Joonis 27. Puudega ja puudeta 65-aastaste ja vanemate inimeste suhtelise vaesuse määr, 2015–2024



Allikas: autorite arvutused Statistikaameti Eesti Sotsiaaluuringu 2016–2024 andmetel (sissetulekuaastad 2015–2023).

Kuigi suhteline vaesus on keskmise puudega inimeste seas vähenenud, siis leibkonna hinnang oma majanduslikule toimetulekule näitab, et endiselt on keeruline igapäevaselt toime tulla. Jooniselt on näha, et keskmise puudega korral hinnatakse oma toimetulekut mõnevõrra keerulisemaks kui raske või sügava puudega inimeste leibkondades. Viimane selgitab ka seda, et sügava puudega korral on leibkonnas enam teisi liikmeid ja ka võimalikke töötasu saajaid.

Joonis 28. Puudega ja puudeta 65-aastaste ja vanemate inimeste jaotus subjektiivse majandusliku toimetuleku hinnangu alusel leibkonnas, 2024

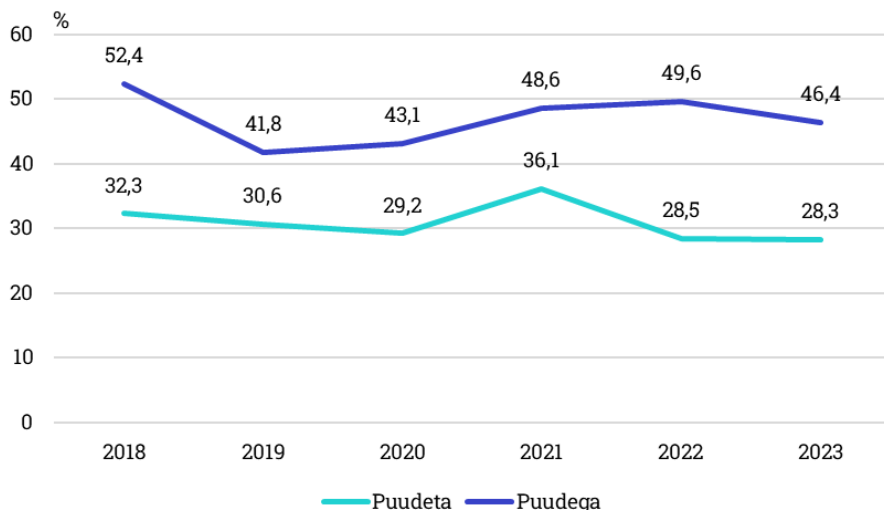


Allikas: autorite arvutused Statistikaameti Eesti Sotsiaaluuringu 2024 andmetel.

Märkus: Sügava puudega inimeste arv subjektiivse toimetuleku küsimusele ei ole piisav eraldi esitamiseks. Seetõttu on esitatud raske ja sügava puudega inimeste hinnang koondina. Samal põhjusel ei ole esitatud hinnanguid detailsemalt (nt väga hõlpsasti vastanute arv on kõikides rühmades avaldamiseks liiga väike).

Suhtelise vaesuse vähenemine viimastel aastatel peegeldub ka püsivaesuse³⁴ näitajates. Võrreldes 2018. aastaga on püsiv suhteline vaesus puudega 65-aastaste ja vanemate elanike seas oluliselt vähenenud, kuid on endiselt veidi enam kui 18 protsendipunkti suurem kui nendel vanemaelistel, kellel ei ole puuet.

Joonis 29. Puudega ja puudeta 65-aastaste ja vanemate inimeste püsiva suhtelise vaesuse määr, 2018–2023



Allikas: autorite arvutused Statistikaameti Eesti Sotsiaaluuringu 2016–2024 andmetel (sissetulekuaastad 2015–2023).

Märkus: Puude raskusastme löikes ei ole püsiva suhtelise vaesuse andmeid vaatluste arvu vähesuse tõttu võimalik avaldada.

Kulude kirjeldus

2024. aastal maksti vanaduspensioniealistele toetusi (sh nende hooldamise eest) kokku 25,5 miljonit euro ulatuses. Raske puudega vanaduspensioniealise toetus moodustas sellest 48% (12,3 miljonit), hooldajatoetus 16,5% (4,2 miljonit) ning sügava puudega vanaduspensioniealise toetus 12,5% (3,2 miljonit).

Tabel 29. Vanaduspensioniealistele makstud toetuste ja hüvitiste kogusumma toetuse liigi järgi, 2024

Rühm	Aasta summa, €
Keskmise puudega vanaduspensioniealise toetus	2 599 668 €
Raske puudega vanaduspensioniealise toetus	12 306 029 €
Sügava puudega vanaduspensioniealise toetus	3 223 802 €
Keskmise puudega tööealise toetus	82 954 €
Raske puudega tööealise toetus	61 259 €
Sügava puudega tööealise toetus	8 550 €
Puudega täisealise toetus (määratud enne 2008)	46 816 €
Puudega vanema toetus (üks puudega vanematest)	
Puudega vanema toetus (üksi last kasvatav)	1 975 €
Puudega isik, täienduskoolituseks	850 €

³⁴ Püsiva suhtelise vaesuse määr näitab nende isikute osatähtsust, kelle ekvivalentnetosissetulek (tarbimiskaaludega 1:0,5:0,3 jagatud leibkonna netosissetulek) oli suhtelise vaesuse piirist madalam vaadeldud aastal ja vähemalt kahel eelnenud kolmest aastast. Püsivaesuse näitaja aasta näitab viimast uuringu aastat.

Hooldajapuhkus	19 611 €
Hooldajatoetus (hooldajale)	4 211 661 €
Sotsiaalmaks (hooldajatoetuse saaja)	2 385 948 €
Toimetulekutoetus	452 527 €
Töötutoetus	
Töövõimetoetus	-1 811 €
Töötuskindlustushüvitis	92 923 €

Allikas: autorite arvutused Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Töötukassa 2024. aasta registriandmete põhjal. Valimi suurus: 70 387.

Märkus: Summa sisaldab ka tagasimakseid (miinusemärgiga). Vanus on arvestatud 31.12.24 seisuga, mistõttu võidi aasta jooksul jõuda vanaduspensioniiikka, kuid enne seda saadi tööealiste toetusi/hüvitiisi (nt töötutoetust).

Vanaduspensioniealiste teenuste kasutamise kaasnivad kulud on tabelis 30. SRT kogukulu oli 437 999 eurot, millest kõige suurema osa moodustas psühholoogi individuaalteenus (88 915 eurot). 71 105 eurot kulus füsioterapeudi individuaalteenusele, ning 60 298 eurot tegevusterapeudi individuaalteenusele. Töötukassa teenustele kulus 233 900 €, millest kõige suurem osa oli tööalane rehabilitatsioon (63 950 eurot), palgatoetus (46 409 eurot) ning tööturukoolitus töötutele ja tööotsijatele (sh kutseeksam) (43 877 eurot).

Tabel 30. Vanaduspensioniealiste teenuste kulud, 2024

Teenused	Kulu
SKA teenused kokku	437 999 €
TK teenused kokku	233 900 €
Toetused teenustel osalemiseks	4 972 €

Allikas: autorite arvutused Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Töötukassa 2024. aasta registriandmete põhjal. Valimi suurus: 70 387.

11. Lahendused

Selles peatükis pakume välja alternatiivseid teekondi senisele töövõime- ja puude tuvastamise süsteemile, lähtudes eeldusest, et puude tuvastamine praegusel kujul on lõpetatud.

Teekondade koostamiseks kasutasime töötubade, teiste riikide analüüsi ja ekspertintervjuude sisendit. Esimesi visandeid arutati puuetega inimeste töötubades. Oluline on märkida, et puudega inimesed pole ühetaoline grupp, seetõttu ei saa väita, et iga teekond peegeldaks kõigi puuetega inimeste vaadet.

Praegu on lisaks PISTS toetusele puudega inimesel erinevad õigused nii toetustele, teenustele kui muudele õigustele ja soodustustele (edaspidi hüved). Erinevused on seotud vanusega (tööealised ja vanaduspensioniealised). Samuti kehtivad mõned toetused, teenused ja hüved ka osalise või puuduva töövõimega isikutele. Lisaks on osa õigusi seotud puudega isiku hooldamisega. Ülevaade toetustest, teenustest ja hüvedest ning sellest, kellele need praegu kehtivad, on esitatud tabelis Lisas 3. Lahenduste juures kirjeldame, kuidas või mille alusel on olulisemaid hüvesid edaspidi võimalik saada. Detailsemalt on mõju kirjeldatud terviklahenduse peatükis.

11.1. Väärtused, millest hindamine peaks lähtuma

Reformi väärtusraamistik sündis ühises tööprotsessis, kus töötubade osalejad jagasid oma kogemusi, ootuseid ja muresid ning arutlesid puude hindamise süsteemi üle. Arutelude tulemusel jõuti üksmeelele väärtustes, millele peaks tuginema õiglane, inimkeskne ja toetav hindamissüsteem – väärtustes, mis lähtuvad inimeste vajadustest ja loovad aluse väärrikale ning läbipaistvale hindamisele. Järgnevaid väärtusi tulekski käsitleda kui sihtrühma aruelude sünteesi.

Läbipaistvus ja lihtsus

Hindamise protsess ja otsuste kujunemine on selged, arusaadavad ja läbipaistvad. Inimene saab teada, kuidas tema olukorda hinnati ja mis põhjusel otsus tehti.

Usaldus ja väärrikus

Iga inimest koheldakse austuse ja lugupidamisega ning eelarvamusteta. Hindamine toimub toetavas, mitte kontrollivas või kahtlustavas vaimus.

Inimese kogemuse usaldamine

Hindamisel on kombineeritud spetsialisti objektiivne hinnang tervisele ja inimese enda ja/või tema lähedaste hinnang oma toimetulekule ja vajadustele. Ekspertide roll on kuulata ja toetada, mitte kahtlustada.

Ligipääsetavus ja toetatus

Hindamise protsess on kõigile ligipääsetav, ka esmataotlejale, sõltumata inimese digipädevusest või tervisest tulenevast takistusest. Pakutakse vajalikku tuge, et iga inimene saaks osaleda oma hindamises võrdselt ja väärikalt.

Siht täisväärtuslikuma (iseseisva) elu poole

Hindamise aluseks on inimese iseseisev ja täisväärtuslik elus osalemine tervikuna (füüsiline, vaimne, sotsiaalne heaolu) võrdselt nendega, kellel ei ole puuet, mitte pelgalt puudega inimese baasvajaduste rahuldamine. Hindamise aluseks peaks olema küsimus: „mis tingimused peaksid olema täidetud, et inimene saab iseseisvalt hakkama“, mitte „mis tingimustel inimene jääb ellu?“.

11.2. Eeldused, mida süsteemi muutmise peaks täitma

Puuetega inimeste vaates on hindamise süsteemi mõttekas muuta vaid siis, kui on täidetud teatud olulised eeldused, mis aitavad lahendada probleeme, millega puuetega inimesed praeguses süsteemis kokku puutuvad. Ilma selleta tähendaks muutus pelgalt vormilist nihet, mis ei paranda puuetega inimeste olukorda ega muuda süsteemi õiglasemaks. Puuetega inimeste vaatest ei seisne probleemi tuum hindamismetoodikas ega selles, milline asutus puude hindamist läbi viib, vaid eelkõige selles, kas süsteem suudab tugineda täpsetele ja ajakohastele andmetele, pakkuda inimestele selget ja toetavat hindamiskogemust ning tagada, et hindamise tulemusel saavad inimesed vajalikku tuge. Kui need tingimused jäävad täitmata, taastoodab muutus samu probleeme, mis on praeguse süsteemi keskmes – ülemäärane halduskoormus ja ebavõrdsed võimalused teenustele ligipääsemisel.

Ka Riigikontrolli (2024) hinnangul tuleb süsteemi muutmisel eraldi tähelepanu pöörata inimese toetamisele abini jõudmisel, mitte ainult piirduda süsteemide sisemise toimimise lihtsustamisega. Puuetega inimeste vaatest tuleb seetõttu järgnevaid eeldusi käsitleda vältimatute struktuursete eeltingimustena. Alles kui need on tagatud, saab rääkida puuetega inimeste elu parandavast muutusest, mitte vaid halduslikust ümberkorraldusest.

Ka järgnev on sihtrühma arutelude sünteesi tulemus.

Andmete kvaliteet

Terviseandmete ajakohasus TIS-is

Selleks, et puude hindamise süsteem toimiks õiglaselt ja tõhusalt, peavad terviseandmed TIS-is olema pidevalt ajakohased. Püsivate seisundite, näiteks nägemis-, kuulmis- või liikumisfunktsiooni piirangute diagnoosid, peavad jääma süsteemis nähtavaks ka aastate möödudes. See tagab, et inimese olukorra hindamine tugineb täielikule ja realistlikule pildile tema tervislikust seisundist ning välistab olukorrad, kus olulised diagnoosid on „kadunud“ või „aegunud andmete“ tõttu hindamisel arvesse võtmata. Riigikontrolli (2025) hinnangul halvendavad töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise aluseks olevad puudulikud terviseandmed inimeste võimalusi saada sotsiaaltoetusi ja -teenuseid, millele neil on õigus ja mille järele on vajadus.

Raviarstide kanded ja spetsialisti juurde suunamise vähendamine

Puude hindamise süsteemi toimimise eelduseks on, et raviarstid sisestavad TIS-i põhjalikud ja sisukad kanded. Nii ei pea inimene enne hindamist spetsiaalselt eriarsti juurde minema ainult selleks, et uuendada andmeid juba teadaolevate seisundite kohta. Selline lähenemine vähendab bürokraatiat, säästab inimeste aega ja vähendab nii tervishoiusüsteemi kui ka taotlejate halduskoormust.

Tõhus andmevahetuse asutuste vahel

Tõhus puude hindamise süsteem eeldab, et andmevahetus eri asutuste – näiteks rehabilitatsiooniteenuse osutajate, kohalike omavalitsuste ja teiste osapoolte – vahel toimib sujuvalt ja turvaliselt. Hästi korraldatud andmevahetus välistab dubleerimist, võimaldab terviklikku ülevaadet inimese olukorrast ning kiirendab otsuste tegemist. Samuti vähendab see vajadust, et inimene peaks korduvalt samu andmeid erinevatele asutustele esitama.

Inimeste toetamine hindamisprotsessis

Eeltäidetud taotlusvormide kasutuselevõtt

Et vähendada taotlejate halduskoormust ja lihtsustada protsessi, peaks süsteem kasutama eeltäidetud taotlusvorme, mis tõmbavad automaatselt vajalikud andmed TIS-ist ja teistest seotud registritest ning oleks varasema taotluse põhjal eeltäidetud. See suurendab efektiivsust ning muudab taotlemise kasutajale arusaadavamaks ja kiiremini teostatavaks. Korduvhindamisel on taotlusvorm eeltäidetud varasemate andmetega, mida taotleja saab vajadusel muuta ning täiendada.

Info kättesaadavus hindamisprotsessis

Süsteemi läbipaistvuse ja kasutajasõbralikkuse tagamiseks peab kogu hindamise protsess – sealhulgas teave hindamise sisu, vastutavate asutuste ja taotlemise sammude kohta – olema inimestele kergesti kättesaadav. Selged juhised ja lihtne ligipääs infomaterjalidele aitavad vähendada teadmatusel tulenevat stressi ja toetavad inimeste võrdseid võimalusi teenustele ligipääsuks.

Püsivad seisundid ja korduvhindamised

Uue süsteemi kujundamisel tuleb arvestada, et püsiva iseloomuga tervises seisundite puhul ei ole mõistlik ega inimkeskne nõuda sagedasi korduvhindamisi. Kui inimese seisund ei ole ajas muutuv, peaks hindamise kehtivus olema oluliselt pikem – vähemalt kümme aastat või vajadusel eluaegne. Selleks tuleks täiendada ja korrastada nimekirja püsivatest seisunditest, mille puhul hindamise tulemus kehtib automaatselt eluaegselt või väga pika perioodi jooksul. Selline lahendus toetab süsteemi ressursitõhusust, vähendab inimeste haldus- ja emotsionaalset koormust ning võimaldab suunata hindamisvõimekuse juhtudele, kus inimese seisund võib ajas muutuda.

Teenuste ja toetuste kättesaadavus

Teenuste sidumine tuvastatud piirangutega

Inimestel peab olema võimalik kiiresti mõista, millised teenused ja toetused neile tuvastatud piirangute alusel kuuluvad, millised tingimused nende kasutamiseks kehtivad ning kuidas neile ligi pääseda. Ideaalis peaks puude hindamisele (olgu selleks puude raskusastme hindamine, töövõime hindamine või midagi muud või uut) järgnema konkreetsete sekkumiste või teenuste pakkumine, mis aitavad tuvastatud piiranguid kompenseerida.

Teenuste sõltumatuse tagamine leibkonna sissetulekust

Süsteem peab tagama, et puuetega inimestele mõeldud teenused ja toetused ei sõltu leibkonna sissetulekust. Puue ei ole majanduslik, vaid funktsionaalne kategooria ning sellest tulenevad vajadused ei kao seetõttu, et inimese pereliikmel on kõrgem sissetulek. Teenuste sidumine ainult vajadusega, mitte sissetuleku tasemega tagab õiglasema süsteemi.

Toetuste säilimine

Süsteemi muutuse õnnestumise eelduseks on ka see, et olemasolevad toetused säiliks ega väheneks. Puuetega inimeste jaoks on praegused toetused sageli vaid miinimumtase, mis küll aitavad katta puudest tulenevaid lisakulutusi, kuid seda siiski osaliselt. Tegelik ootus ja vajadus on suurematele toetustele, mis vastavad puude tõttu tekkivatele tegelikele kuludele.

Ilma piisavate toetusteta ei ole hindamissüsteemi täpsusel ja õiglusel päriselulist mõju inimeste elukvaliteedile. Sellest tulenevalt ei ole puudetoetuse maksmise lõpetamine ja ümberjaotamine sihtrühma vaates asjakohased süsteemi muudatused, kuna need ei lahenda toimetulekuraskusi.

Olemasoleva süsteemi kasutajasõbralikumaks muutmine seisneb eeskätt eeltäidetud taotluste kasutamises, otsuste kestvuse pikendamises püsivate seisundite puhul, muude hindamiste arvesse võtmist puude tuvastamisel ning põhiteenuste kuvamist, mida sama puudeliigiga inimesed võivad saada. Õiguseksperdi hinnangul on rahvusvahelisi kohustusi arvesse võttes need sammud õiges suunas ning ei ole võetud kohustustega vastuolus (vt Lisa 2).

Siiski ei lahenda need sammud põhiküsimusi:

- Viiakse läbi vähemalt kaks hindamist.
- Abi andmise süsteem on endiselt killustatud (ja mitte ainult seetõttu, et hindamisi viivad läbi ja teenuseid osutavad SKA ja TK; teenuseid osutavad ka kohalikud omavalitsused ja eraõiguslikud asutused).
- Sotsiaaltoetust makstakse sõltumata tegelikest puudest tingitud lisakuludest.
- Puuetega inimesi käsitletakse endiselt peamiselt sotsiaalteenuste saajatena kõigis eluvaldkondades. Inimestele ei osutata koordineeritud abi, mis hõlmaks vajadusel ka muid eluvaldkondi.
- Ettepanekutega arvestamine loob info jagamise kaudu rohkem võimalusi sotsiaalteenuste saamiseks, kuid jätab lahenduseta inimõiguste mudeli keskse küsimuse, kuidas tagada iseseisev elu, osalus ja võrdsus kõigis eluvaldkondades.

11.3. Teekond 1 – üks hindamine töötukassas, riik ei tuvasta puude raskusastet

Selles lahenduses hinnatakse tööealistel inimestel ainult töövõimet. Vanaduspensioniealistel inimestel hinnatakse õigustatust toetusele tegutsemispiirangute alusel. KOV-ide roll ja ülesanded ei muutu – KOV hindab abivajadust ja pakub teenuseid sarnaselt praegusele. KOV teenused ega toetused ei ole seotud puude raskusastmega.

11.3.1. Tööealised inimesed

Kahe hindamise ühendamist ja seeläbi süsteemi lihtsustamist tööealistele inimestele on soovitanud Riigikontroll erivajadustega inimeste auditis (Riigikontroll, 2024). Sihtrühmaga läbiviidud töötubades toodi välja kahe hindamise keerukus ning arutati võimalust, mille puhul toimub üks hindamine töötukassas. Sihtrühma arutelu tõi välja, et praegused PISTS

toetused on nende toimetulekuks ja ka erinevate kulude tegemisel olulised ning seetõttu peeti oluliseks säilitada diferentseeritud toetused. Seda näitavad ka ptk-s 7 kirjeldatud puuetega inimeste probleemid ehk vaesuse ja ilmajäetuse andmed ning ka teiste uuringute tulemused (nt Vainu, 2025).

Sellest tulenevalt leiti töötubades, et puudega tööealise inimese toetuse määramine ja maksmine on vaja viia süsteemi lihtsustamiseks üle töötukassasse. Ametnike ja ekspertide töötoas loobuti sellisest lahendusest, sest puudega tööealise inimese toetuse maksmise jätkamine töötukassas eeldab vastava metoodika ületoomist SKAst ning selle tulemusena suureneksid oluliselt nii töökorralduse kui arendustega seotud kulud. Samuti tähendaks see, et sisuliselt jääks ikkagi kaks erinevat hindamist ning olukord ei muutuks oluliselt.

Arvestades, et sihtrühma üheks mureks on majanduslik toimetulek (vt ptk 7), analüüsiti pärast töötube erinevaid teisi toetuste stsenaariume, mida oleks võimalik lisada töövõimetoetuse skeemi. Seetõttu ei arutanud ka sihtgrupp konkreetseid lahendusi, mis on välja pakutud teekonna erinevates stsenaariumides.

Üks hindamine töötukassas tundus puuetega inimeste organisatsioonide esindajatele valdavalt loogiline. Mõned töötubades osalejad tõid välja, et puude tuvastamine ei ole esmatähtis, vaid oluline on toe pakkumine. Vähem hindamisi vähendab administratiivset ning taotlemise koormust. Samas tõid osalejad riskina välja, et süsteemi lihtsamaks muutmine ei tähendada, et see muutub õiglasemaks. Ka nähti võimaliku riskina, et puude mõiste sidumine töövõime mõistega võib kitsendada arusaama puudest liialt tööturukeskseks. Esindusorganisatsioonide esindajad tõid välja, et muudatus ei lahenda hindamismetoodika põhiprobleeme, millele nad on tähelepanu juhtinud (näiteks, et metoodika ei kirjelda piisavalt inimese tegelikku abivajadust igapäevases elus osalemiseks). Seetõttu on uuringu autorite hinnangul oluline lisaks töövõimet välistavate seisundite loetelule välja töötada muutumatute või püsivate seisundite loetelu, mille puhul saab vähendada töövõime korduvat hindamist.

Ka uuringu autorite hinnangul ei lahenda üks hindamine erinevaid puuetega inimeste probleeme. Üheks selliseks probleemiks on teenuste kättesaadavus, sh teenusteni jõudmine. Seetõttu on oluline lisada töövõime hindamise juurde ka info teenuste kohta ja tugevdada koostööd kohalike omavalitsustega. Puudega inimesed ei tea sageli, kuhu pöörduda vajalike teenuste saamiseks (seda kinnitavad ka uuringute andmed, vt Vainu, 2025) ja puudub usaldus sotsiaaltöötajate vastu. Lahendus eeldab ka paremat kommunikatsiooni ja proaktiivset kontakti KOV poolt.

Selle teekonna all käsitleme kaht peamist varianti koos (ala)stsenaariumidega, arvestades mh süsteemi lihtsustamisega ning mõjuga inimeste toimetulekule. Kõikide selle teekonna stsenaariumide puhul hindab töötukassa töövõimet ning SKA puude raskusastet enam ei tuvasta. Töövõime hindamise metoodika ei muutu.

Variant 1: Töövõimetoetuse suuruse muutmine:

- Makstakse ainult töövõimetoetust. Töövõimetoetuse suurust tõstetakse kõikidel töövõimetoetuse saajatel, jäädes esimesel aastal olemasolevate ressursside³⁵ piiridesse (stsenaarium STS 1a), kuid sellele järgnevatel aastatel lisandub töövõimetoetuse päevamäära indekseerimisest tulenev mõju.
- Makstakse ainult töövõimetoetust. Töövõimetoetust tõstetakse praeguse puudega tööealise inimese toetuse summa võrra kõigil vähenenud töövõimega inimestel (sh neil, kes praegu puudega tööealise inimese toetust ei saa) (stsenaarium STS 1b).
- Makstakse ainult töövõimetoetust, kuid seda tõstetakse ainult puuduva töövõimega inimestel (stsenaariumid STS 1c ja STS 1d). Puuduva töövõimega inimeste toetuse tõstmisel on lähtutud sellest, et suurel osal puude raskusastmega inimestest on täna ka puuduv töövõime (vt alaptk 10.1. „Sihtrühmade ülevaade“).

Variant 2: Täiendav toetus tegevuspiirangutega inimesele:

- Lisaks töövõimetoetusele maksab töötukassa töövõime hindamise ekspertiisis tuvastatud täieliku või raske tegutsemispiiranguga inimestele toetust (**edaspidi TRT**), mida ei indekseerita, kuid mida saab tõsta Riigikogu otsusega. Toetus on kahes suuruses, seda makstakse täieliku või raske piiranguga puuduva töövõimega inimestele suuremas summas ning täieliku või raske piiranguga osalise töövõimega inimestele väiksemas summas (vt statistilised andmed koos selgitusega lisa 4). Toetust maksab töötukassa puudega tööealise inimese toetuse asemel. Eeldatavalt need inimesed, kellel on tänases süsteemis tuvastatud puude raskusaste, saavad ka edaspidi täiendavat toetust. Piirangute raskusastme alusel toetuse suuruse diferentseerimine on põhjendatud, kuna uuringute järgi on igapäevategevuses oluliselt piiratud inimeste, aga ka osaliselt piiratud inimeste suhteline vaesus suurem kui tegevuspiiranguteta inimestel (vt ptk 7).
- Lisaks töövõimetoetusele maksab töötukassa täieliku või raske tegutsemispiiranguga inimestele toetust, mida ei indekseerita, kuid saab tõsta Riigikogu otsusega. Toetus on kahes suuruses, seda makstakse puuduva töövõimega inimestele suuremas summas ning täieliku ja raske piiranguga osalise töövõimega inimestele väiksemas summas (vt ka lisa 4).
- Võimalik on maksta ka suuremas summas toetust, kui on täielik piirang (sh välistavad seisundid), ja väiksemas summas, kui on raske piirang, olenemata sellest, milline on töövõime ulatus. Selline lahendus võib aga tekitada segadust, kuivõrd nii osalise kui puuduva töövõimega inimesed saaksid samas suuruses toetust, kui neil on raske piirang. Ka ei ole EUROMOD andmestikus teavet töövõime otsuste aluseks

³⁵ Olemasolevad ressursid tähendavad siin praeguse puude raskusastme tuvastamise ja puudega tööealise inimese toetuse maksmise vahendeid.

olnud piirangutest, mistõttu ei ole võimalik selle alternatiivi mõju hinnata. Edasises analüüsis on fookuses variandid a ja c.

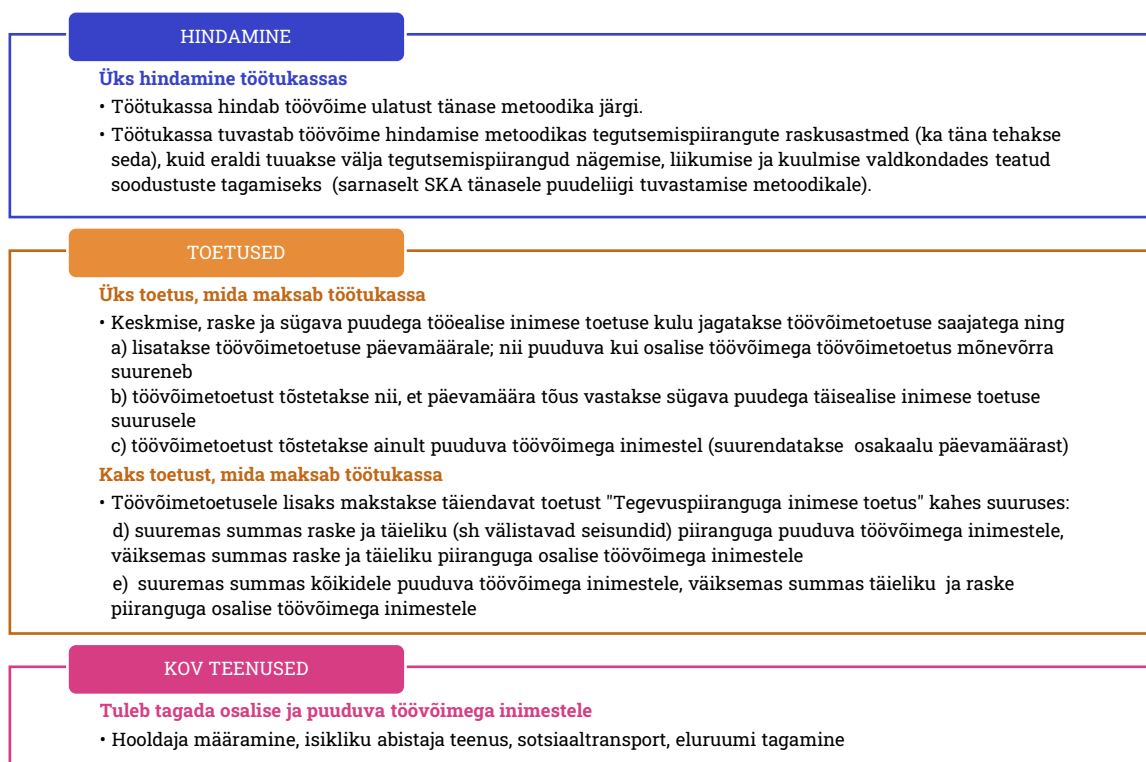
Töövõimetoetuse tõstmine toetab ka Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi ja sotsiaalharta miinimumnõuete täitmist. 2024. aasta töövõimetoetuse suuruseid arvestades jäi Sotsiaalkindlustuskoodeksi miinimumnõuete³⁶ täitmisest puudu ligi 60 eurot ning kui siis oleks kehtinud üldine maksuvaba tulu, oleks puudu jäänud ligi 70 eurot³⁷. Alastsenaariumid a ja c arvestavad toetuste suurustes neid kitsaskohti. Õiguseksperdi hinnangul TRT siiski asendussissetulekuna arvesse ei pruugi minna. Töövõimetoetuse tõstmine aitaks vähendada neid puudest tingitud lisakulusid, mida inimesed teevad oma sissetuleku arvelt. Selle võrra jääks inimestele rohkem raha toiduks ja muudeks igapäevaeluga seotud kulutusteks. Siiski soovitame konsulteerida koodeksi ekspertidega, millistel tingimustel ja kas üldse on võimalik edaspidi arvestada, et sama sotsiaalkindlustusriski korral arvestatakse lisaks puuduva töövõime toetusele ka perioodilist TRT-d, kui viimane on suunatud samale sihtrühmale majanduslike mõjude kompenseerimiseks.

Seejuures analüüsiti ka, kas uuele töövõimetoetuse suurusele või TRT-le on võimalik üle minna järk-järgult ehk vastavalt sellele, kuidas tööealise puudega inimese toetuse vahendid vabanevad, kui tööelistel enam puude raskusastet ei tuvastata (sellele lisanduvad ka SKA tööealiste inimeste ekspertiisi vabanevad vahendid). Arvestades puude raskusastme otsuste lõppemist, oleks esimeste üleminekuaastate eelarveliste vahendite summa liiga väike, katmaks ära seda, et õigus toetusele on ka üksnes vähenenud töövõimega inimestel. Ka ei oleks õigustatud määrata töövõimetoetust suuremas määras vaid uutele taotlejatele. Näiteks oleks esimesel aastal vabaneva PISTS tööealiste toetuste summa u 1,5 milj eurot ehk kui ainult puuduva töövõimega inimese töövõimetoetus suureneb ning seda keskmiselt 97,8 euro võrra kuus, siis saaks uues määras toetust maksta 1296-le puuduva töövõimega inimesele (täpsemad arvutused on esitatud Exceli kulumudelil). Seetõttu on ettepanek sätestada tähtaeg, kui lõpetatakse PISTS alusel tööelistele toetuste maksmine SKA kaudu ning alustatakse töövõimetoetuse maksmist suuremas määras kõigile üheaegselt. Viimane tähendab, et puudega tööealise sotsiaaltoetuse vahendid antakse TK-le töövõimetoetuse maksmiseks kogusummas konkreetsest ajahetkest alates.

³⁶ Sotsiaalkindlustuskoodeksis on määratletud, et invaliidsushüvitise perioodilised väljamaksed standardsetele hüvitisesaajatele (mees abikaasa ja kahe lapsega) peavad moodustama 65% meeslihttöölise netopalgast. <https://rm.coe.int/168007b3d6>

³⁷ 2024. aasta andmetel oli umbes 60 eurot puuduva töövõime korral puudu 65% meeslihttöölise netopalgast + peretoetused (arvestatakse isik koos ülalpeetava abikaasa ja kahe lapsega); maksuküüru kaotamisel aga ca 70 eurot puudu. Modelleeritud andmete alusel oli 2024. aastal meeslihttöölise brutopalk 1313,24 eurot kuus ning netopalk 1127,12 eurot kuus. Maksuküüru kaotamise korral oleks netopalk olnud 1141,46 eurot kuus. Kahe lapsega pere peretoetuste summa oli 160 eurot kuus. Meeslihttöölise palga modelleerimise aluseks on Statistikaameti avaldatud andmed ja Sotsiaalkindlustuskoodeksi põhimõtted ning Eesti viimati esitatud [aruanne](#).

Joonis 30. Teekond 1 tööelised inimesed



Tabelis 31 on esitatud, kuidas tagada muudatuse järel praegused puude olemasolu, liigi või raskusastmega seotud peamised hüved. Puude raskusastme asemel saab aluseks võtta kas töövõime ulatuse, töövõime hindamise raames tuvastatud tegutsemispiirangu raskusastme ja/või tuvastatud valdkondlikud piirangud (nt nägemises). Hüvedest jäävad ilma inimesed, kellel on tuvastatud üksnes puude raskusaste, sh varem pensionile jäänud inimesed. Seetõttu on vajalik üleminekuperiood, mille jooksul pensioni saajatele jätkub praeguse puudega tööelise inimese toetuse maksmine kuni vanaduspensioniiikka jõudmiseni (kokku oli 2024. aastal 218 tööelist, kellel oli tuvastatud üksnes puude raskusaste; kvalitatiivuuring näitas, et peamiseks töövõime hindamise mittetaotlemise põhjuseks on ennetähtaegselt pensionile jäämine). Pensioni mittesaajaid tuleks teavitada võimalusest taotleda töövõime hindamist. Kui nende töövõime on hinnatud täielikuks, siis tuleb tagada neile üleminekuperioodi jooksul (kuni kehtiva puude raskusastme otsuse lõppemiseni) praeguse toetuse säilimine. Eraldi kaalumist vajab, kas sätestata erand neile, kellel on püsiv töövõimetus ja puude raskusaste, ning maksta neile tööelise PISTS toetust kuni puude otsuse kehtivuse lõpuni.

Tabel 31. Kaasuvate hüvede saamine

HÜVE	LAHENDUS
Puudega tööealise inimese toetus	Selle asemel: a) makstakse töövõimetoetust suuremas suuruses b) makstakse lisaks töövõimetoetusele tegevuspiiranguga inimese toetust töötukassa kaudu
Puudega vanema toetus	Toetust saavad osalise või puuduva töövõimega üksi last kasvatav vanem või üks osalise või puuduva töövõimega vanematest.
Õppetoetus	Toetus kaob ära, summad antakse üle HTM-le erivajadusega üliõpilase stipendiumi ressursiks.
Täienduskoolitustoetus	Toetus kaob ära, eelarvesumma antakse üle TK-le koolitustoetuseks.
Puudega isiku kaart/European Disability Card	Kaardi saavad töövõimetoetuse ja töövõimetuspensionini saajad. Kaardil on välja toodud liikumis- ja nägemisfunktsioonide piirangud koos raskusastmetega.
Erivajadusega üliõpilase stipendium	Õigus stipendiumile on töövõime hindamisel tuvastatud funktsioonipiirangu alusel. Sügav puue = täielik piirang; raske puue = raske piirang; keskmine puue = mõõdukas piirang.
Välisõpingute stipendium	Taotlejal on tuvastatud osaline või puuduv töövõime.
Õppekulude hüvitamine	Õppekulude hüvitamist ei nõuta üliõpilaselt, kellel on osaline või puuduv töövõime.
Puhkus sügava puudega isiku hooldamiseks	Puhkust antakse puuduva töövõimega isiku hooldamiseks.
Tööandja poolt antud abivahendeid ei maksustata erisoodustusmaksuga	Erisoodustus ei kehti osalise või puuduva töövõimega töötaja tööalaste abivahendite kuludele.
Puudega inimeste õigusabi	Osalise või puuduva töövõimega isikud, töövõimetuspensionärid.
Puudega inimese parkimiskaart	Isikud, kellel on liikumis- või nägemisfunktsiooni piirangud (täielik või raske piirang). Väljastab KOV.
Riigisisised sõidusoodustused	Puuduva töövõimega inimesed, täieliku ja raske liikumisfunktsiooni või nägemisfunktsiooni piiranguga isik ja saatja ning juhtkoer.
Tasuta riigimuuseumi külastus	Puuduva töövõimega inimesed.
Vähendatud riigilõiv isikut töendavate dokumentide taotlemisel	Osalise või puuduva töövõimega isikud, töövõimetuspensionini saajad.

Riigi kulud ja mõju vaesusele

Tööealiste seas analüüsitakse järgnevalt mõju vaesusele ja antakse kuluhinnangud kahe variandi korral. **Esimese variandina** antakse hinnangud olukorras, kus puuetega inimeste toetust enam tööealistele ei maksta ja see integreeritakse töövõimetoetusesse (st töövõimetoetuse päevamäära kohandamine). **Teise variandina** luuakse töövõimetoetuse kõrvale TRT. Mõlemal juhul on arvutuste aluseks 2024. aasta andmed tegelike toetuse saajate kohta ning mõjude analüüsil eeldatakse, et muudatus jõustuks koheselt (muude 2025. aasta poliitikareeglite samaks jäädes). Metoodika täpsema kirjelduse leiab metoodika peatükist.

Esimese variandi kuluhinnangud ja mõju vaesusele on leitud järgnevates olukordades:

- puuetega tööealiste inimeste sotsiaaltoetuse arvelt (riigi kulud ei kasvaks) tõstetakse töövõimetoetuse päevamäära kõigil vähenenud töövõimega inimestel (STS 1a, vt toetuse suuruseid tabelis 32);
- puuetega tööealiste inimeste sotsiaaltoetuse arvelt tõstetakse töövõimetoetuse päevamäära kõigil vähenenud töövõimega inimestel selliselt, et katta ära 2025. aastal puuetega inimestele makstav toetuse suurus kuus (STS 1b);
- töövõimetoetust tõstetakse üksnes puuduva töövõimega inimestel nii, et toetuse suurus ei ole 100% päevamäärast, vaid 115% (STS 1c) – sellisel juhul vastab toetuse suurenemine ligikaudu tänase sügava puudega tööealise toetuse suurusele;
- töövõimetoetust tõstetakse üksnes puuduva töövõimega inimestel nii, et toetuse suurus ei ole 100% päevamäärast, vaid 108% (STS 1d) – sellisel juhul vastab toetuse suurenemine ligikaudu tänase raske puudega tööealise toetuse suurusele.

Töövõimetoetuste päevamäärad, toetuse suurus kuus ning kogukulud ja nende muutus võrreldes praeguse olukorraga on esitatud tabelis 32.³⁸ Ilma riigi kulude olulise kasvuta saaks kõigil vähenenud töövõimega inimestel töövõimetoetuse päevamäära tõsta vaid 1 euro võrra kuus. Kui tõsta töövõimetoetuse päevamäär praeguselt 21,74 eurolt 25,07 euroni, mis kataks puuetega inimestel praeguse igakuise PISTS toetuse, siis kasvaksid kulud ligikaudu 63,6 miljonit eurot aastas. Kui töövõimetoetust tõsta üksnes puuduva töövõimega inimestel, siis praeguste PISTS kulude juures saaks päevamäära tõsta 23,48 euroni.³⁹

Et töövõimetoetuse päevamäär on iga aasta 1. aprillil indekseeritav pensioniindeksiga, kaasneb stsenaariumidega STS 1a ja STS 1b lisaks tabelis 32 toodule täiendav kulu seoses suurema päevamäära indekseerimisega edaspidi (seejuures on indekseerimise mõju ajas kumuleeruv). Näiteks kui STS 1a kulude muutus on -1,29 mln eurot, siis juba kahe aasta pärast oleks vaja juurde 1,24 mln eurot ehk siis juba ei piisaks toetuse tõusu katteks PISTS tänastest kuludest ning vaja oleks täiendavaid vahendeid. Täpsemad arvutused on esitatud Exceli kulumudelil. Stsenaariumid STS 1c ja STS 1d töövõimetoetuse päevamäära ei muuda, mistõttu indekseerimisest tulenevaid lisakulusid otseselt ei teki. Küll aga suureneb iga-aastase indekseerimise mõjul toetuse absoluutne suurus, sest toetuse määr puuduva töövõime korral on tõstetud 100%-lt 115%-le või 108%-le ning see mõjutab teatud määral ka muudatusega kaasnevat kulude muutust. Seega, kui STS 1d kulude muutus on esimesel aastal 0,6 miljonit

³⁸ Kuluhinnangud on leitud nii Exceli kulumudeli kui ka EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal. Üldine suurusjärg on neil tulemuste osas sarnane. Mõned erinevused võivad tuleneda sellest, et EUROMOD-i mudelis on detailsemad andmed ja seega arvutused tehtud isikupõhiselt, Exceli kulumudel on agregeeritud kujul.

³⁹ Kuluanalüüsis on arvestatud, et ka praegu üksnes puude raskusastmega inimesed võivad süsteemi muutumisel otsustada liikuda töövõime hindamise süsteemi. Siiski ei ole täpselt võimalik hinnata, kui paljud neist seda teeksid või kui paljud saaksid töövõime hindamisel positiivse otsuse (hüvitisele kvalifitseeruks). Samas ei muudaks see analüüsi tulemusi või kuluhinnangute suurusjärke eri stsenaariumite korral. Näiteks STS 1b korral oleks täiendavate kulude suuruste hinnangud nende inimeste liikumisel uude süsteemi või mitte liikumisel uude süsteemi vastavalt +63,6 miljonit vs. +62,3 miljonit või STS 1a korral vastavalt -1,29 miljonit vs. -2,48 miljonit eurot.

eurot, siis sellele järgneval aastal 1,83 miljonit eurot. Täpsemad arvutused on esitatud Exceli kulumudelis.

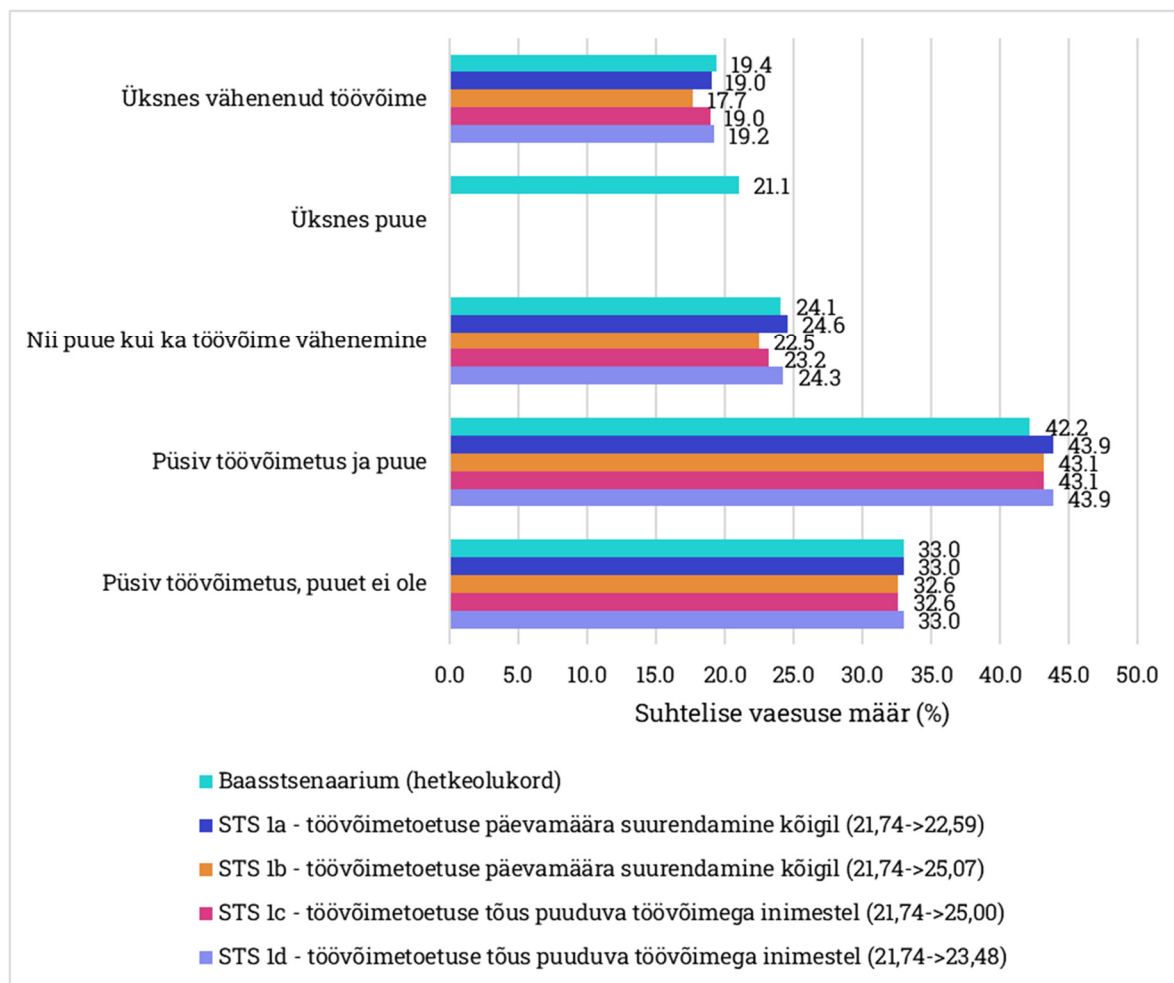
Tabel 32. Toetustega seotud kulude muutus puuetega inimeste sotsiaaltoetuse ja töövõimetoetuse integreerimisel

	Baasstsenaarium (2025)	STS 1a - töövõimetoetuse päevamäär suurendamine kõigil	STS 1b - töövõimetoetuse päevamäär suurendamine kõigil	STS 1c - töövõimetoetuse tõus puuduva töövõimega inimestel	STS 1d - töövõimetoetuse tõus puuduva töövõimega inimestel
Töövõimetoetuse päevamäär, eurot	21,74	22,59	25,07	21,74	21,74
...osaline, eurot	12,39	12,88	14,29	12,39	12,4
...puuduv, eurot	21,74	22,59	25,07	25,00	23,48
Töövõimetus keskmiselt kuus, eurot 30 päeva					
...osaline, eurot	371,8	386,3	428,7	371,8	371,8
...puuduv, eurot	652,2	677,7	752,1	750,0	704,4
Töövõimetoetuse kulud					
...osaline, miljonit eurot	266,0	277,2	307,6	266,7	266,7
...puuduv, miljonit eurot	302,0	314,3	348,8	347,8	326,6
Töövõimetoetuse kulud kokku	568,0	591,4	656,3	614,5	593,4
PISTS kulud kokku, eurot	24,7	0	0	0	0
Kulude muutus (registriandmed), miljonit eurot		-1,29	63,6	21,8	0,6
Kulude muutus (EUROMOD), miljonit eurot		-0,37	55	20	2,2

Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete ja EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal, kasutades 2024. aasta andmeid

Kui puuetega inimeste sotsiaaltoetuse maksmine lõpetada ja suurendada selle arvelt (töövõimetoetust kõigil vähenenud töövõimega inimestel nii, et riigi kulud toetustele oluliselt ei muutuks), siis kasvaks suhtelises vaesuses olevate inimeste osakaal sihtrühmades „nii puue kui ka töövõime vähenemine“ ning „püsiv töövõimetus ja puue“ (vt joonis 31). Üksnes vähenenud töövõimega inimeste seas vaesusmäär langeks. Seda seetõttu, et ressursside ümber jagamisel jaotuks praegune puudetoetus ka neile, kes seda praegu ei saa (üksnes vähenenud töövõimega inimesed) ja seega muutub toetuse summa inimese kohta väiksemaks. Kui töövõimetoetust tõsta kõigil vähenenud töövõimega inimestel sellises ulatuses, et katta ära puuetega inimeste sotsiaaltoetuse summa (päevamäär kasvaks 25 euroni), siis suhtelise vaesuse määr langeb kõigis rühmades välja arvatud „töövõimetus ja puue“, sest nemad jääksid toetusest ilma ja töövõimetoetuse kasv neid ei mõjuta.

Joonis 314. Puudega ja vähenenud töövõimega tööealiste inimeste suhtelise vaesuse määr puuetega inimeste sotsiaaltoetuse integreerimisel töövõimetoetusega võrreldes hetkeolukorraga



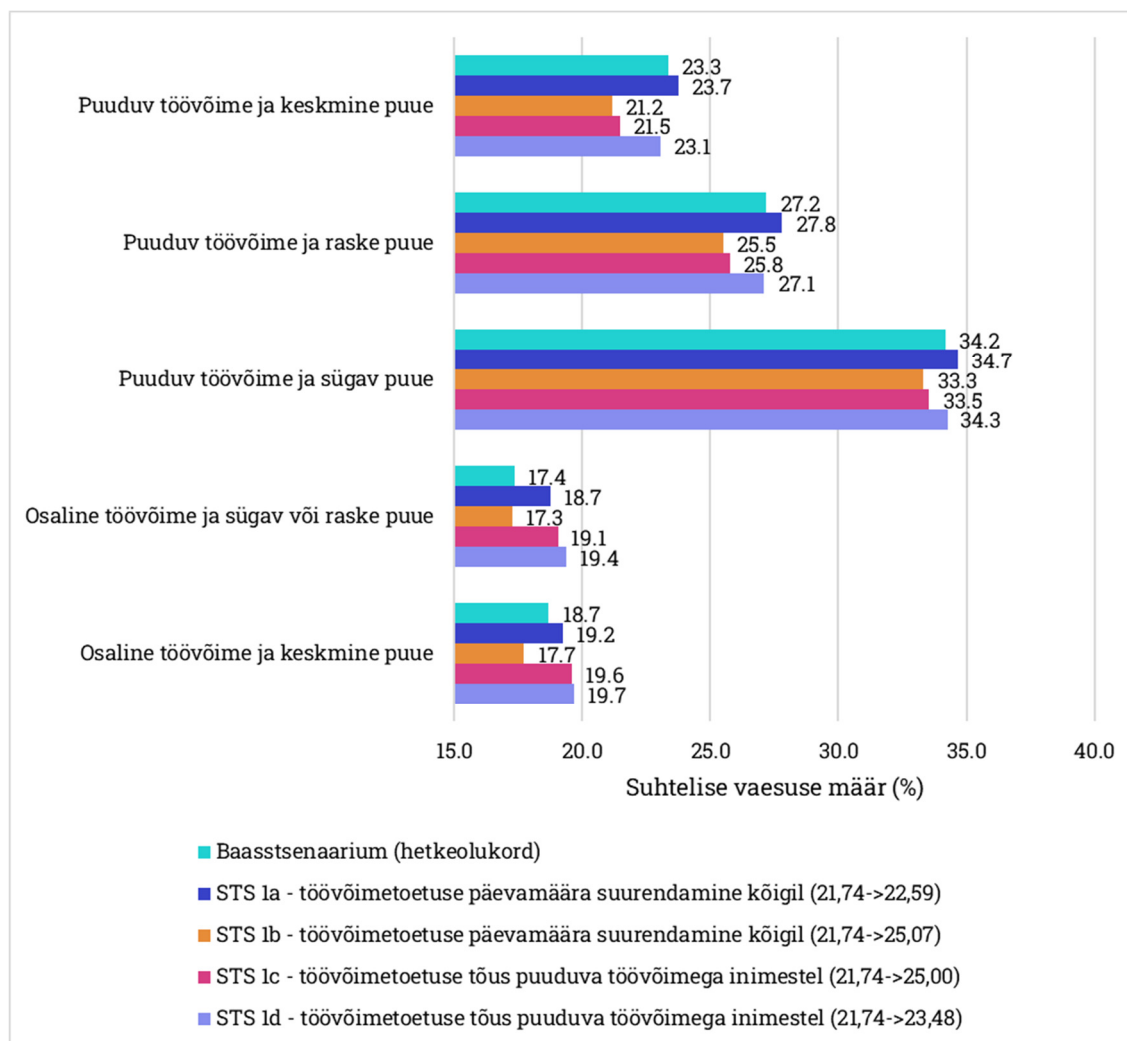
Allikas: autorite arvutused EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal.

Märkused: Vaesuse määra arvutamiseks on leibkonna kogu netosissetulek simuleeritud (sh maksuarvestus) EUROMOD-iga tuginedes 2024. aasta andmetele ja viidud hinnaindekseid arvesse võttes 2025. aasta väärtustesse. Üksnes puudega inimeste sihtrühm on väga väike (ligikaudu 200 inimest) ning stsenaariumite muutmisel oli suhtelises vaesuses väga väike arv inimesi (alla 20), et selle põhjal sisulisi (ja andmete konfidentsiaalsust arvestavaid) järeldusi teha.

Analüüsides sihtrühmasid ja eri stsenaariumite mõju nende suhtelisele vaesusele detailsemalt puude raskusastme ja töövõime ulatuse järgi, siis ilmneb, et mõju ei ole alagruppide lõikes ühtlane. Kui puuetega inimeste sotsiaaltoetuse maksmine lõpetada ja suurendada selle arvelt töövõimetoetust kõigil vähenenud töövõimega inimestel, siis kasvaks suhtelises vaesuses olevate inimeste osakaal nii osalise töövõime kui ka puuduva töövõimega inimeste seas. Kui töövõimetoetust tõsta kõigil vähenenud töövõimega inimestel sellises ulatuses, et katta ära puuetega inimeste sotsiaaltoetuse summa (päevamäär kasvaks 25 euroni), siis suhtelise vaesuse määr kõikides vaadeldavates alalõigetes väheneks, kuid riigi kulud kasvaksid oluliselt (vt tabel 32). Enim võidaksid sellest need, kellel on puuduv töövõime ja keskmine või raske puue (joonis 32), st. nende saadav puuetega inimeste sotsiaaltoetus on

madalam, kui selle arvelt suurendatav töövõimetoetus. Kui puuetega inimeste sotsiaaltoetuse arvelt tõsta töövõimetoetust üksnes neil, kellel on puuduv töövõime, siis kaotaks sissetulekus enim need, kellel osaline töövõime (eriti osalise töövõime, aga raske või sügava puudega inimesed). Nende suhtelise vaesuse määr tõuseks eri lõigetes kuni 2 protsendipunkti.

Joonis 325. Nii puudega kui ka vähenenud töövõimega inimeste suhtelise vaesuse määr puuetega inimeste sotsiaaltoetuse integreerimisel töövõimetoetusega võrreldes hetkeolukorraga



Allikas: autorite arvutused EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal.

Märkused: Vaesuse määra arvutamiseks on leibkonna kogu netosissetulek simuleeritud (sh maksuarvestus) EUROMOD-iga tuginedes 2024. aasta andmetele ja viidud hinnaindekseid arvesse võttes 2025. aasta väärtustesse.

Teise variandina luuakse töövõimetoetuse kõrvale TRT, mida maksab töötukassa ja mille maksmine ja suurus sõltub tegutsemispiirangust. Kuna selle uuringu raames päritud registriandmetes ja EUROMOD-is puudub informatsioon tegutsemispiirangute kohta, siis modelleeritakse piirangu olemasolu lähtuvalt praegusest töövõime ulatusest ja puude raskusastmest (vt ka detailsemalt teekond 1 kirjeldusest ja Lisa 4 – täiendavad statistilised andmed ja selgitused). Teise variandi kuluhinnangud ja mõju vaesusele on leitud järgnevates olukordades:

- puuetega inimeste sotsiaaltoetuse eelarve jagatakse ümber selliselt, et osalise töövõimega inimesed, kellel on raske või täielik piirang (mudelis modelleerimisel raske või sügav puue), saavad TRT 35 eurot ning puuduva töövõimega inimesed, kellel on raske või täielik piirang (mudelis modelleerimisel keskmine, raske või sügav puue), saavad 55 eurot (STS 2a);
- puuetega inimeste sotsiaaltoetuse eelarve jagatakse ümber selliselt, et osalise töövõimega inimesed, kellel on raske või täielik piirang (mudelis modelleerimisel raske või sügav puue), saavad TRT 25 eurot ning kõik puuduva töövõimega inimesed (olenemata piirangust) saavad 50 eurot (STS 2b);
- TRT suurus oleks kõrgem kui tänased PISTS toetused ehk TRT suurus vaesuse leevendamiseks oleks nii, et osalise töövõimega inimesed, kellel on raske või täielik piirang (mudelis modelleerimisel raske või sügav puue), saavad 70 eurot ning puuduva töövõimega inimesed, kellel on raske või täielik piirang (mudelis modelleerimisel keskmine, raske või sügav puue), saavad 130 eurot (STS 2c);
- TRT suurus oleks kõrgem kui tänased PISTS toetused ehk toetuse suurus vaesuse leevendamiseks oleks nii, et osalise töövõimega inimesed, kellel on raske või täielik piirang (mudelis modelleerimisel raske või sügav puue), saavad 70 eurot ning puuduva töövõimega inimesed (olenemata piirangust) saavad 130 eurot (STS 2d).

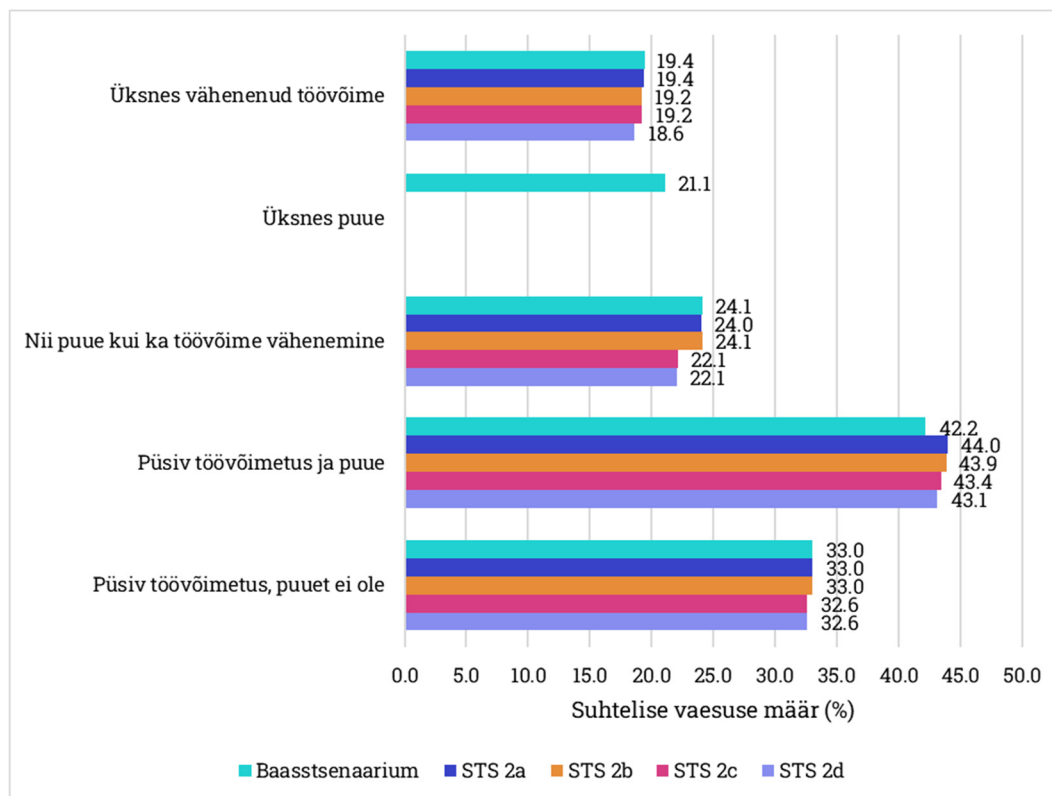
Eelnevalt kirjeldatud stsenaariumite kuluhinnangud ja toetuste suurused on esitatud tabelis 33 ning suhtelise vaesuse määrad sihtrühmade lõikes joonisel 33. Kui toetused jagada ümber selliselt, et riigi kulud oluliselt ei kasvaks (STS 2a ja STS 2b), siis on ka mõju sihtrühmade suhtelisele vaesusele üldiselt madal või puudub (muutus kuni -0,2 protsendipunkti). Kui toetusi tõsta selliselt, et puuetega inimeste vaesus väheneks, siis kasvaksid riigi kulud oluliselt (olenevalt stsenaariumist kuni 41 miljonit eurot aastas). Kokkuvõttes langeks stsenaariumite 2c ja 2d korral suhtelise vaesuse määr nende seas, kellel on nii puue kui ka töövõime vähenemine 24,1% pealt 22,1% peale. Kuna TRT jääksid ilma need, kellel vähenenud töövõimet ei ole (püsiva töövõimetusega inimesed), siis nende seas vaesusmäär kasvaks.

Tabel 33. Toetustega seotud muutus loomisel töövõimetoetuse süsteemi

	Baasstsenaarium (2025)	STS 2a	STS 2b	STS 2c	STS 2d
Toetuse suurus					
...keskmine puue	29-42	NA	NA	NA	NA
...raske puue	50	NA	NA	NA	NA
...sügav puue	100	NA	NA	NA	NA
...raske/täieliku piiranguga osalise töövõimega inimese toetus kuus, eurot	NA	35	25	70	70
...raske/täieliku piiranguga puuduva töövõimega inimese toetus kuus, eurot	NA	55	50	130	130
Kulud aastas kokku registriandmetes, miljonit eurot	24,7	24,4	25,0	56,8	65,3
Kulude muutus (registriandmed), miljonit eurot		-0,27	0,26	32,11	40,56
Kulude muutus (EUROMOD), miljonit eurot		0,83	3,08	28,11	38,93

Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete ja EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal, kasutades 2024. aasta andmeid

Joonis 33. Puudega ja vähenenud töövõimega tööealiste suhtelise vaesuse määr puuetega inimeste sotsiaaltoetuse asendamisel TRT-ga töövõimetoetuse kõrvale võrreldes hetkeolukorraga

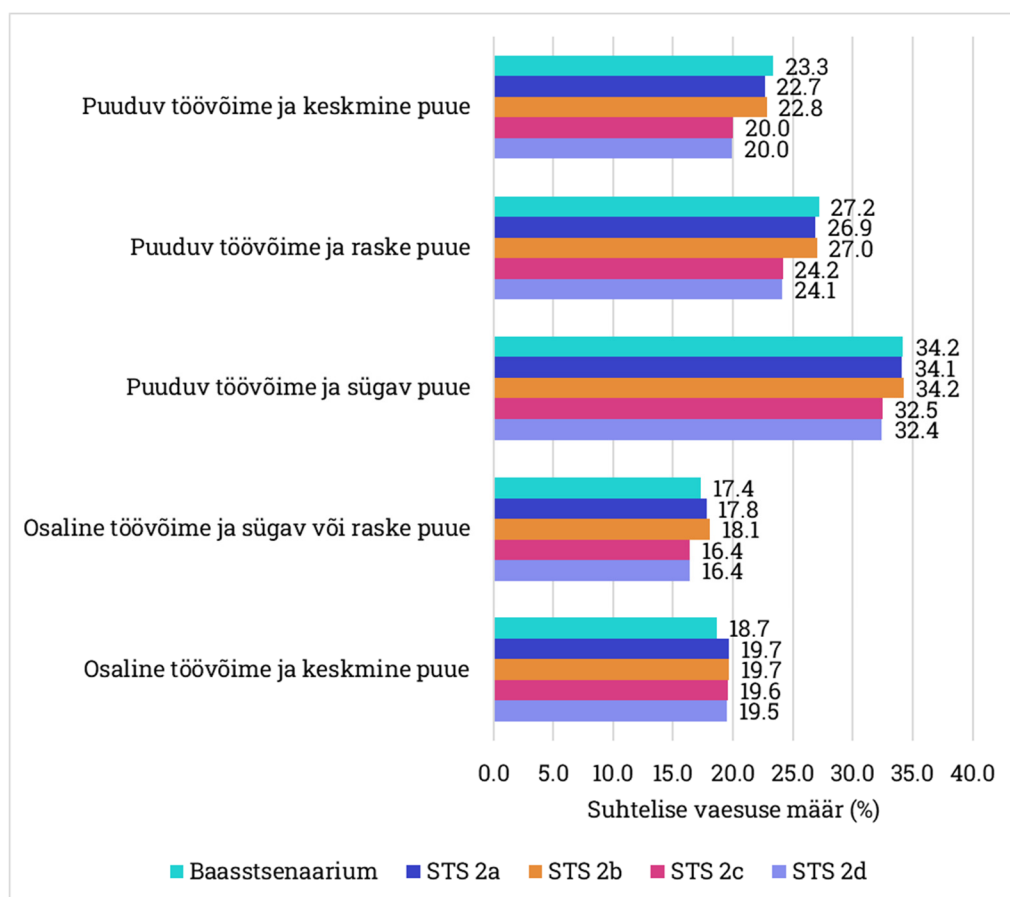


Allikas: autorite arvutused EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal.

Märkused: Vaesuse määra arvutamiseks on leibkonna kogu netosissetulek simuleeritud (sh maksuarvestus) EUROMOD-iga tuginedes 2024. aasta andmetele ja viidud hinnaindekseid arvesse võttes 2025. aasta väärtustesse.

Suhtelise vaesuse määr detailsemalt puude raskusastme ja töövõime ulatuse lõikes nende seas, kellel on nii puue kui ka vähenenud töövõime, on välja toodud joonisel 34. Sarnaselt esimese variandiga ilmneb ka siin suurem varieeruvus mõju osas, kui analüüsida sihtrühma lõikeid detailsemalt. Suhtelise vaesuse määr langeb puuduva töövõime korral olenemata puude raskusastmest. Kuna toetus keskmise puudega inimeste jaoks olenevalt stsenaariumist kas väheneb või ka kaob täielikult, kui inimesel on osaline töövõime ja keskmine puue, siis suhtelise vaesuse määr osalise töövõimega inimeste seas tõuseb.

Joonis 34. Puudega ja vähenenud töövõimega tööealiste suhtelise vaesuse määr puuetega inimeste sotsiaaltoetuse asendamisel eraldi toetusega töövõimetoetuse kõrvale võrreldes hetkeolukorraga



Allikas: autorite arvutused EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal.

Märkused: Vaesuse määra arvutamiseks on leibkonna kogu netosissetulek simuleeritud (sh maksuarvestus) EUROMOD-iga tuginedes 2024. aasta andmetele ja viidud hinnaindekseid arvesse võttes 2025. aasta väärtustesse.

Teekond 1 variantide 1 ja 2 lahendustega kaasnevad muutused tööjõukuludes on välja toodud tabelis 34. Isegi kui poliitikamuudatus jõustub järk-järgult ehk töötukassasse liiguvad järk-järgult need, kelle puude raskusastme otsused lõppevad, siis uusi taotlusi ja hindamisi enam koheselt SKA-s ei toimuks. Seega võib eeldada tööjõukulude kokkuvõidu eksperthinnangute ja taotluste menetluste arvelt. SKA andmete põhjal olid kulud tööealiste inimeste puudega

seotud eksperthinnangutele 2024. aastal 96 tuhat eurot ning kulud puudega seotud toetuste menetlemisele 224 tuhat eurot. Eeldades sarnast suurusjärku taotluste esitamisel ka edaspidi, oleks kulude kokkuhoid aastas ligikaudu 320 tuhat eurot.

Eelduste kohaselt töötukassa metoodika ei muutu ning toetusi makstakse kas töövõime ulatuse või piirangute alusel, mille kohta töötukassal on informatsioon juba olemas. Seega eeldame, et toetuste maksmine toimub automaatselt ega too kaasa töökoormuse kasvu, vaid ühekordse IT arenduse kulu (vt all). Praktikas võib toetuse suurenemine või selle maksmine kindla kriteeriumi alusel tuua kaasa vaiete suurenemise ning seeläbi ka halduskulude kasvu, kuid olemasolevate andmete põhjal ei ole võimalik seda hinnata. EUROMOD analüüsi põhjal oli ligikaudu 200 inimest, kellel oli tuvastatud üksnes puude raskusaste ja ei olnud töövõime vähenemist. Kui puude tuvastamine ja vastav toetuse maksmine lõpetatakse, siis võib osa neist inimestest siiski liikuda töötukassasse. Samas ei saa täpselt öelda, millised oleksid nende inimeste hindamise otsused. Kui aga eeldada, et kõigile neile 200 inimesele oleks samuti vaja määrata töövõimetoetus, siis tooks see kaasa ligikaudu 5000 euro suuruse halduskulu aastas⁴⁰.

Tabel 34. Tööjõukulud ja nende muutus baasstsenaariumi ja teekond 1 korral

Kulu liik	Baasstsenaarium			Teekond 1		
	Taotluste/ hinnangute arv	Keskmin e ühiku hind	Kulud kokku	Taotluste/ hinnangut e arv	Keskmin e ühiku hind	Kulud kokku
Sotsiaalkindlustusamet						
...puudega seotud eksperthinnangud:	3595	26,8	96202,2	0	26,8	0
...puudega seotud taotluste menetlus:	31456	7,1	223966,7	0	7,1	0
...Sotsiaalkindlustusameti kulud kokku:			320168,9			0
Eesti Töötukassa						
...töövõimetoetuse määramised:	34465	23,0	793729,0	34668	23,03	798404,0
...Töötukassa kulud kokku:			793729,0			798404,0
Tööjõukulud kokku:			1113897,9			798404,0
Muutus tööjõukuludes:						-315493,8

Allikas: autorite arvutused.

Kui SKA enam puudega seotud toetusi ei maksaks, võib SKA-l olemasolevate infosüsteemide töös hoidmise arvelt tekkida kulude kokkuhoid. Et andmevahetus on siiski endiselt vajalik

⁴⁰ Töötukassa kulude hindamisel on tuginetud „Andmepõhise personaliseerituse potentsiaal ja mõju sotsiaal- ja haridusvaldkonna avalikes teenustes ja toetustes (Arrak *et al.*, 2024)“ uuringus kasutatud ja töötukassalt päritud keskmisele tegevuskulule (23,0 eurot ühiku ehk taotluse hind), mis sisaldab palgakulu, infosüsteemide arenduskulu ning üldtegevuskulu.

SKA teenuste pakkumiseks, ei teki sealt olulist kokkuhoidu. Lisaks oleks töötukassal vaja täiendavaid ühekordseid arenduskulusid, et poliitikamuudatus ellu viia.

- Variant 1: töövõimetoetuse päevamäära suurendamine toob kaasa ühekordsed väiksed arenduskulud (hinnanguliselt ligikaudu 15 tuhat eurot), kui seda teha ajal, mil muidu päevamäära ei oleks muudetud; kui päevamäära muutus viia sisse indekseerimise ajaga, siis ilmselt ei kasvaks kulud sellises mahus.
- Variant 2: TRT loomine ja selle maksmise automatiseerimine piirangute alusel toob kaasa ühekordsed suured arenduskulud (hinnanguliselt ligikaudu kuni 250 tuhat eurot).

11.3.1. Vanaduspensioniealised inimesed

Selle teekonna kohaselt lõpetatakse puude raskusastme tuvastamine riigi poolt. Puuetega inimeste sissetulekud on madalad ning paljud vanaduspensioniealised inimesed on suhtelises vaesuses (vt ptk 7). Ka puuetega inimeste organisatsioonide vanemaealiste esindajad tõid töötubades peamise probleemina välja toetuste ebapiisavuse ja toimetulekuraskused. Praegused toetused ei kata inimeste abivajadust ning väikese toetuse taotlemine on inimese jaoks alandav kogemus. Seda arvestades on vanemaealiste puuetega inimeste esindajatel ootus, et vanaduspensioniealiste puuetega inimeste toetused tõuseksid ja oleksid võrdsed tööealistega, minimaalsel juhul olemasolevad toetused säiliks.

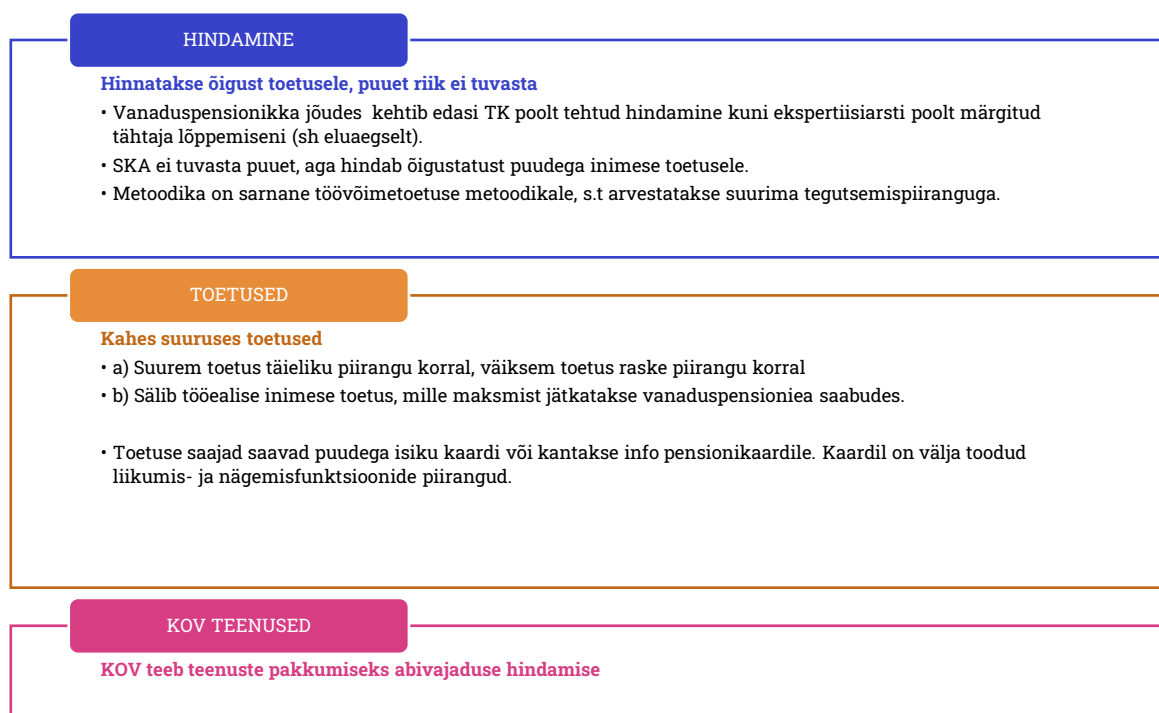
Ametnike ja ekspertide töötoas toodi esile vajadus kindlate kriteeriumide järele, mille alusel pakutakse tervisekahjustusega ja puuetega inimestele soodustusi ja hüvesid. Toodi esile, et hüvede saajate ringi laiendamine eeldab märkimisväärset kulude kasvu. Seetõttu on vaja ka juhul, kui riik lõpetab puude tuvastamise, teatud ühtseid kriteeriume (sh võimalusel ka andmevahetus õigustatuse tuvastamiseks). Iga teenust või hüve pakkuval asutusel ei ole võimekust ega ressursi ise tuvastada õigustatust.

Arvestades nii puudega vanemaealiste majanduslikke toimetulekuprobleeme kui ka ekspertide väljatoodud vajadust võtta hüvede osutamise aluseks kindlad kriteeriumid, on ka edaspidi vaja toetust piirangute kompenseerimiseks. Erinevalt tänasest saab lahendusena aluseks võtta piirangute raskusastmed. Kokkuvõttes pakume välja stsenaariumid, mis on jätkuks teekond 1 all tööealiste inimeste pakutud variant 2 stsenaariumitele.

Edaspidi ei tuvasta SKA puude raskusastet, vaid määrab kahes suuruses toetused vastavalt piirangute raskusastmetele. Kui töötukassa ekspertarst on prognoosinud piirangute eeldatava kestuse, siis vanaduspensioniea saabudes võtab SKA piirangud ja prognoositud kestuse arvesse ning määrab toetuse ilma uut ekspertiisi tegemata. SKA teeb järgmise ekspertiisi pärast otsuse kestuse lõppemist. Töövõimet välistavate seisundite ning püsivate seisundite korral võib SKA tuvastada piirangud eluaegselt, et vähendada korduvhindamisi. Seega,

vanaduspensioniea saabudes võtab toetuse maksmise üle SKA TK hindamise tulemuse alusel ilma ekspertiisi tegemata. Erinevalt tänasest ei arvutata piirangute aritmeetilist keskmist, vaid tuginedes töötukassa töövõime metoodikale lähtutakse sellest, milline on võtmetegevuste punktide väärtus ning kas selle skoori järgi on tegemist täieliku või raske piiranguga. Kui enne vanaduspensioniiiga ei ole töövõimet hinnatud, siis vanaduspensionieas sisenejate toetusele õigustatust hindab SKA, võttes samuti aluseks võtmetegevused ja arvutab nende skoori.

Joonis 35. Teekond 1 vanaduspensioniealised inimesed.



Selle teekonna korral muutub inimesele lihtsamaks ja loogilisemaks üleminek tööeas vanaduspensioniiikka. Hindamismetoodikad tööealistele ja vanaduspensioniealistele inimestele ühtlustuvad. Kui tööealiste töövõime hindamise metoodikas määratletakse ära püsivad seisundid, siis sama on vaja teha ka vanemaealiste korral – püsivate seisundite määratlemine aitab vähendada korduvhindamiste arvu. Samas ei lahenda stsenaarium seda, et abivajadus ja teenuste saamine ei ole piisavalt seotud, teenuseid on ebapiisavalt ning nendeni jõudmine on keerukas. Need kitsaskohad eeldavad täiendavaid lahendusi.

Tabel 35. Kaasuvate hüvede saamine

HÜVE	LAHENDUS
Puudega vanaduspensioniealise inimese toetus	Selle asemel maksab SKA tegevuspiirangutega inimese toetust. Toetus on kahes suuruses olenevalt piirangute raskusastmest (täielik või raske). Toetuse määramisel võetakse aluseks töövõime hindamise metoodika lähenemine, kus piirangu aste sõltub võtmetegevuste skoorist.
Puudega isiku kaart/European Disability Card	Kaardi saavad SKA makstava toetuse saajad või kantakse info pensionikaardile. Kaardil on välja toodud liikumis- ja nägemisfunktsioonide piirangud koos piirangu raskusastmega.
Puhkus sügava puudega isiku hooldamiseks	Puhkust antakse isiku hooldamiseks, kes saab SKA-lt suuremas määras toetust.
Puudega inimeste õigusabi	SKA toetuse saajad.
Puudega inimese parkimiskaart	SKA toetuse saajad, kellel on liikumis- või nägemisfunktsiooni piirangud (täielik või raske piirang).
Riigisisised sõidusoodustused	SKA toetuse saajad, kes on täieliku ja raske liikumisfunktsiooni või nägemisfunktsiooni piiranguga ja tema saatja ning juhtkoer.
Tasuta riigimuuseumi külastus	Suuremas määras toetuse saajad.
Vähendatud riigilõiv isikut tõendavate dokumentide taotlemisel	Vanaduspensioniealistel inimestel on sarnane soodustus olemas.

Riigi kulud ja mõju vaesusele

Vanaduspensioniealistele kohanduvate stsenaariumite kuluhinnangud ja mõju vaesusele on leitud järgnevates olukordades:

- Puuetega vanaduspensioniealiste inimeste sotsiaaltoetuse eelarve jagatakse ümber selliselt, et täieliku piiranguga (modelleerimisel sügava puudega)⁴¹ vanaduspensioniealised inimesed saavad TRT 41 eurot ning raske piiranguga (mudelil modelleerimisel keskmise või raske puudega) inimesed 20 eurot (STS 2a);
- puuetega inimeste sotsiaaltoetuse eelarve jagatakse ümber selliselt, et inimesed, kellel on täielik piirang (mudelil modelleerimisel raske või sügav puue) saavad TRT 41 eurot ning raske piirang (mudelil modelleerimisel keskmise puudega) inimesed saavad 20 eurot (STS 2b);
- uue, TRT loomine kõrgemas toetuse suuruses kui tänased PISTS toetused ehk toetuse suurus oleks vaesuse leevendamiseks nii, et täieliku piiranguga (modelleerimisel

⁴¹ Andmete piirangute tõttu on arvutustes on kasutatud järgmisi eeldusi: a) täielik piirang vastab sügavale puudele ning raske piirang vastab keskmisele või raskele puudele; b) täielik piirang vastab sügavale või raskele puudele; raske piirang keskmisele puudele. Tegelikult võivad piirangud jaguneda ka nii, et nt osadel raske puudega inimestel on täielik piirang, osadel raske piirang ja osadel mõõdukas piirang.

sügava puudega) inimesed saavad 130 eurot ning raske piiranguga (modelleerimisel keskmise või raske puudega) inimesed saavad 70 eurot (STS 2c);

- uue, tegevuspiirangutega inimese toetuse loomine kõrgemas toetuse suurusel kui tänased PISTS toetused ehk toetuse suurus oleks vaesuse leevendamiseks nii, et inimesed, kellel on täielik piirang (mudelil raske või sügav puue) saavad 130 eurot ning raske piiranguga (mudelil modelleerimisel keskmise puudega inimesed) saavad 70 eurot (STS 2d).

Kuluhinnangud ja TRT suurused eri stsenaariumite korral on esitatud tabelis 36.

Kõige madalamate kuludega on STS 2a, kus täieliku piiranguga (sügava puudega) vanaduspensioniealised inimesed saavad TRT 41 eurot ning raske piiranguga (keskmise või raske puudega) inimesed 20 eurot. Kuna sellisel juhul raske puudega inimestele makstav toetus langeb 27 euro pealt 20 euro peale, siis toob see kaasa ka suhtelise vaesuse suurenemise puudega vanaduspensioniealiste seas (25,6% vs. 26,1%) (raske puudega inimesi on ka kõige enam puudega vanaduspensioniealiste seas). Peamiselt tõuseks suhteline vaesus just praeguste raske puudega vanaduspensioniealiste seas (24,8% vs. 26,6%) (vt joonis 36). Keskmise puudega vanaduspensioniealiste suhtelise vaesuse määr langeb (24,2% vs. 22,6%), sest nende toetus tõuseb.

STS 2b korral on kulud mõnevõrra kõrgemad (ligikaudu 8,7 miljonit), kuid suhteline vaesus langeks nii praeguste keskmise (24,2% vs 22,6%) kui ka raske puudega (24,8% vs. 22,1%) inimeste seas ja seega ka puude raskusastmega vanaduspensioniealiste seas tervikuna (25,6% vs. 23,5%). Praeguste sügava puudega inimeste jaoks toetuse suurus ega ka vaesus ei muutuks.

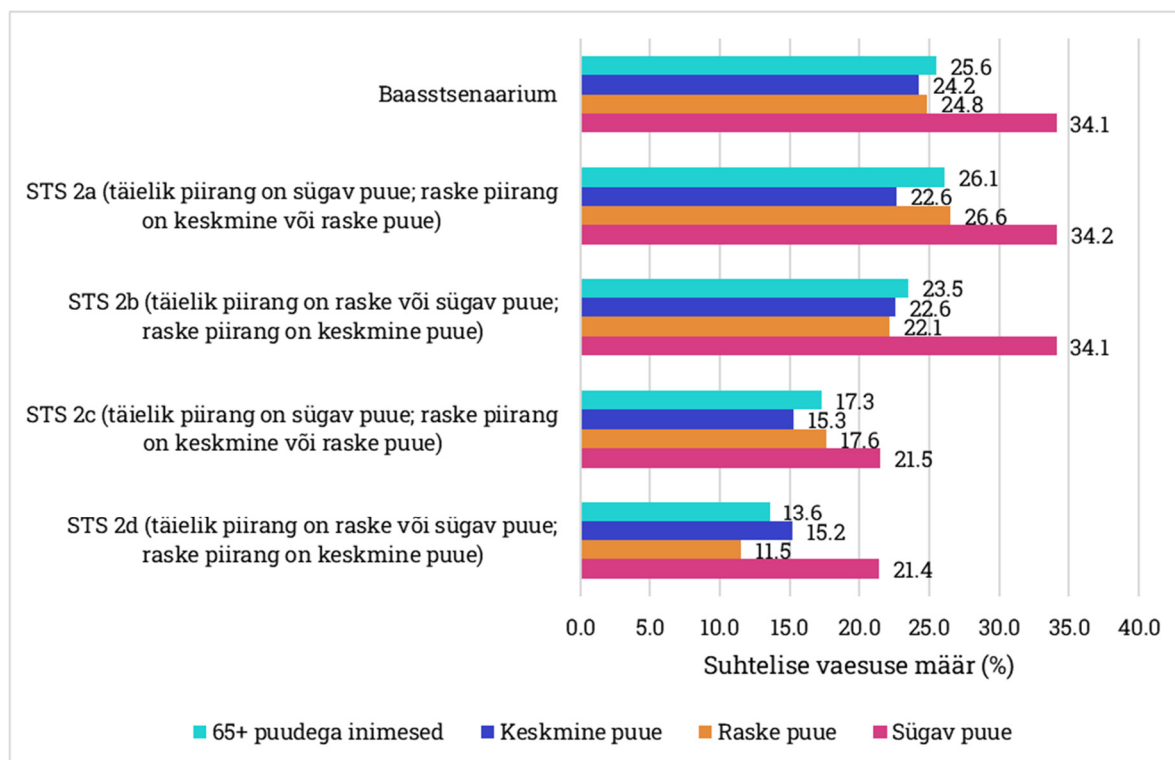
Stsenaariumite 2c ja 2d korral on riigi kulud märgatavalt kõrgemad (vastavalt 43,3 miljonit ja 73,3 miljonit eurot). Samas langeks nende stsenaariumite korral ka suhtelise vaesuse määr märgatavalt: praeguste keskmise ja raske puudega inimeste suhtelise vaesuse määr oleks isegi madalam kogu elanikkonna suhtelise vaesuse määrast. Sügava puudega inimeste suhtelise vaesuse määr langeks samuti märgatavalt (34,1% vs. 21,4%).

Tabel 36. Toetustega seotud kulude muutus TRT loomisel

	Baas- stsenaarium	STS 2a (täielik piirang on sügav puue; raske piirang on keskmine või raske puue)	STS 2b (täielik piirang on raske või sügav puue; raske piirang on keskmine puue)	STS 2c (täielik piirang on sügav puue; raske piirang on keskmine või raske puue)	STS 2d (täielik piirang on raske või sügav puue; raske piirang on keskmine puue)
Toetuse suurus					
...keskmine puue	13	NA	NA	NA	NA
...raske puue	27	NA	NA	NA	NA
...sügav puue	41	NA	NA	NA	NA
...raske piiranguga inimese toetus kuus, eurot	NA	20	20	70	70
... täieliku piiranguga inimese toetus kuus, eurot	NA	41	41	130	130
Kulud aastas kokku registriandmetes, miljonit eurot	20,42	18,57	29,08	63,73	93,77
Kulude muutus (registriandmed), miljonit eurot		-1,85	8,66	43,31	73,35
Kulude muutus (EUROMOD), miljonit eurot		-1,59	7,95	39,09	66,34

Allikas: autorite arvutused Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti registrite andmete ja EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal, kasutades 2024. aasta andmeid

Joonis 36. Puudega vanaduspensioniealiste suhtelise vaesuse määr puuetega inimeste sotsiaaltoetuse asendamisel TRT-ga



Allikas: autorite arvutused EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal.

Märkused: Vaesuse määra arvutamiseks on leibkonna kogu netosissetulek simuleeritud (sh maksuarvestus) EUROMOD-iga tuginedes 2024. aasta andmetele ja viidud hinnaindekseid arvesse võttes 2025. aasta väärtustesse.

Teekond 1 lahenduse korral ei tuvasta SKA enam vanaduspensioniealistel puude raskusastet, aga maksab siiski TRT lähtuvalt piirangust. TRT maksmiseks on siiski vajalik hinnata piirangu olemasolu. Kui eeldada, et piiranguga seotud inimeste arv on sama suur kui 2024. aastal puude raskusastmega inimeste arv, siis toetuse saajate ja taotluste arv ei muutu. Sellisel juhul jääksid ka SKA tööjõukulud puude raskusastmega seotud hindamiste ja taotluste menetlemisele sarnaseks. SKA 2024. aasta andmete kohaselt olid kulud vanaduspensioniealiste puude raskusastmega seotud eksperthinnangutele ja taotluste menetlemisele kokku 375 tuhat eurot. Kui taotluste üle vaatamiste ja hindamiste vahelist perioodi pikendatakse (hindamisi toimuks harvem ja seega arvuliselt aastas vähem), siis tooks see kaasa kulude kokkuhoiu. Kuna vanaduspensioniealistest vaid 7%-l (4622 inimest) oli 2024. aastal puude raskusaste tuvastatud vähemaks kui viieks aastaks, 72%-l viieks aastaks ning 21%-l tähtajatult, siis viies hindamisi läbi minimaalselt iga 5 aasta tagant, mõjutaks see pigem väikest osa praegustest puude raskusastmega vanaduspensioniealistest inimestest (93%-l juba on puude raskusastme kestus 5 või enam aastat). Neil vanaduspensioniealistel, kellel puue on määratud vähem kui viieks aastaks, on tegemist 50% juhtudest esmase puude tuvastamisega. Siiski, kui eeldada, et kõigil neil inimestel jääks ära vähemalt üks vahepealne (eelduste kohaselt positiivse otsusega) hindamine, siis võib see tuua kaasa tööjõukulude kokkuhoiu ligikaudu 104 tuhat eurot viie aasta jooksul.⁴² Kui analüüsida tööeast vanaduspensioniiikka üleminekut, siis puude raskusastme kehtivuse otsuste järgi on tööealistest 18%-l otsus kehtiv kuni vanaduspensionieani. Vanaduspensioniealistel aga määratakse puude raskusaste ka tähtajatult (kokku 21%-l puudega vanaduspensioniealistest oli 2024. aastal tähtajatu puude otsus). Seega suuremal enamusel on vaja täna korduvhindamine läbi viia vähemalt kord viie aasta jooksul.

Tabel 37. Tööjõukulud ja nende muutus baasstsenaariumi ja teekond 1 korral

Kulu liik	Baasstsenaarium			Teekond 1		
	Taotluste/ hinnangute arv	Keskmine ühiku hind	Kulud kokku	Taotluste/ hinnangute arv	Keskmine ühiku hind	Kulud kokku
Sotsiaalkindlustusamet						
...puudega seotud eksperthinnangud:	16673	15,3	255432,0	16673	15,3	255432,0
...puudega seotud taotluste menetlus:	16843	7,1	119922,2	16843	7,1	119922,2
...Sotsiaalkindlustusameti kulud kokku:			375354,2			375354,2
Muutus tööjõukuludes:						0,0

Allikas: autorite arvutused.

⁴² Vanaduspensioniealiste puudega seotud ühe eksperthinnangu kulu Sotsiaalkindlustusametil oli 2024. aastal 15,3 eurot ja ühe taotluse menetluse kulu 7,1 eurot ((15,3+7,1)*4622=104 tuhat).

Märkused: andmed piirangute kohta puuduvad ja seetõttu on eeldustes lähtutud puude raskusastmest. Tegelik taotlejate arv võib seetõttu olla erinev ja sellest lähtuvalt ka kulud suuremad või väiksemad.

Poliitikamuudatuse ellu viimisega kaasnevad ka IT arenduskulud, et edaspidi TRT määrata. Eeldatavasti toob TRT loomine kaasa ühekordsed suured arenduskulud (ligikaudu 250 tuhat eurot).

11.4. Teekond 2 – Tervishoiukeskne

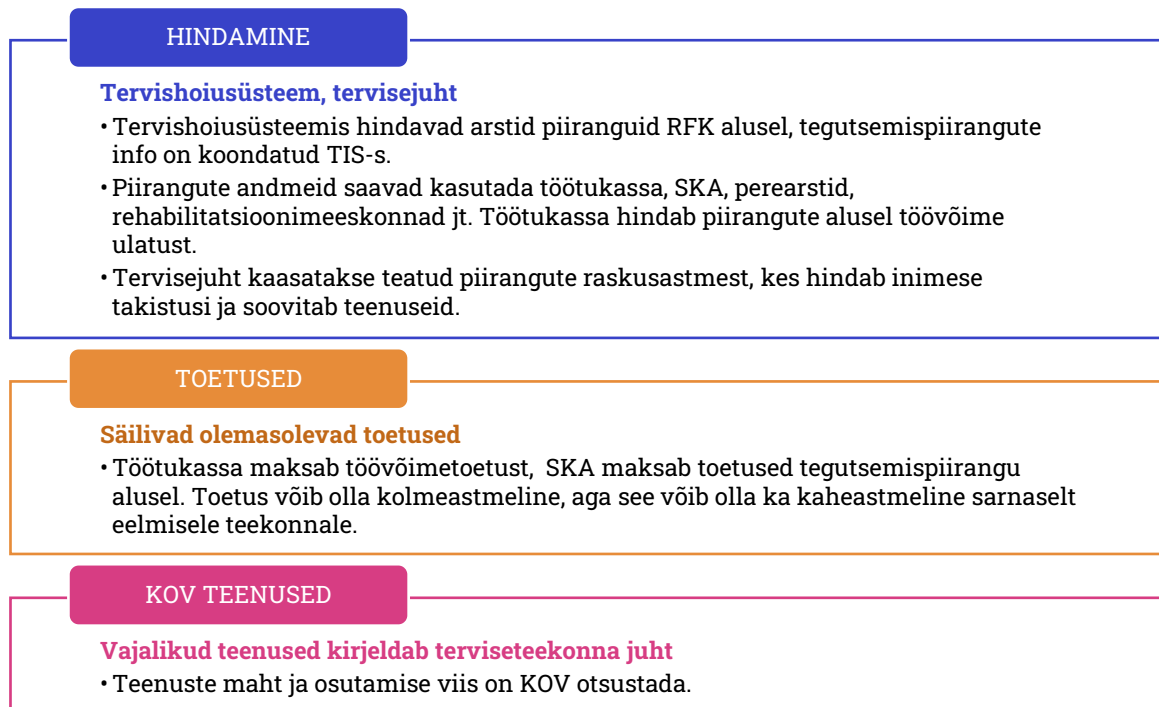
Teekonna kirjeldus

Puuetega inimeste töötubades arutati tulevikku suunatud stsenaariumi, kus piirangute ja toetusvajaduse hindamine toimuvad integreeritult tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemis (TERVIKute reform). Kuigi teostatavus ei ole kohe praegu võimalik, nägid töötubades osalejad selles suurt potentsiaali. Riik on võtnud suuna sotsiaal- ja tervishoiuteenuste integreerimisele ning antud teekond toetab seda suunda, sidudes hindamise ja teenusteni jõudmise.

Selle teekonna puhul toimub piirangute hindamine tervishoiusüsteemis. Diagnoosimisega koos hindab raviarst või terapeut inimese funktsiooni- ja tegutsemispiirangud RFK alusel. Piirangute andmed kajastuvad TIS-s ning neid andmeid saavad kasutada teised tervishoiuteenuse osutajad, töötukassa, SKA ja KOV. Selle mudeli keskmes on terviseteekonnajuht või koordinaator, kes mõistab nii tervise- kui ka sotsiaalvaldkonda ning aitab inimesel leida personaalsed, talle sobivad teenused. Lahendus aitaks vältida topelthindamisi ja toetaks individuaalset lähenemist. Toetuste määramist ja maksmist selle teekonnaga ei käsitleta, need võivad jääda muutumatuks. Sarnaselt tänasele teeb töövõime ulatuse otsuse ning maksab töövõimetoetust töötukassa, puudega inimese toetused määrab ja maksab SKA nii tööealistele kui ka vanaduspensioniealistele inimestele. Võib kaaluda tööealistele ja vanaduspensioniealistele isikutele sarnase metoodika kasutatamist toetuste määramisel. SKA väljastab toetuse saajatele puudega isiku kaardi.

Vabanevad TK ja SKA ekspertiiside tegemiseks kuluvad eelarvevahendid, mille saab suunata tervishoiusüsteemi. Samas eeldab lahendus IT arenduse kulusid TIS-s.

Joonis 67. Teekond 2.



Hindamine

Selle teekonna eelduseks on, et tervishoiusüsteemis võetakse laialdasemalt kasutusele piirangute hindamine RFK alusel. Näiteks võib piirangu ulatuse tuvastada eriarst koos diagnoosi panemisega või tuvastatakse piirangud rehabilitatsiooniteenuse osutamisel. Vajadusel teeb piirangute hindamise perearst või tervisekeskuse ekspert. RFK põhjal hinnatud piirangute andmed koos kestusega on koondatud TIS-is. Neid andmeid saavad kasutada perearstid abivahendite vajaduse hindamisel, rehabilitatsioonimeeskonnad rehabilitatsioonivajaduse hindamisel, TK töövõime ulatuse hindamisel, SKA puude raskusastme tuvastamisel. Sellega ei ole hindamistulemuste kasutamine siiski piiratud ning tulemusi saaksid kasutada teenuste planeerimiseks ja inimestele abi osutamiseks näiteks ka haridussüsteem ning kohalikud omavalitsused.

Teatud piirangute raskusastmest alates kaasatakse terviseteeakonna juht, kes hindab (koos inimesega) tema takistusi ja abivajadust ning paneb kokku eri valdkondade teenuste paketi. Omavalitsustel on kohustus sotsiaalteenuseid pakkuda, aga nende maht ja osutamise viis on iga KOV-i otsustada. Kaasuvate hüvede saamine on esitatud tabelis 38.

Tabel 38. kaasuvate hüvede saamine

LAHENDUS	
Puudega tööealise inimese toetus	SKA maksab tegutsemispiirangu alusel
Puudega vanaduspensioniealise inimese toetus	SKA maksab tegutsemispiirangu alusel
Puudega vanema toetus	SKA maksab tegutsemispiirangu alusel
Õppetoetus	Poliitikakujundaja otsus, kas jätkata toetusega sellisel kujul või anda vahendid üle HTM-le.
Täienduskoolitustoetus	Poliitikakujundaja otsus, kas jätkata toetusega sellisel kujul või anda vahendid üle TK-le koolitustoetuseks.
Puudega isiku kaart	Kaardi väljastab SKA toetuse saajatele. Kaardil on välja toodud liikumis- ja nägemisfunktsioonide piirangud koos raskusastmetega.
Erivajadusega üliõpilase stipendium	Õigus stipendiumile tuvastatakse tegutsemispiirangu alusel. Sügav puue = täielik piirang; raske puue = raske piirang; Keskmine puue = mõõdukas piirang.
Välisõpingute stipendium	Puudega isiku kaardi saajad (SKA toetuse saajad)
Õppekulude hüvitamine	Puudega isiku kaardi saajad (SKA toetuse saajad)
Puhkus sügava puudega isiku hooldamiseks	SKA suurimas määras toetuse saajad
Tööandja poolt antud abivahendeid ei maksustata erisoodustusmaksuga	Erisoodustus ei kehti osalise või puuduva töövõimega töötaja tööalaste abivahendite kuludele
Puudega inimeste õigusabi	Puudega isiku kaardi saajad, töövõimetuspensionärid.
Puudega inimese parkimiskaart	Isikud, kellel on liikumis- või nägemisfunktsiooni piirangud (täielik või raske piirang).
Riigisisised sõidusoodustused	Puudega isiku kaardi alusel, täieliku ja raske liikumisfunktsiooni ja nägemisfunktsiooni piiranguga isik ja saatja ning juhtkoer
Tasuta riigimuuseumi külastus	SKA suurimas määras toetuse saajad
Vähendatud riigilõiv isikut tõendavate dokumentide taotlemisel	SKA toetuse saajad, töövõimetuspensionärid

Mõjud

Selle teekonnaga muutub olulisel määral tervishoiuvaldkonna roll piirangute hindamisel. See teekond pakub lahendusi ootustele, mille sõnastasid puuetega inimesed töötubades: piirangute hindamine toimub raviva arsti või terapeudi poolt, piirangute andmed on TIS-is ajakohased ning piirangud seostatakse teenuste vajadusega. Lahenduste mõjusid ei ole hinnanud tervisevaldkonna eksperdid, mõjud on hinnatud sihtgrupi vaatest.

Piirangute hindamine tervishoiusüsteemis on töötubades osalejate hinnangul taotlejale loogilisem ja usaldusväärsem. Lahendusel võib olla positiivne mõju funktsioonipiirangute hindamise täpsusele, sest hindamise teeb spetsialist, kes tunneb inimese terviseseisundit. Kui

hindamise viib läbi inimese raviarst või terapeut, võib eeldada, et hindamisprotsess on inimese jaoks toetav kogemus.

Tervisejuhi kaasamine aitab hinnata abi- ja teenuste vajadust ning jõuda vajaliku abini kiiremini. Samuti tõid osalejad esile, et tervisekeskused on paljudes piirkondades inimestele paremini tuntud ja füüsiliselt ligipääsetavamad kui kohaliku omavalitsuse asutused. Riskina tõid töötubades osalejad välja rollijaotuse ebaselguse – inimese jaoks pole selge, millal pöörduda perearsti, millal pereõe ja millal tervisejuhi poole. Kui pole piisavalt teenuseid ja teenusepakkujaid, ei lahenda tervisejuhi lisamine teenuste kättesaadavuse probleemi. Sellisel juhul võib suureneda tervisejuhi ametikohaga seotud ressursid ja halduskoormus, kuid teenuste kättesaadavus ei parane.

Uuringu autorite hinnangul kaasneb lahendusega suurem koormus perearstidele ja eriarstidele. Raviarstidel tekib kohustus võtta kasutusele RFK metoodika ning kasutada seda igapäevatöös, mis eeldab süstemaatilisi koolitusi. Kuna lahenduses on pandud hindamise raskuskese tervishoiusüsteemile, võib see võimendada (pere)arstide ülekoormatust, perearstide tööjõupuudust ja erinevate spetsialistide puudust. Tervisejuhi roll ei ole veel rakendunud ning tema ülesanded ei ole täpselt paigas. Selline lahendus paneks tervisejuhile olulisel määral lisaülesandeid. Taustal on üldine tervise- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistide puudus, mis võib tekitada raskusi tervisejuhtide leidmiseks.

Kui piirangute hindamine on integreeritud raviprotsessi ning RFK põhised andmed on TIS-is kättesaadavad, on tervishoiutöötajatel parem ülevaade inimese funktsioonipiirangutest ja toetusvajadusest. See võib soodustada varasemat suunamist rehabilitatsioonile, abivahendite soetamisele ja muudele tervist toetavatele teenustele. Terviseteele juhi kaasamine aitab tagada, et ravi, rehabilitatsioon ja sotsiaalne tugi on omavahel koordineeritud. Selgem seos diagnooside, funktsioonipiirangute ja teenusteni suunamise vahel toetab terviklikku lähenemist ja mis soosib sotsiaalmajanduslikku toimetulekut – abivajaduse tuvastamine ja asjakohastele teenustele suunamine toetavad nii töö- kui ühiskonnaelus osalemist. Paranenud teenuste kättesaadavus (rehabilitatsioon, tugiisik, psühholoogiline tugi) võib parandada puuetega inimeste tööhõivet.

Kui aga tervishoiusüsteem ei suuda täiendavat hindamis- ja koordineerimiskoormust kanda, võivad pikeneda raviteenuste saamise ooteajad. RFK kasutamine ilma selleks piisavalt aega ja väljaõpet võimaldamata võib viia ebatäpse hindamiseni, mis ei peegelda inimese tegelikku olukorda. Kui KOV-ide võimekus teenuseid pakkuda on erinev, võib ka pärast tervisekeskset hindamist jääda teenuste maht ja kvaliteet tugevalt sõltuma inimese elukohast.

Kuna ettepanekuga ei muudeta toetuste suuruseid, ei ole asjakohane analüüsida mõju vaesusele ja majanduslikule toimetulekule. Eeldades, et toetuste kättesaadavus ei halvene ja toetuste ulatus jääb samaks, ei muutu ka riigi kulud ning puudub mõju inimeste sissetulekutele või vaesusele. Siiski on toetuse kulude kontrollimine raskendatud olukorras,

kus hindaja ja toetuse maksja on erinevad asutused. Vähenevad töötukassa ja SKA kulud ekspertiiside tegemisele. Töötukassal peavad siiski olema mõned ekspertarstid, kes saavad vajadusel hinnata, kas raviarsti piirangute hinnang vastab metoodikale.

Õiguseksperdi hinnangul täidaks see teekond pakutud stsenaariumitest tõenäoliselt kõige paremini puuetega inimeste konventsiooni ning parandatud ja täiendatud sotsiaalthartaga võetud kohustusi. Võrreldes muude teekondadega pöörab Teekond 2 oluliselt rohkem tähelepanu puude tuvastamise aluseks oleva andmekvaliteedi parandamisele. Hindamine on sama nii tööealistele kui ka vanaduspensioniealistele ega sõltu inimese elukohast. Sellega välditakse inimeste vanuselist ja elukohast tulenevat diskrimineerimist. Uus lahendus võtaks aega, kuid SKA kui TK saaksid hindamise asemel keskenduda nende omaste meetmete pakkumisele.

Ehkki SKA ja TK inimeste piiranguid enam ei hindaks, tuleks neil hindamistulemuste alusel teha haldusotsused vähenenud töövõime ja töövõimetoetuse ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise kohta. Vaiete lahendamiseks on asutustel vaja teatud ulatuses ka ekspertiisi tegemise ressursi.

Lahenduse elluviimiseks on vaja mitmete struktuursete muudatuste eelnevat rakendumist – RFK kasutuselevõtmine eri- ja perearstide poolt, TERVIKute reformi⁴³ käivitumine ning tervisejuhtide rolli rakendumine. Infotehnoloogilised arendusvajadused puudutavad TIS-i, töötukassat ja SKA-d. Kui hindamistulemused on ühes infosüsteemis, siis vähendab see pikas perspektiivis riigi kulutusi infosüsteemidele. Kuna teekond on esialgu teoreetiline, ei ole süsteemi ümberkorraldamise kulusid või mõju võimalik analüüsida.

11.5. Teekond 3 – puude tuvastamine asendatakse abi- ja toetusvajaduse hindamisega KOV-is

Töötubades arutati ka teekonda, milles puude tuvastamist ei toimu ei tööealistel kui vanaduspensioniealistel, tervisekahjustusega inimeste abivajadust hindab KOV. Puude raskusastme tuvastamise asendab KOV-i abivajaduse hindamine⁴⁴ ning sellega koos teenuste ja toetuste pakkumise kohustus. Kuigi abivajaduse hindamise kohustus on omavalitsustel ka täna, on sihtgrupi vaates siiski tegemist olulise muudatusega, millega kaasneb mitmeid küsimusi ja lahendamist vajavaid kitsaskohti, et tegevuspiirangutega inimesed ei jääks ilma abita. Arvestades, kui paljud täna KOV-delt eeldatavalt vajalikku abi teenustena saavad või

⁴³ Vt <https://www.sm.ee/uudised/tervishoiu-ja-sotsiaalsüsteemi-integreerimise-visioon-ootab-tagasisidet>

⁴⁴ SHS § 15 järgi on ka täna KOV-del abivajaduse hindamise kohustus. Abivajaduse väljaselgitamisel peab lähtuma terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sh isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

kui suur on tegelik vajadus täiendavate teenuste järele, on mõistetav, miks sihtrühm üksmeelselt seda teekonda ei toeta ning näeb selles riski, mis võib nende olukorda halvendada.

Teekonna rakendamise eelduseks on ühtse STAR-i põhise abi- ja toetusvajaduse hindamisvahendi⁴⁵ kasutuselevõtmine kõikides omavalitsustes. Toetuste ja teenuste määramine tervisekahjustustega ja -piirangutega inimestele on KOV-ide ülesanne. Funktsioonipiiranguid hindab KOV inimese enesehinnangu ja KOV töötaja vaatluse alusel. Võrreldes praeguse puude raskusastme tuvastamisega ei kasuta KOV-id hindamisel diagnooside infot. Kuivõrd SKA enam puude raskusastet ei tuvasta, siis on ka abi- ja toetusvajaduse hindamise juurde vaja luua vaiete süsteem – kuhu ja kelle poole inimene pöördub, kui tal on vaja saadud otsust vaidlustada, sh kui ta ei saa puudega inimese kaarti.

Kui hindamise tulemusena tuvastatakse tegevuspiirangud, siis väljastab KOV puudega inimese kaardi. Kaardi väljastamise aluseks on mõõdukas, raske või täielik piirang vähemalt ühes valdkonnas. Piirangud on enesehinnangulised ega põhine diagnoosidel. Eeldatavalt on vaja välja töötada konkreetsemad ja ühtsed kriteeriumid, et KOV-idel oleks ühetaoline lähenemine (kui KOV-id kasutavad täna enda väljatöötatud hindamisvahendit, siis ei pruugi nt täielik piirang ühes KOV-is olla sama, mis teises KOV-is). Samuti tuleb selle juures arvestada, et puudega inimese kaardi väljastamise otsus fikseeritaks STAR-is.

Praegused vahendid (SKA ekspertiisikulu ja PISTS tööealise ja vanaduspensioniealise inimese sotsiaaltoetuse vahendid) antakse KOV-de tasandusfondi ja/või riigi poolt osutatavate teenuste pakkumiseks (rehabilitatsioon, abivahendid, erihoolekanne). Kuna ei ole andmeid, milliste teenuste ostmiseks puudega inimesed saadud toetusi kasutavad (seda ei osanud välja tuua ka sihtgrupi liikmed ise), on võimalik välja pakkuda teoreetiline vahendite jagamise skeem. Nii 2020. kui ka 2025. aasta elanikkonna tegevuspiirangute ja hooldusvajaduse uuringu (Turu-uuringute AS, 2020; Vainu, 2025) järgi vajavad Eesti elanikest täiendavaid teenuseid keskmiselt 9–10%. Vanuserühmade võrdluses täiendavate teenuste vajadus oluliselt suureneb ning seda eriti 80-aastaste ja vanemate elanike seas. Kõige enam vajatakse täiendavaid teenuseid transpordiks, igapäevaste toimingute tegemiseks isiku eluruumides, apteegist ravimite ja poest toidu ja muude vajalike kaupade koju toomiseks, kuid ka muudeks tegevusteks. 2025. aasta uuringus nähtus, et tegevuspiirangute raskuse ja funktsiooni kõrvalekallete lõikes võib täiendavate teenuste vajadus ulatuda ka kuni 48%-ni ning puude raskusastmete lõikes kuni 58%-ni vastavast rühmast. (Turu-uuringute AS, 2020; Vainu, 2025)

⁴⁵ Vt ka: <https://sotsiaalkindlustusamet.ee/spetsialistile-ja-koostoopartnerile/kohalike-omavalitsuste-noustamine#hindamisvahendid>

Kokkuvõttes on sellel teekonnal sihtgrupi vaates järgmised puudujäägid ja võimalikud negatiivsed mõjud:

- Probleemiks on võimalik rahade jaotuskava riigilt KOV-dele – kui puuet riigi tasemel ei tuvastata, ei teki alust vahendite jaotuskava koostamiseks. Seega on vaja leida uus jaotuse alus, sh on vaja KOV-del hindamised tulemused fikseerida STAR-is.
- Üleminek praeguselt süsteemilt uuele toob kaasa ebaselgust ning küsimuse, kas SKA-lt endiselt toetusi saavad puudega inimesed peaksid saama KOV-lt vähem teenuseid võrreldes riigilt toetusi enam mitte saavate inimestega.
- Muud hüvede saamise aluseks on KOV-i väljastatud puudega isiku kaart. Ebaühtlase hindamise tulemusel võimendub ebaühtlane ligipääs teistele hüvedele ja soodustustele.

Puuetega inimeste töötubades tuli esile ka soovimatus pöörduda abi saamiseks sotsiaaltöötajate poole. Mitmetel osalejatel oli negatiivseid kogemusi KOV-i teeninduskultuuri ning sotsiaaltöötajate valmidusega inimesele teenuseid pakkuda. Samuti kaheldi sotsiaaltöötajate ekspertteadmistes pakkuda konkreetsete puude liikidega inimeste vajadustest lähtuvat abi. Iseäranis tuli see hoiak välja osalenud meeste seas. Et loodav tugisüsteem toimiks, tuleb arvestada inimeste kogemuste ja hoiakutega. Arvestades omavalitsuste erinevat võimekust, võib halveneda tegelikult abi vajajate olukord.

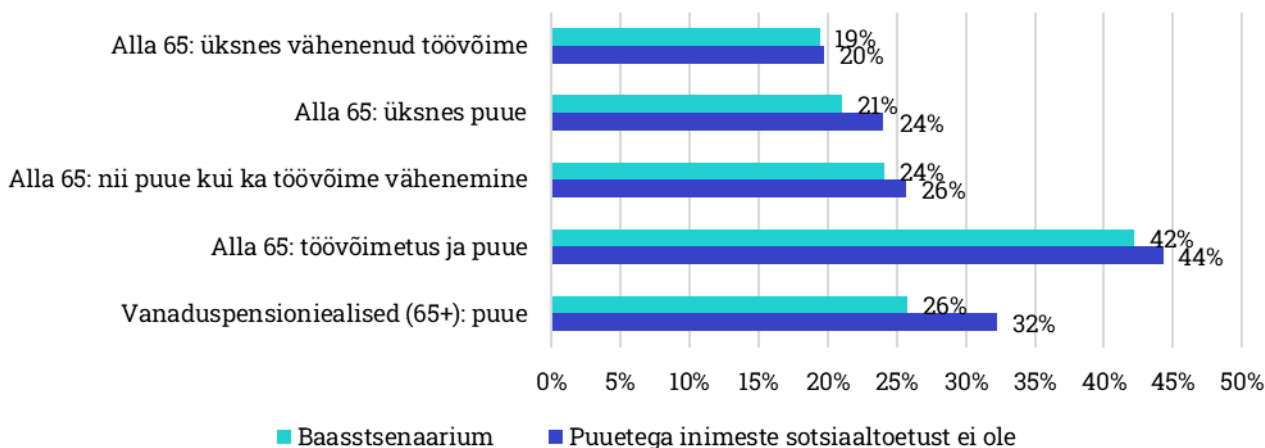
Riigi kulud ja mõju vaesusele

Kui puude tuvastamine asendatakse abi- ja toetusvajaduse hindamisega ning puuetega inimeste sotsiaaltoetused asendatakse teenuste pakkumisega, halveneb leibkondade majanduslik toimetulek oluliselt. EUROMOD hinnangute kohaselt kasvaks Eestis üldiselt suhtelise vaesuse määr 0,6 protsendipunkti (18,5% vs. 19,1%). Ka ebavõrdsus (Gini indeks) kasvaks vähesel määral. Kuna puuetega inimeste osakaal on kõrge vanaduspensioniealiste seas, väga suur osa puudega inimesi elavad üksi või teise täisealise leibkonnaliikmega ning pensioniealiste (eriti üksi elavate inimeste) üldine vaesusrisk juba on kõrge, siis oleks toetuse kadumisel pensioniealistele märkimisväärne mõju. Üle 65-aastaste üksi elavate naiste suhteline vaesus kasvab selle stsenaariumi korral ligikaudu 4 protsendipunkti, meeste vaesus 2 protsendipunkti. Üle 65-aastaste puudega inimeste vaesus kasvab pea 7 protsendipunkti (25,8% vs. 32,3%) (vt joonis 38). Seega suhtelises vaesuses olevate puudega eakate arv suureneks rohkem kui 4000 inimese võrra. Kuna pikaajalise puudega inimeste töötamise võimalused üle elukaare on olnud väiksemad, siis on puudega vanaduspensioniealiste keskmine ja mediaanpension ligikaudu 50–100 eurot väiksemad Eesti keskmisest pensionist ja seetõttu nende vaesusrisk veelgi suurem.

Puudetoetuse kaotamise mõju tööealistele on võrreldes pensioniealistega mõnevõrra väiksem, sest osa sihtrühmast veel ka töötab (ligikaudu 70% üksnes vähenenud töövõimega

inimeste sihtrühmas sai töötasu). Samuti on selles grupis enam neid, kes elavad koos teise täisealise inimesega, kes samuti panustavad leibkonna sissetulekusse. Siiski kasvaks suhtelise vaesuse määr üksnes puudega inimeste seas ligikaudu 3 protsendipunkti, üksnes vähenenud töövõimega inimeste seas alla 1 protsendipunkti ja nende seas, kellel on nii puue kui ka vähenenud töövõime, ligikaudu 2 protsendipunkti.

Joonis 38. Puudega ja vähenenud töövõimega inimeste suhtelise vaesuse määr puuetega inimeste sotsiaaltoetuse kadumise korral võrreldes hetkeolukorraga tuginedes 2024. aasta registriandmetele



Allikas: autorite arvutused EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal.

Märkused: Vaesuse määra arvutamiseks on leibkonna kogu netosissetulek simuleeritud (sh maksuarvestus) EUROMODiga tuginedes 2024. aasta andmetele ja viidud hinnaindekseid arvesse võttes 2025. aasta väärtustesse.

Kui rakendada muudatust lähtudes 2024. aasta tööealiste ja vanaduspensioniealiste toetuse saajate arvust ja 2025. aastal kehtivat toetuse suurust arvestades, siis väheneks EUROMOD hinnangu kohaselt riigieelarve kulud toetusele ligikaudu 56,3 miljonit eurot. See kulu oleks võimalik ümber paigutada teenustesse.

Teenuste pakkumiseks KOV-is riigi toetuse asemel on KOV-idel vaja lisaressurssi. Võttes aluseks 2025. aasta elanikkonna tegevuspiirangute ja hooldusvajadusega elanike uuringu andmed, siis on võib täiendava sotsiaaltranspordi teenuse vajaduse katmiseks tänaste puude raskusastmega inimeste seas vaja olla 7–11,9 miljonit eurot ning koduteenuse vajaduse katteks 31–51,5 miljonit eurot. Tabelis 39 on esitatud ka hinnang tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse vajaduse katmisest. Uuringu järgi võib eeldada, et need teenused ühtivad kõige enam sellega, millise sisuga toimingute või tegevuste jaoks teenuseid vajatakse.

Hinnangule lisanduvad praegused teenuse saajad, kes vajavad teenust suuremas mahus või väiksema omaosalusega. Samas on puudega leibkonnaliikmega leibkondades sundkulutuste ehk toidukulude osakaal ja eluasemekulude osakaal suurem kui Eestis keskmiselt ning samuti on tervisega seotud kulutuste osakaal puuetega inimeste leibkondades suurem (vt ka

Laurimäe, Sinisaar, Jezierska, 2025). Seega on ka teenuste omaosaluse vähendamine oluline puuetega inimeste toimetulekuks ja teenuste vajaduse katmiseks.

Tabel 39. Hinnang lisakulude vajadusele täiendavate teenuste katmiseks tänaste täisealiste puude raskusastmega seas

	Hinnanguline täiendavate teenuste vajadus – osakaal 18+ vanuses puude raskusastmega inimestest*			Hinnanguliselt lisanduv saajate arv**			Täna (2024) keskmine KOV kulu ühe teenuse saaja kohta aastas***	Hinnanguline lisakulu, mln eurot		
	min	keskmine	max	min	keskmine	max		min	keskmine	max
sotsiaal-transporditeenus	17%	24%	30%	19 684	27 150	33 423	356	7,0	9,7	11,9
isikliku abistaja teenus	9%	13%	17%	9 972	14 806	19 339	5 273	52,6	78,1	102,0
tugiisiku teenus	16%	23%	28%	18 326	25 509	31 571	926	17,0	23,6	29,2
koduteenus	18%	24%	30%	19 858	27 374	33 638	1560	31,0	42,7	52,5
KOKKU								107,5	154,1	195,6

Allikas: Autorite arvutused S-veebi andmete (teenuste saajad, kulud 2024. aastal), 2025. aasta elanikkonna tegevuspiirangute ja hooldusvajaduse uuringu andmetabelid (avaldamata) ja Sotsiaalkindlustusameti registriandmete alusel.

Märkus: * täiendava teenuste vajadus võib olla erineva puude raskusastme ja vanuse kombinatsioonis olla suurem või väiksem. 2025. aasta elanikkonna tegevuspiirangute ja hooldusvajaduse uuringus on puue enesehinnanguline, st vastaja andmetele ei ole lingitud andmed puude raskusastme kohta registriandmetest. Arvutustes on aluseks võetud kõik 18+ vanuses puudega inimesed ning teenuste vajadus tegevuste lõikes. Sotsiaaltransporditeenus: keskmiselt vajab 24% puudega 18+ inimestest täiendavat teenust transpordiks kaugemal asuvatesse kohtadesse; Isikliku abistaja teenus: töötamiseks või õppimiseks, sh huviharidusega tegelemiseks vajab täiendavaid teenuseid keskmiselt 13% puudega täisealistest; Tugiisikuteenus: keerulisemate või uute ülesannete lahendamiseks (nt remondi või kodumasinade paranduse korraldamine, digiallkirja andmine, aga ka uute asjade või töövahendite kasutama õppimine, uude kohta minek ja seal orienteerumine jms) vajab täiendavaid teenuseid keskmiselt 23% täisealistest puudega inimestest; Koduteenus: igapäevaste toimingute tegemiseks isiku eluruumides (pea sama palju vajab ka apteegist ravimite ning poest toidu ja muude kaupade koju toomiseks) vajab täiendavaid teenuseid 24% puudega täisealistest. ** Aluseks S-veebi andmed, keskmine kulu on arvutatud KOV kulude järgi: kulusumma/jagatud teenuse saajate kogu arv. Teenuse kulu võib vanuserühmade, puude jm lõikes tegelikkuses erineda.

Kui aga lähtuda, et puuet enam ei tuvastata ja edaspidi hinnatakse tegevuspiiranguid, siis võib võimalik sihtrühm olla oluliselt suurem ja teenuste potentsiaalseteks vajajateks on ka need, kellel täna puuet tuvastatud ei ole, kuid kellel tegelikult on tegevuspiirangud. Arvestades ka piirangute raskusastet, võib täiendava teenuste vajaduste katmiseks olla vaja 37,1–201,5 miljonit eurot.

Tabel 40. Hinnang lisakulude vajadusele täiendavate teenuste katmiseks täisealiste tegevuspiirangutega elanike seas

Piirangute raskusaste***	Hinnanguline täiendavate teenuste vajadus - osakaal 18+ vanuses tegevuspiirangutega inimestest, %*			Hinnanguliselt lisanduv saajate arv*			Täna (2024) keskmine KOV kulu ühe teenuse saaja kohta aastas**	Hinnanguline lisakulu, mln eurot		
	K	M	T	K	M	T		Kerged	Mõõdukad	Tõsised
sotsiaal-transpordi teenus	6%	6%	36%	6 396	15 981	38 799	356	2,3	5,7	13,8
isikliku abistaja teenus	3%	5%	16%	3 432	12 192	17 634	5 273	18,1	64,3	93,0
tugiisiku teenus	8%	7%	32%	8 968	17 845	34 046	926	8,3	16,5	31,5
koduteenus	5%	6%	38%	5 422	16 271	40 488	1560	8,5	25,4	63,2
KOKKU*	10%	12%	48%	11 179	32 020	51 395		37,1	111,9	201,5

Allikas: Autorite arvutused S-veebi andmete (teenuste saajad, kulud 2024. aastal), 2025. aasta elanikkonna tegevuspiirangute ja hooldusvajaduse uuringu andmetabelid (avaldamata) ja Statistikaameti rahvastiku statistika alusel (18+ vanuses rahvastik).

Märkus: *Arvutustes on aluseks võetud kõik 18+ vanuses tegevuspiirangutega inimesed ning teenuste vajadus tegevuste lõikes. Sotsiaaltransporditeenus: täiendava teenuse vajadus transpordiks kaugemal asuvatesse kohtadesse; Isikliku abistaja teenus: täiendava teenuse vajadus töötamiseks või õppimiseks, sh huviharidusega tegelemiseks vajab täiendavaid teenuseid; Tugiisikuteenus: täiendava teenuse vajadus keerulisemate või uute ülesannete lahendamiseks (nt remondi või kodumasinade paranduse korraldamine, digiallkirja andmine, aga ka uute asjade või töövahendite kasutama õppimine, uude kohta minek ja seal orienteerumine jms); Koduteenus: täiendavate teenuste vajadus igapäevaste toimingute tegemiseks isiku eluruumides. ** Aluseks S-veebi andmed, keskmine kulu on arvutatud KOV kulude järgi: kulusumma/jagatud teenuse saajaate kogu arv. Teenuse kulu võib vanuserühmade, puude jm lõikes tegelikkuses erineda. *** K – kerged piirangud, M – mõõdukad piirangud, T – tõsised piirangud.

Poliitikamuudatustega kaasnevad ka muutused halduskuludes ja tööjõukuludes. 2024. aastal olid SKA kulutused tööealiste puude raskusastme hindamise ja taotluste menetlemistega seoses kokku 320 tuhat eurot ning vanaduspensioniealistega seotud kulud 375 tuhat eurot. Sarnaselt teekond 1-ga tooks see kaasa vastavate kulude kokkuhoiu. Mõnevõrra tõuseksid töötukassa kulud töövõimetoetuse menetlemisele, kui eeldada praeguste üksnes puudega inimeste liikumist töövõimetoetuse skeemi. Lisaks asendatakse puude tuvastamine abi- ja toetusvajaduse hindamisega kohalikus omavalitsuses. Tuginedes tegevuspiirangute klastritele (Vainu, 2025) ja tõsistele piirangutele, oleks abivajadusega tööealiste arv hinnanguliselt 50 417 ja vanaduspensioniealiste arv 57 438. Kui eeldada, et kõik nad pöörduvad aasta jooksul kohaliku omavalitsuse poole ühel korral abivajaduse hindamiseks, ning võtta kuluühiku hinnaks SKA taotluse menetlemise tasu (7,1 eurot taotluse kohta), siis

kasvaksid kulutused vanaduspensioniealistele ligikaudu 32 tuhat eurot aastas⁴⁶ ja tööelistel 42 tuhat eurot aastas⁴⁷. Olenevalt abivajaduse hindamise täpsest meetodikast (sh andmete ja infosüsteemide kasutamise võimalusest, mida aluseks võtta) võivad kulud olla kas väiksemad või suuremad.

Tabel 41. Tööjõukulud ja nende muutus baasstsenaariumi ja teekond 3 korral

Kulu liik	Tööelised		Vanaduspensioniealised	
	Baasstsenaarium	Teekond 3	Baasstsenaarium	Teekond 3
Sotsiaalkindlustusameti kulud puudega seotud hindamistele ja taotluste menetlemisele	320 168,9	0	375 354,2	0
Töötukassa kulud töövõimetoetuse menetlemisele	793 729,0	798 404,0	0	0
KOV kulud abivajaduse hindamisele	0	357 960,7	0	407 809,8
Kulud kokku	1 113 897,9	1 156 364,7	375 354,2	407 809,8
Kulude muutus		+42 466,9		+32 455,6

Allikas: autorite arvutused.

Selle stsenaariumi korral täiendavaid arenduskulusid töötukassale ei kaasne. Sarnaselt teekond 1-ga võib kaasneda kulude kokkuhoid SKA arenduskuludes, st praegu olemasolevate süsteemide töös hoidmise arvelt (enam ei ole puude tuvastamise ja toetustega seoses süsteeme vaja uuendada/parendada/töös hoida).

11.6. Kokkuvõtte lahendusettepanekutest

Süsteemi korralduse muudatus ei oma soovitud mõju, kui puudega inimesed ei saa piirangute kompenseerimiseks vajalikke ja sobivaid teenuseid. Puuetega inimeste vaates ei ole peamine puudujääk tänase süsteemi ülesehituses, vaid selle rakendamises ja lünkades.

Tabel 42 Teekondade SWOT analüüs

Teekond	Tugevused	Nõrkused	Võimalused	Ohud
Teekond 1	Luuakse üks süsteem tööelistele inimestele, mis on selgem ja lihtsam. Vanaduspensionieas jätkub toetuse maksmine sama meetodika alusel. Sujuvam üleminek tööeliste süsteemist vanaduspensioniealistesse süsteemi. Vähem hindamisi on	Sügava puudega inimesed võivad kaotada toetustes (sõltuvalt konkreetsest stsenaariumist võivad kaotada ka teised). Ei lahenda teenuste puudumist ega teenusteni jõudmist.	Võimalus muuta puudetoetuse määramise meetodika lihtsamaks ja ühetaoliseks tööelistele ja vanaduspensioniealistele inimestele. Võimalus vähendada hindamise arvu.	Kolmeastmelise toetuse muutmine kaheastmeliseks võib jätta keskmise piiranguga inimesed toetuseta. Toetuse mehhaaniline tõstmine ühte asutusse ei lahenda sisulisi probleeme. Reform toob kaasa kulud, kuid inimeste jaoks muutub olukord vähe.

⁴⁶ Kulud teekond 3 korral: $57\,438 \times 7,1 = 407\,809,8$; muutus kuludes: $407\,809,8 - 375\,354,2 = 32$ tuhat

⁴⁷ Kulud teekond 3 korral: $50\,417 \times 7,1 = 357\,960,7$; muutus kuludes: $357\,960,7 - 320\,168,9 = 42$ tuhat

	puuetega inimestele vähem koormav.	Ei lahenda mitmeid hindamise kitsaskohti. Olenevalt stsenaariumist ei pruugi leevendada vaesust.		
Teekond 2	Tugev toetus sihtrühmalt. Hindamine vastab paremini puuetega inimeste ootustele. Piirangute seostatus teenustega. Elukaarepõhine lähenemine.	Tervishoid ei ole valmis kasutama RFK hindamist. Tervisejuhi roll ei rakendu oodatult. Tööeliste inimestele jääb kaks toetust, mida määravad kaks asutust. Ei lahenda teenuste puudust ega leevenda vaesust.	RFK metoodikaga hinnatud piirangute info on kättesaadav erinevatele osapooltele, kes seda vajavad.	Süsteem, kus üks asutus hindab ja teine maksab toetusi või pakub teenuseid, ei toimi, võib viia kulude kontrollimatu kasvuni.
Teekond 3	KOV on inimesele lähedal ja näeb tema olukorda. On olemas abivajaduse hindamise metoodika, inimest hinnatakse tema igapäevases keskkonnas.	KOV-de tase hindamisel ja teenuste osutamisel on ebaühtlane, oht jääda teenustest ilma. Rahastamine on keeruline. KOV-d on reformidest üle koormatud, napib tööjõudu, tööriistu ja teadmisi erinevate piirangute spetsiifikast. Kaudselt mõjutab teenuste saamine mõjutab majanduslikku toimetulekut kui väheneb teenuste maksumus/omaos alus, kuid otseselt ei leevenda vaesust.	Rakendades üle riigi ühtset hindamismetoodikat, universaalset õigust saada teenuseid ning ühtset teenuste hinnastamist, saaks puuetega inimeste abistamise anda üle suuremas määras kohalikule tasandile.	Paljudel puuetega inimestel puudub usaldus KOV-de vastu. Reformi õnnestumiseks on vaja täita palju eeldusi.

12. Persoonad

Eelnevale analüüsile tuginedes on järgnevalt esitatud 8 persoonat tööeliste sihtrühmade kohta. Persoonade loomine aitab paremini mõtestada analüüsitavate muudatuste mõju eri sihtrühmadele ning kujundada lahendused, mis arvestaksid nende rühmade erisustega. Iga persona juurde on lisatud ka võimalik mõju teekondade lõikes.

Persoonad 1 ja 2. Tööelised isikud, kellel on hinnatud ainult vähenenud töövõime

PERSOONA 1: Mari, 56, teenindus- ja müügitöötaja

Mari on 56-aastane teenindus- ja müügitöötaja hulgi- ja jaekaubandussektoris Harjumaal. Maril on töötukassas hinnatud töövõime vähenemine (osaline töövõime), kuid puuet Maril määratud ei ole. Seega saab Mari töövõimetoetust 371,8 eurot kuus. Mari osaline töövõime tuleneb kroonilistest valudest. Krooniliste valude tõttu esineb ka meeleolulangust, sest on hetki, kus töö tegemine ei ole võimalik ning see paneb muretsema töö kaotamise pärast.

Mari elab koos elukaaslasega, lapsi neil ei ole. Mari keskmine töötasu kuus on 1000 eurot. Kuna ka Mari elukaaslane töötab, siis elavad nad üsna hästi. Kuna töökoht on olemas ja majanduslik toimetulek keskmine, ei pea Mari praegu ka vajalikuks töötukassa teenuste kasutamist. Varem on Mari siiski töötukassa teenuseid sobiva töö leidmiseks kasutanud. Mari vajab tervishoiusüsteemi abi üksikteenustes – füsioteraapiat ja taastusravi. Maril võiks kasu olla tööalasest rehabilitatsiooniteenusest, et tulla toime meeleolulanguse ja kroonilise valuga.

Teekond 1: Kui puudega tööelise inimese toetus integreeritakse töövõimetoetusesse ja puuet enam ei tuvastata (variant 1), siis mõju Marile oleks väike, sest Maril ei ole ka hetkel puuet tuvastatud. Küll aga hoopis kasvaks Mari sissetulek, kui rakenduks süsteem, kus puudetoetuste arvelt kasvaks töövõimetoetuse päevamäär kõigil vähenenud töövõimega inimestel (kasv 25–100 eurot kuus olenevalt rakenduvast stsenaariumist). Kui töövõimetoetus kasvab vaid neil, kellel on puuduv töövõime, siis sel juhul mõju Mari jaoks puudub, sest Maril on üksnes osaline töövõime vähenemine. Kui töövõimetoetuse kõrvale lisanduks TRT (variant 2), siis olenevalt stsenaariumist (piirangust) kasvaks tema sissetulek 25–70 eurot.

Teekond 2: Otsene mõju majanduslikule toimetulekule puudub – eeldatavasti toetused säilivad samas mahu ulatuses.

Teekond 3: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse kaotamisel mõju Mari sissetulekule puudub, sest ta ei saa ka praegu seda. Samas võib see mõjutada tema olukorda tulevikus, kui ta sooviks toetust taotleda või tema tervislik seisund halveneks.

PERSOONA 2:
Karl, 48,
lihttööline

Karl on keskharidusega 48-aastane maapiirkonnas elav meesterahvas. Karlil on samuti hinnatud osaline töövõime vähenemine (töövõimetoetus 371,8 eurot kuus). Siiski on Karl tööturul aktiivne ja töötab lihttöölisena töötleva tööstusega tegelevas ettevõttes. Osaline töövõime vähenemine tuleneb liikumisraskustest. Karl elas läbi autoõnnetuse, mille tagajärjel lonkab ta tugevalt ühte jalga. Tal on keeruline kasutada ühistransporti, autojuhilube tal pole, seega vajaks ta tööle jõudmiseks sotsiaaltransporti, aga kuna tal pole puuet määratud, on kohalik omavalitsus keeldunud talle teenust pakkuma. Karl vajab ortopeedilisi jalanõusid ja taldu ning töötukassalt tööalast abivahendit. Karl on varem ühel korral küll puuet taotlenud, kuid sai siis negatiivse otsuse, põhjusel, et takistus on kompenseeritav abivahendiga. Uue taotluse või vaide tegemiseks tal ressursid ja oskused puuduvad. Samuti ei ole tal lähedasi, kes sellega toetaks või aitaks.

Karl elab üksi, lapsi ja elukaaslast tal ei ole. Kuigi üksinda toime tulla on keeruline, aitab teenitav töötasu ja maapiirkonna madalad üürikulud piisava majandusliku toimetuleku tagada.

Teekond 1: Mõju sama, mis Maril (persoon 1).

Teekond 2: Otsene mõju majanduslikule toimetulekule puudub – eeldatavasti toetused säilivad samas mahus ja ulatuses. Teenuste vajaduse hindamisel pööratakse tähelepanu liikumistakistusele ja selgitatakse välja kompenseerivad teenused, nt sotsiaaltransport, sobivad abivahendid ja füsioteraapia.

Teekond 3: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse kaotamisel mõju Karli sissetulekule puudub, sest ta ei saa ka praegu seda. Samas võib see mõjutada tema olukorda tulevikus, kui ta sooviks siiski uuesti toetust taotleda või tema tervislik seisund halveneks. Kohaliku omavalitsuse poole Karl teenuste saamiseks ise pöörduda ei soovi, kuna on varem selles pettunud.

Persoonad 3 ja 4. Tööealised isikud, kellel on tuvastatud ainult puude raskusaste

PERSOONA 3:
Oksana, 56,
töötu

Oksana elab Ida-Virumaal. Ta on 56-aastane. Oksanal on olnud juba lapseeest saadik liikumispiirang, mille tõttu on tal tuvastatud keskmine puue ja õigus PISTS toetusele (liikumisfunktsiooni kõrvalekalde korral toetus 42 eurot kuus). Kuigi Oksanal on kõrgharidus, siis on tal töö leidmine keeruline. Ühelt poolt on Ida-Virumaal töökohti vähem, teiselt poolt ei võimalda puue ka kõiki töid teha. Tema kultuuritaust toetab seda, et naine on kodune ja leivateenija on mees. Seega on Oksana hetkel töötu ja sõltub üksnes leibkonnaliikmete toetasust ja toetustest. See paneb ta haavatavasse olukorda ning tal ei ole võimalik suhtest välja astuda. Töövõime vähenemist Oksanal hinnatud ei ole, keelebarjääri tõttu on olnud see keerukas. Samuti ei ole ta osalenud töötukassa või SKA pakutavatel teenustel, mis võiksid tema olukorda parandada, sest tal endal ei ole midagi silma jäänud ning ta ka ei tea, mida või kust otsida. Teenuseid ei ole talle keegi pakkunud.

Teekond 1: Kui puudega tööealise inimese toetus integreeritakse töövõimetoetusesse ja puuet enam ei tuvastata (variant 1), siis kaotaks Oksana praeguse puudetoetuse (42 eurot kuus) ja seega ka ainsa sissetulekuallika (töövõimetoetust ta hetkel ei saa). Toetuse jätkumiseks peaks Oksana nüüd siiski läbima töövõime hindamise. Samas positiivse otsuse korral hakkaks Oksana saama kõrgendatud töövõimetoetust, mille tulemusena tema sissetulek kokkuvõttes kasvaks märgatavalt (olenevalt stsenaariumist oleks uus töövõimetoetus osalise töövõime korral 371,8 eurot kuni 428,7 eurot kuus), talle rakenduks aktiivsuskohustus. Kui praeguse töövõimetoetuse kõrvale lisanduks TRT (variant 2), siis sellele Oksana tõenäoliselt ei kvalifitseeruks, sest eeldab täieliku või raske piirangu olemasolu (eelduste kohaselt osalise töövõime korral raske või sügav puue). Kui otsus osutub negatiivseks, siis Oksana toetusele enam ei kvalifitseeru. Kuna pereliikmed töötavad, ei kvalifitseeru Oksana ka toimetulekutoetusele.

Teekond 2: Otsene mõju majanduslikule toimetulekule puudub – eeldatavasti toetused säilivad samas mahus ja ulatuses. Kui Oksana läheb taotlema töövõime hindamist, saab ta teadlikuks teenustest, mis aitavad tema liikumispiirangut ületada ning töötukassa motiveerib teda osalema tööturuteenustel.

Teekond 3: PISTS toetuse asendamise korral abi- ja toetusvajaduse hindamisega kaotaks Oksana oma praeguse toetuse, mis on 42 eurot kuus. Kohaliku omavalitsuse poole pöördumiseks puudub Oksanal teadlikkus, aga ka julgus.

PERSOONA 4:
Mati, 61,
pensionil enne
vanadus-
pensioniga

Mati on 61-aastane Harjumaal elav pensionär. Matil on sügav liikumispuue, mille tõttu ta saab PISTS toetust 100 eurot kuus. Mati kaotas mõned aastad tagasi töökoha ja kuna vanuse ning puude tõttu oli uue töökoha leidmine keerukas, otsustas ta minna ennetähtaegsele pensionile. Liikumispiirang süvenes peale töötamise lõppemist ning nüüd kasutab ta ratastooli. Pensioni saamise tõttu aga kadus Matil ka võimalus töövõimetoetusele. Kuna Matil on olnud ka varem keeruline töökohta leida ja püsivalt töötada ning ettetähtaegne pension on tavapensionist madalam, siis on ta pension väike (660 eurot kuus), vaesusrisk on suur ning üldine toimetulek kehv. Varasemale pensionile minnes ei saanud Mati nõustamist seoses töövõimetoetusega. Mati on olukorras pettunud ja peab seda ebaõiglaseks. Mitmed soodustused on seotud vanaduspensionieaga (nt kõrgem maksuvabatulu) ning tal ei ole õigust ka neile. Kohaliku omavalitsuse poole ta pöördunud ei ole, sest ei usu, et omavalitsusel on talle midagi pakkuda. Pigem saab ta teenuseid naabritelt ja tuttavatelt, kes aitavad teda transpordiga ja mõnede töödega majapidamises, mille eest Mati tasub neile kokkuleppel. Sotsiaaltransporti peab Mati liiga kulukaks, ehkki omavalitsus on valmis seda pakkuma.

Teekond 1: Kuna Mati on läinud pensionile enne vanaduspensioniga, siis PISTS toetuse kaotamise korral ta kõrgendatud määras töövõimetoetust ei saaks ning kaotaks enda sissetulekus 100 eurot kuus (variant 1). Mati peaks minema töövõime hindamisele, et tal oleks võimalus saada TRT-d (variant 2), kuid kuna ta saab pensioni, siis ta ei saa töövõimetoetust ning seetõttu on vähetõenäoline, et ta hindamisele läheb. Arvestades tema puudega seotud kulusid, oleks see talle märkimisväärne kaotus. Kuna vanaduspensioniealistele määratakse endiselt puudetoetust, siis mõne aasta pärast, jõudes vanaduspensioniealistele, saaks Mati uuesti toetust taotleda. Siiski on vanaduspensioniealistele makstav toetus oluliselt madalam (41 eurot kuus). Selline muudatus süvendab Matis ebaõigluse tunnet ja tekitab palju segadust.

Teekond 2: Otsene mõju majanduslikule toimetulekule puudub – eeldatavasti toetused säilivad samas mahus ja ulatuses. Mati ei ole teadlik, et ta võib taotleda töövõime hindamist (ilma toetuse maksmiseta), mis annaks talle parema ligipääsu teenustele. Seega jääb ta teenustest endiselt kõrvale.

Teekond 3: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse kaotamisel oleks oluline negatiivne mõju Mati sissetulekule (ta kaotaks 100 eurot kuus, 1200 eurot aastas). Kuna Mati on läinud pensionile enne vanaduspensioniga ning tema pension on madal, siis kasvaks tema vaesusrisk seetõttu märgatavalt. Kui Mati naabrite korduval soovitusel pöördub kohaliku omavalitsuse poole, määrab omavalitsus talle sissetulekust sõltuva toetuse ning pakub koduteenust.

Persoonad 5 ja 6. Tööealised isikud, kellel on vähenenud töövõime koos puude raskusastmega

PERSOONA 5:
Harri, 59,
töötu

Harri on 59-aastane puuduva töövõimega meesterahvas Harjumaalt. Lisaks puuduvale töövõimele on Harril tuvastatud ka raske intellektipuu. Harri sissetulekuks on töövõimetoetus (652,2 eurot) ja PISTS toetus (50 eurot), mis kokku on 702,2 eurot kuus. Harri on juba pikalt töötu, sest pole leidnud töökohta, mis vastaks tema võimetele ja oleks valmis kohanduma tema vajadustega. Ta töötas varem erinevates korteriühistutes koristajana. Igapäevaselt kasutab ta tegevusjuhendaja abi läbi toetatud elamise teenuse. Tegevusjuhendaja toetab ja juhendab teda erinevatest majapidamistoimingutes ning aitab planeerida igakuiseid kulusi. Pärast töötuks jäämist on Harril keeruline, sest puudub igapäevane mõtestatud tegevus. Ta käib küll päevakeskuses teistega suhtlemas, aga see ei paku Harrile eneseteostust piisaval määral, nagu seda tegi töö käimine. Harri elab koos elukaaslasega, kes küll praegu veel töötab, kuid hakkab samuti peagi pensionile suunduma. Seega on Harri ja tema elukaaslase toimetulekuks Harri töövõimetoetus ja puudetoetus väga olulised.

Harri on koolis omandanud vaid põhihariduse. Harri jaoks on erinevate taotluste tegemine väga keerukas ja tihti arusaamatu ning muudatused ja uued hindamised ei ole talle eriti meeltnööda ning ta vajaks selleks sisulist nõustamist ja tuge.

Teekond 1: Kuna Harril on tuvastatud nii raske puue kui ka puuduv töövõime, siis jätkuks Harril (vähemalt osaliselt) toetuse saamine ka toetuste integreerumise korral (variant 1). Samas sõltub täpsem mõju sellest, milline uus töövõimetoetuse variant rakenduks. Kui töövõimetoetus kasvaks ühtlaselt väiksemas määras kõigil töövõimetoetuse saajatel, siis Harri kaotaks sissetuleku, sest tema varasem puudetoetus (50 eurot kuus) oli kõrgem kui uus rakenduv töövõimetoetuse kasv (kaotaks 25,5 eurot kuus). Kui töövõimetoetus kasvaks vaid puuduva töövõimega inimestel, siis Harri sissetulek oluliselt ei muutuks (702,2 eurot kuus vs. 704,4 eurot kuus) või kõrgema päevamäära korral isegi kasvaks (750 euronit kuus). Kui töövõimetoetusele makstakse juurde TRT (variant 2), siis saab Harri puudega inimese toetuse asemel toetust töötukassalt, mis võib, sõltuvalt stsenaariumist, olla suurem või väiksem tema praegusest toetusest. Hindamine muutub Harri jaoks vähemkoormavaks ning korduvhindamisi ei tehta nii sageli, mis on Harrile ja tema elukaaslasele kergenduseks.

Teekond 2: Otsene mõju majanduslikule toimetulekule puudub – eeldatavasti toetused säilivad samas mahus ja ulatuses. Töövõime hindamise järgselt tehakse Harrile teenuste kava, tervisekeskuse tervisejuht hoiab sidet Harriga, tema tegevusjuhendajaga ning kaasab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja. Perearst pöörab rohkem tähelepanu ka Harri füüsilisele tervisele.

Teekond 3: PISTS toetuse asendamise korral abi- ja toetusvajaduse hindamisega kaotaks Harri oma praeguse PISTS toetuse, mis on 50 eurot kuus. Kohalik omavalitsus on kimpus, kuna seal puuduvad pädevused lisateenuste pakkumiseks intellektihäirega inimesele.

PERSOONA 6:
Katrín, 50,
kodune
pereema

Katrín on 50-aastane pereema. Katrínil on mitu erinevat kroonilist haigust. Seetõttu on Katrínile määratud nii puuduv töövõime töötukassas kui ka keskmine puue SKA-s. Tema toetused kuus kokku on 689,2 eurot (töövõimetoetus 652,2 eurot, PISTS toetus muu funktsiooni kõrvalekalde korral 37 eurot kuus). Kuigi Katrín on rõõmsameelne, siis igapäevased pearinglused, halb enesetunne, kroonilised valud segavad ka lihtsamaid igapäevatoimetusi nagu koristamine või söögitegemine. Katrín tahab väga teha kasvõi osajaga tööd, aga kui ta kuhugi kandideerib, siis tööandjad ei ole eriti vastutulelikud osajaga töö pakkumisel.

Praegu Katrín ei tööta, kuid varem on ta siiski väikse koormusega olnud hõivatud lihttöölisena teenindussektoris. Katrín elab koos elukaaslase ja kooliealise lapsega. Praegu sõltubki nende pere elukaaslase sissetulekust ja Katrini puudetoetusest ning töövõimetoetusest. Seega on neile iga euro oluline ja puudetoetusest ilma jäämine võib nende majandusliku olukorra väga kehvaks muuta.

Teekond 1: Kuna Katrínil on määratud puuduv töövõime, siis rakenduks talle kõrgendatud töövõimetoetus kõikide variant 1 stsenaariumite korral. Siiski, kui töövõimetoetus kasvaks ühtlaselt väiksemas määras kõigil töövõimetoetuse saajatel, siis Katrín kaotaks sissetulekus, sest tema varasem puudetoetus (37 eurot kuus) oli kõrgem kui uus rakenduv töövõimetoetuse kasv (25,5 eurot kuus). Kui töövõimetoetus kasvaks vaid puuduva töövõimega inimestel, siis Katrini sissetulek kasvaks (689,2 eurot kuus vs. 704,4/750 eurot kuus olenevalt päevamäärast uuest astmest). Kui töötukassa hakkab maksma TRT (variant 2), tõuseb Katrini toetuse summa mõnevõrra eeldusel, et tal on tuvastatud raske piirang (uue toetuse suurus olenevalt stsenaariumist 50-130 eurot kuus).

Teekond 2: Otsene mõju majanduslikule toimetulekule puudub – eeldatavasti toetused säilivad samas mahus ja ulatuses. Töövõime hindamisel suunab tervisejuht Katrini rehabilitatsiooniteenusele ning jälgib rehabilitatsioonitegevuste tulemuslikkust. Katrín on perearsti jälgimisel ning koostöös tervisejuhiga kohandatakse vajadusel tema rehabilitatsioonitegevusi. Rehabilitatsiooni tulemusel paranevad ka töötamise perspektiivid ning Katrín saab üle pika aja osaleda tööturuteenustel.

Teekond 3: PISTS toetuse asendamise korral abi- ja toetusvajaduse hindamisega kaotaks Katrín oma praeguse PISTS toetuse, mis on 37 eurot kuus. Kohalik omavalituse hindab Katrini teenustevajadust, kuid omavalitsuse teenused Katrínile ei sobi, ta vajab eeskätt rehabiliteerivaid tervishoiuteenuseid.

Persoonad 7 ja 8. Tööealised isikud, kellel on püsiv töövõimetus (koos ja ilma puude raskusastmeta)

PERSOONA 7:
Jüri, 60, elab
hooldekodus

Jürile määrati saajaprotsendiline töövõime kaotus rohkem kui 20 aastat tagasi kuni vanaduspensionieani. Jüri ei tule iseseisvalt toime, sest vajab suures mahus hooldust. Seetõttu elab ta hooldekodus juba rohkem kui kümme aastat. Talle ei ole määratud eestkostet ning ta peab ise esitama hindamistaotlused. Jüri on juba pensionieale lähenev mees ning ei soovi suuri muutuseid. Keegi ei ole soovitanud tal töövõime hindamiseks töötukassasse pöörduda. Jüri on oma probleemide ja vajaduste osas pöördunud üksnes SKA poole ning on valmis taotlema üksnes puude tuvastamist (toetus sügava puude korral 100 eurot kuus). Teda abistab selles hooldekodu töötaja.

Kuna Jüri lähedased puuduvad ja tööd tal enam võimalik teha ei ole, siis on tema toimetulek väga kehv ja vaesusrisk suur. Töövõimetuspension ja puudetoetus kuluvad hooldekodu kohatasuks ja igapäevakuludeks – hügieenitarbed, riided ja hooldekodus kasutatavad abivahendid.

Teekond 1: Kui puudega tööealise inimese toetus integreeritakse töövõimetoetusesse või lisandub TRT ja puuet enam ei tuvastata, siis kaotaks Jüri oma praeguse puudetoetuse (100 eurot kuus), sest Jüri saab töövõimetuspensioni ning samaaegselt töövõimetoetust ja töövõimetuspensioni saada ei ole võimalik. Toetuse jätkumiseks peaks Jüri nüüd siiski läbima töövõime hindamise. Positiivse otsuse korral hakkaks Jüri saada kõrgendatud töövõimetoetust või töövõimetoetust ja TRT, mille tulemusena võib tema sissetulek olla varasemast suurem. Samas kuna Jüri on peagi pensionieas ning peale seda lõppeks tal õigus ka töövõimetoetusele, siis on motivatsioon süsteemi vahetada ja uut hindamist läbida väike.

Teekond 2: Otsene mõju majanduslikule toimetulekule puudub – eeldatavasti toetused säilivad samas mahus ja ulatuses.

Teekond 3: PISTS toetuse asendamise korral abi- ja toetusvajaduse hindamisega kaotaks Jüri oma praeguse PISTS toetuse, mis on 100 eurot kuus. Kuna Jüri elab hooldekodus, siis kohalik omavalitsus jätkab sama teenusega.

PERSOONA 8:
Aare, 58,
kodune
töövõimetus-
pensionär

Aarel on püsiv töövõimekaotuse protsent määratud kuni vanaduspensionieani ning sügav puue. Aarel on psüühiline erivajadus, mistõttu on tal raskusi teiste inimestega suhtlemisel. Pärast abikaasa surma on Aare jäänud väga kodukeskseks. Talle on soovitatud SKA poole pöörduda, et taotleda igapäevaelu toetamise teenust, et Aarel tekiks tahe ja motivatsioon kodust välja käia ja eakaaslastega suhelda. Ta ei soovi minna töötukassasse töövõime hindamisele, isegi kui tema töövõimetoetus oleks praegusest töövõimetuspensionist suurem, sest tal on varasemaid negatiivseid kogemusi riigiasutustega. Ta ei soovi muudatusi ja pelgab võimalikke töötukassa sunnimeetmeid. Kuna Aarel on vaid põhiharidus ning erivajadus, siis arvab ta, et sobiva töö leidmine on nageni keerukas.

Aare elab üksi, seega tuleb ta vaevu oma töövõimetuse ja puudest tingitud toetustega toime. Selles osas suhtleb Aare peamiselt kohaliku omavalitsusega, kust taotleb lisaks ka toimetulekutoetust. Kohalik omavalitsus on teenuste pakkumisel üldiselt passiivne, kuid on aidanud küttepuude hankimise ja ladumisega.

Teekond 1: *Mõju sarnane Jüriga (vt persoona 7).*

Teekond 2: *Otsene mõju majanduslikule toimetulekule puudub – eeldatavasti toetused säilivad samas mahus ja ulatuses.*

Teekond 3: *PISTS toetuse asendamise korral abi- ja toetusvajaduse hindamisega kaotaks Jüri oma praeguse PISTS toetuse, mis on 100 eurot kuus.*

13. Terviklahendused

Selles peatükis pakume välja terviklahendused täisealiste puudega inimeste toetamise süsteemiks. Riigikontroll on probleemidena välja toonud olukorra, kus esmalt puudub loogiline abi andmise terviklik teekond ning abi saamine on seetõttu keeruline, ja teiseks on kaks sarnast hindamise süsteemi. Tänapäevases süsteemis hinnatakse pigem seda, kas inimese olukord on vastavuses toetuse või teenuse saamise tingimustega ega sihita inimesele pakutavat tuge vajadustele vastavamaks. Puuetega inimesed töid töötubades samuti välja abi saamise keerukuse, lisaks metoodika arusaamatuse ja hindamisotsuste vähese põhjendatuse, infopuuduse, kuidas oma olukorda parandada ning teenuste vähesuse. Uuringus on käsitletud ka puuetega inimeste kõrgemat vaesusriski võrreldes koguelanikkonnaga. Süsteemi muutmise eesmärgiks peaks olema liikumine inimõiguste mudeli suunas.

Terviklahendused⁴⁸ on välja töötatud lähtuvalt kolmest eesmärgist:

- A) Luua lihtsam süsteem puuetega inimeste toetamiseks praeguse eelarve piires.
- B) Luua lihtsam süsteem, mis pakub puuetega inimestele paremat majanduslikku toimetulekut.
- C) Luua süsteem, mis toetab teenuste kättesaadavust.

Kokkuvõtte lahendustest on toodud tabelis 43.

Tabel 43. Terviklahendused

	Lahendus A	Lahendus B	Lahendus C
Kirjeldus raportis	Teekond 1 sts 2a	Teekond 1 sts 2c	Teekond 3
Eesmärk	Süsteemi lihtsustamine	Parem majanduslik toimetulek	Parem teenuste kättesaadavus
Kulud toetustele	Ei kasva	Kasvavad	Kasvavad
Tööjõukulud	Vähenevad	Vähenevad	Kasvavad
Arenduskulud	Täiendavad suured ühekordsed kulud	Täiendavad suured ühekordsed kulud	Ei muutu
Mõju vaesusele	Ei muutu	Vaesus väheneb	Vaesus suureneb

Allikas: Autorite koostatud.

13.1. Lahendus A – puuetega inimeste toetamise süsteemi lihtsustamine

Selle lahenduse eesmärgiks on lihtsustada olemasolevat süsteemi. Tööealisi hindab ainult töötukassa, kes maksab ka neile suunatud toetusi. Lahendusega vähendatakse

⁴⁸ Terviklahenduses on esitatud analüüsitud toetuste stsenaariumidest need, mis uuringu autorite hinnangul enam jäävad praeguse eelarve piiresse või toetavad enam puudega inimeste majanduslikku toimetulekut.

administratiivset keerukust, tagatakse sujuv üleminek tööealiste ja vanaduspensioniealiste toetuse maksmisel ning vähendatakse hindamiste arvu.

Raske ja täieliku tegutsemispiiranguga inimestele makstakse lisaks töövõimetoetusele tegutsemispiiranguga inimese toetust, mida ei indekseerita. Toetuse maksmine lähtub eeldusest, et suuremate piirangutega kaasnevad kulud, mida ilma piiranguteta või väiksemate piirangutega inimestel ei ole või on väiksemal määral (nt on uuringute järgi ka tervishoiule tehtud kulud nii tegevuspiirangutega kui tänaste puuetega inimeste seas suuremad kui teistel leibkondadel, vtk ptk 7). Nende kulude osaline katmine aitab piirangutega inimestel osaleda teistega võrdsemalt ühiskonnaelus. Inimesel on vaba voli otsustada, milliste kulude katmiseks toetust kasutada. Toetuse suurus on 55€ raske ja täieliku tegutsemispiiranguga puuduva töövõimega inimestele ning 35€ raske ja täieliku tegutsemispiiranguga osalise töövõimega inimestele. Vanaduspensionieas jätkub kaheastmeline toetuse süsteem: 20€ makstakse raske tegutsemispiiranguga inimestele ning 41€ täieliku tegutsemispiiranguga inimestele (stsenaarium 2a).

Muutub üleminek tööeast vanaduspensioniiikka: tegutsemispiiranguga inimese toetuse määramine sarnase metoodika alusel võimaldab vältida uut kohustuslikku hindamist vanaduspensioniiikka jõudes. Üleminek võib toimuda kahel viisil:

- 1) Kui tööealisel inimesel on hinnatud vähenenud töövõime ja talle makstakse TRT-d, teeb SKA vanaduspensioniea saabumisel tähtajatu toetuse määramise otsuse vastavalt tegutsemispiirangu raskusastmele. Vanaduspensioniea saabumise järel on kõikidel õigus taotleda korduvhindamist, tegutsemispiirangu ulatuse tuvastab ja toetuse määrab SKA. SKA hindab ka neid inimesi, kes taotleavad toetust esmakordselt vanaduspensionieas.
- 2) Töövõime hindamisel töötukassa prognoosib osalise või puuduva töövõime kestust ning ei piira kestuse tähtaega vanaduspensionieaga. Vanaduspensioniea saabudes teeb SKA hindamise andmete alusel toetuse määramise otsuse kuni hindamisperioodi lõpuni. Edasi jätkub tegutsemispiirangu hindamine ja toetuse maksmine SKA-s. Muutumatute või progresseeruva prognoosiga töövõimet välistavate seisundite korral teeb SKA toetuse määramise otsuse tähtajatult (s.o eluaegselt).

Selleks, et vähendada inimese ja asutuste hindamiskoormust, soovitame koostada tingimused muutumatutest ehk püsivatest seisunditest, mille esinemisel on korduvhindamiste tähtajad pikemad (nt 10 aastat) või tehakse hindamisotsus tähtajatult. Samuti soovitame kaaluda vanaduspensionieas proaktiivse hindamise rakendamist, mille puhul ei pea inimene esitama korduvhindamiseks taotlust, vaid asutus algatab korduvhindamise proaktiivselt ainult terviseandmete alusel. Kui terviseandmed ei ole muutunud, võib jätkuda toetuse saamise õigus varasemate andmete alusel.

Puuetega inimeste õiguste konventsioon ega teised rahvusvahelised aktid ei eelda puuetega inimestele toetuste maksmiseks laia tähendusega puuetega inimeste õigusliku termini kehtestamist. Konventsioon kohaldub inimestele, kelle ühiskonnaelus osalemine võib olla tervisepiirangute tõttu takistatud. Riik peab nendele inimestele tagama inimväärikuse, sotsiaalse kaasatuse ning võrdse ligipääsu tervishoiule, haridusele ja tööle. Puude õigusliku mõiste defineerimisel saab lähtuda praktilisest vajadusest kehtestada näiteks toetuse saajate ring, s.o täieliku ja raske tegutsemispiirangutega inimesed, kellel on eeldatavalt piirangutest tulenevad lisakulud ning võtta toetuse saamise vajadus aluseks ka näiteks erinevate valdkondade hüvede saamisel. Abivajaduse korral ei tohi inimene abita jääda ka siis kui ta ei saa toetust.

Lahenduse A mõjud

Alljärgnevalt on toodud välja lahenduse mõjud, võttes aluseks HÖNTE metoodika.

Tervishoiukorraldus

Lahendus puudutab tervishoiukorraldust vähesel määral. Vähem korduvhindamisi vanaduspensionieas võib mõnel määral vähendada arstivisiitide arvu ja eriarstide koormust. Muudatusega ei muudeta töövõime hindamise metoodikat. Ekspertarstide töökoormust ei mõjuta oluliselt ka see, et potentsiaalselt võib töövõime hindamise taotlejate arv kasvada nende inimeste arvelt, kellel on tänases süsteemis tuvastatud üksnes puude raskusaste (ligikaudu 200 inimest). Kuna andmete järgi on suurem osa neist pensioni saajad, siis eeldatavalt lisandub töövõime hindamise taotlejaid nende hulgast vähe. Samas võib enne vanaduspensioniea saabumist tekkida mõõdukas korduv- või esmahindamiste taotluste tõus.

Tervis

Kuivõrd süsteemi ümberkorraldamine ei paranda tegelikku juurdepääsu tervist toetavatele teenustele (rehabilitatsioon, psühholoogiline tugi, abivahendid), ei ole süsteemi muutmisel eeldatavalt mõju inimeste tervisele. Töövõime hindamise töö- ja sissetulekukeskus võib jätta vähem tähelepanu nendele terviseaspektidele, mis ei ole otseselt seotud tööturul osalemisega, kuid on olulised igapäevase toimetuleku ja ühiskonnaelus osalemise perspektiivist. Kui süsteem muutub inimese jaoks lihtsamaks ning hindamine on vähem killustatud, võib väheneda stress ja ebakindlus, mis toetab puudega/vähenenud töövõimega inimeste vaimset tervist.

Heaolu

Töötubades osalejad tõid esile, et puude mõiste sidumine töövõime mõistega võib kitsendada arusaama puudest liialt tööturukeskseks. See võib tingida olukorra, kus tähelepanuta jäävad

abivajadused, mis ei ole otseselt seotud tööturul osalemisega, kuid on inimese heaolu perspektiivist olulised (nt toetavad iseseisvust ja osalemist kogukonna- või kultuurielus).

Hindamine sõltub endiselt suuresti TIS-i andmekvaliteedist. Muudatus ei lahenda hindamismetoodika põhiprobleeme, millele puuetega inimeste esindusorganisatsioonid on varem tähelepanu juhtinud (näiteks, et metoodika ei kirjelda piisavalt inimese tegelikku abivajadust igapäevases elus osalemiseks).

Praeguste sügava puudega inimeste toetuse suurus väheneb eeldatavalt puuduva töövõimega tööelistel inimestel 45 euro võrra kuus ning osalise töövõimega inimestel 65 euro võrra kuus. Toetuse kaotavad mõõdukate piirangutega tööelised ja vanaduspensioniealised inimesed. See mõjutab negatiivselt inimeste igapäevast toimetulekut võimalusi tasuda piiranguid kompenseerivate teenuste eest. Lahendusega saaksid suurema toetuse keskmise puudega inimesed, kellel on raske või täielik piirang.

Sihtrühma muutus mõjutab teenuste, sh sotsiaalteenuste kättesaadavust. Kui sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kättesaadavus tööeliste seas laieneb tänastelt puude raskusastmega inimestelt vähenenud töövõimega inimestele, siis suureneb kokkuvõttes teenuse sihtrühm ligikaudu kaks korda (47 tuhat vs. 98 tuhat⁴⁹). Samas sügava puudega täisealise inimese hooldamiseks ettenähtud puhkuse seostamine puude asemel täieliku piiranguga võib selle hüve saajate ringi vähendada (3940 sügava puudega tööelist vs. 2066 täieliku piiranguga tööelist inimest) (vt kulusid ka Lisa 6).

Tööturg ja tööhõive

Süsteem ei toeta otseselt paremat tööturul osalemist. Ka täna osutab töötukassa vähenenud töövõimega inimestele ja tervisepiirangutega inimestele erinevaid tööturuteenuseid. Seega võib eeldada, et ptk-s 7 esitatud tööhõive määr tänaste puuetega inimeste seas muudatuse tulemusena ei muutu.

Sooline võrdõiguslikkus

Muudatus ei panusta soolise võrdõiguslikkuse parandamisesse. Kaudselt mõjutab muudatus mehi ja naise erineval määral, olenevalt sellest, kui suure osa vastavast sihtrühmast moodustavad. Näiteks on tööeliste puude raskusastmega inimeste seas mehi 54%, kuid vähenenud töövõimega inimeste seas 48%. Seevastu aga vanaduspensioniealiste puuetega inimeste seas on enam naisi (meeste osakaal 32%).

⁴⁹ Praeguse sihtrühma suuruse arvutamisel on tuginetud EUROMOD 2024. aasta andmestikule ja järgnevatele eeldustele: puude raskusastmega või vähenenud töövõimega inimeste arv, kes ei tööta (ei ole saanud aasta jooksul töist tulu), ei õpi, ei ole olnud aasta jooksul töötuna registreeritud ning puuduva töövõimega inimesed olenemata aktiivsusest (kokku 47389 inimest). Nii praeguse kui tuleviku lahenduse sihtrühm hõlmab teenuse saajaid/inimeste arvusid aasta jooksul.

Võrdsed võimalused

Puudega inimese kaardi ja vähenenud töövõime kaardi ühendamine muudab hüved ühtsemaks eeldusel, et kaardil tuuakse ka edaspidi välja nt liikumis- või nägemispiirangud. Inimene ei pea enam kaasas kandma kahte kaarti ega meeles pidama, kumb kaart millises olukorras kehtib. See võib parandada kultuuri- ja spordiürituste kättesaadavust, sõltuvalt sellest, millistel tingimustel ja kellele soodsamatel tingimustel hüvesid osutatakse.

Vanemaealistel inimestel muutub toetuse taotlemine vähem koormavaks ning sarnaselt tööealistega piirangust lähtuvaks (TRT). Samas on toetuse suurused väiksemad kui tööeas ning see võib tekitada sarnaselt tänasele küsimusi, miks on TRT suurused erinevad olenevalt sellest, kas seda makstakse tööeas või vanaduspensionieas.

Hetkel kehtiva süsteemi korral on puude raskusastmega inimestel võimalik saada puudega inimestele suunatud õigusabi. 2024. aastal kasutas seda võimalust 938 inimest. Kui teenus laiendada tööealiste seas vähenenud töövõimega inimestele, siis kasvab sihtrühma suurus pea 55 tuhande inimese võrra (vt muutusi kuluhinnangutes ka Lisa 6).

Piirkondlik ebavõrdsus

Süsteemi muutmine ei panusta otseselt piirkondliku ebavõrdsuse parandamisse. Siiski võib poliitikamuudatus avaldada mõju praegu puude raskusastmega seotud teenuste kättesaadavusele. Näiteks kehtib riigisiselisel liiniveol tasuta sõidu õigus sügava puudega täisealistele ning sügava ja raske nägemispuudega täisealistele ja nende saatjatele. Tööealiste ja vanaduspensioniealiste seas puudutab see kokku 19 304 inimest (arvestatud ka saatjad). Kui muudatuse järgselt enam puuet ei tuvastata ning tasuta sõidu õiguse määramisel lähtutakse piirangutest, siis hinnanguliste arvutuste kohaselt võib sihtrühma suurus tulevikus ulatuda 62 tuhande inimeseni (täpne info piirangute kohta puudub, arvutustes lähtuti puude raskusastmest, töövõime ulatusest, puude liigist) (vt ka Lisa 6).

Töötubades osalejad tõid riskikohana välja, et sotsiaalteenuste, nt isikliku abistaja teenuse lahti sidumine puude raskusastmest võib vähendada nende kättesaadavust. Kuigi ka täna ei peaks KOV teenuste osutamine olenema sellest, kas PISTS alusel on tuvastatud inimesel puue või mitte, siis praktikas määratlevad KOV-id puude raskusastme otsuse olemasolu ühe teenuse saamise või omaosaluse vähendamise tingimusena. Näiteks: Anija vallas on koduteenuse⁵⁰ omaosalusest osaliselt/täielikult vabastatud puudega psüühilise erivajadusega inimesed. Lääne-Nigula vallas on aga täisealise isiku hooldaja määramisel⁵¹ seatud tingimus, et hooldatav peab olema raske või sügava puudega.

⁵⁰ <https://www.riigiteataja.ee/akt/421052025012>

⁵¹ <https://www.riigiteataja.ee/akt/424052024012>

Lahenduseks ei ole määratleda SHS-s saajate ring konkreetse töövõime ulatuse või tegevuspiiranguga inimese toetuse saamisega, sest laiem riigi eesmärk on, et KOV-id osutaksid teenuseid lähtuvalt inimese abivajadusest, mitte konkreetsest sildist. Seetõttu suureneb eeldatavalt KOV-de otsustusõigus teenuste pakkumisel, kui enam puude raskusastet ei tuvastata. Kui KOV-d kasutavad laialdasemalt abivajaduse hindamist ning pakuvad sellele tuginedes teenuseid, võib eeldada teenuste kättesaadavuse paranemist. Teisalt on puuetega inimeste esindusorganisatsioonid toonud välja, et paljudel KOV-del ei ole piisavat võimekust ega valmisolekut teenuseid osutada. Seetõttu pakutakse sageli vaid neid teenuseid, mis on otseselt seotud puude (raskusastme) olemasoluga. Puude raskusastme tuvastamine annab inimesele kindluse, et ta saab abi isegi siis, kui sotsiaaltöötaja ei pea teenust vajalikuks. Kui teenused ei ole enam seotud puude olemasoluga ja teenuse vajadus sõltub ainult sotsiaaltöötaja hinnangust, võib teenuste kättesaadavus halveneda.

Majandus

Kuivõrd otseselt ei toetata tööturul osalemise suurendamist, siis ei suurene eeldatavalt ka sihtrühmas töise tulu saamine ja seeläbi ei mõjuta lahendus tarbimiskäitumist.

Osade tänaste puuetega inimeste majanduslik toimetulek võib halveneda (need, kes ei saaks tegevuspiiranguga inimese toetust või saaksid seda võrreldes praegusega vähem) ning see vähendab nii nende osalemist ühiskonnaelus kui ka mõjutab negatiivselt nende tarbimisotsuseid. Lähtudes ptk-s 7 kirjeldatust, ei vähene sundkulutuste osakaal tarbimiskuludest ning endiselt on vaja meetmeid, mis aitaksid katta ka teenuste omaosalust: kui tegevuspiirangutega inimese toetus on 35 eurot, siis sellest üksi ei piisa, et katta nii ravimite, transpordi kui muude vahendite või teenuste kulu. Mõju vaesusele on kirjeldatud eraldi (vt Mõju vaesusele ja riigi kuludele).

Haridus

Süsteemi muutmine ei panusta hariduse kättesaadavuse parandamisse. Muudatus ei lahenda tugispetsialistide nappust ega hariduse ligipääsetavuse probleeme (füüsiline ja vaimne ligipääsetavus, tugiteenuste järjepidevus).

Kui puuet enam ei tuvastata, siis avaldab see mõju puuetega inimestele suunatud hariduslike toetuste ja meetmete kättesaadavusele. 2024. aastal sai erivajadusega üliõpilase stipendiumi 170 inimest ja täienduskoolitustoetust 44 puude raskusastmega inimest. Õppetoetust ja välisstipendiumi ei saanud. Kuna koolitusvõimalused on kättesaadavad ka töötukassa kaudu, siis uue süsteemi korral seda eraldi enam ei pakuta. Samuti lõpetatakse õppetoetuse maksmine, sest selle kasutajate arv on väike või puudub. Erivajadusega üliõpilase stipendiumi maksmine seotakse töövõime ja piirangutega. Detailset mõju sihtrühmale ei ole siin kahjuks võimalik hinnata. Üldiselt võib siiski eeldada sihtrühma suurenemist, sest

keskmise, raske ja sügava puudega täisealisi inimesi, kes omandavad kõrgharidust oli 2024. aastal 423, kuid vähenenud töövõimega kõrgharidust omandavaid isikuid 1795 (vt ka Lisa 6).

Kultuur

Hüvede sidumine töövõime ja tegevuspiirangutega ning ühine kaart võivad lihtsustada ligipääsu kultuuriteenustele (riigimuseumide külastus, soodustused kultuuriüritustel).

Muudatus ei muuda kultuuritaristu ligipääsetavust ega kultuuriruumi hoiakuid puuetega inimeste suhtes. Kui KOV-ide ja riigi tasandil ei panustata süsteemselt ligipääsetavusse (transport, füüsiline keskkond, info kättesaadavus), jäävad kultuuriosalust piiravad barjäärid püsima olenemata hindamissüsteemi ümberkorraldamisest.

Sügava puudega inimesed ja nende saatjad saavad täna külastada riigimuseume tasuta. Kultuuriministeeriumi andmete ja Statistikaameti info järgi kasutati seda võimalust 2024. aastal 13 286 korral. 2024. aastal oli eeldatav sihtrühma suurus 11 602 (3940 tööelist ja 7662 sügava puudega inimest). Kui siduda hüve tööelistel puuduva töövõimega, siis suureneks sihtrühm oluliselt (38 590 puuduva töövõimega inimest). Samas seostades hüve täieliku piiranguga, siis sihtrühm tööeliste seas väheneks (2066 täieliku piiranguga tööelist) (vt ka Lisa 6).

Infotehnoloogia

IT arenduste vajadus on kirjeldatud sotsiaalmajanduslike kulude alapeatükis. Üks hindamine töötukassas lõpetab ära paralleelsete IT arenduste tegemise vajaduse kahes asutuses ning hoiab tulevikus seeläbi kokku arenduskulusid.

Siseturvalisus

Mõned töötubades osalejad pidasid oluliseks „puude silti“ kui identiteedi ja huvikaitse tööriista. Puude raskusastme tuvastamise lõpetamine võib osale sihtrühmast mõjuda kui nende kogemuse ja identiteedi tühistamisena. See võib suurendada pahameelt ja usaldamatust riigi suhtes ning süvendada tunnet, et puuetega inimeste probleemid taandatakse üksnes töövõime küsimuseks. Täpset mõju ulatust on keeruline hinnata.

Kui süsteem toob kaasa suure ootuse muutuseks, kuid igapäevane kogemus (pikk ooteaeg, vähesed teenused, keeruline suhtlus) ei parane või halveneb, võib see suurendada frustratsiooni ja usaldamatust riigi vastu.

Riigivalitsemine

SKA roll tööeliste inimeste puude raskusastme tuvastamisel lõpeb, mis vähendab nende töökoormust ning võimaldab keskenduda paremini teistele sihtrühmadele (nt

vanaduspensioniealised). Inimeste endi hindamiskoormust see lahendus ei muuda, sest ka praegu on võimalik esitada töövõime tuvastamise ja puude raskusastme tuvastamise taotlus ühistaotlusena, millel on sama andmekoosseis.

Uue metoodikaga ei teki paralleelsete otsuste vastuolu (puude raskusaste vs töövõime), mistõttu võib väheneda vaiete arv. Teiselt poolt võib vaiete arv suureneda mõõduka tegutsemispiiranguga inimeste arvelt, kes hakkavad saama ainult töövõimetoetust. Võib eeldada, et vähemalt muudatuse alguses on vaja töötukassal, kuid ka SKA-l suurendada kommunikatsiooni ning jagada selgitusi ja teavet, kellele edaspidi toetust võidakse määrata.

Süsteemi muutmisega kaasneb suure hulga õigusaktide muutmine, mis toob kaasa ajutise töökoormuse riigiasutustele tervikuna (eelkõige on mõjutatud sotsiaalministeerium, kuid ka erinevate hüvede valdkondade vastutavad ministeeriumid).

Kohalikud omavalitsused

KOV-de roll ja ülesanded ei muutu. KOV-de halduskoormus võib suureneda, kui praegused puude raskusastmega seotud teenused (täisealise isiku hooldus ja isiklik abistaja) seotakse lahti ning teenusevajaduse tuleb siduda abivajaduse hinnangu tulemustega. KOV-de teenused ja toetused on praegu sageli seotud puude raskusastmega. Kui puude raskusastet enam ei tuvastata, peavad KOV-d oma toetuste ja teenuste süsteemi ümber korraldama, mis toob lisaks kaasa ajutise halduskoormuse kasvu ning võib halvendada üleminekuperioodil teenuste pakkumise sujuvust.

Riigikaitse

Olulist otsest mõju riigikaitse korraldusele ja riigikaitseleisele võimekusele ei ole. Mõju võib ilmnedagi vaid kaudselt, kui sotsiaalsüsteem ei toeta piisavalt inimeste toimetulekut ja tervist ning inimeste usaldus riigi vastu seetõttu muutub hapramaks.

Mõju vaesusele ja riigi kuludele

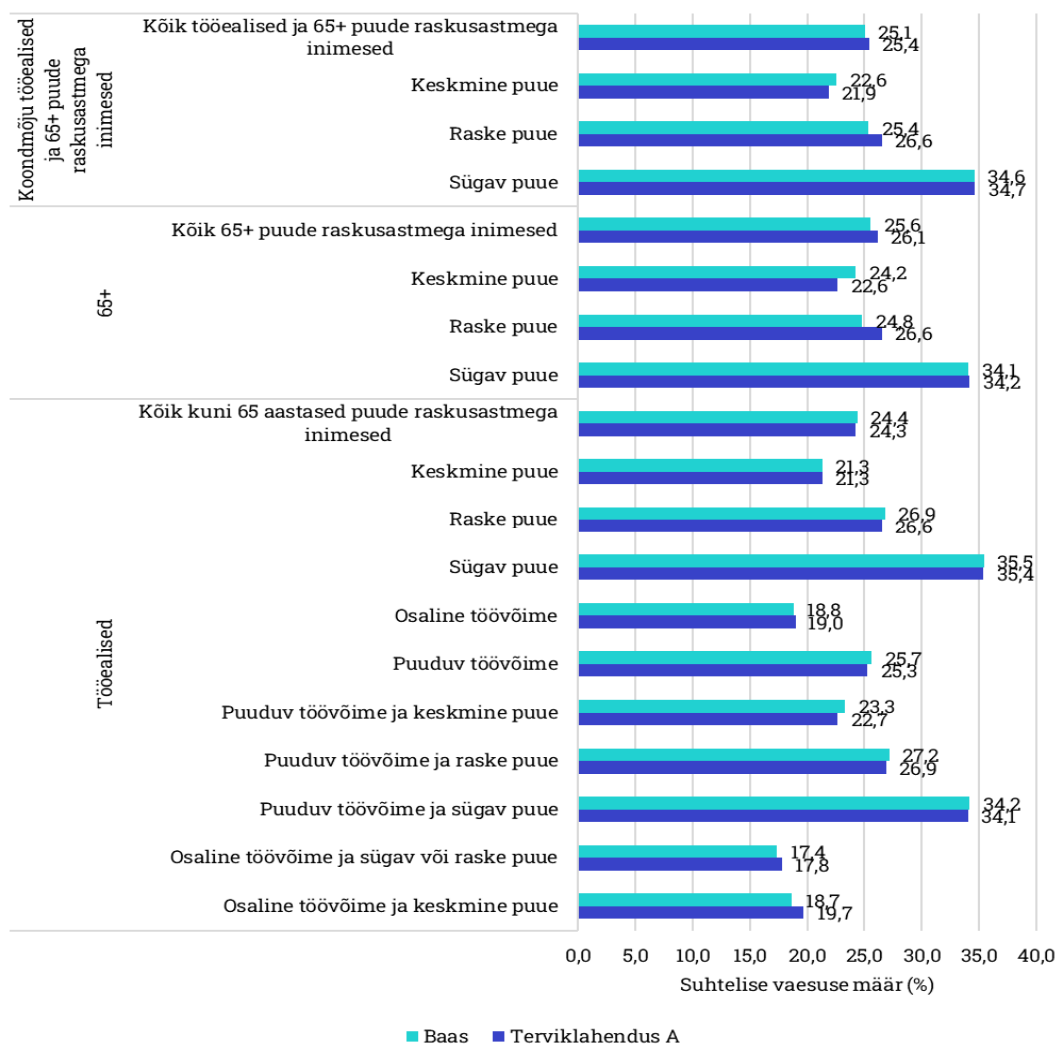
Lahendus A korral riigi kulud toetustele oluliselt ei muutu. EUROMOD hinnangu kohaselt kulud toetustele isegi väheneksid (ligikaudu 760 tuhat eurot). Samuti võib eeldada kokkuhoidu hindamistelt ja administratiivkuludelt, sest toetusvajadust hinnatakse ja toetusi makstakse ühest asutusest. Kui võtta aluseks 2024. aastal SKA kulud puudega seotud hindamistele ja taotluste menetlemisele, siis oleks aastane kulude kokkuhoid ligikaudu 315 tuhat eurot (detailsem arvutuskäik tööealiste ja vanaduspensioniealiste kohta leitav peatükis, mis kirjeldab teekond 1 mõju riigi kuludele ja vaesusele). Siiski vajaks mõlema sihtrühma puhul TRT loomine täiendavaid ühekordseid suuri kulusid IT arendustele nii töötukassas (tööealiste lahendus) kui ka SKA-s (vanaduspensioniealised), mis hinnanguliselt võivad ulatuda 250 tuhande euronni asutuse kohta.

Tabel 44. Tööjõukulud ja nende muutus baasstsenaariumi ja Lahendus A korral, eurodes

Kulu liik	Tööealised		Vanaduspensioniealised		Tööealised ja vanaduspensioniealised kokku	
	Baas	Lahendus A	Baas	Lahendus A	Baas	Lahendus A
Sotsiaalkindlustusameti kulud puudega seotud hindamistele ja taotluste menetlemisele, eurot	320 168,9	0	375 354,2	375 354,2	695 523,11	375 354,2
Töötukassa kulud töövõimetoetuse menetlemisele, eurot	793 729,0	798 404,0	0	0	793 729,0	798 404,0
Kulud kokku, eurot	1 113 897,9	798 404,0	375 354,2	375 354,2	1 489 252,1	1 173 758,2
Kulude muutus, eurot		-315 493,8		0		-315 493,8

Allikas: autorite arvutused Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Töötukassa statistika põhjal.

Joonis 39. Puude raskusastmega ja vähenenud töövõimega inimeste suhtelise vaesuse määr puuetega inimeste sotsiaaltoetuse süsteemi lihtsustamisel



Allikas: autorite arvutused EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal.

Märkused: vaesuse määra arvutamiseks on leibkonna kogu netosissetulek simuleeritud (sh maksuarvestus) EUROMOD-iga tuginedes 2024. aasta andmetele ja viidud hinnaindekseid arvesse võttes 2025. aasta väärtustesse.

Mõju suhtelisele vaesusele on samuti väga väike. Kõikide tööealiste ja 65+ puude raskusastmega inimeste seas kasvaks suhtelise vaesuse määr 25,1%-lt 25,4%-ni. Kui vaadata mõju eraldi tööealiste ja vanaduspensioniealiste seas, siis on hinnangud sarnased sellele, mis on esitatud teekond 1 analüüsis STS 2a juures. Vanaduspensioniealiste seas kasvab suhtelise vaesuse määr nende seas, kellel on raske puue ja väheneb nende seas, kellel on keskmine puue. Tööealiste inimeste seas on muutused minimaalsed. Veidi enam kasvab suhteline vaesus nende seas, kellel on osaline töövõime ja puue samaaegselt. Siiski tuleb siin arvestada, et EUROMODis ei ole informatsiooni tegutsemispiirangute kohta ja seega on tehtud täiendavad eeldused puude raskusastme põhjal. Samuti tuleb pidada meeles, et suhtelise vaesuse määr tugineb leibkonna sissetulekutele ja kui leibkonnas on mitu puude raskusastmega inimest, siis mõjutab leibkonna vaesusriski nende mõlema toetuse muutus samaaegselt.

Kulude muutused puudega seotud hüvede ümberkorraldamiseks on leitavad peatükis Lisa 6.

13.2. Lahendus B – süsteemi lihtsustamine ja puuetega inimeste majandusliku toimetuleku parandamine

Lahenduse eesmärk on lihtsustada süsteemi, tagada puuetega inimeste majandusliku toimetuleku paranemine ja vaesuse vähenemine. Lahendus on sarnane lahendusega A, kuid lisaks tõstetakse puudega tööealiste inimestele makstavat toetusi nii, et töövõimetoetus ja TRT koos vastaksid võetud rahvusvahelistele kohustustele. Toetused vähendaksid inimeste sissetulekute arvelt tehtavaid puudest tingitud lisakulutusi ja jätaksid inimestele rohkem raha igapäevaste kulutuste katteks. Toetussummad oleksid praegusest enam vastavuses inimeste tegelike lisakuludega. Toetuste suurused on raske ja täieliku tegutsemispiirangu korral 130€ puuduva töövõimega inimestele ning 70€ osalise töövõimega inimestele. Vanaduspensionieas jätkub kaheastmeline toetuse süsteem: 70€ makstakse raske tegutsemispiiranguga inimestele ning 130€ täieliku tegutsemispiiranguga inimestele (stsenaariumid 2c).

Lahenduse B mõjud

Kuivõrd lahendus on sarnane lahendusega A, siis ei kirjelda mõju erinevates valdkondades uuesti, vaid keskendutakse valdkonnale, mis on selle lahendusega otseselt mõjutatud.

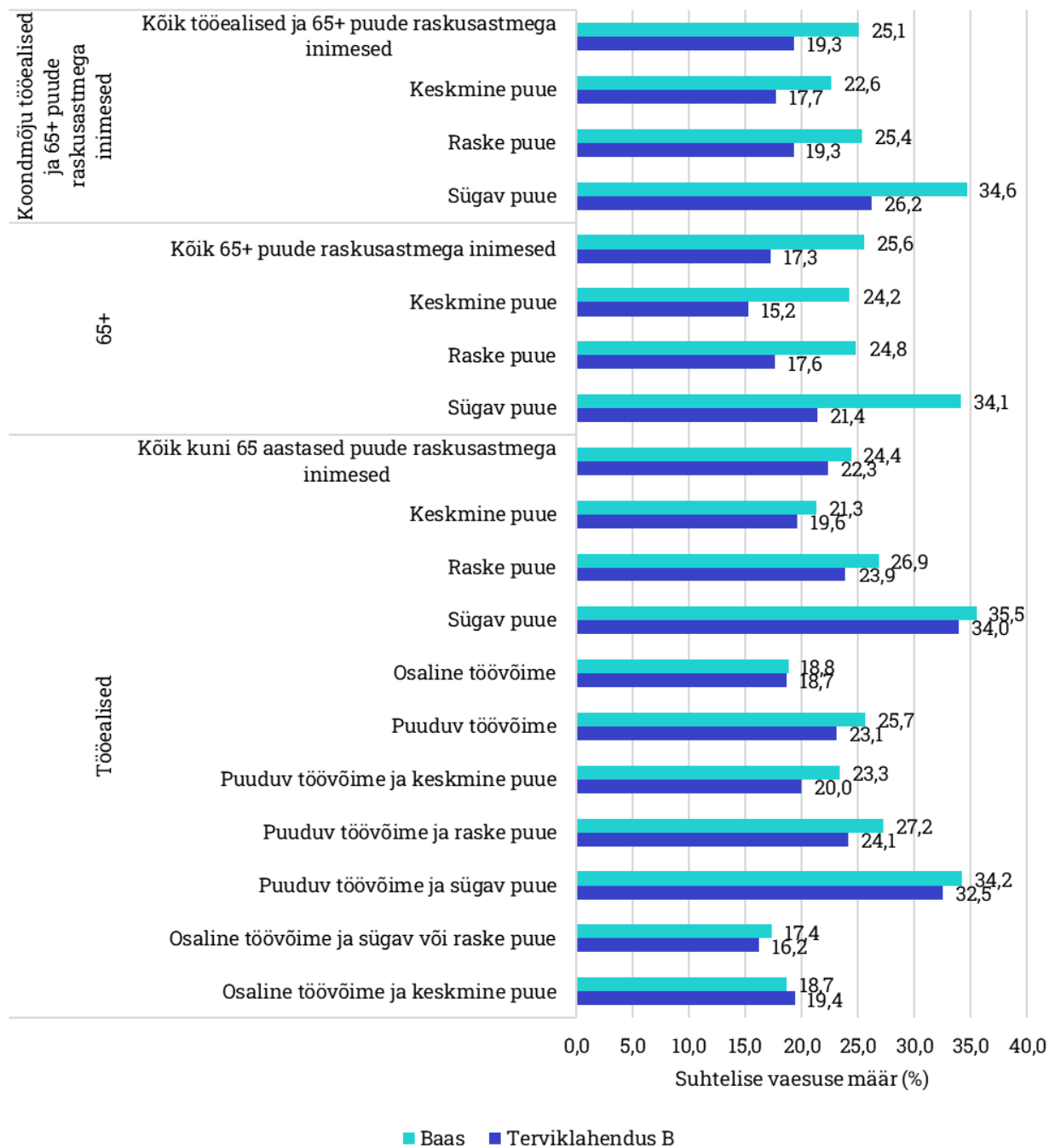
Mõju riigi kuludele ja vaesusele

Lahendus B korral kasvaksid EUROMOD hinnangute kohaselt riigi kulud toetustele ligikaudu 67 miljonit eurot, sh toetused tööealistele moodustavad sellest 28 miljonit ja toetused vanaduspensioniealistele 39 miljonit eurot.

Selle lahenduse üheks eesmärgiks on koos süsteemi lihtsustamisega ka puuetega inimeste majandusliku toimetuleku parandamine ja vaesuse vähendamine. Muudatuste tulemusena väheneks suhteline vaesus nii tööealiste kui ka vanaduspensioniealiste seas ja seda pea kõikide praeguste puuetega inimeste hulgas. Enim toetab muudatus praeguseid sügava ja raske puudega inimesi, kelle vaesusrisk on väga kõrge (suhtelise vaesuse määr vastavalt 34,6% ja 25,4%). Kui võrrelda eraldi mõju tööealistele ja vanaduspensioniealistele, siis on mõju suurim sügava puudega vanaduspensioniealiste seas, kelle hulgas suhteline vaesus väheneb 34,1%-ilt 21,4%-ni. Vaesus kasvab siiski nende hulgas, kellel on praeguste tingimuste järgi osaline töövõime ja keskmine puue ning eeldatavasti rasket või täielikku tegevuspiirangut ei ole ja seega uuele toetusele ei kvalifitseeru (vt ka detailsemalt teekond 1 mõjude kirjeldust).

Kuna lahendused A ja B erinevad peamiselt toetuste suuruste poolest, siis on mõju tööjõu- ja arenduskuludele sama, mis lahendus A korral (vt ka alaptk 11.3.1 ja 13.1). Suuremad toetused võivad küll tuua kaasa kasvu taotlejate ja ka vaiete arvus ning seeläbi kõrgemad tööjõukulud, kuid olemasolevate andmete põhjal ei saa seda täpsemalt analüüsida.

Joonis 40. Puude raskusastmega ja vähenenud töövõimega inimeste suhtelise vaesuse määr puuetega inimeste sotsiaaltoetuse süsteemi lihtsustamisel



Allikas: autorite arvutused EUROMOD maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudeli põhjal.

Märkused: vaesuse määra arvutamiseks on leibkonna kogu netosissetulek simuleeritud (sh maksuarvestus) EUROMOD-iga tuginedes 2024. aasta andmetele ja viidud hinnaindekseid arvesse võttes 2025. aasta väärtustesse.

13.3. Lahendus C - teenuste kättesaadavuse tagamine

Lahenduse eesmärk on tagada teenuste kättesaadavus puuetega inimestele. Praegune täisealise puudega inimeste toetused asendatakse teenustega.

Puude (disability) mõiste on antud lahenduse puhul töökeskne ja seotud vähenenud töövõimega. Vanaduspensioniealistel inimestel puuet ei tuvastata, kuid neile peab olema kättesaadav vajalik abi ja teenused. Puudega isiku kaardi väljastab KOV, selleks tuleb kehtestada ühtsed kriteeriumid, mis saavad põhineda abivajaduse või hoolduskoormuse mahul.

Lahenduse C mõjud

Selle muutusega lahendatakse teenuste vähese kättesaadavuse probleemi, mis tuli töötubades teravalt esile ning mida kinnitavad ka erinevad uuringud (vt ka ptk 6 ja alaptk 8.2). See ei lahenda teisi ootuseid, mille sõnastasid puuetega inimesed töötubades – terviseandmetele tuginev piirangute täpsem hindamine ja hindamisprotsessi läbipaistvus. Lahendus ei mõjuta otseselt majanduslikku toimetulekuprobleemi ja vaesust, aga teenuste parem kättesaadavus võib toetada inimeste toimetulekut laiemalt.

Tervishoiukorraldus

Lahendus ei sea tervishoiule lisakohustusi puude või piirangute hindamisel, mistõttu ei kaasne tervishoiusüsteemile täiendavat halduskoormust. Kuivõrd terviseinfo on hindamisel piirangute mõistmiseks oluline, siis võib suureneda mitteformaalselt perearstiga konsulteerimise praktika ning seeläbi ka perearstide koormus. Uuringute järgi pöörduvad täna puuetega inimesed kõige enam perearsti poole (Turu-uuringute AS, 2020; Vainu 2025) ning võib eeldada, et muudatuse järel tehakse seda veelgi rohkem.

Tervis

Kohalikel omavalitsustel ei ole ligipääsu inimese terviseandmetele. Hindamine põhineb enesehinnangul ja sotsiaaltöötaja vaatluspõhisel hinnangul, hindamise aluseks ei ole diagnoos. Töötubades osalejad rõhutasid, et täpse abivajaduse hinnanguks tuleks arvestada erinevaid allikaid, sh objektiivseid terviseandmeid, spetsialisti hinnanguid ja inimese enda hinnangut. Vajadustele vastavate teenuste saamine aga võib eeldatavalt toetada seda, et terviseseisund ja iseseisev toimetulek ei halvene või selle halvenemine pidurdub.

Heaolu

KOV-idel on vahetu kontakt inimestega ja hindamisel saab toetuda abi- ja toetusvajaduse hindamise juhendile⁵² ning STAR-i abivajaduse hindamise tööriistale. Piirkondliku ebaühtluse riski vähendamiseks on oluline, et KOV-ide sotsiaaltööspsialistid kasutaksid abivajaduse hindamise tööriista ning fikseeriks abi- ja toetusvajaduse STAR-is. See loob eelduse, et vajadusel saab läbi STAR-i luua infovahetust ka teiste valdkondadega erinevate hüvede tagamiseks. Kui KOV-il on tugev sotsiaaltöö meeskond, võib otsene kontakt võimaldada paremini mõista inimese igapäevast olukorda (elukoht, perekond, keskkond) ning kujundada paindlikke lahendusi. Samas on risk, et abivajajad ei pöördu sotsiaaltöötaja poole tulenevalt erinevatest ühiskondlikest ja käitumuslikest barjääridest. Puuetega inimeste töötubades jagati negatiivseid kogemusi KOV-i teeninduskultuuri ning sotsiaaltöötajate pädevusega. Samuti ilmnes, et väiksemates piirkondades võivad KOV-i pöördumine ja abi saamine olla mõjutatud abivajaja ja sotsiaaltöötaja varasematest kontaktidest, tutvusringkondadest ja kogukonna dünaamikast. Ka uuringute (Turu-uuringu AS, 2020) järgi on abi saamisel esmaseks kontaktiks väljaspool oma pere pigem perearst kui sotsiaaltöötaja. Teenuste vajadust ja võimalikku kulu on täpsemalt kirjeldatud teekonna 3 all.

Tööturg ja tööhõive

Kui toetus asendatakse teenustega, mis toetavad tööhõivet ja tööturule liikumist, siis võib muudatusel olla positiivne mõju inimeste aktiivsuse suurenemisele. Kui lisaks KOV teenustele paraneb ka rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus, siis see aitab kaasa hõives püsimisele ja võib aidata hõivesse liikumisel. Positiivne mõju puudutab rohkem neid, kellel on kerged piirangud või osaline töövõime. Puuduva töövõime korral on mõju tööhõivele tõenäoliselt väike (ka praegu on tööhõive määr madal).

Kui teenuste kättesaadavus paraneb, siis võivad töötamise võimalused paraneda nendel, kes praegu hooldavad enda lähedast puudega inimest.

Sooline võrdõiguslikkus

Parem teenuste kättesaadavus mõjutab hoolduskoormust ja eeldatavalt vähendab seda. Kuna hoolduskohustustega on koormatud rohkem naised, on lahendusel seeläbi positiivne mõju soolisele võrdõiguslikkusele. Kaudselt mõjutab meeste ja naiste olukorda ka see, milline on tegevuspiirangutega inimeste sooline jaotus ning milliseid ja millises ulatuses teenuseid nad

⁵² Sotsiaalkindlustusamet. (2025b). Täisealise abi- ja toetusvajaduse hindamise juhend. <https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/documents/2025-01/Täisealise%20abi-%20ja%20toetusvajaduse%20hindamise%20juhend%202025.pdf>

vajavad. Näiteks on täna puudega tööealiste seas meeste osakaal kõrgem kui puudega vanaduspensioniealiste seas.

Võrdsed võimalused

Kui teenused on paremini kättesaadavad, siis paraneb haavatavas olukorras olevate ühiskonnagruppide olukord. Samuti võib see tähendada, et kui inimene saab oma vajadustele vastava teenuse õigel ajal ja piisavas mahus, aitab see vältida probleemi süvenemist või pidurdab selle halvenemist. Selle tulemusel väheneb ka vajadus hilisemate, märksa mahukamate ja kulukamate teenuste järele.

Riskina tõid töötubades osalejad välja, et abivajaduse hindamine sõltub liiga palju sotsiaaltöötaja subjektiivsest hinnangust. Abivajaduse hindamise tööriist ei pruugi seda riski piisavalt vähendada. Näiteks võivad omavalitsused erineda selles, kuidas nad abivajadust kirjeldavad, kas nad kaasavad hinnangusse lähedasi või kas nad teevad kodukülastuse. Samuti võib-olla vajalik riigi poolt kehtestada ühtsed kriteeriumid, et nt kõik KOV-id mõistaksid täieliku piiranguna üht ja sama. Töötubades osalenud puuetega inimeste organisatsioonide esindajad tõid välja mitmeid negatiivseid kogemusi omavalitsustega, mis võib kaasa tuua erinevaid riske lahenduse elluviimisel. Ebaühtlane hindamine viib ebavõrdsete võimalusteni laiemalt, nt kultuurielus osalemises, sest puudega inimese kaart antakse erinevatel alustel.

Piirkondlik ebavõrdsus

Süsteemi muutmisega võib suurenedagi piirkondlik ebavõrdsus. Teenuste kättesaadavus ja kvaliteet sõltuvad suurel määral KOV-de teenuste osutamise võimekusest ja ressurssidest, mis võib süvendada piirkondlikku ebavõrdsust, kuivõrd KOV-ides erineb võimekus kvaliteetseid teenuseid pakkuda.

Majandus ja riigieelarve

Muudatuste mõju riigi kuludele on esitatud teekonna 3 all.

Haridus

Teenuste, sh isikliku abistaja teenuse, sotsiaaltransporditeenuse, rehabilitatsiooniteenuse, viipekeele tõlgi jt teenuste parem kättesaadavus võimaldab piirangutega inimestele parema ligipääsu haridusele. Süsteem ei muuda haridusasutuste taristut ligipääsetavamaks ega haridusasutuses töötavate inimeste hoiakuid. Kui haridusasutused ei tee ligipääsetavuse arendamiseks sihipäraseid investeeringuid, jäävad osalemist takistavad barjäärid püsima.

Kultuur

Teenuste parem kättesaadavus võimaldab piirangutega inimestele parema ligipääsu kultuuri- ja spordiüritustele. Süsteem ei muuda iseenesest kultuuritaristu ligipääsetavust ega kultuurikorraldajate hoiakuid.

Infotehnoloogia

Puude raskusastme tuvastamise lõpetamine SKA-s vähendab asutuse IT arenduste vajadusi, mis on seotud tänase ühistaotlusega. Lahendus eeldab kõikide KOV-de abivajaduse hindamise menetlemise andmeregistris STAR ning andmete olemasolu paranemist selles. Lahendus võib kaasa tuua STAR-i arenduse vajaduse, sh puudega isiku kaardi väljastamisel.

Siseturvalisus

Kui puudega inimesed jäävad vajaliku abita, kasvavad sotsiaalmajanduslikud raskused, suureneb piirkondlik ebavõrdsus, võivad sellega seonduvalt süveneda sotsiaalsed probleemid, mis toovad kaasa rahulolematuse kasvu. Kui süsteem toob kaasa suure ootuse muutuseks, kuid igapäevane kogemus (pikk ooteaeg teenuse saamiseks, vähesed teenused, keeruline suhtlus) ei parane või halveneb, võib see suurendada frustratsiooni ja usaldamatust riigi vastu.

Riigivalitsemine

Vähenevad SKA ekspertiisidega ja puude raskusastme tuvastamisega seotud menetsluskulud. Kulu kokkuhoid on ligikaudu 0,7 miljonit eurot aastas (tugineb SKA tänase süsteemi kulude hinnangule), mis on võimalik anda üle omavalitsustele abivajaduse hindamiseks. Olulisel määral suurenevad KOV-de kulud teenustele ning tööjõule. Tuleb välja töötada mehhanism, mille alusel KOV-dele abivajaduse hindamise ja teenuste osutamise vahendid eraldatakse.

Kohalikud omavalitsused

Kohalike omavalitsuste halduskoormus ning sotsiaaltöötajate koormus kasvavad märkimisväärselt. KOV-id vajavad juurde tööjõudu – eeskätt sotsiaaltöö spetsialiste, aga ka teenuseosutajaid. Näiteks kui koduteenust täiendavalt vajavate inimeste arv on 19 858 ning kui 2024. aastal⁵³ oli ühe teenust osutava isiku kohta umbes 13,2 koduteenuse saajat, siis on

⁵³ 2024. aastal oli koduteenust saavate inimeste arv aasta jooksul 9088 ning teenust vahetult osutavate inimeste arv aasta lõpu seisuga oli 690. Allikas: S-veeb, koduteenus (2024).
https://sveeb.sm.ee/index.php?tid=e2ePS5SWbcEctj_rPRz45zEkW2jQ3AQrERW_wDPm

vaja täiendavalt juurde 1508 teenuseosutajat. Üleminek teistsugusele süsteemile suurendab alguses märkimisväärselt halduskoormust eriti rakendamise esimestel aastatel.

Riigikaitse

Olulist otsest mõju riigikaitse korraldusele ja riigikaitsele võimekusele ei ole. Mõju võib ilmnedagi ka kaudselt, kui sotsiaalsüsteem ei toeta piisavalt inimeste toimetulekut ja tervist ning inimeste usaldus riigi vastu seetõttu muutub hapramaks.

Mõju vaesusele ja riigi kuludele

Kui puuetega inimeste toetuste maksmine lõpetatakse, suureneb puuetega inimeste vaesus, seda eriti tänaste puudega pensioniealiste inimeste seas. Täpsemalt on mõju vaesusele analüüsitud teekond 3 all. Kui toetuse maksmine asendatakse teenuste pakkumisega vajalikus mahus, parandab see inimeste toimetulekut ja vähendab nende tõrjutust. Inimesed, kes kasutavad rohkem teenuseid või varasemalt kasutasid tasulisi teenuseid, võivad muudatusest saada kaudselt majanduslikku kasu ning hoida kokku kulusid. Muudatuste riigi kuludele on esitatud teekonna 3 all.

13.4. Võimalikud riskid ja nende maandamismeetmed

Järgnevalt on välja toodud terviklahendustega kaasnevad peamised võimalikud riskid ja nende maandamismeetmed.

RISK 1: uued TRT-d on teatud juhtudel madalamad kui praegune PISTS toetus. Lahendus A rakendamisel kaotavad tänased tööealised sügava puudega inimesed toetuse suuruses (sissetulekus), sest täieliku piirangu korral makstav TRT on väiksem kui PISTS toetus sügava puude korral. Vanaduspensioniealistest kaotaksid praegused raske puudega inimesed. Ka töötubades osalejad tõid välja, et lihtsam süsteem ei pruugi tähendada õiglasemat süsteemi.

Maandamismeede: toetuste sellisel kujul ümber korraldamisel otsesed maandamismeetmed puuduvad ja nende gruppide sissetulek langeb. Riski maandamiseks saab siiski pakkuda suuremas mahus teenuseid, vähendades teenuste omaosaluse määra ja seeläbi inimese võimalikke kulusid. Kõikide inimeste puhul toetuse vähenemise riski maandada ei saagi.

RISK 2: kõik praegused PISTS toetuse saajad uut TRT-d ei saa. Analüüsitud lahenduste kohaselt makstakse TRT-d üksnes raske või täieliku piirangu korral ning toetusest jäävad ilma mõõduka piiranguga inimesed.

Maandamismeede: Vt Risk 1.

RISK 3: lahenduste A ja B korral on riskiks inimese individuaalse keskkonna vähene arvestamine töövõime hindamisel. Selle ohukoha tõid välja nii töötubades osalejad kui õigusekspert.

Maandamismeede: riski maandamise lahenduseks on töövõime hindamise metoodika täiendamine, võttes arvesse kodukeskkonda ja igapäevaelu piiranguid.

RISK 4: Puuduva töövõimega inimesed, kellel on sagedamini ka täielikud või rasked piirangud, ei ole suurel määral töötukassa teenuste fookuses (tööturule liikumine). Siiski vajaksid nad abi nende õiguste tutvustamisel ja sobivate sotsiaalteenusteni jõudmisel.

Maandamismeede: kuna seda tüüpi teenuste pakkumine ei ole otseselt töötukassa roll, siis tuleb leida lahendus, kuidas inimesed jõuavad abini. Kui selline roll anda KOV-le, tuleb tagada info liikumine töötukassa ja KOV-i vahel ning KOV-ide poolt nõustamisteenuse osutamine. KOV-d saavad vajadusel konsulteerida puudespetsiifiliste organisatsioonidega.

RISK 5: Hetkel kehtiva süsteemi korral on töövõimetoetuse maksmine seotud töise tulu saamisega ning kui töine tulu ületab teatud piirmäära, siis inimene töövõimetoetust ei saa. Kui TRT siduda otse töövõimetoetusega, siis jäävad inimesed sellisel juhul ilma ka TRT-st.

Maandamismeede: riski maandamiseks tuleks maksta TRT-d, kui inimesel on sellele õigus, sõltumata töövõimetoetuse maksmisest või töise tulu teenimisest.

RISK 6: Inimesed, kes valivad töövõimetoetuse asemel pensioni saamise enne vanaduspensioniiiga või on püsiva töövõime kaotusega, jäävad ilma ka TRT-st.

Maandamismeede: maandamiseks saab üleminekusätetega jätkata praegustele pensioni saajatele puudega tööealise inimese toetuse maksmist teatud aja jooksul, kuni vanaduspensionieani või puude tuvastamise otsuse kehtimiseni. Uued tööealsed pensioni saajad peavad omama õigust saada TRT-d. See eeldab head teavitustööd, et pensioni saavad inimesed teaksid taotleda töövõime hindamist.

13.5. Kooskõla võetud rahvusvaheliste kohustustega

Lahendus A

Õiguseksperdi hinnangul on lahendus A võetud rahvusvahelisi kohustusi arvesse võttes problemaatiline, sest puuet hinnatakse töövõime kontekstis. Ehkki töövõime hindamiseks ja puude raskusastme tuvastamiseks kasutatakse ka praegu osaliselt sama RFK raamistikku, on otsuste eesmärk ja fookus erinevad. Ühel juhul on tegemist töövõime hindamisega, teisel juhul aga ühiskonnaelus osalemise piirangute või igapäevaelu takistuste ja kõrvalabi vajaduse tuvastamisega. Ainult töövõime hindamise tulemusena võivad vajalikust abist ilma jääda need inimesed, kelle peamine abivajadus on muudes eluvaldkondades.

Lahendus vähendab administratiivset koormust, kuid kergemate piirangutega inimestele kaob meede, millega riik tagab praegu osaliselt puudest tingitud lisakulude katmise neis olukordades, kus muud riigi ja kohaliku omavalitsuse meetmed puuduvad või need meetmed

ei ole küllaldased (sealhulgas kulutused transpordile, kultuuritegevusele, vaba aja veetmise võimalustele).

Lahendus halvendab sügava puudega tööeliste inimeste olukorda. Inimesed, kellel on puuduv töövõime ja rasked piirangud, ei ole otseselt töötukassa meetmete sihtrühm. Ka need inimesed, kellel töötamise perspektiivi ei ole, on väärtuslikud ühiskonna liikmed, kellele tuleb aktiivselt tähelepanu pöörata. Inimesed, kelle igapäevaelu takistused on nii suured, et nad ei saa töötada, vajavad sellist hindamist, mille tulemusel tekib arusaam, kuidas paremini võimaliku abini jõuda. Lahendusel puudub ka vaesuse vähendamise komponent.

Järelikult puuetega inimeste võimalused teistega võrdseks ühiskonnaelus osalemiseks halvenevad. Seda oleks võimalik kompenseerida muude sobivate meetmete laiendamisega. Kui aga kompenseerivaid meetmeid ei osutata ja osade puuetega inimeste võimalused võrreldes praegusega halvenevad, siis pole lahendus tõenäoliselt puuetega inimeste õiguste konventsiooni ning parandatud ja täiendatud sotsiaalhartaaga kooskõlas.

Lahendus B

Lahendus toetab vaesuse vähendamist ning aitab tagada võrdsemat vanuselist kohtlemist. Võrreldes lahendusega A on positiivne see, et osad inimesed saavad suuremat rahalist abi. Siiski kaotavad kergemate piirangutega inimesed igakuises toetuses, tööelised inimesed vähemalt 29 eurot kuus, vanaduspensioniealised inimesed 13 eurot kuus. Seetõttu jääb üles küsimus, kuidas tagatakse, et inimesed saavad seda abi, mida nad vajavad ja kuidas toetatakse nende perekondi.

Võetud kohustuste täitmist saab paremini tagada järgmiselt:

- parandades puudest tingitud piirangute hindamise aluseks olevate andmete kvaliteeti;
- täiendades hindamist võttes arvesse igapäevaelu osalus- ja tegusemispiirangud;
- suunates KOV-dega koostöös inimesi rohkem neile vajalike teenusteni;
- kaasates puuetega inimesed süsteemi toimimise üle järelevalvesse ja ettepanekute tegemisse.

Lahendus C

Selle lahendusega on seotud kõige suuremad õiguslikud riskid. Õiguseksperdi hinnangul võib lahendust C võetud rahvusvahelisi kohustusi arvesse võttes pidada problemaatiliseks, sest süsteem on praegusest enam killustatud ja juurdepääs teenustele sõltub inimese elukohast. Lahenduse rakendamise eelduseks on ühtse STAR-i põhise abivajaduse hindamise instrumendi kasutuselevõtmine kõikides omavalitsustes, kuid ainult selle hindamisinstrumendi kasutuselevõtt ei taga, et seda rakendatakse üle kogu riigi ühtemoodi. Abivajaduse hindamise vahendile peaksid lisanduma ühtsel miinimumstandardil põhinevad kohustuslikud teenused ning järelevalve.

Probleemiks võib kujuneda õigusemõistmise võimaluste vähenemine, sest KOV-de ülest vaidemenetlust individuaalkaebuse lahendamiseks ei ole ning inimestel tuleb KOV otsusega mittenõustumisel alati pöörduda kohtusse.

Kui lahendus ei taga ühtset hindamist ja võrdset juurdepääsu teenustele ja muule abile kogu riigi territooriumil ning abi kättesaadavus jääb suuresti sõltuma kohaliku omavalitsuse võimekusest, on see suure tõenäosusega puuetega inimeste õiguste konventsiooni ning parandatud ja täiendatud sotsiaalharta vastuolus.

Kokkuvõte ja soovitused

Käesolev uuring analüüsis võimalusi lõpetada täisealiste inimeste puude raskusastme eraldiseisev tuvastamine ning korraldada ümber sellega seotud toetused ja teenused. Analüüsi, sihtrühmade tagasiside ja välisriikide praktikate põhjal joonistub välja selge vajadus süsteemi põhimõtteliseks muutmiseks. Tänapäevane korraldus, kus inimese seisundit hindavad paralleelselt kaks asutust (töötukassa ja SKA), on riigi jaoks ebaefektiivne, ega taga sageli puuetega inimestele tegelikku abi toetuste ja teenuste näol.

Analüüsi käigus töötati välja kolm võimalikku teekonda ning toodi välja ettepanekud tänase süsteemi parandamiseks. Lahendustes analüüsiti vastutuse täieliku üleandmist kohalikele omavalitsustele (**Teekond 3**). Kuigi töötubades osalejad nägid ideaalis tulevikus tervishoiukeskset lahendust (**Teekond 2**), ei ole tervishoiusüsteem selleks täna veel valmis. Seetõttu peab uuring praeguses etapis kõige realistlikumaks **Teekonda 1**, mis koondab tööealiste hindamise ja toetamise ühte asutusse (töötukassa), kaotades seeläbi riikliku dubleerimise ja pakkudes inimesele selgemat, "ühe ukse" lahendust. Kuna osade inimeste toetused võivad väheneda või kaduda, tuleb rakendada muud inimeste abivajadust kompenseerivad meetmed.

Muudatuse elluviimisel pakume välja kolme lahendust, mille puhul tööealiste ja vanaduspensioniealiste tegutsemispiirangutega inimestele rakendatakse sarnaseid toetuse määramise aluseid.

Lahendus A (Süsteemi lihtsustamine – kuluneutraalne)

- **Tööealised:** puude raskusastme tuvastamine lõpetatakse, lisaks töövõimetoetusele maksab töötukassa raske või sügava tegutsemispiirangu korral toetust vastavalt 35 või 55 eurot.
- **Vanaduspensioniealised:** SKA hindab õigustatust toetusele tegutsemispiirangute alusel. Toetusi makstakse sarnaselt tööealistele inimestele kahes suuruses raske ja täieliku tegutsemispiiranguga inimestele, vastavalt 20 või 41 eurot. Süsteemi lihtsustamisele aitab kaasa lihtsam üleminek tööealiste süsteemist vanaduspensioniealiste süsteemi. Vanaduspensionieal võetakse toetuse määramisel arvesse töötukassas hinnatud tegutsemispiiranguid.

Lahendus B (Toimetuleku parandamine – lisainvesteeringuga)

- **Tööealised:** Lisaks süsteemi lihtsustamisele ja toetuste maksmisele sarnaselt lahendusele A tõstetakse raske ja täieliku tegutsemispiiranguga inimeste toetuste suuruseid (70 ja 130 euron), et vähendada tegutsemispiirangutega inimeste vaesusriski ja tagada nende toimetuleku paranemine.
- **Vanaduspensioniealised:** Süsteemi muudetakse sarnaselt lahendusele A ning toetuste tegutsemispiiranguga inimeste toetuste maksmine vanaduspensionieas jätkub samas

summas mis tööelistel inimestel – vastavalt 70 ja 130 eurot. See on kriitilise tähtsusega muudatus, mis vähendab oluliselt puudega vanemaealiste suhtelist vaesust ja parandab nende ligipääsu vajalikele ravimitele ja teenustele.

Lahendus C (Teenuspõhine lähenemine)

- **Tööelised:** Rahalistest toetustest jääb alles töövõimetoetus. Puudega tööelise inimese toetus asendatakse teenuste pakkumisega. See võib jätta inimesed ilma vajalikust paindlikkusest oma elu korraldamisel ning suurendab vaesusriski. Teenuste pakkumine siiski aitab kaasa ühiskonnaelus osalemisele.
- **Vanaduspensioniealised:** puude raskusastme tuvastamist ei toimu ning toetused asendatakse teenustega. Rahalise toetuse kadumine oleks vanemaealistele eriti ränga mõjuga, kuna praegune toetus on sageli hädavajalik sissetulekuosa igapäevaste lisakulude (sh ravimite, abivahendite ja teenuste omaosalus) katmiseks. See toob kaasa vaesusriski kasvu ja toimetuleku halvenemise, mida võib kompenseerida teenuste parem kättesaadavus.

Lähtuvalt teostatud analüüsist on uuringu keskne soovitus süsteemi korrastamisel tööeliste inimeste puhul koondada hindamise ja toetuste maksmine **töötukassasse**. See struktuurne muudatus kaotaks tänase kuluka dubleerimise ja looks inimesele selgema „ühe ukse“ lahenduse. Süsteemi muutmise elluviimisel seisab riik aga valiku ees: kas piirduda halduskoormuse vähendamisega (kuluneutraalne **Lahendus A**) või investeerida sihtrühma toimetuleku parandamisse (**Lahendus B**), mis omaks olulist mõju puuetega inimeste vaesusriski vähendamisele. Seevastu rahaliste toetuste täielik asendamine teenustega (**Lahendus C**) ei pälvinud sihtrühma toetust ning sellega võivad kaasneda mitmed ebasoovitavad mõjud.

Kuluanalüüsi ja vaesuse mõjude tõlgendamisel tuleb arvestada, et osade stsenaariumite korral lisandub töövõimetoetuse kõrvale TRT, mille maksmine sõltub inimese piirangust. Kuna selle uuringu jaoks päritud andmetes puudub informatsioon tegutsemispiirangute kohta ja hinnangute andmiseks oli vajalik teha täiendavaid eelduseid, siis detailsemate mõjuhinnangute jaoks oleks vajalik tulevikus kõrvutada selle uuringu tulemusi ka tegelikest piirangutest lähtuvate andmete ja hinnangutega.

Ainuüksi asutuste vaheline ülesannete ümberjagamine ei ole piisav. Süsteemi muudatus täidab oma eesmärgi juhul, kui sellega lahendatakse tänased kitsaskohad: tagatakse **terviseandmete parem kvaliteet ja liikuvus**, vabastatakse **püsivate seisunditega inimesed tarbetutest korduvhindamistest** ning luuakse toimiv **seos hindamistulemuse ja vajalike teenuste kättesaadavuse vahel**. Ilma nende sammudeta jääb muudatus vaid tehniliseks ümberkorralduseks, mis ei paranda puuetega inimeste tegelikku elukvaliteeti.

Seetõttu soovitame tulevikus kaaluda teekonna 2 rakendamist ning kombineerimist eespool pakutud lahendustega. Teekonna märksõnaks on küll „tervishoiukeskne lähenemine“, kuid kui tervishoiusüsteemis tehtud piirangute hindamise tulemusi kasutatakse ka laiemalt teistega võrdse ühiskonnaelus osalemise saavutamiseks, siis õiguseksperdi arvamuse kohaselt tagab pakutud lahendustest see teekond kõige paremini puuetega inimeste õiguste konventsiooni ning parandatud ja täiendatud sotsiaalhartaiga võetud kohustuste täitmise. Seda toetasid ka töötubades osalejad.

Soovitused muudatuste elluviimiseks ja kasutajakogemuse parandamiseks

Et kavandatav süsteemi muutmine pakuks inimestele tõhusamat tuge, peaks hindamine keskenduma inimese toimetulekule ja heaolule, mitte ainult toetuste ja teenuste tingimustele vastamisele. Seega soovitame uue süsteemi disainimisel lähtuda järgmistest põhimõtetest:

1. Taotlemise koormuse vähendamine. Süsteemi muutmisel (lahendused A ja B) tuleks:

- **Vähendada korduvaid hindamisi:** lisaks töövõimet välistavate seisundite loetelule luua muutumatute ehk püsivate seisundite loetelu, mis sobib nii tööealistele kui ka vanaduspensioniealistele inimestele. Muutumatute seisundite otsuste kestust tuleks pikendada üle praeguse 5 aasta maksimumpiiri.
- **Kasutada nutikaid lahendusi:** Rakendada eeltäidetud taotlusi, kus kuvatakse varasemal hindamisel sisestatud info.
- **Parandada kliendikogemust:** Saata meeldetuletustega koos juhised taotluse täitmiseks, tagada piisav tugi asjaajamisel (nt pikemad vastuvõtuajad) ja selgitada otsuse saajale arusaadavalt hindamise aluseid. Kasutajauuringud aitaksid uue süsteemi loomisel kitsaskohti ennetada.

2. Pöörata rohkem tähelepanu inimese abini jõudmise toetamisele. Kui hindamise tulemusena ei pakuta inimesele personaliseeritud abi ja teenuseid, siis ei ole see inimese jaoks tõhus ega toetav. Varasemalt on rõhutatud, et inimesed vajavad abi sotsiaalhoolekandesüsteemis orienteerumisel, et võimalikult kiiresti sobivate teenuste ja meetmeteni jõuda (Riigikontroll, 2024; Kallaste *et al.*, 2022). Selleks soovitame:

- **Luua seos teenustega:** Hindamistulemus peab viima konkreetsete soovitusteni. Otsusega võiks kaasneda nimekiri personaliseeritud teenustest (sh teenusepakujad), mida sarnaste piirangutega inimesed on kasutanud ning millele võib inimesel õigus olla, ning info nende taotlemise kohta.
- **Rakendada personaalset nõustamist:** Otsusega peab kaasnema nõustamine, kelle poole edasise abi saamiseks pöörduda.

- **Suurendada KOV-i proaktiivsust:** raske ja mõõduka piiranguga inimeste kohta peaks info jätkuvalt liikuma kohalikku omavalitsusse, kellel on kohustus proaktiivselt inimesega ühendust võtta. KOVide abi pakkumist tuleks seirata ja takistuste korral põhjuseid uurida.

3. Hindamismetoodika ja andmete kvaliteet. Tulevikus tuleks kaaluda analüüsis mainitud tervishoiukeskset lähenemist (Teekond 2) ja terviseteekonnajahi kaasamist. Seni aga parandada olemasolevat hindamist:

- **Terviklik vaade:** Arvestada lisaks terviseandmetele laiemalt igapäevaelu, keskkonna aspekte ja inimese enesehinnangut talle olulistes tegevustes.
- **Andmete riskasutus:** Võtta arvesse teisi tehtud hindamisi (nt rehabilitatsiooniteenuste osutajate hinnanguid) ja KOV-ide abivajaduse hindamise infot (STAR), mis kirjeldab tegelikku hakkamasaamist keskkonnas.

4. Klienditeeninduskultuuris arvestada, et taotleja võib olla haavatavas olukorras (näiteks valu, stress, sotsiaalmajanduslikud raskused). Seetõttu võib ta vajada täiendavat tuge ja juhendamist taotlemisel ja abi leidmisel. Samuti on oluline edendada austavat ja eelarvamustevaba suhtumist ekspertide ja ametnike seas, kes abivajajaga kokku puutuvad.

5. Jätkata puuetega inimeste kaasamist neid puudutavate süsteemide muudatustesse, et need arvestaksid inimeste võimaluste ja vajadustega.

Lisad

Lisa 1 – Lühikokkuvõtted

Eesti- ja inglisekeelsed lühikokkuvõtted on esitatud eraldi failis.

Lisa 2 – Puude mõiste ja puude tuvastamisega seotud rahvusvahelised kohustused

Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta

Sotsiaalharta näeb ette, et riigid peavad astuma samme, et tagada puuetega inimestele õigus elada iseseisvalt, sotsiaalselt integreeruda ja võtta osa ühiskonna elust, sõltumata nende vanusest ning puude põhjusest ja laadist (artikkel E). Selleks peavad nad võtma meetmeid puuetega inimeste hariduslike õiguste (sotsiaalharta artikli 15 lõige 1) ja tööalaste õiguste (sotsiaalharta artikli 15 lõige 2) edendamiseks ning ka laiemalt puuetega inimeste sotsiaalseks integreerumiseks ning osavõtuks ühiskondlikust elust (sotsiaalharta artikli 15 lõige 3).

Artikli 15 lõike 3 kohaselt peab riik võtma meetmeid puuetega inimeste suhtlemis- ja liikumistakistuste ületamiseks ning transpordi, eluaseme ja kultuuritegevuse ning vaba aja veetmise võimaluste kättesaadavuse tagamiseks. Neil meetmel peab olema mittediskrimineeriv õiguslik alus ning meetmeid tuleb osutada koordineeritult. Abivahendid ja tugiteenused peavad olema inimestele kättesaadavad ning inimesed ei tohi rahaliste vahendite puudumise tõttu vajalikust abist ilma jääda (Council of Europe, 2022, lk 139–141).

Kui puuetega inimesed on vaesuses, siis on nende võimalus elada iseseisvalt, sotsiaalselt integreeruda ja võtta osa ühiskonna elust piiratud. Seetõttu hindab Sotsiaalõiguste Komitee artikli 15 lõikega 3 võetud kohustuste täitmisel, milline on puuetega inimeste olukord ja kuidas on riik puuetega inimeste vaesust vähendanud. Kui vaesus on puuetega inimeste seas levinud, siis ei ole riik sotsiaalharta artikliga 15 võetud kohustusi täitnud (Council of Europe, 2022, lk 141).

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmise üks eesmärk on puuetega inimeste iseseisva toimetuleku, sotsiaalse integratsiooni ja võrdsete võimaluste toetamine (PISTS § 1 lõige 2). Seega on need toetused üheks meetmeks, millega Eesti sotsiaalharta võetud kohustusi täidab.

Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks

[Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks](#) kehtestab sellega ühinenud riikidele miinimumstandardid üheksas sotsiaalkindlustuse valdkonnas, neist üks (IX osa) käsitleb invaliidsushüvitisega seonduvat.

Invaliidsushüvitist tuleb maksta, kui inimene ei ole võimeline tegelema mistahes tulutoova tegevusega ettenähtud ulatuses, kui selline seisund on tõenäoliselt püsiva iseloomuga või kestab pärast haigushüvitise maksmise perioodi lõppemist (koodeksi artikkel 54).

Invaliidsuse mõistet ega tuvastamise reegleid koodeks ei kehtesta. Ka on tegemist vananenud mõistega, mille kasutamisest on enamus riike loobunud (koodeksi tekst lepiti kokku 1964. aastal). Koodeks ei kehtesta puude mõistet ega puude tuvastamise reegleid.

Invaliidsushüvitise eesmärk on tagada vähenenud töövõimega inimesele elatusvahendid ehk sissetulek (koodeksi artikkel 55). Eestis täidab invaliidsushüvitise eesmärki töövõimetoetus (TVTS § 1 lõige 1).

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste eesmärk on puudest tingitud lisakulude osaline hüvitamine (PISTS § 1 lõige 2). Seega on puuetega inimeste sotsiaaltoetustel töövõimetoetusest erinev eesmärk. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste vastavust koodeksile ei hinnata.

Puude tuvastamisega seotud kohustused

Puuetega inimeste konventsioon, Euroopa Sotsiaalharta ega Euroopa Sotsiaalkindlustuskoodeks ei nõua ühte kindlat puude tuvastamise viisi.

Sellegipoolest ei ole konventsiooniga kooskõlas ainult või eelkõige meditsiinilistel näidustustel põhinev puude tuvastamine (vt nt Kakoullis, & Ikehara, 2018, lk 37, 54; Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2018, punktid 2 ja 8; Waddington & Broderick, 2018, lk 8, 36; vt ka Council of Europe, 2022, lk 135; Council of Europe, 2015, lk 1–2).

On siiski riike, kaasa arvatud Euroopa Liidu liikmesriigid, kus senini hinnatakse puuet peamiselt meditsiinilise mudeli alusel (vt nt Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2025, punkt 10). Euroopa Puuetega Inimeste Foorum on ühes oma 2022. aastal koostatud dokumendis märkinud, et puude tuvastamisel on eelkõige meditsiiniline lähenemine Saksamaal, Iirimaa, Lätis, Leedus, Maltas ja Sloveenias (vt European Disability Forum, 2022).

ÜRO puuetega inimeste komitee on Läti esimese konventsiooni täitmise kohta esitanud tähelepanekutes märkinud, et puude tuvastamine peab põhinema inimõiguste mudelil; hõlmama puuetega inimeste vajaduste, tahte ja eelistuste hindamist; keskendumata takistuste kõrvaldamisele ja puuetega inimeste täieliku ja tõhusa ühiskonnaelus osalemise edendamisele (vt Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2017, punkt 7 a).

Euroopa puudealaste ekspertide akadeemilise võrgustiku eksperdid ([The Academic Network of European Disability Experts](#), ANED) on aga leidnud, et puuetega inimeste õiguste konventsiooni tõlgendust silmas pidades ning puude inimõiguste mudelit arvestades saab puude tuvastamise reeglite osas teha järgmised üldistavad järeldused (vt Waddington *et al.*, 2018, lk 176–178; vt ka Priestley, 2022, lk 30 ja 31).

- Tuleb järgida konventsiooni artiklis 3 sätestatud üldpõhimõtteid: inimväärikus ja autonoomia, mittediskrimineerimine, ühiskonnaelus osalemine, erinevuste austamine, võrdsed võimalused ja juurdepääsetavus, sooline võrdõiguslikkus, austus puuetega laste arenevate võimete ja identiteedi vastu. Neid põhimõtteid rikkuvad puude tuvastamise meetodid ei ole konventsiooniga kooskõlas;
- konventsioonist tulenevad riigi kohustused kehtivad kogu riigi territooriumil ning seega peavad ka kohalikud omavalitsused täitma artiklist 4 tulenevaid üldkohustusi ning artikliga 5 kehtestatud võrdsuse ja mittediskrimineerimise nõudeid;
- puude tuvastamine ei tohi piirduda üksnes terviseseseisundi või kõrvalekallete kirjeldamisega, vaid tuleb kindlaks teha, millised takistused segavad inimest ühiskonnaelus osalemast ja millised mõistlikud abinõud aitaksid need takistused kõrvaldada (artikkel 1);
- puude hindamisega seotud hoonete, teabe, suhtlusvahendite, taotlusvormide ja hindamisvahendite juurdepääsupiirangud tuleb kõrvaldada ning vajadusel tagada mõistlikud individuaalsed kohandused (artikkel 9);
- tuleb tunnustada puuetega inimeste õigusvõimet: nende õigusi, tahet ja eelistusi tuleb austada, vältides huvide konflikti ja liigset mõjutamist ning rakendades proportsionaalseid ja võimalikult vähe piiravaid meetmeid (artikkel 12);
- puude hindamise menetlus ja selle tulemus ei tohi viia inimese meelevaldse vabadusekaotuseni; kui vabadust piiratakse, tuleb tagada kõik konventsioonis ette nähtud õiguskaitsegarantiid (artikkel 14);
- puude hindamise menetlus ja selle tulemus ei tohi põhjustada julma, ebainimlikku või alandavat kohtlemist; alati tuleb austada inimese füüsilist ja vaimset puutumatust (artikkel 17);
- hindamistulemuse läbivaatamise ja vaidlustamise reeglid peavad tagama puuetega inimeste juurdepääsu õigusemõistmisele, sealhulgas vajadusel mõistlikud kohandused, et võimaldada inimesel võrdselt teistega osaleda kõigis õigusemõistmise menetlusetappides (artikkel 13);

- puude hindamises osalevaid spetsialiste ja töötajaid tuleb koolitada, et nad mõistaksid konventsioonis sätestatud õigusi ja kohustusi ning oskaksid neid oma töös rakendada (artiklid 4 ja 13);
- puuetega inimeste sotsiaalsete vajaduste hindamine peab lähtuma õigusest elada iseseisvalt ja olla kogukonda kaasatud. Seejuures ei tohi piirata õigust valida elukohta ja kaaselanikke; hindamine peab hõlmama isikliku abi, kogukonnateenuste ja muu vajaliku abi kindlaksmääramist (artikkel 19);
- konkreetsetele toetustele ja teenustele juurdepääsu hindamise kriteeriumid peavad olema kooskõlas konventsiooni artiklitega 23–30 (kodu ja perekonna austamine, haridus, tervishoid, habilitatsioon ja rehabilitatsioon, töö ja tööhõive, piisav elatustase ja sotsiaalkaitse, osalemine poliitilises ja avalikus elus ning kultuuri-, vaba aja- ja sporditegevuses); töö- või haridusvaldkonna toe vajaduse hindamisel tuleb arvestada konventsiooniga võetud kohustusi;
- vajadusel tuleb puude tuvastamise meetodit muuta, et see oleks konventsiooni põhimõtete ja kohustustega kooskõlas.

Lisa 3 – Toetused, teenused ja muud soodustused

Hüve	Viide seadusele	Täna õigustatud isik				
		tööeas (puudega)	vanaduspensionieas (puudega)	osaline töövõimega	puuduv a töövõimega	Täna vanaduspensionil (puudeta)
PISTS toetused						
Puudega tööealise inimese toetus	Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus–Riigi Teataja	jah	ei	ei	ei	ei
Puudega vanaduspensionialise inimese toetus	Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus–Riigi Teataja	ei	jah	ei	ei	ei
Puudega vanema toetus	Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus–Riigi Teataja	jah	jah	ei	ei	ei
Õppetoetus	Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus–Riigi Teataja	jah	jah, kuid ei ole tõenäoline	ei	ei	ei
Täienduskoolitustotetus	Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus–Riigi Teataja	jah	jah, kuid ei ole tõenäoline	ei	ei	ei
Teenused ja puhkus						
Sotsiaalne rehabilitatsioon	Sotsiaalhoolekande seadus–Riigi Teataja	jah	jah	ei	jah	ei
Puhkus täisealise sügava puudega isiku hooldamiseks	https://www.riigiteataja.ee/akt/102052024028	jah	jah	ei	ei	ei
Puudega inimese parkimiskaart	https://www.riigiteataja.ee/akt/131122024009 https://www.riigiteataja.ee/akt/107032025008	jah	jah	ei	ei	ei
Soodustused						
Riigisisised sõidusoodustused (tasuta)	https://www.riigiteataja.ee/akt/123122024010	jah	jah	ei	ei	ei
Riigisisised sõidusoodustused	https://www.riigiteataja.ee/akt/126042025007 https://www.riigiteataja.ee/akt/128062024004	jah	jah	ei	ei	jah, oleneb piirkonnast, liinist, KOVst
Tasuta riigimuuseumi külastus	Muuseumiseadus–Riigi Teataja	jah	jah	ei	ei	ei
Haridusmeetmed						
Erivajadusega üliõpilaste stipendium	https://www.riigiteataja.ee/akt/110122024003	jah	jah, kuid ei ole tõenäoline	ei	ei	ei
Välisõpingute stipendium	https://www.riigiteataja.ee/akt/105042024009	jah	jah, kuid ei ole tõenäoline	jah	jah	ei

Õppekulude hüvitamine	https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019012?leiaKehtiv	jah	jah, kuid ei ole tõenäoline	ei	ei	ei
Eesti keele tasemeeksami osaoskuste vabastuse saamine	https://www.riigiteataja.ee/akt/103112023012?leiaKehtiv	jah	jah	ei	ei	ei
Kodakondsuseksami ulatuse ja viisi või eksamitest vabastamise taotlus	https://www.riigiteataja.ee/akt/128072020008?leiaKehtiv	jah	jah	ei	ei	ei
Õigused						
Puudega isiku kaart	Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus–Riigi Teataja	jah	jah, pensionitunnistusega	ei	ei	ei
Puudega inimestele õigusabi	https://www.riigiteataja.ee/akt/117022021004	jah	jah	ei	ei	ei
Muud hüved (ei analüüsi)						
Eluruumi tagamine puudega inimesele	Sotsiaalhoolekande seadus–Riigi Teataja	jah	jah	ei	ei	ei
Teenuse hüvitis (nt nõustamine, rehabilitatsioon), abivahendite toetus (soetamine, üürimine, remont); Kulude hüvitis (lisakulud, eluruumi kohandamine), sõidukulu hüvitis	https://www.riigiteataja.ee/akt/129032023036	jah	jah, kuid ei ole tõenäoline	ei	ei	ei
Ajateenistusse kutsumata jätmise; ajapikenduse andmine seoses ülalpidamiskohust ustega, ajateenistuse ennetähtaegne lõppemine	Kaitseväeteenistuse seadus–Riigi Teataja	jah	ei kohaldu	ei	ei	ei kohaldu
Vähendatud riigilõiv isikut tõendavate dokumentide taotlemisel	https://www.riigiteataja.ee/akt/102102025007?leiaKehtiv	jah	ei	ei	ei	jah
Soodustatud isikute harrastuskalapüügi õigus	https://www.riigiteataja.ee/akt/106072018013?leiaKehtiv	jah	jah	jah	jah	jah
Toetuse andmine ettevõtjale rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks	https://www.riigiteataja.ee/akt/130052025011	jah	jah	jah	jah	ei
Tulumaksu vabastus isikliku mootorsõiduki kasutamise hüvitiselt elu - ja töökoha vaheliseks sõiduks, kui puudub ühistranspordi	Tulumaksuseadus–Riigi Teataja	jah	jah, kui töötab	ei	ei	ei

kasutamise võimalus						
Erisoodustusena ei maksustata töötajate elu- ja töökoha vaheliseks transpordiks kasutatud ühistranspordi piletihinna hüvitamist ja muu transpordikulu hüvitamist	Tulumaksuseadus–Riigi Teataja	jah	jah, kui töötab	ei	ei	ei
Tööandja poolt antud tööalaseid abivahendeid ei maksustata erisoodustumaksuga	https://www.riigiteataja.ee/akt/120122024005?leiaKehtiv	jah	jah, kui töötab	jah	jah	ei
Sideteenuse osutaja kohustus sõlmida liitumisleping eelisjärjekorras sügava või raske puudega inimese või tema hooldajaga puudega inimese elukohas	https://www.riigiteataja.ee/akt/130122024009?leiaKehtiv	jah	jah	ei	ei	ei
Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute abistamine	https://www.riigiteataja.ee/akt/111012019012	jah	jah	ei	ei	ei
Vaktsiinist põhjustatud kahjude hüvitamine	https://www.riigiteataja.ee/akt/123052023055	jah	jah	jah	jah	ei
Juhtimisõiguse ära võtmise keeld	https://www.riigiteataja.ee/akt/117042025004	jah, liikumispuue	jah, liikumispuue	ei	ei	ei
Abinõud pakettreisi lepingu rikkumise korral	https://www.riigiteataja.ee/akt/104072024018?leiaKehtiv	jah	jah	ei	ei	ei
Töökohustuse rakendamise keeld; Täiendavate töö- ja teenistusülesannete täitmise kohustus eriolukorra ajal	Hädaolukorra seadus–Riigi Teataja	jah	jah, kui töötab	ei	jah	ei
Välismaalasele viisa andmine	https://www.riigiteataja.ee/akt/117042025013?leiaKehtiv	jah	jah, kui töötab	ei	ei	ei
Välismaalasele viisa andmine	Välismaalaste seadus–Riigi Teataja	jah	jah	ei	ei	ei
Välismaalasele osutatavad teenused	Välismaalaste seadus–Riigi Teataja	jah	jah	ei	ei	jah

Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud teose vaba kasutamine puuetega inimeste huvides	https://www.riigiteataja.ee/akt/114032025022	jah	jah	ei	ei	ei
Kaitsja kohustuslik osavõtt kriminaalmenetlusest.	https://www.riigiteataja.ee/akt/117042025006	jah	jah	ei	ei	ei
Ühistranspordi pakkumise vastavus	Ühistranspordiseadus–Riigi Teataja	jah	jah	ei	ei	jah
Toetus sõiduki soetamiseks, kohandamiseks	Ühistranspordiseadus–Riigi Teataja	jah	jah	ei	ei	ei

Lisa 4 – Kulumudel

Eraldiseisev Exceli põhine kulumudel.

Lisa 5 – Täiendavad statistilised andmed ja selgitused

Töötukassa statistiliste andmete järgi on suurem enamus puuduva töövõimega inimestest kas täieliku või raske piiranguga (sh välistavad seisundid) ning vaid 14%-l on mõõdukas piirang. Osalise töövõimega inimeste seas on sagedamini tegemist mõõduka piiranguga.

Tabel 45. Piirangute raskusaste töövõime ulatuse otsustes, 2024

Töövõime ulatus	Piirangu raskusaste	2024. a kuude keskmine	Piirangu osakaal vastavas töövõime ulatuse rühmas, %
osaline töövõime	erijuht	1 380	2%
	täielik piirang	7	0%
	raske piirang	5 615	10%
	mõõdukas piirang	48 660	87%
puuduv töövõime	erijuht	143	0%
	täielik piirang	1 965	5%
	raske piirang	24 974	68%
	mõõdukas piirang	5 028	14%
	välistav seisund	4 724	13%
Kokku	Osaline ja puuduv töövõime	92 496	

Allikas: Eesti Töötukassa statistilised andmed, autorite arvutused.

Kui 2024. aastal oli analüüsi järgi kokku 95 593 vähenenud töövõimega inimest, kellest 58 782-l oli osalise ja 36 811-l puuduv töövõime, siis tabelis esitatud jaotuse järgi võib eeldada, et kui lisatoetust makstakse täieliku või raske piiranguga inimestele, siis saaksid osalise töövõimega inimestest lisatoetust umbes 5938 inimest ja puuduva töövõime korral 31 642 inimest. Kuivõrd täieliku või raske piiranguga või välistava seisundiga inimeste osakaal on puuduva töövõimega inimeste seas väga suur, siis on analüüsis ühe alternatiivina esitatud ka stsenaarium, mille kohaselt puuduva töövõime korral makstakse kõigile lisatoetust suuremas määras kui osalise töövõimega inimestele. See toetab enam ka puudega inimesi, sest suurem enamus puuduva töövõimega inimestest omab ka puude raskusaste otsust. Samas ei ole teada, kui paljudel keskmise puudega inimestest, kellel on osaline töövõime, on raske piiranguga ehk kui paljud tänastest puuetega inimeste toetuste saajatest lisatoetust ei saaks.

Vähenenud töövõime diagnooside jaotus on esitatud tabelis 46.

Tabel 46. Vähenenud töövõimega seotud diagnoosid, 2024

Üksnes vähenenud töövõime				Samaaegselt puude ja vähenenud töövõime otsusega	
				Osaline töövõime	Puuduv töövõime
I	Teatavad	nakkus-	ja		
	parasiithaigused (A00–B99)			167	87
II	Kasvajad (C00–D48)			1337	1120
III	Vere- ja vereloomeelundite				
	haigused ning teatavad				
	immuunmehhanismidega seotud			146	8
	haigusseisundid (D50–D89)				13
					31

IV Sisesekreetsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused (E00–E90)	3413	171	450	759
V Dementsus (F00–F03)	1	46	1	622
V Mõõdukas, Raske, sügav Vaimne alaareng (F70–F73)	527	188	1174	6034
V Vaimne alaareng (F74–F79)	17	7	20	97
V Psüühika- ja käitumishäired (F00–F99)	12512	3523	1812	10418
VI Närvisüsteemahaigused (G00–G99)	3429	625	852	3736
VII Silma- ja silmamanuste haigused (H00–H59)	284	29	447	601
VIII Kõrva- ja nibujätkehaigused (H60–H95)	527	17	1458	165
IX Vereringeelundite haigused (I00–I99)	3021	497	415	1761
X Hingamiselundite haigused (J00–J99)	786	80	79	216
XI Seedeelundite haigused (K00–K93)	581	152	36	145
XII Naha- ja nahaaluskoe haigused (L00–L99)	328	10	19	29
XIII Lihasluukonna ja sidekoehaigused (M00–M99)	18155	785	2441	2653
XIV Kuse-suguelundite haigused (N00–N99)	212	72	31	227
XV Rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne periood (O00–O99)	1	29	227	279
XVI Perinataal- e sünniperioodis tekkivad teatavad seisundid (P00–P96)	5	59	71	179
XVII Kaasasündinud vääramendid, deformatsioonid ja kromosoomianomaaliad (Q00–Q99)	475	130	381	736
XVIII Muijal klassifitseerimata sümptomid, tunnused ja kliiniliste ning laboratoorsete leidude hõlbed (R00–R99)	375	27	72	114
XIX Vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed (S00–T98)	1661	1	1	5
XXI Tervises seisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega (Z00–Z99)	170	87	18	83
XXII Koodid spetsiifiliste eesmärkide jaoks (U00–U99)	8	1120	155	1203
Muu / teadmata	5	8	0	31
KOKKU	48143	7663	10173	30093

Allikas: Eesti Töötukassa registriandmed, autorite arvutused.

Lisa 6 – Hüvede ümberkorraldamine ja nendega seotud kulude muutus

Tabel 47. Puudega seotud soodustuste ja hüvede ümberkorraldamine ja sellest tulenev kulude muutus Teekond 1 (Terviklahendus A ja B) korral

Kehtivad soodustused ja muud hüved	Täna sed kulud puude raskusastme g a või vähenenud töövõimega inimestele kokku	Teekond 1: <u>tööeas</u> töövõime hindamine, puuet ei tuvastata	Teekond 1: <u>65+ eas</u> hinnatakse õigust toetusele, puuet riik ei tuvasta	Teekond 1: Lisakulu kokku	Kommentaar
PISTS toetused					
Puudega vanema toetus	165 743.00 €	MUUTA: a) Toetust saavad osalise või puuduva töövõimega üksi last kasvatav vanem või vanemad. Toetuse suurus jääb samaks. Toetust maksab SKA. B) vähenenud töövõimega, kes on täieliku või raske piiranguga	MUUTA: makstakse neile, kes saavad uut toetust.	229 211.56 €	
Õppetoetus	0.00 €	LÕPETADA: Toetus kaob ära, summad antakse üle HTM-le erivajadusega üliõpilase stipendiumi ressursiks	N/A	0.00 €	Toetust baasstsenaariumis ei kasutatud.
Täienduskoolitustoetus	15 054.21 €	LÕPETADA: Toetus kaob ära, eelarvesumma antakse üle TK-le koolitustoetuseks	N/A	-15 054.21 €	
Teenused ja puhkus					
Sotsiaalne rehabilitatsioon	6 170 827.00 €	MUUTA: Osalise või puuduva töövõimega isik, kellel on tuvastatud sotsiaalse rehabilitatsiooni vajadus.	MUUTA: a) uue toetuse saajad; b) Või tagada vastavalt vajadusele kõikidele vanaduspensioniealiste le	5 533 793.24 €	Arvutus lähtub vanemaealiste puhul eeldusest a. Ei ole detailset infot rehabilitatsiooni vajaduse kohta. Eeldused lähtuvad praegusest teenuse kasutajate osakaaludest ja uutest sihtrühmade suurustest.
Puhkus täisealise sügava puudega isiku hooldamiseks	44 471.00 €	MUUTA: Täieliku piiranguga vähenenud töövõimega isiku hooldaja.	MUUTA: hooldatav on täieliku piiranguga toetuse saaja	-12 225.10 €	
Puudega inimese parkimiskaart	NA	MUUTA: vähenenud töövõimega inimene, kellel on täielik või raske nägemis- või	MUUTA: SKA toetuse saajad, kellel on täielik või raske liikumis- või nägemisfunktsiooni piirang	MUUTUS SAAJATE ARVUS: -5380	Piirangute eeldused on tehtud puude raskusastme ja puude liigi põhjal

		liikumisfunktsiooni piirang			
Soodustused					
Riigisisesed sõidusoodustused (tasuta)	NA	MUUTA: osalise või puuduva töövõimega inimene, kes on täieliku ja raske liikumisfunktsiooni või nägemisfunktsiooni piiranguga ja täieliku nägemisfunktsiooni piiranguga isiku saatja ning juhtkoer	MUUTA: SKA toetuse saajad, kes on täieliku ja raske liikumisfunktsiooni või nägemisfunktsiooni piiranguga ja täieliku nägemisfunktsiooni piiranguga isiku saatja ning juhtkoer	MUUTUS SAAJATE ARVUS: +42732	Detailne info piirangute osas puudub. Piirangute eeldused on tehtud tööealistel töövõime ulatuse, puude raskusastme ja puude põhjal, kuid tegelik kvalifitseeruvate inimeste arv võib erineda.
Riigisisesed sõidusoodustused	0.00 €	MUUTA: osalise või puuduva töövõimega isik, kes on täieliku ja raske liikumisfunktsiooni või nägemisfunktsiooni piiranguga ja täieliku nägemisfunktsiooni piiranguga isiku saatja ning juhtkoer	MUUTA: SKA toetuse saajad, kes on täieliku ja raske liikumisfunktsiooni või nägemisfunktsiooni piiranguga ja täieliku nägemisfunktsiooni piiranguga isiku saatja ning juhtkoer	0.00 €	
Tasuta riigimuuseumi külastus	NA	MUUTA: a) puuduva töövõimega isik ja tema saatja; b) asendada täieliku piiranguga vähenenud töövõimega	MUUTA: täieliku piiranguga vanaduspensioniealine isik	MUUTUS SAAJATE ARVUS: -1874	Arvutus lähtub eeldusest b.
Haridusmeetmed					
Erivajadusega üliõpilaste stipendium	215 536.00 €	MUUTA: lähtuvalt piirangust või funktsioonipiirangu kõrvalekaldest		699 090.76 €	Kulude arvutamisel võimalik arvestada üksnes osalist/puuduvat töövõimet ja samal ajal õppimist.
Välisõpingute stipendium	0.00 €	EI VAJA MUUTMIST: Ei vaja eraldi lahendust - täna on õigus lisaks puudega ka nii osalise töövõimega kui puuduva töövõimega isikul;		NA	Stipendiumi saajaid baastsenaariumis ei olnud
Eesti keele tasemeeksami osaoskuste vabastuse saamine	NA	MUUTA: asendada "puue" terviseseisundiga. Aluseks on taotlus ning vajadusel saab esitada töövõime vm andmed	MUUTA: asendada "puue" terviseseisundiga. Aluseks on taotlus ning vajadusel saab esitada töövõime vm andmed	NA	Andmed puuduvad
Kodakondsuseksami ulatuse ja viisi või eksamitest vabastamise taotlus	NA	MUUTA: lisada vähenenud töövõime otsus; ka täna aluseks terviseseisundi otsus raviarstilt	MUUTA: asendada "puue" terviseseisundiga. Aluseks on taotlus ning vajadusel saab esitada töövõime vm andmed	NA	Andmed puuduvad
Õigused					
Puudega isiku kaart	166 867.21 €	MUUTA: Kaardi saavad töövõimetetoetuse ja töövõimetuspensioni	MUUTA: Kaardi saavad SKA makstava toetuse saajad või kantakse	81 369.41 €	Sihtrühma suurus kasvab (vähenenud töövõimega

		saajad. Kaardil on välja toodud liikumis- ja nägemisfunktsioonide piirangud koos raskusastmetega.	info pensionikaardile. Kaardil on välja toodud liikumis- ja nägemisfunktsioonide piirangud koos raskusastmetega.		inimesed, kellel puuet ei ole). Ühe kaardi hind 1,5 eurot
Puudega inimestele õigusabi	70 000.00 €	MUUTA: Osalise või puuduva töövõimega isikud, töövõimetuspensionärid.	MUUTA: SKA uue toetuse saajad ehk täieliku või raske piiranguga	30 169.65 €	Eeldatud, et kasutajate osakaal jääb samaks, aga sihtrühm muutub (kasvab).
Õppekulude hüvitamine	NA	MUUTA: asendada osalise või puuduva töövõimega		MUUTUS SAAJATE ARVUS: +149	Puudega vanaduspensioniealiste seas õppijaid väga vähe; EUROMODist vaadates kokku alla 20 kõikide tasemete lõikes. Analüüsist väljas.
Vähendatud riigilõiv isikut tõendavate dokumentide taotlemisel	196 280.00 €	MUUTA: Osalise või puuduva töövõimega isikud, töövõimetuspensionisaajad	EI VAJA MUUTMIST: Vanaduspensioniealistel inimestel on sarnane soodustus olemas.	248 489.40 €	Sihtrühma suurus kasvab oluliselt (ligikaudu 55 tuhande inimese võrra); eeldatud sarnast osakaalu taotlemistest (22,6%)

Allikas: autorite arvutused registriandmete ja ministeeriumitelt päritud statistika põhjal.

Kasutatud kirjandus ja õigusaktid

Aavik-Märtmaa, G. (2020). Kuidas liigume edasi RFK metoodikaga? *Sotsiaaltöö*, 15. september 2020. [Link](#)

Agency for the Protection of the Rights of a Person with a Disabilities. [Link](#)

Anija Vallavolikogu määrus 38. Sotsiaalteenuste osutamise kord. RT IV, 28.09.2023, 4. [Link](#)

Arrak, K., Koppel, K., Toim, K., Laurimäe, M., Pall, K., Kadarik, I. & Viks-Binsol, P. (2024). *Andmepõhise personaliseerituse potentsiaal ja mõju sotsiaal- ja haridusvaldkonna avalikes teenustes ja toetustes*. Civitta Eesti AS, Sihtasutus Mõttekoda Praxis.

Baptista, I. & Marlier, E. (2022). *Social protection for people with disabilities in Europe. An analysis of policies in 35 countries*. European Social Policy Network (ESPN). Luxembourg: Publications Office of the European Union. [Link](#)

Care Needs Assessment Centre (CIZ). [Link](#)

Committee on the Rights of Persons with Disabilities. (2017). *Concluding observations in relation to the initial report of Latvia: Committee on the Rights of Persons with Disabilities : draft / prepared by the Committee (CRPD/C/LVA/CO/R.1)*. United Nations. [Link](#)

Committee on the Rights of Persons with Disabilities. (2018). *General comment No. 6 on equality and non-discrimination (CRPD/C/GC/6)*. United Nations. [Link](#)

Committee on the Rights of Persons with Disabilities. (2025). *Concluding observations on the combined second and third periodic reports of the European Union (CRPD/C/EU/CO/2-3)*. United Nations. [Link](#)

Council of Europe. (1990). *Social Security (Revised Code) (ETS No. 139)*. November 6, 1990. [Link](#)

Council of Europe. (2015). *Article 15 of the European Social Charter in the light of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Conference of INGOs of the Council of Europe. [Link](#)

Council of Europe. (2022). Digest of the case law of the European Committee of Social Rights. [Link](#)

Directive (EU) 2024/2841 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2024 establishing the European Disability Card and the European Parking Card for persons with disabilities. Official Journal of the European Union. [Link](#)

Disability : IN. *Global directory : Finland*. [Link](#)

Disability : In. *Global directory : The Netherlands*. [Link](#)

Disability : IN. *Global directory : Sweden*. [Link](#)

Eesti Töötukassa. *Tervisepiiranguga inimesele*. [Link](#)

EPIKoda. (2024). *Ettepanekud seoses puude mõiste ja PISTS alusel makstava toetuse eesmärgi ja termini sõnastamisega ning arvamus PISTS ja SHS muudatustega seondult*. Kiri Sotsiaalministeeriumile, 15.03.2024 nr 15. [Link](#)

EPIKoda. (2025). *Pöördumine Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti poole seoses puuetega inimeste arvu vähenemisega*. [Link](#)

Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks. RT II 2004, 6, 17. [Link](#)

European Disability Forum. (2022). *Disability Assessment and Social Protection*. [Link](#)

Eurostat. Database. [Link](#)

Försäkringskassan. *Disability*. [Link](#)

Hanga, K (2020). Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime klassifikatsioon. *Sotsiaaltöö*, 15.09.2020. [Link](#)

Heap, J. & Schön, P. (2022). *ESPN Thematic Report on Social protection for people with disabilities – Sweden*. European Social Policy Network (ESPN). Brussels: European Commission. [Link](#)

Invaliditātes novērtēšanas sistēmas pilnveide pilngadīgām personām. Valsts kanceleja. [Link](#)

Kakoullis, E., & Ikehara, Y. (2018). Article 1: Purpose. In I. Bantekas, M. A. Stein, & D. Anastasiou (Eds.), *The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary* (pp. 35–63). Oxford University Press.

Kallaste, E., Anspal, S., Nuiamäe, M., Sömer, M., Koppel, K., Lang, A., Laurimäe, M., Michelson, A., Murasov, M. & Sandre, S-L. (2022). *Töövõime toetamise süsteemi loomise ja juurutamise makromajandusliku mõju hindamine*. Tallinn: Eesti Rakendusuuringu Keskusest Centar ja Poliitikauuringute Keskus Praxis. [Link](#)

Kallioma-Puha, L. & Kangas, O. (2022). *ESPN Thematic Report on Social protection for people with disabilities – Finland*. European Social Policy Network (ESPN). Brussels: European Commission. [Link](#)

KELA. *Care allowance for pensioners*. [Link](#)

KELA. *EU Disability Card*. [Link](#)

Kreitzberg, M., Kamenik, K. & Sinisaar, H. (2015). *Töövõime hindamise metoodika piloteerimise tulemuste analüüs*. Sotsiaalministeerium. [Link](#)

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987). [Link](#)

Laurimäe, M., Sinisaar, H., Jezierska, I. M. (2025). *Analüüs riiklike maksutõusude ja eelarvekärbete mõjust haavatavas olukorras sihtrühmadele*. Tallinn: Mõttekoda Praxis. [Link](#)

Lääne-Nigula Vallavolikogu määrus nr 10. Puudega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord. RT IV, 24.05.2024, 12. [Link](#)

Made in Vilnius. (2023). *From January 1 the procedure for determining working capacity is changing*, 05.12.2023. New media group, UAB. [Link](#)

Ministry of Health, Welfare and Sports. *Care and Support. Government of Netherlands*. [Link](#)

MISSOC. *Comparative tables*. [Link](#)

Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta ratifitseerimise seadus. RT II 2000, 15, 93. [Link](#)

Posarac, A., Celmina, E., & Bickenbach, J. (2020). *Disability policy and disability assessment system in Latvia*. World Bank. [Link](#)

Priestley, M. (2022). *Disability assessment, mutual recognition and the EU Disability Card. Progress and opportunities*. STUDY Requested by the PETI committee. European Union. [Link](#)

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus. RT I 1999, 16, 273. [Link](#)

Puuetega inimeste õiguste komitee. (2021). *Kokkuvõtvad tähelepanekud Eesti esialgse aruande kohta (CRPD/C/EST/CO/1)*. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. [Link](#)

Puuetega inimeste õiguste konventsioon ja fakultatiivprotokoll. RT II, 04.04.2012, 6. [Link](#)

Randlepp, M. (2012). *Sotsiaalkaitse kogukulutuste (ESSPROS) käsiraamat*. Statistikaamet. [Link](#)

Reisberg, L. (2022). *Lapse puude astme tuvastamine halduskohtute praktikas. Kohtupraktika analüüs*. Riigikohus. Tartu 2022.

Report for the period of July 1, 2022 to June 30, 2023 on measures implementing the provisions of the European Code of Social Security signed by the Government of Estonia on January 24, 2000. Estonia – ECSS 17th annual report. [Link](#)

Riigikohtu halduskolleegiumi 20. juuni 2022. a otsus nr 3-20-2474, punktid 25 ja 26. [Link](#)

Riigikontroll. (2024). *Riigi tegevus erivajadustega inimeste toetamisel. Riigikontrolli aruanne Riigikogule*. Tallinn, 12. aprill 2024. [Link](#)

Riigikontroll. (2025). *Terviseandmete õigsuse, täpsuse ja ajakohasuse tagamine. Riigikontrolli aruanne Riigikogule*. Tallinn, 5. detsember 2025. [Link](#)

Sosiaalihooldolaki (1301/2014). [Link](#)

Sotsiaalhoolekande seadus. RT I, 30.12.2015, 5. [Link](#)

Sotsiaalkaitseministri määrus nr 18, lisa 1. Lapsel või vanaduspensioniealisel inimesel esinevate piirangute hindamise tingimused ja piirangute raskusastmete arväärtused. [Link](#)

Sotsiaalkaitseministri määrus nr 18, lisa 2. Tööealisel inimesel esinevate piirangute hindamise tingimused, piirangute raskusastmete arväärtused ja võtmetegevuste raskusastmete vastavustabel. RT I, 01.03.2016, 11. [Link](#)

Sotsiaalkaitseministri määrus nr 18. Puude raskusastme tuvastamise tingimused ja kord ning puudega tööealise inimese toetuse tingimused. RT I, 01.03.2016, 11. [Link](#)

Sotsiaalkaitseministri määrus nr 30. Tööealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu, RT I, 19.05.2016, 1. [Link](#)

Sotsiaalkindlustusamet. (2025a). Juhend laste ja vanaduspensioniealiste isikute puude raskusastme tuvastamise eksperdiarvamuse andmiseks (kinnitatud käskkirjaga nr 93, 30.05.2025; versioon 1.1, 20.05.2025). [Link](#)

Sotsiaalkindlustusamet. (2025b). *Täisealise abi- ja toetusvajaduse hindamise juhend*. [Link](#)

Sotsiaalkindlustusamet. *Kohalike omavalitsuste nõustamine: Hindamisvahendid*. [Link](#)

Sotsiaalkindlustusamet. *Puude tuvastamine*. [Link](#)

Sotsiaalministeerium. (2020). *Töövõime hindamise metoodika, 31.03.2020 korrigeeritud versioon*. [Link](#)

Statistikaamet. (2014). *Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine*. [Link](#)

Statistikaamet. Statistika andmebaas. [Link](#)

Statistikaamet. Tööturu rakendus. [Link](#)

S-veeb. *Sotsiaalhoolekande alased statistilised aruanded*. [Link](#)

Tallinna Halduskohtu 30.12.2020 otsus kohtuasjas nr 3-19-1799.

Tervej den ja hj vinvoinnin laitos (THL). *Handbook on Disability services*. [Link](#)

Tervise Arengu Instituut. *RFK ehk rahvusvaheline funktsioneerimisvõime klassifikatsioon*. [Link](#)

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus. *Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime klassifikatsioon ehk RFK*. [Link](#)

Tervise- ja tööministri määrus nr 39. Töövõime hindamise taotlusele kantavate andmete loetelu, töövõime hindamise tingimused ja töövõimet välistavate seisundite loetelu, RT I, 08.09.2015, 4. [Link](#)

The Academic Network of European Disability Experts (ANED). [Link](#)

The Finnish Transport and Communications Agency Traficom. *Apply for a parking card for people with reduced mobility*. [Link](#)

Turu-uuringute AS. (2020). *Elanikkonna tegevuspiirangute ja hooldusvajaduse uuring*. [Link](#)

Töövõimetoetuse seadus. RT I, 13.12.2014, 1. [Link](#)

United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. [Link](#)

United Nations. (2022). *Introducing the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. [Link](#)

Waddington, L. & Broderick, A. (2018). *A comparison of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and EU equality and non-discrimination law*. Directorate-General for Justice and Consumers. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. [Link](#)

Waddington, L. & Priestley, M. (2021). A human rights approach to disability assessment. *Journal of International and Comparative Social Policy*, 37(1), 1–15. doi:10.1017/ics.2020.21 [Link](#)

Waddington, L., Priestley, M. & Sainsbury, R. (2018). *Disability Assessment in European States*, ANED Synthesis Report (December 2018). European Commission. [Link](#)

Vainu, V. (2025). *Elanikkonna tegevuspiirangute ja hooldusvajaduse uuringu lõppraport. Andmetabelid (avaldamata materjal)*. Sotsiaalministeerium/Turu-uuringute AS/ Euroopa Sotsiaalfond.

Van Dijk, L. (2022). *ESPN Thematic Report on Social protection for people with disabilities – The Netherlands*. European Social Policy Network (ESPN). Brussels: European Commission. [Link](#)

Wasserman, D. & Aas, S. (2023). Disability : Definitions and models. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2023 Edition)*. Stanford University . [Link](#)

Welfare Experiences. [Link](#)

WHO. *Disability Assessment Schedule WHODAS*. [Link](#)

Viidalepp, K. (2023). Rahvusvahelise funktsioneerimisvõime klassifikatsiooni valdkonnaülene rakendamine. *Sotsiaaltöö*, 8. november 2023. [Link](#)

World Health Organization. (2001). *International classification of functioning, disability and health (ICF)*. World Health Organization. [Link](#)

Võrdse kohtlemise seadus. RT I 2008, 56, 315. [Link](#)